



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN APRIL
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi..... 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 5

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)..... 5

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 5

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO..... 5

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 5

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 5

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 5

3.3.2 Rawat Inap..... 5

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)..... 5

3.3.4 Maternitas 5

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)..... 5

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 5

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 7

3.4.1 Instalasi Farmasi..... 7

3.4.2 Laboratorium..... 7

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 7

3.4.4 Radiologi 7

3.4.5 Gizi..... 7

3.4.6 CSSD - Laundry..... 7

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan..... 8

3.5.1 MFK dan K3RS 7

3.5.2 Security..... 7

3.5.3 Parkir 7

3.5.4 Humas Marketing..... 7

3.5.5 Penjaminan..... 7

3.5.6 PIPP – MOD - MPP 7

3.5.7 *Cleaning Service*..... 7

3.6 Komite dan Tim 7

3.6.1 Komite Mutu 7

3.6.2 Komite PPI 7

3.6.3 Tim PKRS..... 7

3.6.5 Tim Prognas 7

3.7 Klaim Pending 10

3.7.1 Analisis 10

3.7.2 Tindak Lanjut.....	10
3.8 Permasalahan Rumah Sakit.....	44
3.9 Profil SDM	48
3.9.1 Komposisi dan Distribusi SDM.....	48
3.9.2 Update STR/SIP	51
3.10 Kemajuan Piutang	52
3.10.1 Data Piutang yang Belum Terbayar	52
3.10.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang	53
3.10.3 Update IKS	54
Bab V Kesimpulan dan Saran	104
Bab VI Penutup	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan April Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

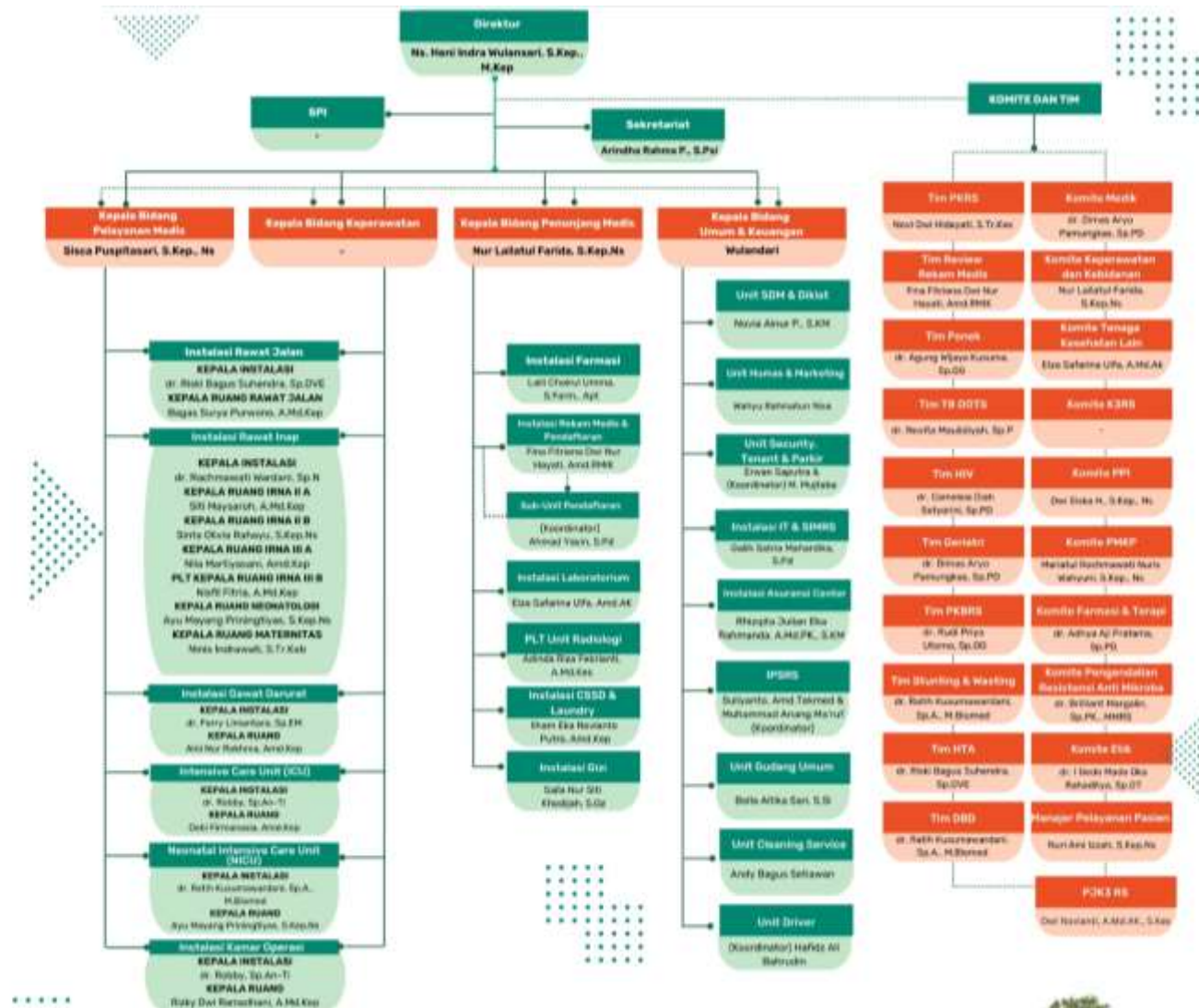
Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Dipercaya
3. Tanggung Jawab
4. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

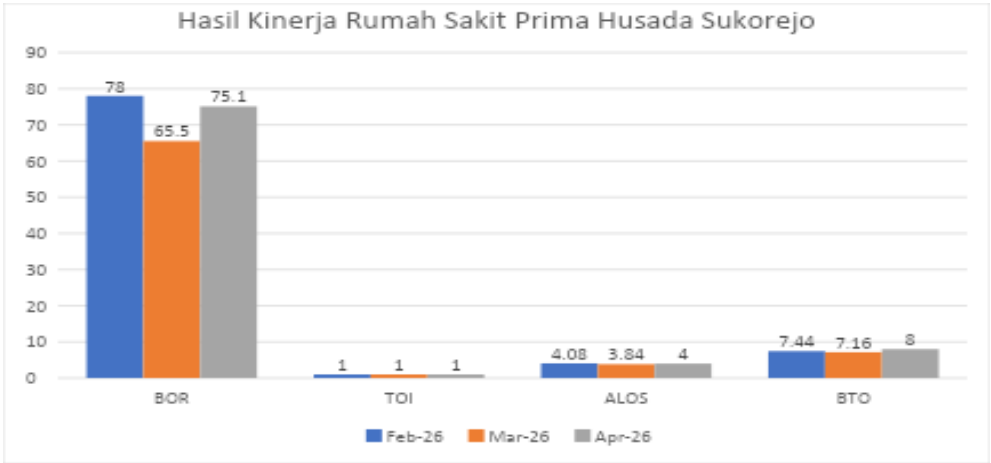
Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai berikut :



BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT,BOR,ALOS,BTO,TOI)

3.1.1 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO



3.1.2 Analisa dan Tindak Lanjut

Berikut adalah analisis kinerja indikator pelayanan rawat inap Rumah Sakit RSPHS untuk Bulan April 2026, berdasarkan empat indikator utama: BOR, LOS, TOI, dan BTO.

Indikator	Februari 2026	Maret 2026	April 2026	Standar Ideal	Evaluasi Umum
BOR (Bed Occupancy Rate)	78%	65.5%	75.1%	60–85%	Semua dalam standar, turun dari Bulan Januari ke Maret
LOS (Length of Stay)	4 hari	4 hari	4 hari	BPJS: 3 Umum: 6–12	Stabil, tidak sesuai untuk BPJS
TOI (Turn Over Interval)	1 hari	1 hari	1 hari	1–3 hari	Stabil
BTO (Bed Turn Over)	7 hari	7 hari	8 hari	4–5 kali	Konsisten namun mengalami kenaikan dari bulan Maret ke April

a. Analisis Tren Per Bulan

1. BOR (Bed Occupancy Rate)
- Februari : 78% → tidak ada kenaikan atau penurunan, secara grafik naik

• Maret : 65% → terjadi penurunan

• April : 75,1% → terjadi kenaikan
- Tren : Konsisten menaik sejak bulan Januari,

Beberapa faktor terjadinya kenaikan nilai BOR di Bulan April

- a) Jumlah kenaikan jumlah pasien yang masuk di Bulan Maret , rata-rata pasien masuk di Maret 56 pasien per hari, sedangkan rata-rata pasien masuk di Bulan April 58 pasien per hari
- b) Faktor internal

- Fasilitas dan sarana prasarana yang baik menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar

- Sikap tenaga medis dan staf yang membuat nyaman konsumen dengan adanya pembenahan jika ada kendala yang terjadi

- c) Faktor eksternal
- Adanya kepercayaan dan citra yang baik di lingkungan masyarakat terkait RS Prima Husada Sukorejo
 - Adanya perubahan kebijakan terkait lama dirawat pasien BPJS kesehatan yang harus dirawat minimal 3 hari.
 - Faktor pancaroba (perubahan musim panas ke musim hujan) juga menjadi salah satu faktor terjadinya lonjakan pasien rawat inap di RS Prima Husada Sukorejo, diagnose terbanyak adalah Thypoid Fever dan Bronchopneumonia.

2. LOS (Length of Stay)

- a) Stabil di angka 4 hari untuk tiga bulan berturut-turut.
- b) Tidak sesuai SE PT.DPM untuk pasien BPJS, tetapi terlalu rendah untuk pasien umum (standar: 6–12 hari).

Sedangkan pada Bulan Maret

Dengan lama dirawat 1-3 hari = 740 = 45.8%

Dengan lama dirawat 4-13 hari = 876= 54.2%

- Adanya pasien yang dirawat melebihi SE dari PT DPM, perlu dikaji terkait indikasi dirawat pasien
- Adanya perubahan kebijakan terkait lama dirawat pasien BPJS kesehatan yang harus dirawat minimal 3 hari

Tren: Konsisten, tetapi perlu audit LOS pasien

3. TOI (Turn Over Interval)

Stabil di angka 1 hari untuk tiga bulan berturut-turut.

Tren: Konsisten, tetapi perlu adanya penggantian fasilitas kamar dan menjaga kebersihan ketika akan pergantian pasien sehingga infeksi nosocomial dapat diminimalisir

4. BTO (Bed Turn Over)

- a) Februari : 7 kali
- b) Maret : 7 kali
- c) April : 8 kali

Tren: Terlalu tinggi dari standar ideal (4–5 kali), yang bisa menandakan rotasi pasien sangat cepat → perlu dievaluasi dari aspek beban kerja, mutu layanan, dan risiko infeksi nosocomial.

a. Permasalahan yang Muncul

Isu	Penjelasan
Fluktuasi BOR	Bisa mencerminkan ketidakteraturan alur pasien atau perbedaan kebijakan antar bulan.
LOS terlalu singkat untuk pasien umum LOS terlalu lama untuk pasien BPJS	- Risiko pemulangan dini, kemungkinan readmisi meningkat. - Risiko meningkatkan penggunaan BMHP dan penggunaan kamar yang lebih lama
BTO tinggi secara konsisten	Potensi beban kerja berat bagi tenaga medis, penurunan mutu perawatan, dan tekanan administratif.
TOI rendah	Efisien, tetapi dalam konteks BTO tinggi → bisa berarti pasien terlalu cepat digantikan.

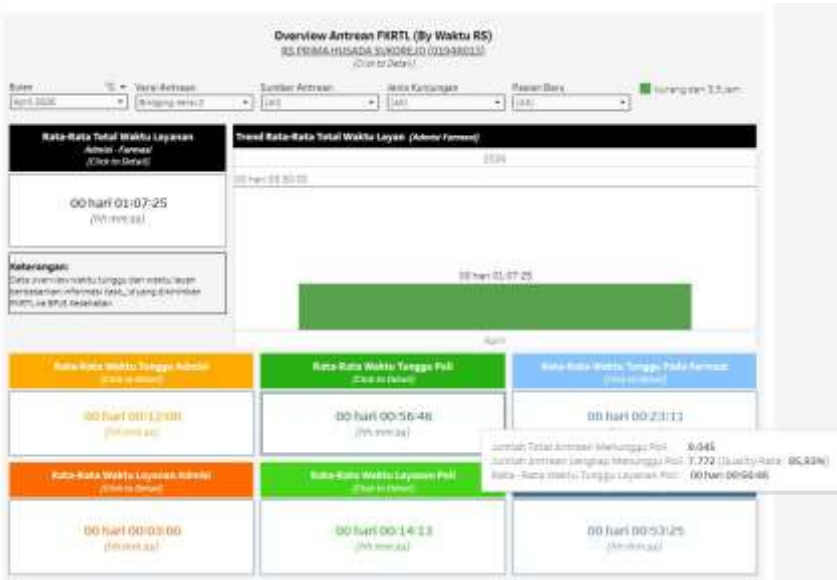
- b. Rekomendasi Tindak Lanjut**
- 1) Evaluasi Manajemen Pelayanan Rawat Inap
 - Tinjau alur pasien dan penyebab fluktuasi BOR.
 - Koordinasi antar unit untuk menjaga kestabilan utilisasi tempat tidur.
 - Rotasi pasien masuk dan keluar yang sangat cepat, kebutuhan kamar sangat tinggi.
 - 2) Audit LOS Berdasarkan Jenis Pasien
 - Pisahkan analisa LOS pasien BPJS dan umum.
 - Cek outcome klinis untuk mendeteksi risiko pemulangan terlalu dini.
 - Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya untuk memonitor pasien BPJS yang sudah melebihi lama rawat 3 hari, perlu dikaji kembali terkait kondisi dan indikasi medis pasien.
 - 3) Kaji Kembali Beban Kerja SDM
 - Lakukan survei kepuasan dan kelelahan staf medis akibat BTO tinggi.
 - Pertimbangkan redistribusi staf atau perekrutan tambahan jika diperlukan.
 - 4) Implementasi Sistem Bed Management
 - Gunakan sistem digital untuk manajemen tempat tidur real-time dan efisiensi ruang rawat inap.
 - 5) Monitoring Mutu Layanan
 - Pantau indikator mutu lain seperti readmisi, komplain pasien, dan kepuasan pasien pasca rawat inap.

- c. Kesimpulan Akhir**
- RSPHS menunjukkan kinerja indikator rawat inap secara umum dalam standar, tetapi:
- a) Ada fluktuasi BOR yang perlu distabilkan.
 - b) BTO terlalu tinggi secara konsisten, bisa berdampak pada mutu dan beban kerja.
 - c) LOS tetap 4 hari, tidak ideal bagi pasien BPJS maupun umum dan asuransi

3.1.3 Antrian Online BPJS Kesehatan

A. Profil Pelayanan Antrian Online

Menampilkan Dashboard Layanan Antrian Online Bulan April 2026



B. Kendala

- 1. kendala jaringan yang menghambat proses, namun terkendali

C. Rencana Tindak Lanjut

- 1. Monev pelaksanaan alur antrian online oleh karu dan kapid
- 2. Perbaikan jaringan

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

No	Unit	Recana Pengembangan	Keterangan		Konfirmasi
			Tercapai	Belum Tercapai	
1	IGD	1. Pengembangan kompetensi SDM IGD berbasis Skill Aktual	√		Pelatihan ACLS for Nurse dilakukan mulai bulan November 2025 – Januari 2026
		2. IGD Gatekeeper program		√	Rencana akan dilakukan di pertengahan bulan Februari
		3. Humanized Emergency Care		√	Rencana akan dilakukan di pertengahan bulan Februari
		4. Pengajuan pengadaan alat tambahan ventilator mobile		√	Rencana akan dilakukan pengajuan di bulan Maret
2	ICU	1. Penambahan ruang tunggu bagi keluarga pasien ICU	√		Penambahan ruang tunggu berada di depan area ruang Dahlia Irna 3A
		2. Memasang alat observasi yang central dan bisa terecord		√	
		3. Diadakannya ruang PICU		√	Sedang dalam proses pembangunan gedung baru yang akan selesai di tahun 2026
		4. Mengadakan alat kebersihan untuk pasien		√	Proses pengajuan di pertengahan bulan Februari
3	IKO	1. Efisiensi batal operasi elektif	√		
		2. Efisiensi waktu kamar operasi	√		
		3. Rapat mutu berkala kamar operasi	√		
4	IRJA	Pelayanan Poli Eksekutif		√	Sedang dalam proses pembangunan gedung baru yang akan selesai di tahun 2026
5	Maternitas	1. Pembukaan layanan Mom SPA untuk ibu hamil dan pasca melahirkan dan menyiapkan ruangannya		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		2. Membuka penitapan anak khusus bagi karyawan		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		3. Paket melahirkan premium		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret

		4. Peningkatan kompetensi SDM (PPGDON dan APN)		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
6	Neonatologi	1. Layanan Baby SPA		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		2. Rutin diadakan layanan Baby SPA untuk pasien dari luar, seperti layanan Dolina (senam hamil)		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		3. Peningkatan kompetensi SDM (kegawatan pada Neonatus)		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
7	NICU	1. Ruang tunggu untuk ibu yang bayinya sakit dengan dilengkapi fasilitas untuk memompa ASI (ruang ibu menyusui)		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		2. Peningkatan kompetensi SDM (NICU)		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
8	IRNA 2A	1. Nurse station yang terpisah dengan nurse station unit lainnya		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		2. Adanya ruang HCU		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
9	IRNA 2B	Nurse station yang layak dan nyaman disertai dengan ruang edukasi yang nyaman bagi keluarga pasien yang privasi		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
10	IRNA 3A	1. Penambahan accesoris di setiap ruangan anak, agar pasien anak terhindar dari trauma tentang RS		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		2. Penambahan accesoris pada setiap alat kesehatan pemeriksaan pada anak		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
11	IRNA 3B	1. Program e-Vital dan e-EWS Ward		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		2. QR Bedside Nursing Access		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret
		3. Smart Nursing Task List		√	Sedang dalam proses pengajuan di bulan Maret

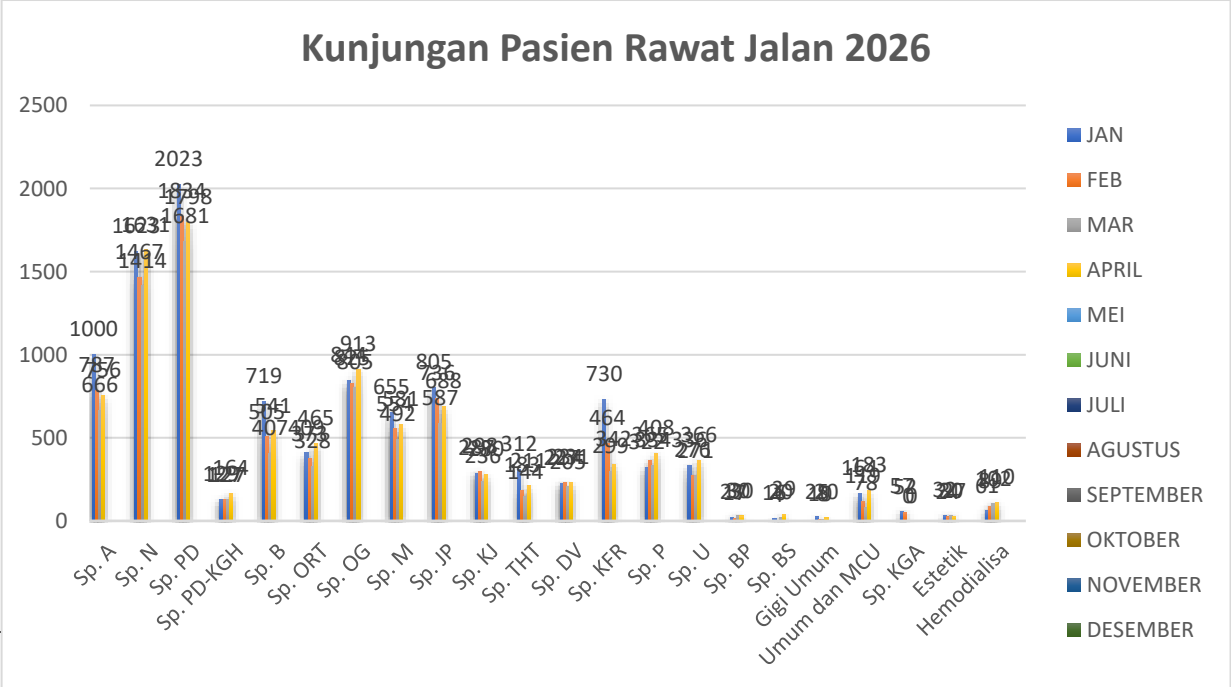
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2026

NO	NAMA POLIKLINIK	DES 2025	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	%
1	Anak	862	1000	787	666	756									↑ 0.9
2	Saraf	1623	1623	1467	1414	1631									↑ 2.17
3	Penyakit Dalam	1886	2023	1834	1681	1798									↑ 1.08
4	Penyakit Dalam KGH	19	129	127	127	164									↑ 0.37
5	Bedah Umum	640	719	505	407	541									↑ 1.34
6	Orthopedi	331	409	373	328	465									↑ 1.37
7	Kandungan	877	844	825	805	913									↑ 1.08
8	Mata	687	655	554	492	581									↑ 0.89
9	Jantung	758	805	736	587	688									↑ 1.01
10	Jiwa	243	287	298	236	280									↑ 0.44
11	THT	275	312	183	144	211									↑ 0.67
12	Kulit dan Kelamin	279	227	234	205	231									↑ 0.26
13	Rehab Medik	822	730	464	299	342									↑ 0.43
14	Paru	387	322	365	334	408									↑ 0.74
15	Urologi	305	336	276	271	366									↑ 0.95
16	Bedah Plastik	16	23	17	30	30									Tetap
17	Bedah syaraf	12	16	4	20	39									↑ 0.19
18	Gigi umum	29	25	10	8	20									↑ 0.12
19	Umum dan MCU	224	164	119	78	183									↑ 1.05
20	Gigi Anak	36	57	52	0	0									Tetap
21	Estetik	34	32	24	30	27									↓ 0.03
22	Hemodialisa	0	61	89	102	110									↑ 0.08
TOTAL		10345	10798	9343	8264	9784									↑ 15.2

B. Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan 2026



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan Grafik 3.2 diatas menunjukkan terdapat kenaikan sebanyak 15,2% dibandingkan dengan bulan Maret 2026 dengan jumlah 9784 pasien di bulan April 2026.

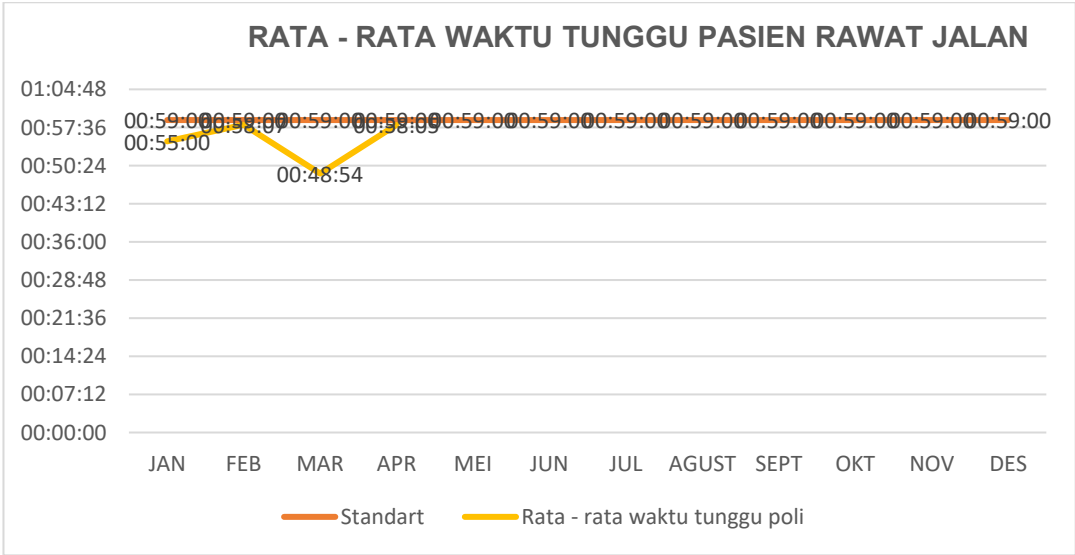
Masalah

Problem	Kejadian berkas tidaak layak bayar dikarenakan fragmentasi
Step	Mengurangi kejadian tidak layak bayar akibat fragmentasi
Plan	1. Rencana: a. Mengidentifikasi penyebab dengan 4M dan 1 E 2. Harapan a. Mengurangi kejadian klaim tidak layak bayar akibat fragmentasi. b. Meningkatkan ketepatan pengajuan klaim sesuai regulasi BPJS/penjamin. c. Meningkatkan kualitas dokumentasi dan verifikasi klaim. 3. Tindakan a. Sosialisasi Kembali dengan Poli, DPJP dan Pendaftaran terkait fragmentasi b. Menetapkan control Kembali +7 hari c. Melakukan penulisan indikasi medis secara lengkap di surat control
Do	1. Melakukan sosialisasi aturan fragmentasi klaim kepada petugas terkait. 2. Membuat checklist verifikasi episode pelayanan sebelum klaim dikirim. 3. Melakukan double check antara rekam medis, SEP, billing, dan data pelayanan. 4. Mengoptimalkan koordinasi antara DPJP, coder, casemix, pendaftaran, dan unit pelayanan. 5. Melakukan audit internal terhadap berkas klaim yang berisiko fragmentasi. 6. Membuat panduan/alur penanganan kasus dengan potensi fragmentasi
Study	1. Monitoring jumlah klaim tidak layak bayar akibat fragmentasi setiap bulan. 2. Audit kepatuhan penggunaan checklist verifikasi. 3. Evaluasi penyebab terbanyak terjadinya fragmentasi.

	4. Membandingkan angka klaim pending/tidak layak bayar sebelum dan sesudah perbaikan
Action	1. Menetapkan verifikasi internal klaim sebagai prosedur tetap. 2. Melakukan monitoring rutin terhadap klaim berisiko tinggi. 3. Memberikan umpan balik dan pembinaan kepada petugas bila ditemukan kesalahan. 4. Melakukan evaluasi berkala terhadap alur klaim dan regulasi terbaru. 5. Mengembangkan sistem notifikasi/verifikasi elektronik untuk mencegah fragmentasi klaim

Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan

NO	Bulan	Rata-Rata Waktu Tunggu Poli
1	Januari	00;55;00
2	Februari (24-2-2026)	00;58;07
3	Maret	00;48;54
4	April	00;58;05



Analisa

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan adanya waktu tunggu sudah sesuai standart. Ini tetap dilakukan monitoring berkala agar waktu tunggu tetap sesuai standart yaitu kurang dari 59 menit.

Masalah

Problem	Monitoring waktu tunggu agar tetap di bawah 59 menit
Step	Waktu tunggu tetap bagus dibawah 59 menit sesuai standart
Plan	1. Rencana: a. Memantau alur yang sudah berjalan untuk mempertahankan waktu tunggu dibawah 59 menit 2. Harapan Waktu tunggu layanan tetap sesuai dengan standart yaitu kurang 59 menit 3. Tindakan a. Memonitoring dan evaluasi alur baru yang sudah dijalankan
Do	Buat laporan terkait waktu tunggu yang didalamnya ada kendala dan evaluasi
Study	1. Bandingkan waktu tunggu rata- rata sebelum dan sesudah intervensi 2. Kumpulkan data umpan balik pasien melalui survey singkat 3. Apakah perubahan menunjukkan penurunan waktu tunggu
Action	Monitoring dan evaluasi alur yang sudah berjalan

Rekapan Data Keterlambatan DPJP

NO	NAMA DOKTER	JUMLAH KEHADIRAN	TERLAMBAT	TIDAK TERLAMBAT	% TERLAMBAT
1	dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	21	4	17	19%
2	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	24	1	23	4%
3	dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	22	4	18	18%
4	dr. Muhammad Irawan, Sp.A	19	2	17	11%
5	dr. Esti Purwaningrum, Sp.A	15	5	10	33%
6	dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed	23	21	2	91%
7	dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A	11	8	3	73%
8	dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD	18	10	8	56%
9	dr. Heriyatmo, Sp.PD	21	0	21	0%
10	dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	24	0	24	0%
11	dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	26	7	19	27%
12	dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD-KGH	8	0	8	0%
13	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	22	1	21	5%
14	dr. Zaki Yamani, Sp.B	13	0	13	0%
15	dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B	22	0	22	0%
16	dr. Angga Prawira Purwanto, Sp.B	12	3	9	25%
17	dr. Arianto Prabowo, Sp.OT	4	0	4	0%
18	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT	4	0	4	0%
19	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	16	2	14	13%
20	dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS	4	1	3	25%
21	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	25	2	23	8%
22	dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	10	1	9	10%
23	dr. Akhmad Zainul Arifin, Sp.N., M.Kes	20	3	17	15%
24	dr. Rachmawati Wardani Sp.N	11	1	10	9%
25	dr. Badariyatud	5	5	0	100%

	Dini, Sp.BP-RE(K)				
26	drg. Syafrini Farrahdebi	8	0	8	0%
27	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	22	9	13	41%
28	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	9	0	9	0%
29	dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS	3	0	3	0%
30	dr. Kristia Fahmi, Sp P	5	1	4	20%
31	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	11	10	1	91%
32	dr. Dion Setiawan, Sp. JP	12	2	10	17%
33	dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M	25	20	5	80%
34	dr. N. Indra Bayu, Sp.M	14	4	10	29%
35	dr. Latifah, Sp.M	18	7	11	39%
36	dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L	10	6	4	60%
37	dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L.	12	8	4	67%
38	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	24	2	22	8%
39	dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ	4	0	4	0%
40	dr. Andika Widiati, Sp.KJ	12	1	11	8%
41	dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR	13	1	12	8%
42	dr. Eko Nugroho, Sp.KFR	25	25	0	100%
43	dr. Ferry Limantara, Sp.EM	10	0	10	0%

Tabel Rekap data Ijin DPJP April 2026

NO	NAMA DOKTER	JUMLAH KEHADIRAN	TANGGAL IJIN	JUMLAH IJIN	KETERANGAN
1	dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	21	20-30	10	Petugas haji
2	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG	24			
3	dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	22	11	1	Seminar
4	dr. Muhammad Irawan, Sp.A	19			
5	dr. Esti Purwaningrum, Sp.A	15			
6	dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed	23			
7	dr. Qashastia Sukma	11	18	1	Acara ABD

	Paripurna Sp.A				
8	dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD	18	28	1	Operasi Memanjang di RSUD Bangil
9	dr. Heriyatmo, Sp.PD	21			
10	dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD	24			
11	dr. Aditya Purwaka, Sp.PD	26			
12	dr. Ardityo Rahmat Ardhan, Sp.PD-KGH	8	29	1	Akreditasi RS
13	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	22	20-30	10	Petugas haji
14	dr. Zaki Yamani, Sp.B	13			
15	dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B	22	11	1	Seminar
16	dr. Angga Prawira Purwanto, Sp.B	12			
17	dr. Arianto Prabowo, Sp.OT	4			
18	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT	4			
19	dr. Fiski Purantoro, Sp.OT	16	18	1	Acara ABD
20	dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp. BS	4	28	1	Operasi Memanjang di RSUD Bangil
21	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N	25			
22	dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N	10			
23	dr. Akhmad Zainul Arifin, Sp.N., M.Kes	20			
24	dr. Rachmawati Wardani Sp.N	11	29	1	Akreditasi RS
25	dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K)	5	20-30	10	Petugas haji
26	drg. Syafrini Farrahdebi	8			
27	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	22	11	1	Seminar
28	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	9			
29	dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS	3			
30	dr. Kristia Fahmi, Sp P	5			
31	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	11	18	1	Acara ABD
32	dr. Dion Setiawan, Sp. JP	12	28	1	Operasi Memanjang di RSUD Bangil
33	dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M	25			
34	dr. N. Indra Bayu, Sp.M	14			
35	dr. Latifah, Sp.M	18			
36	dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L	10	29	1	Akreditasi RS
37	dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L.	12	20-30	10	Petugas haji

38	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	24			
39	dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ	4	11	1	Seminar
40	dr. Andika Widiarti, Sp.KJ	12			
41	dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR	13			
42	dr. Eko Nugroho, Sp.KFR	25			

Analisa

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan adanya dokter spesialis yang terlambat dengan prosentase > 50% yaitu dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K) dengan prosentase 100%, dr. Eko Nugroho, Sp.KFR dengan prosentase 100%, dr. Ratih Kusumawardani, Sp. A, M. Biomed dengan prosentase 91%, dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP dengan prosentase 91%, dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M dengan prosentase 80%, dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A dengan prosentase 73%, dr. Fuad Fauzi, Sp. T.H.T.K.L dengan prosentase 67%, dr. Julian Hertawan, Sp. T.H.T.K.L dengan prosentase 67, dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD dengan prosentase 56%.

Masalah

Problem	Angka keterlambat dokter spesialis > 50%
Step	Menurunkan angka keterlambatan dokter spesialis < 50 %
Plan	1. Rencana: Menurunkan keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan 2. Harapan Tidak ada dokter spesialis yang terlambat 3. Tindakan a. Monitoring keterlambatan dokter spseialis di rawat jalan b. Ganti Hfis dokter sesuai jam kedatangan c. Membuat sistem pengingat ke DPJP setiap 15 menit sebelum praktek setiap dokter belum datang. d. Berikan raport kepada DPJP yang terlambat dan surat komitmen dalam kedisiplinan
Do	1. Ingatkan dokter 15 menit sebelum jadwal praktik 2. Sosialisasi Kembali kebijakan disiplin waktu praktek dokter spesialis 3. Memberi teguran secara tertulis (raport) kepada dokter spesialis yang terlambat > 50 %
Study	1. Terdapat 6 dokter spesialis dengan angka keterlambatan > 50% 2. Keterlambatan ke 6 dokter spesialis
Action	1. Ganti jadwal Hfis dokter spesialis yang sering terlambat sesuai jam kedatangan 2. Lakukan reward dan punishment bagi dokter terkait ketepatan waktu 3. Lakukan monitoring Bersama Komite Mutu dan Komite medik

Rencana Tindak Lanjut

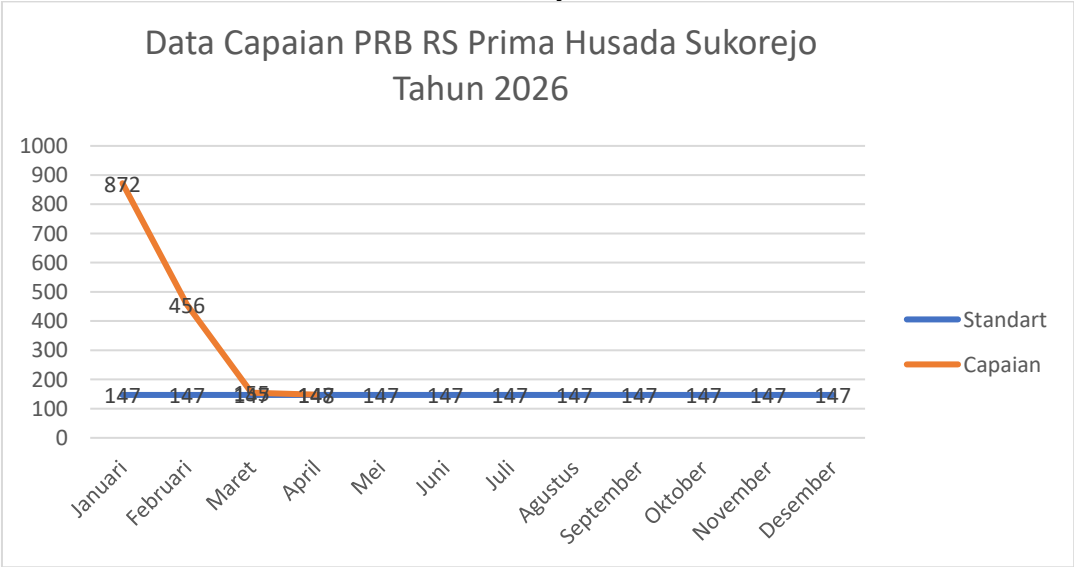
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Menyesuaikan jam Hfis dengan kedatangan real dokter	Tidak ada keterlambatan	DPJP	1. Catat waktu kedatangan secara real dan bandingkan dengan jam Hfis	1. Sekertaris Komdik 2. DPJP	1 bulan

				2. Beri teguran secara tertulis jika di dapatkan terlambat >50% 3. Lakukan perubahan jam Hfis segera jika keterlambatan masih tetap		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel Data PRB RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2026

NO	TARGET PRB	BULAN	JUMLAH PRB	KEKURANGAN
1	1.757	Januari	572	426
2		Februari	456	
3		Maret	155	
4		April	148	
5		Mei		
6		Juni		
7		Juli		
8		Agustus		
9		September		
10		Oktober		
11		November		
12		Desember		

Grafik Data PRB Rs Prima Husada Sukorejo



A. Analisa

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian PRB belum mencapai standart. Untuk target terbaru tahun 2026 ini adalah 1757. Dengan target per bulan harus 147 pasien. Melihat grafik diatas untuk capaian bulan April sudah tercapai.

B. Rencana Tindak Lanjut

Table Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Meningkatkan angka capaian PRB sesuai dengan target	Memenuhi target PRB	1. Seluruh dokter spesialis 2. Seluruh perawat Rawat Jalan	1. Buat pemberitahuan terbaru untuk target PRB tahun 2026 2. Buat alur PRB	1. Dokter spesialis 2. Perawat Rawat Jalan 3. IFRS	1 Bulan

				(ada tanda di ERM untuk pasien potensi PRB) 3. Buat target capaian per DPJP setiap bulannya		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel Pengisian Dokumen Rekam Medis Elektronik oleh DPJP Rawat Jalan April 2026

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	PAM		CPPT	
									%L	%TL	%L	%TL
1	dr. Muhammad Irawan Sp.A.	351	59	51	8	292	290	2	86%	14%	99%	1%
2	dr. Esti Purwaningrum Sp.A.	70	19	16	3	51	51	0	84%	16%	100%	0%
3	dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	298	85	61	24	213	213	0	72%	28%	100%	0%
4	dr Badariyatud Dini Sp.BP-RE	30	16	15	1	14	14	0	94%	6%	100%	0%
5	dr Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	39	26	26	0	13	13	0	100%	0%	100%	0%
6	dr Maria Valentina Evelyn Sp. JP	491	43	38	5	448	448	0	88%	12%	100%	0%
7	dr Yekti Mumpuni Sp.KJ.	63	7	7	0	56	56	0	100%	0%	100%	0%
8	dr. Andika Widiанти Sp.K.J	217	22	22	0	195	195	0	100%	0%	100%	0%
9	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	420	118	117	1	302	301	1	99%	1%	100%	0%
10	dr. Santoso Rahardjo Sp.OG.	320	110	103	7	210	209	1	94%	6%	100%	0%
11	dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	136	26	26	0	110	110	0	100%	0%	100%	0%
13	dr Nurhadhi Sutanto Sp. M	269	49	48	1	220	220	0	98%	2%	100%	0%
14	dr Arianto Prabowo Sp. OT	88	23	23	0	65	65	0	100%	0%	100%	0%
15	dr. I Gede Made Oka Rahaditya Sp. OT	127	26	26	0	101	101	0	100%	0%	100%	0%
16	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	250	51	51	0	199	199	0	100%	0%	100%	0%
17	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	82	25	25	0	57	57	0	100%	0%	100%	0%
18	dr. Novita Maulidiyah Sp.P	290	77	77	0	213	213	0	100%	0%	100%	0%
19	dr Cameleia Diah Setyorini Sp.PD	313	33	33	0	280	280	0	100%	0%	100%	0%
20	dr. Heriyatmo Sp. PD	566	50	50	0	516	516	0	100%	0%	100%	0%
21	dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	550	83	83	0	467	467	0	100%	0%	100%	0%
22	dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	306	24	24	0	282	282	0	100%	0%	100%	0%
23	dr. Ahmad Farid Wajidi Sp.N.	838	100	99	1	738	738	0	99%	1%	100%	0%
24	dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	141	49	48	1	92	92	0	98%	2%	100%	0%
25	dr Ferdyan Rachmat Efendi Sp.U	366	101	101	0	265	262	3	100%	0%	99%	1%
26	dr. Zaki Yamani, Sp. B	186	59	59	0	127	127	0	100%	0%	100%	0%
27	dr. Aditya Purwaka Sp.PD	233	81	81	0	152	152	0	100%	0%	100%	0%

NO	NAMA DOKTER	Σ DRM ALL	PAM			CPPT			KELENGKAPAN			
									PAM		CPPT	
			Σ DRM	L	TL	Σ DRM	L	TL	%L	%TL	%L	%TL
29	dr. Eko Nugroho Sp. FKR	259	25	24	1	234	234	0	96%	4%	100%	0%
31	dr. Erinda Rahma Mulia Sp. FKR	83	10	10	0	73	73	0	100%	0%	100%	0%
32	dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	305	18	18	0	287	287	0	100%	0%	100%	0%
33	dr. Ardityo Rahmat Ard hany Sp.PD-KGH	164	48	48	0	116	116	0	100%	0%	100%	0%
34	dr. Latifah Sp.M	176	39	39	0	137	136	1	100%	0%	99%	1%
35	dr. Rachmawati Wardani Sp. N.	95	20	20	0	75	75	0	100%	0%	100%	0%
36	dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	240	85	85	0	155	155	0	100%	0%	100%	0%
37	dr. Agung Wijaya Kusuma, Sp.OG	173	53	53	0	120	120	0	100%	0%	100%	0%
38	dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD	136	36	36	0	100	100	0	100%	0%	100%	0%
39	dr. Dion Setiawan, Sp.JP	197	53	52	1	144	144	0	98%	2%	100%	0%
40	dr. Julian Hartawan Wijaya, Sp. T.H.T.K.L	70	53	53	0	17	17	0	100%	0%	100%	0%
41	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE	231	84	82	2	147	147	0	98%	2%	100%	0%
42	dr.Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	37	20	16	4	17	17	0	80%	20%	100%	0%
43	dr. Sefrina Trisadi Sp.DV	3	2	2	0	1	0	1	100%	0%	0%	100%
44	dr. Kristia Fahmi Sp. P	36	16	16	0	20	20	0	100%	0%	100%	0%
45	dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE (ES)	24	3	2	1	21	19	2	67%	33%	90%	10%
46	dr. Ardityo Rahmat Ard hany Sp.PD-KGH (HD)	110	1	1	0	109	109	0	100%	0%	100%	0%
47	drg. Syafrini Farrahdebi	20	10	10	0	10	10	0	100%	0%	100%	0%
48	dr. Angga Prawira Purwanto, Sp.B	115	45	7	38	70	13	57	16%	84%	19%	81%
49	dr. Nurdiana Rahmadani	30	0	0	0	30	0	30	0%	0%	0%	100%
50	dr. Achmad Fauzan Ailani	1	0	0	0	1	0	1	0%	0%	0%	100%
51	dr. Wahyu Firmansyah	1	0	0	0	1	0	1	0%	0%	0%	100%
52	dr. Tamara Aulia Fakhri n nisa	68	30	14	16	38	14	24	47%	53%	37%	63%
53	dr. Mohammad Ilyas Febri	14	0	0	0	14	0	14	0%	0%	0%	100%
54	dr. Moch Dicky Wahyu Irawan	16	0	0	0	16	0	16	0%	0%	0%	100%
TOTAL		9784	1998	1891	107	7786	7548	238	94,6%	5,7%	96,9%	3,2%
				1998			7786					

A. Analisa
 Berdasarkan Tabel 3.9 diatas menunjukkan adanya pengisian ERM yang belum lengkap di pengkajian medis DPJP dibagian tolak ukur, tanda tangan pasien, tanda tangan dokter.

B. Masalah

Problem	Ketidaklengkapan pengisian ERM rawat jalan di pengkajian medis DPJP bagian tanda tangan pasien, tolak ukur dan tanda tangan dokter.
Step	Perbaiki kualitas pengisian rekam medis elektronik (ERM)
Plan	1. Rencana: Perbaiki kualitas pengisian rekam medis elektronik 2. Harapan Kelengkapan pengisian ERM 100 % 3. Tindakan a. Lakukan audit harian ERM acak untuk DPJP b. Sosialisasi kembali standart pengisian ERM c. Koordinasi dengan IT PT agar pengisian yang tidak lengkap tidak dapat menuju pengisian step berikutnya
Do	1. Kirim daftar temuan tidak lengkap kepada DPJP setiap minggu 2. Koordinasi dengan perawat untuk bantu memastikan tanda tangan pasien terisi sebelum pasien meninggalkan ruang rawat
Study	1. Bandingkan data kelengkapan ERM minggu ke 0 dan minggu ke 2 2. Evaluasi feed back dari dokter terkait kendala sistem atau teknis
Action	1. Terapkan reminder dan pelaporan rutin ke semua dokter 2. Adakan pelatihan ulang pengiisan ERM 3. Masukkan ke dalam evaluasi kinerja terkait ketidak lengkapan ERM irja

C. Rencana Tindak Lanjut

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

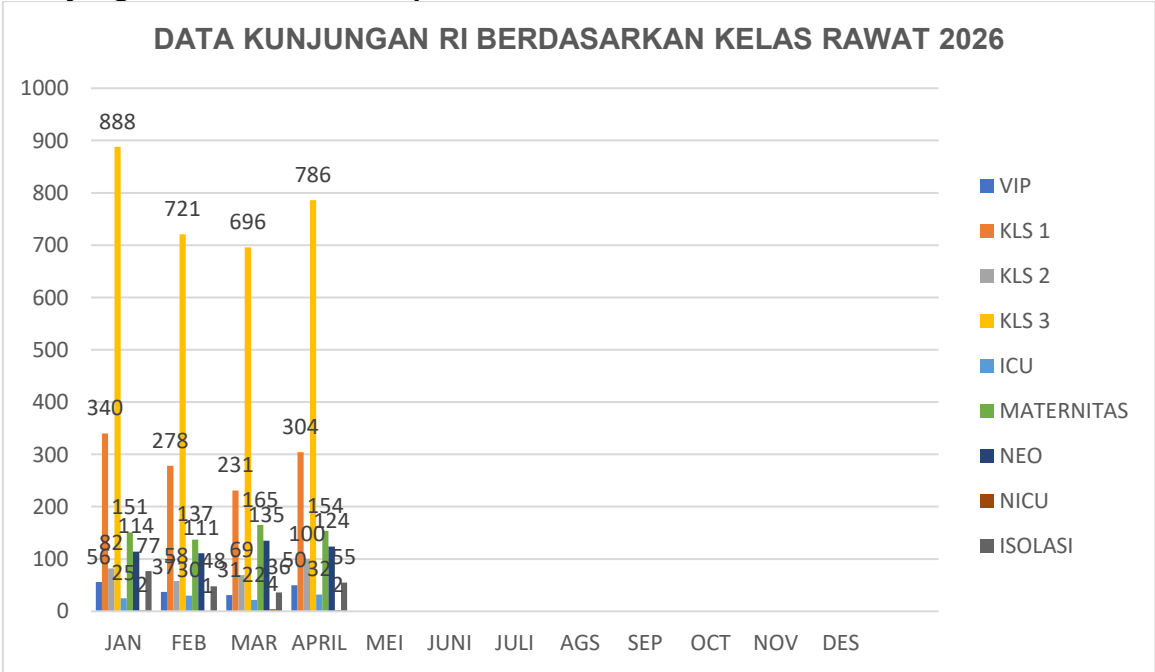
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Meningkatkan kelengkapan ERM	Meningkatkan kelengkapan pengisian ERM menjadi ≥90% dalam waktu 1 bulan	Seluruh dokter spesialis	1. Terapkan reminder dan pelaporan rutin ke semua dokter 2. Adakan pelatihan ulang pengiisan ERM 3. Masukkan ke dalam evaluasi kinerja terkait ketidak lengkapan ERM irja	1. Dokter spesialis 2. RM	1 Bulan

3.3.2 Rawat Inap

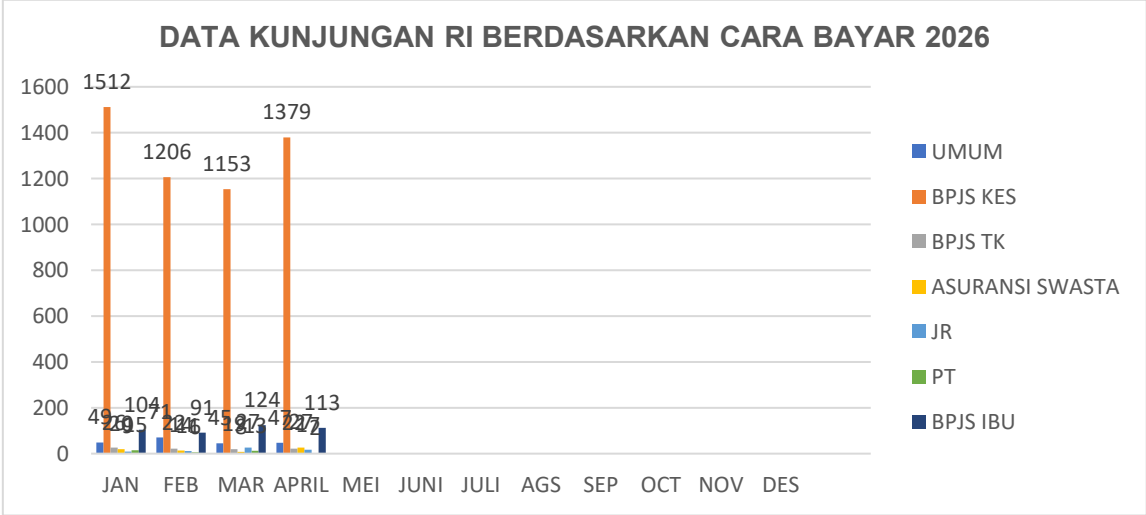
A. Tabel Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar 2026

No	Kelas Perawatan	Jumlah Pasien								
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	JR	PT	BPJS Iktu Ibu	Total	%
1	VIP	12	21	0	17	0	0	0	50	3.1 %
2	Kelas 1	4	295	0	2	0	0	0	304	2.1 %
3	Kelas 2	4	67	22	5	3	0	0	100	6.2 %
4	Kelas 3	20	753	0	0	2	2	0	786	48.9 %
5	ICU	2	30	0	0	11	0	0	32	1.9 %
6	Maternitas	3	150	0	1	0	0	0	154	9.5 %
7	Neonatologi	1	9	0	1	0	0	113	124	7.7 %
8	NICU	0	2	0	0	0	0	0	2	0.12 %
9	Isolasi	1	52	0	1	1	0	0	55	3.4 %
TOTAL		47	1379	22	27	17	2	113	1607	100 %

B. Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Kelas Rawat 2026



Grafik unjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar 2026



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa:

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan jumlah pasien di bulan April 2026 sebanyak 1607 pasien. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan bulan Maret sebanyak 1389 pasien, naik sebanyak 2.18 %.

Masalah

Problem	Ketidakpatuhan DPJP dalam melakukan visite terlebih di tanggal merah dan weekend
Step	Angka kepatuhan visite meningkat
Plan	1. Rencana: a. Menganalisa penyebab dengan 4M dan 1E 2. Harapan DPJP visite sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Tindakan a. Membuat edaran terkait visite b. Mensosialisasikan edaran yang berlaku serta kebijakan yang mendukung
Do	1. Sosialisasi secara door to door kepada masing-masing DPJP terkait aturan visite sesuai dengan edaran yang berlaku dari RS
Study	1. Monitoring jumlah pasien yang tidak dilakukan visite di hari weekend atau pun tanggal merah 2. Monitoring jumlah pasien yang tidak dilakukan visite sekalipun di titipkan ke SMF lainnya 3. Evaluasi kenapa kejadian berulang untuk visite yang tidak dilakukan ke pasien
Action	1. Menetapkan surat edaran beserta kebijakan sebagai peraturan tetap 2. Melakukan monitoring rutin 3. Memberikan umpan balik kepada DPJP bila ditemukan ketidakpatuhan 4. Melakukan evaluasi berkala

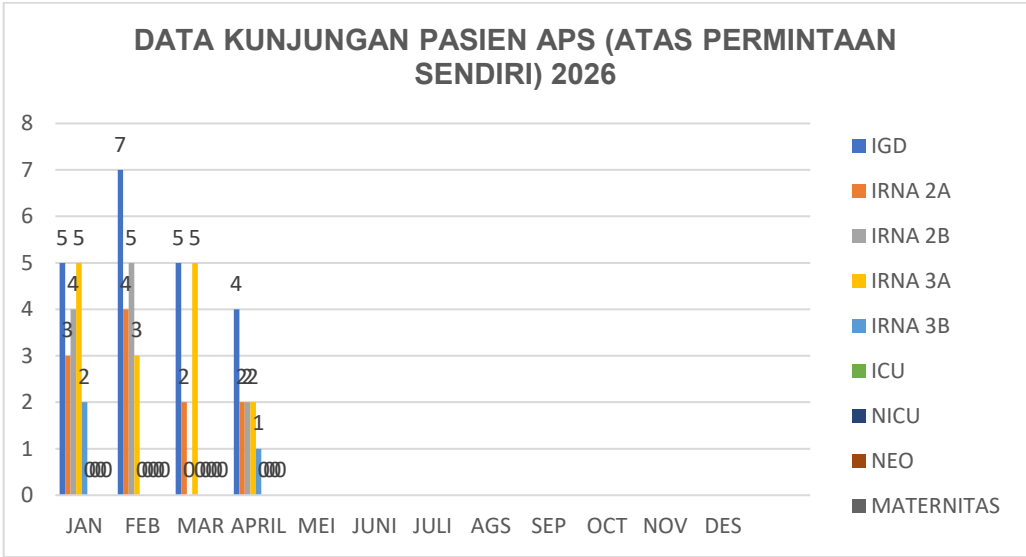
Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Sosialisasi edaran terbaru terkait visite	Angka kepatuhan visite meningkat	DPJP Ruang rawat inap	1. Sosialisasi surat edaran yang berlaku terkait visite kepada DPJP 2. Memberikan opsi jika DPJP berhalangan hadir visite 3. Memberikan umpan balik di OPPE DPJP terkait kepatuhan dalam visite pasien	DPJP	1 bulan

Laporan Pasien APS

No	UNIT	BULAN JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	5	7	5	4								
2	IRNA 2A	3	4	2	2								
3	IRNA 2B	4	5	0	2								
4	IRNA 3A	5	3	5	2								
5	IRNA 3B	2	0	0	1								
6	ICU	0	0	0	0								
7	NICU	0	0	0	0								
8	NEO	0	0	0	0								
9	MATERNITAS	0	0	0	0								

Grafik Pasien APS (Atas Permintaan Sendiri) April 2026



Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2026

Tabel 3.14.Jumlah Kunjungan IRNA Bulan April Tahun 2026

NAMA SMF	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	%
Anak	481	349	315	324									↑ 0.09%
Bedah Umum	234	154	118	193									↑ 0.75%
Bedah Plastik	13	12	16	14									↓ 0.02%
Bedah Syaraf	6	18	15	30									↑ 0.15%
Jantung	29	29	34	29									↓ 0.05%
Jiwa	0	0	1	0									↓ 0.01%
Kandungan	151	138	165	157									↓ 0.08%
Kulit Dan Kelamin	4	5	2	0									↓ 0.02%
Mata	28	15	1	23									↑ 0.22%
Orthopedi	62	65	84	76									↓ 0.08%
Paru	111	87	127	147									↑ 0.2%
Penyakit Dalam	374	351	277	377									↑ 1%
PD-KGH			76	0									↓ 0.07%
Syaraf	163	128	97	134									↑ 0.37%
Urologi	58	60	51	15									↓ 0.36%
THT	21	10	10	88									↑ 0.78%
TOTAL	1735	1421	1389	1607									↑ 2.18%

Tabel Jumlah Kunjungan IRNA Berdasarkan DPJP Bulan April Tahun 2026

No	SMF	Nama DPJP	April	Persentase
1	Anak	dr. Ratih Kusumawardani Sp.A, M.Biomed	120	7.4%
2		dr. Muhammad Irawan, Sp. A	113	7.03%
3		dr. Esti Purwaningrum, Sp. A	54	3.3%
4		dr. Qashastia Sukma Paripurna, Sp.A	37	2.3%
5	IPD	dr. Cameliea Diah Setyorini, Sp. PD	63	3.9%
6		dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD	61	3.7%
7		dr. Heriyatmo Sp. PD	64	3.9%
8		dr. Aditya Purwaka Sp.PD	69	4.2%
9		dr. Adhya Aji Pratama Sp.PD	42	2.6%
10		dr. Ardityo Rahmat Ardhany Sp.PD-KGH	78	4.8%
11	Syaraf	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	70	4.3%
12		dr. Aan Dwi Prasetyo Sp.N	20	1.2%
13		dr. Akhmad Zainul Arifin Sp.N, M.Kes	25	1.5%
14		dr. Rachmawati Wardani Sp.N	20	1.2%
15	Obgyn	dr. Rudi Priyo Utomo Sp.OG	77	4.7%
16		dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG	51	3.1%
17		dr. Agung Wijaya Kusuma Sp.OG	28	1.7%
18	Bedum	dr. Angga Prawira Purwanto Sp.B	45	2.8%
19		dr. Zaki Yamani Sp.B	59	3.6%
20		dr. Djanuar Fitriadi Sp.B	87	5.4%
21	Paru	dr. Fitri Indahyanti Sp.P., MMRS	23	1.4%
22		dr. Novita Maulidiyah, Sp. P	100	6.2%
23		dr. Kristia Fahmi, Sp. P	24	1.4%
24	Orthopedi dan Traumatologi	dr. Fiski Purantoro Sp.OT	36	2.2%
25		dr. I Gede Oka Rahaditya, Sp. OT	16	0.9%
26		dr. Arianto Prabowo Sp. OT	27	1.6%
27		dr. Dion Setiawan Sp.JP	13	0.8%
28	Jantung Pembuluh Darah	dr. Maria Valentina Evelyn, Sp. JP	16	0.9%
29	Urologi	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp. U	88	5.4%
30	Bedah Plastik	dr. Badariyatud Dini, Sp. BP-RE	14	0.8%
31	Bedah Syaraf	dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi Sp, BS	30	1.8%
32	THT	dr. Julian Hartawan Wijaya Sp.T.H.T.B.K.L	3	0.1%
33		dr. Fuad Fauzi Sp.T.H.T.K.L.	11	0.6%
34	Mata	dr. Latifah Sp.M	12	0.7%
35		dr. Nyoman Indra Bayu Sp.M	0	
36		dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M	0	
37	DVE	dr. Riski Bagus Suhendra Sp.DVE	0	
Total			1607	100%

Analisis :

- a. Kunjungan IRNA terbanyak di Bulan Maret 2026 adalah Anak sejumlah 315 pasien dengan DPJP terbanyak yaitu dr. Aditya Purwaka Sp.PD dengan jumlah 107 pasien.
- b. Kunjungan IRNA secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0.32% jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 dengan jumlah kunjungan sebanyak 1421, sementara bulan Maret sebanyak 1389

Data Pasien Rawat Inap Rujuk

Tabel Data Pasien Rawat Inap Rujuk Bulan April 2026

No	Indikator RS	Bulan JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	30	35	45	26								
2	IRNA 2A	9	7	4	4								
3	IRNA 2B	8	5	4	3								
4	IRNA 3A	4	8	2	1								
5	IRNA 3B	3	3	1	1								
6	ICU	0	1	1	1								
7	NICU	5	3	5	4								
8	NEO	0	0	0	0								
9	MATERNITAS	0	0	0	1								

Grafik Pasien Rujuk Januari 2026

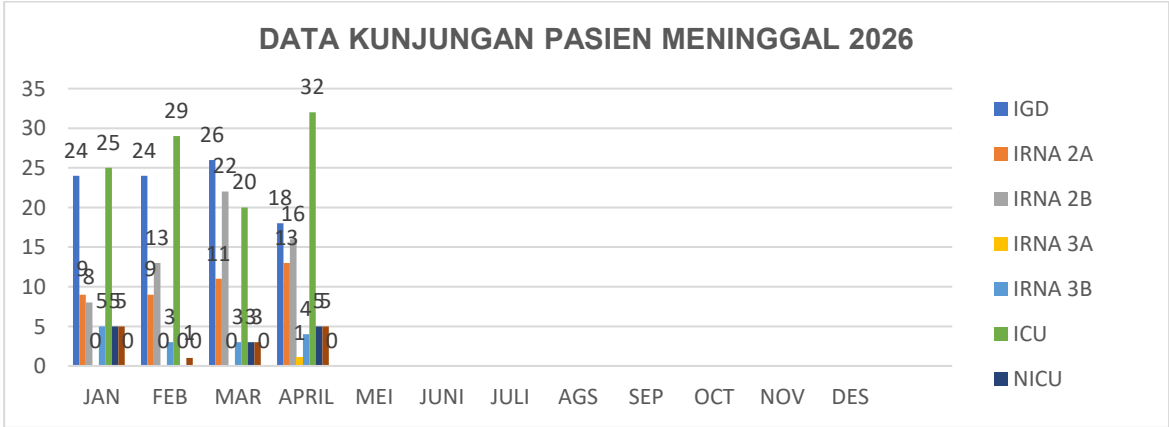


Pasien Meninggal di Rawat Inap

Tabel Pasien Meninggal di Rawat Inap 2026

No	Indikator RS	Bulan JANUARI-DESEMBER											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	IGD	24	24	26	18								
2	IRNA 2A	9	9	11	13								
3	IRNA 2B	8	13	22	16								
4	IRNA 3A	0	0	0	1								
5	IRNA 3B	5	3	3	4								
6	ICU	25	29	20	32								
7	NICU	5	0	3	5								
8	NEO	5	1	3	5								
9	MATERNITAS	0	0	0	0								

Grafik Pasien Meninggal Tahun 2026



Permasalahan Unit
Tabel Permasalahan Rawat Inap April 2026

IRNA 3A	
Problem	Kejadian pemberian obat oleh Farmasi saat sertim dengan perawat yang tidak sesuai dengan etiket
Step	Peningkatan Ketepatan Pemberian dan Serah Terima Obat antara Farmasi dan Perawat
Plan	1. Rencana: Melakukan Analisa penyebab a. Man - Kurangnya ketelitian petugas farmasi dan perawat - Double check belum dilakukan secara optimal - Beban kerja tinggi pada jam sibuk b. Method - Belum ada standar serah terima obat yang baku - Checklist verifikasi obat belum digunakan c. Machine - Printer etiket kurang jelas atau error - SIMRS terkadang mengalami kendala d. Material - Etiket mudah rusak/lepas - Tulisan etiket kurang terbaca e. Environment - Serah terima dilakukan terburu-buru - Gangguan komunikasi saat distribusi obat 2. Harapan a. Penurunan kejadian ketidaksesuaian etiket obat $\geq 90\%$ b. Kepatuhan double check obat mencapai $\geq 95\%$ c. Tidak terjadi medication error akibat kesalahan etiket d. Peningkatan keselamatan pasien 3. Tindakan a. Pelatihan komunikasi efektif & komunikasi terapeutik untuk perawat b. Implementasi standar 3S (Senyum, Salam, Sapa) c. Membuat SOP respon pasien (misal: respon ≤ 5 menit) d. Monitoring penggunaan call bell e. Supervisi kepala ruang (rounding harian) f. Pemberian reward & punishment berbasis kinerja pelayanan
Do	1. Review dan sosialisasi kembali SOP serah terima obat 2. Double check oleh petugas farmasi dan perawat 3. Pengawasan oleh kepala instalasi farmasi dan kepala ruangan 4. Monitoring harian kejadian ketidaksesuaian obat
Study	1. Hasil monitoring a. Penurunan kejadian ketidaksesuaian etiket b. Peningkatan kepatuhan double check c. Komunikasi farmasi dan perawat lebih baik d. Tidak ditemukan medication error selama periode evaluasi 2. Indikator evaluasi a. Ketidaksesuaian etiket obat 0 kejadian b. Kepatuhan double check $\geq 95\%$ c. Kepatuhan checklist $\geq 90\%$ d. Medication error akibat etiket 0 kejadian
Action	1. Menetapkan SOP serah terima obat sebagai prosedur tetap 2. Melakukan audit berkala ketepatan etiket obat 3. Evaluasi rutin kejadian medication error 4. Pembinaan petugas yang tidak patuh terhadap double check 5. Perbaikan sistem cetak etiket dan SIMRS 6. Menjadikan ketepatan serah terima obat sebagai indikator mutu
IRNA 3B	
Problem	Layanan Farmasi untuk pasien KRS lama
Step	Peningkatan Kecepatan Pelayanan Farmasi pada Pasien KRS

Plan	1. Rencana: Analisa penyebab a. Man - SDM farmasi terbatas pada jam sibuk - Petugas belum melakukan prioritas resep KRS b. Method - Belum ada alur percepatan resep KRS - Resep pulang dikirim mendadak c. Machine - SIMRS lambat/error - Printer etiket sering terlambat d. Material - Ketersediaan obat tertentu tidak langsung siap e. Environment - Lonjakan resep pada sore dan malam hari - Komunikasi antar unit kurang efektif 2. Harapan a. Waktu tunggu obat pasien KRS ≤ 60 menit b. Penurunan komplain pasien terkait farmasi $\geq 50\%$ c. Kepatuhan pelayanan resep KRS prioritas $\geq 90\%$ d. Kepuasan pasien meningkat 3. Tindakan a. Membuat alur prioritas resep pasien KRS b. Dokter menyiapkan resep pulang lebih awal c. Pemberian tanda khusus pada resep KRS d. Optimalisasi komunikasi ruangan–farmasi e. Monitoring waktu pelayanan resep f. Edukasi pasien terkait estimasi waktu pelayanan
Do	1. Sosialisasi alur percepatan resep KRS 2. Implementasi label “PRIORITAS KRS” pada resep 3. Farmasi memproses resep KRS lebih dahulu 4. Monitoring waktu mulai resep diterima hingga obat diserahkan 5. Edukasi petugas mengenai pelayanan prima
Study	1. Hasil monitoring a. Waktu tunggu obat pulang menurun b. Komplain pasien berkurang c. Koordinasi ruangan dan farmasi lebih baik d. Pasien lebih memahami proses pelayanan 2. Indicator evaluasi a. Waktu tunggu obat KRS ≤ 60 menit b. Penurunan complain $\geq 50\%$ c. Kepatuhan prioritas resep KRS $\geq 90\%$ d. Kepuasan pasien $\geq 85\%$
Action	1. Menetapkan alur prioritas resep KRS sebagai prosedur tetap 2. Evaluasi rutin waktu pelayanan farmasi 3. Penambahan SDM pada jam sibuk bila diperlukan 4. Penguatan koordinasi DPJP–ruangan–farmasi 5. Pengembangan sistem notifikasi resep KRS di SIMRS 6. Audit kepatuhan pelayanan resep prioritas
IRNA 2A	
Problem	Kejadian komplek pasien terhadap pelayanan pasien KRS pada malam hari di Rawat Inap
Step	Peningkatan Mutu Pelayanan Pasien Pulang (KRS) pada Malam Hari
Plan	2. Rencana: a. Melakukan Analisa penyebab komplek dengan melihat 4 E dan 1 E 3. Harapan a. Penurunan komplek dan peningkatan angka kepuasan pasien b. Waktu tunggu proses KRS ≤ 60 menit

	4. Tindakan a. Membuat alur percepatan KRS malam hari b. Review checklist persiapan pasien pulang c. DPJP menginstruksikan rencana pulang lebih awal d. Koordinasi cepat melalui grup komunikasi antar unit e. Edukasi pasien dan keluarga mengenai estimasi proses KRS f. Monitoring waktu tunggu pasien pulang
Do	1. Sosialisasi alur KRS malam kepada perawat, farmasi, dan administrasi 2. Implementasi checklist kesiapan pasien pulang 3. Farmasi menyiapkan obat pulang lebih awal 4. Perawat melakukan edukasi sebelum proses administrasi selesai 5. Monitoring harian waktu tunggu pasien KRS malam
Study	1. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah 2. Analisa hasil
Action	1. Menetapkan alur KRS malam sebagai prosedur tetap 2. Evaluasi rutin setiap bulan 3. Penambahan monitoring oleh kepala ruangan 4. Penguatan koordinasi dengan farmasi dan administrasi 5. Pengembangan sistem notifikasi KRS di SIMRS 6. Reward unit dengan waktu pelayanan terbaik
IRNA 2B	
Problem	Perbaikan dalam uraian tugas Kepala Tim Jaga dan Perawat Penanggung Jawab Asuhan
Step	Optimalisasi Uraian Tugas Kepala Tim Jaga dan Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA) dalam Pelayanan Keperawatan
Plan	1. Rencana: Menganalisa penyebab berdasarkan a. Man - Pemahaman petugas terhadap job description belum merata - Kurangnya sosialisasi tugas dan tanggung jawab b. Method - Uraian tugas belum diperbarui sesuai kebutuhan pelayanan - Belum ada monitoring evaluasi pelaksanaan tugas c. Machine - Dokumentasi elektronik belum dimanfaatkan maksimal d. Material - Belum tersedia panduan tugas yang mudah dipahami e. Environment - Beban kerja tinggi menyebabkan pelaksanaan tugas tidak optimal 2. Harapan a. Kepatuhan pelaksanaan uraian tugas $\geq 90\%$ b. Penurunan miss komunikasi antar petugas $\geq 50\%$ 3. Tindakan a. Review dan revisi uraian tugas Kepala Tim Jaga dan PPJA b. Menyusun pembagian tugas yang jelas dan terukur c. Sosialisasi uraian tugas kepada seluruh perawat d. Membuat checklist monitoring pelaksanaan tugas e. Supervisi rutin oleh kepala ruangan f. Evaluasi pelaksanaan tugas setiap bulan
Do	1. Melakukan review dan revisi uraian tugas 2. Sosialisasi kepada seluruh petugas keperawatan 3. Implementasi pembagian tugas sesuai revisi 4. Kepala ruangan melakukan supervisi harian 5. Monitoring kepatuhan dokumentasi dan komunikasi pelayanan
Study	1. Hasil monitoring a. Pemahaman petugas terhadap tugas meningkat b. Koordinasi antar perawat lebih baik

	c. Dokumentasi asuhan keperawatan lebih lengkap d. Penurunan kejadian miss komunikasi 2. Indicator evaluasi a. Kepatuhan uraian tugas $\geq 90\%$ b. Kelengkapan dokumentasi $\geq 95\%$ c. Penurunan miss komuniaksi $\geq 90\%$supervisi terlaksana 100%
Action	1. Menetapkan uraian tugas revisi sebagai pedoman resmi 2. Melakukan evaluasi dan revisi berkala sesuai kebutuhan pelayanan 3. Menjadikan monitoring uraian tugas sebagai indikator mutu ruangan 4. Memberikan pembinaan kepada petugas yang belum patuh 5. Mengintegrasikan uraian tugas ke dalam orientasi pegawai baru 6. Melakukan audit dokumentasi dan komunikasi secara rutin

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

A. Tabel Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2026

No	Cara Bayar	Target	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jumlah	Prosentase
1	Umum	0	4	2	2											Tetap
2	BPJS Kes	37	34	29	42											$\uparrow 0.13\%$
3	BPJS TK	0	0	0	0											Tetap
4	Asuransi Swasta	2	2	1	0											$\downarrow 0.01\%$
5	JR	0	0	0	0											Tetap
6	Perusahaan	0	0	0	0											Tetap
TOTAL		39	40	32	44											$\uparrow 1,1\%$

B. Grafik Kunjungan Pasien ICU Berdasarkan Cara Bayar 2025



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa:
Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan terjadi kenaikan pasien di bulan April 2026 sebanyak 0.12% jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 sebanyak 32 pasien.

Masalah

Problem	Ditemukan ketidaksesuaian Tindakan pemasangan intubasi dengan jam perintah pemasangan oleh anastesi
Step	Peningkatan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemasangan Intubasi Sesuai Instruksi Dokter Anastesi
Plan	1. Rencana: Identifikasi masalah a. Man - Petugas kurang memahami urgensi instruksi intubasi - Komunikasi antar tim belum efektif - Pergantian shift menyebabkan informasi tidak tersampaikan optimal

	b. Method - Belum ada alur respon cepat instruksi intubasi - Dokumentasi waktu perintah dan tindakan belum distandardisasi c. Machine - Ketersediaan alat intubasi tidak selalu siap - Kendala komunikasi melalui tepelon / alat komunikasi d. Material Peralatan emergensi tidak lengkap pada saat dibutuhkan e. Environment - Kondisi IGD / ICU ramai - Beban kerja tinggi menyebabkan keterlambatan respon 2. Harapan a. Kesesuaian waktu tindakan intubasi dengan instruksi dokter $\geq 95\%$ b. Penurunan keterlambatan tindakan intubasi $\geq 90\%$ c. Kepatuhan dokumentasi waktu tindakan $\geq 100\%$ d. Peningkatan response time tindakan emergensi 3. Tindakan a. Membuat alur respon cepat tindakan intubasi b. Standarisasi dokumentasi jam instruksi dan jam tindakan c. Edukasi komunikasi efektif menggunakan metode SBAR d. Checklist kesiapan alat intubasi setiap shift e. Monitoring response time tindakan emergensi f. Supervisi pelaksanaan dokumentasi oleh kepala ruangan
Do	1. Sosialisasi alur respon cepat intubasi kepada dokter dan perawat 2. Implementasi form monitoring waktu instruksi dan tindakan 3. Pengecekan rutin trolley emergensi dan alat intubasi 4. Simulasi komunikasi emergensi menggunakan SBAR 5. Monitoring harian kejadian keterlambatan tindakan
Study	1. Hasil monitoring a. Kesesuaian waktu tindakan meningkat b. Dokumentasi lebih lengkap dan jelas c. Komunikasi antar petugas efektif d. Kesiapan alat emergensi lebih baik 2. Indicator evaluasi a. Kesesuaian waktu Tindakan $\geq 95\%$ b. Kepatuhan dokumentasi 100% c. Keterlambatan Tindakan $\leq 10\%$ d. Checklist alat emergency lengkap 100%
Action	1. Menetapkan alur respon cepat intubasi sebagai prosedur tetap 2. Audit rutin dokumentasi tindakan emergensi 3. Evaluasi response time setiap bulan 4. Pembinaan petugas yang belum patuh 5. Penguatan handover antar shift menggunakan SBAR 6. Menjadikan response time emergensi sebagai indikator mutu unit

Rencana Tindak Lanjut

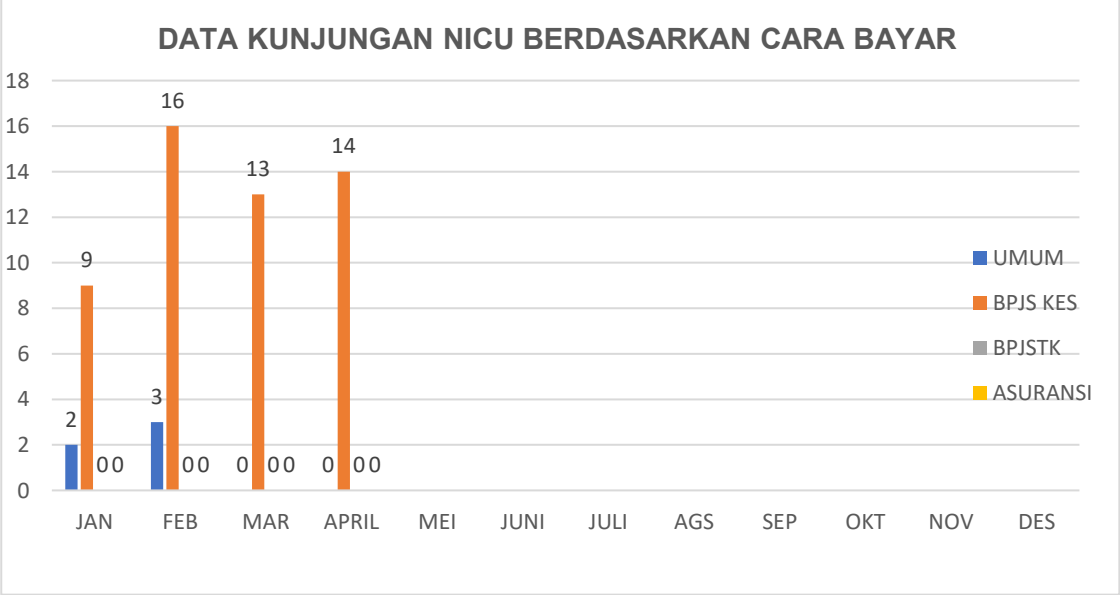
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Review system komunikasi efektif menggunakan SBAR yang mencantumkan intruksi focus dibagian perintah dan pelaksanaan	Memastikan tidak jeda waktu yang lama antara perintah dan pelaksanaan	DPJP Dokter jaga Dokter konsulan Dokter anastesi Perawat ICU Perawat IGD Perawat Rawat Inap	1. Review SPO pelalporan dengan metode SBAR serta pendokumentasiannya 2. Review SPO komunikasi efektif antar unit	Perawat DPJP Dokter jaga Dokter Anastesi	1 Bulan

3.3.4 NICU

A. Tabel Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2026

N o	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	%
1	Umum	2	3	0	0									Tetap
2	BPJS Kes	9	16	13	14									↑ 0.01%
3	Asuransi Swasta	0	0	0	0									Tetap
4	Perusahaan	0	0	0	0									Tetap
TOTAL		11	19	13	14									↑ 0.01%

B. Grafik Kunjungan Pasien NICU Berdasarkan Cara Bayar 2026



C. Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

Analisa :
Berdasarkan hasil rekap kunjungan NICU dibulan April meningkat jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026 sebanyak 14 pasien. Peningkatan sebanyak 0.01%.

Masalah	
Problem	Peraturan baru tentang bayi baru lahir dengan DPJP dan penjamin
Step	Tidak ada komplemen terkait peraturan baru
Plan	1. Rencana a. Mengidentifikasi akar permasalahan 2. Harapan Tidak ada komplemen dari DPJP Anak dan Obygn 3. Tindakan a. Sosialisasi peraturan baru ke semua DPJP Anak dan Obygn b. Membuat alur atau SPO terkait hal baru ini c. Sosialisasi alur dan SPO yang baru
Do	1. Implementasi SOP baru di ruang bersalin dan rawat gabung 2. Melakukan koordinasi aktif saat setiap persalinan
Study	1. Audit RM 2. Evaluasi kendala
Action	1. Revisi SPO/ alur pelayanan 2. Menetapkan sebagai standar pelayanan tetap 3. Monitoring berkala

Rencana Tindak Lanjut

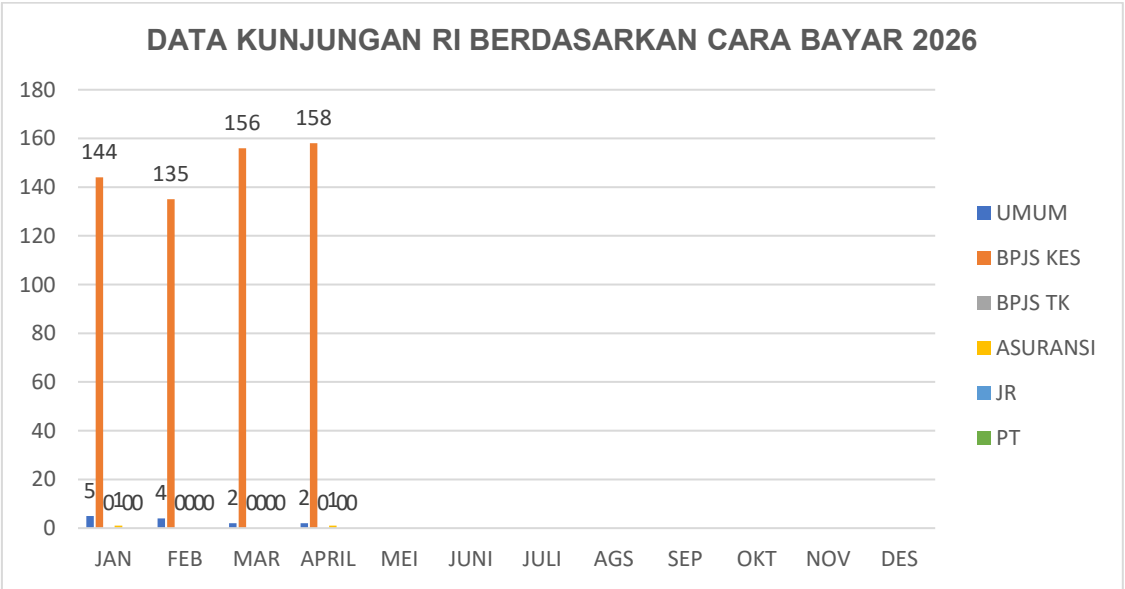
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Sosialisasi kebijakan baru terkait bayi baru lahir	Tidak ada komplemen dari DPJP Anak dan Obygn	DPJP Anak DPJP Obygn Perawat NICU dan Neo Bidan Maternitas	1. Sosialisasi kebijakan baru kepada seluruh DPJP Anka dan Obyn 2. Membuat alur baru terkait penanggung jawab bayi baru lahir	Perawat Neo dan NICU	1 bulan

1.3.2. KINERJA MATERNITAS

Tabel Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar April 2026

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	%
1	Umum	5	4	2	2									Tetap
2	BPJS Kes	144	135	156	158									↑ 0.02%
3	BPJS TK	0	0	0	0									Tetap
4	Asuransi Swasta	1	0	0	1									↑ 0.01%
5	JR	0	0	0	0									Tetap
6	Perusahaan	0	0	0	0									Tetap
TOTAL		150	139	158	161									↑ 0.03%

Grafik Kunjungan Pasien Maternitas Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026



A. Analisa
Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pasien di bulan April 2026 sebanyak 3 pasien dibandingkan dengan bulan Maret 2026 dengan jumlah total pasien 158. Kenaikan sebanyak 0.03%.

B. Masalah	
Problem	Kejadian DPJP lupa untuk schedule pasien Curatage
Step	Tidak ada kejadian DPJP lupa schedule tindakan
Plan	1. Rencana a. Menganalisa penyebab masalah 2. Harapan a. Meningkatkan kepatuhan penjadwalan tindakan curatage oleh DPJP. b. Mengurangi keterlambatan tindakan akibat tidak terjadwal. c. Meningkatkan koordinasi antar petugas pelayanan 3. Tindakan a. Membuat checklist rencana Tindakan dan di share di grub koordinasi unit b. Membuat reminder secara berkala kepada DPJP
Do	1. Membuat checklist penjadwalan tindakan curatage di ruangan. 2. Perawat melakukan konfirmasi ulang kepada DPJP setelah advis tindakan diberikan. 3. Rawat inap mencatat pasien yang memerlukan tindakan dalam buku monitoring atau grup koordinasi. 4. Membuat pengingat melalui sistem EMR/WhatsApp/grup pelayanan. 5. Melakukan edukasi kepada DPJP dan petugas terkait pentingnya ketepatan scheduling tindakan
Study	1. Monitoring jumlah kejadian pasien belum terjadwal setelah advis tindakan. 2. Audit checklist penjadwalan setiap minggu. 3. Evaluasi waktu antara advis DPJP dan jadwal tindakan. 4. Mengumpulkan laporan kendala dari bidan dan DPJP.
Action	1. Menetapkan checklist scheduling sebagai prosedur tetap ruangan. 2. Mengoptimalkan penggunaan reminder elektronik/manual. 3. Melakukan briefing rutin terkait koordinasi tindakan. 4. Jika masih ditemukan kejadian, dilakukan revisi alur komunikasi dan monitoring lebih ketat oleh kepala ruangan/penanggung jawab pelayanan

C. Rencana Tindak Lanjut
Tabel Rencana Tindak Lanjut

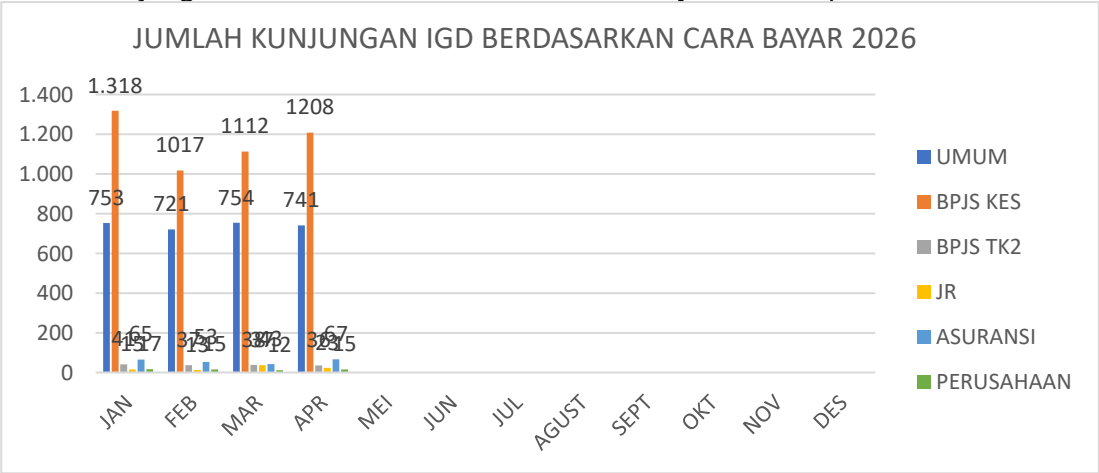
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Peningkatan Kepatuhan Waktu Tindakan Curatage	Tidak ada kejadian DPJP lupa scedule Curatage	1. Seluruh staf di Maternitas 2. DPJP OG	1. Membuat checklist rencana Tindakan hari ini 2. Buat reminder secara berkala kepada DPJP	1. Seluruh staf di Maternitas 2. DPJP OG	1 bulan

1.3.3. KINERJA IGD

Tabel Jumlah Kunjungan IGD Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026

Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	%
Umum	753	721	754	741									↓ 0.13%
BPJS Kes	1318	1017	1112	1208									↑ 0.96%
BPJS TK	41	37	38	36									↓ 0.02%
JR	15	13	37	23									↓ 0.14%
Asuransi	65	53	43	67									↑ 0.24%
Perusahaan	17	15	12	15									↑ 0.03%
Jumlah	2209	1856	1996	2091									↑ 0.95%

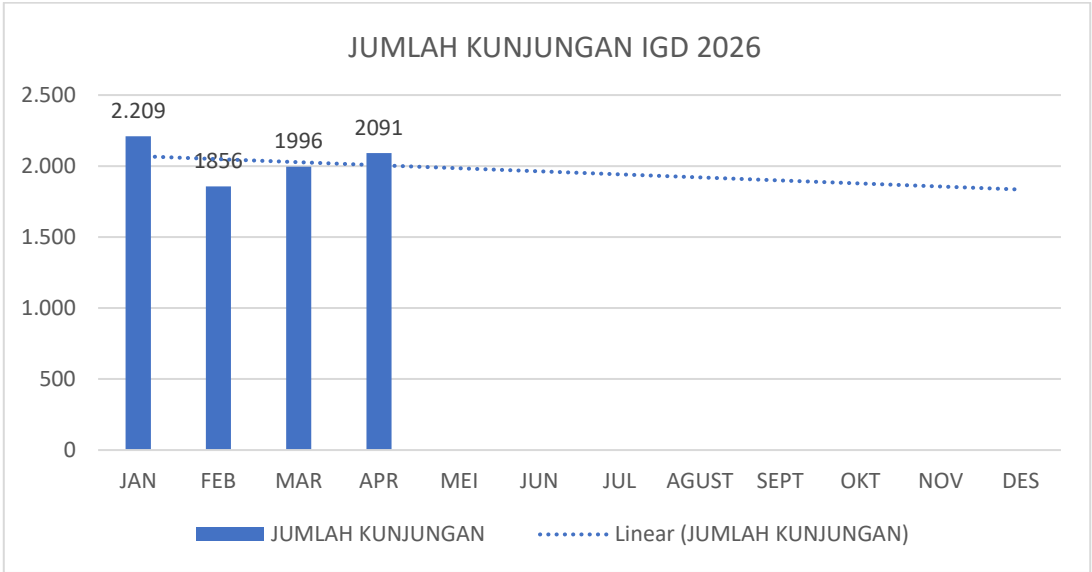
Grafik Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026



Tabel Kunjungan Pasien IGD Bulan April 2026

No	Bulan	Jumlah Kunjungan
1	Januari	2209
2	Februari	1856
3	Maret	1996
4	April	2091
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	October	
11	November	
12	Desember	

Grafik Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Jumlah Kunjungan Bulan April 2026



Analisa

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan kenaikan pasien di bulan April sebanyak 0.95% dibanding dengan bulan Maret 2026 yaitu sebanyak 1996 pasien

Tabel Jumlah Kunjungan IGD per Dokter Jaga Bulan April 2026

No	Nama Dokter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	%
1	Achmad Fauzan Aliani	65	51	50	56									0.06%
2	Tania Calista	262	231	245	264									0.19%
3	Fina Jazilah Rizkiyah	191	136	0	0									Tetap
4	Nejoa Ermaq Fatreciano	282	216	220	0									2.2%
5	Wahyu Firmansyah	230	185	209	242									0.33%
6	Mohammad Ilyas Febri	332	271	345	281									0.64%
7	Moch. Dicky Wahyu Irawan	219	236	340	265									0.75%
8	Nurdiana Rahmadani	295	265	265	254									0.11%
9	Ahmad Akbar Ridho Mustawa	333	265	322	263									0.59%
10	Moch. Choiruz Zaman	0	0	0	119									1.19%
11	Yuriansyah Dwi Rahmaputra	0	0	0	148									0.48%
Total		2.209	1.856	1.996	2.091									0.95%

Tabel Angka Keterlambatan Dokter Jaga IGD Bulan April 2026

NO	Nama Dokter	Jumlah Kehadiran	Keterlambatan	Tidak Terlambat	% Terlambat
1	dr. Achmad Fauzan Ailani	4	4	0	100%
2	dr. Mohammad Ilyas Febri Pitoyo	20	17	3	85%
3	dr. Wahyu Firmansyah	18	18	0	100%
4	dr. Tania Calista	21	21	0	100%
5	dr. Moch. Dicky Wahyu Irawan	18	18	0	100%
6	dr. Nurdiana Rahmadani	18	18	0	100%
7	dr. Ahmad Akbar Ridho Mustawa	18	18	0	100%
8	dr. Yuriansyah Dwi Rahmaputra	17	17	0	100%
9	dr. Moch. Choiruz Zaman	18	18	0	100%

A. Permasalahan Unit

Tabel Permasalahan IGD April 2026

IGD	
Problem	Waktu tunggu pasien di IGD masih belum mencapai standart
Step	Menurunkan waktu tunggu di iGD
Plan	1. Rencana a. Menganalisa oenyebab dari 4M dan 1E 2. Harapan a. Mempercepat waktu tunggu pelayanan pasien di IGD. b. Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. c. Mengoptimalkan alur pelayanan pasien IGD. 3. Tindakan a. Review pembagian jaga dengan melihat tupoksi b. Review cara pelaporan pasien baru kepada DPJP
Do	1. Melakukan evaluasi dan penguatan sistem triase IGD. 2. Membuat alur cepat untuk kasus non-komplikasi dan kegawatdaruratan tertentu. 3. Mengatur redistribusi SDM pada jam kunjungan padat. 4. Memastikan dokter jaga dan perawat standby sesuai jadwal. 5. Mempercepat proses administrasi melalui penggunaan EMR/simplifikasi formulir. 6. Membuat monitoring waktu tunggu pasien setiap shift. 7. Melakukan koordinasi cepat dengan rawat inap terkait ketersediaan tempat tidur pasien admission
Study	1. Monitoring waktu tunggu pasien harian dan bulanan. 2. Audit kepatuhan pelaksanaan triase dan respons awal pelayanan. 3. Evaluasi jumlah komplain pasien terkait waktu tunggu. 4. Membandingkan capaian indikator sebelum dan sesudah perbaikan.
Action	1. Menetapkan monitoring waktu tunggu sebagai indikator mutu rutin IGD. 2. Melakukan briefing harian terkait kendala pelayanan. 3. Menambah SDM atau penyesuaian jadwal pada jam sibuk bila diperlukan.

	4. Mengembangkan sistem dashboard monitoring waktu tunggu pasien. 5. Melakukan evaluasi berkala dan revisi alur pelayanan bila target belum tercapai
Problem	Ketidakpatuhan dalam mengerjakan PR RM
Step	Peningkatan Kepatuhan Pengerjaan PR Rekam Medis
Plan	1. Rencana: Review penetapan waktu dalam pengerjaan PR RM 2. Harapan Presentase PR RM dikerjakan tepat waktu dan lengkap dengan target 100% 3. Tindakan - Tunjuk PIC untuk pengerjaan PR RM - Monitoring dan evaluasi rutin
Do	Sosialisasi peraturan batas waktu pengerjaan PR RM
Study	Audit ketepatan waktu PR RM dan kelengkapan pengisian
Action	1. Kepatuhan PR RM sebagai indicator mutu unit 2. Feedback dari perawat dan DPJP 3. Penerapan kepada seluruh unit pelayanan

1.3.4. KINERJA IKO

Tabel Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	%
1	Umum	13	8	13	7									↓ 0.06%
2	BPJS Kes	463	387	359	508									↑ 1.49%
3	BPJS TK	22	23	15	18									↑ 0.03%
4	JR	7	14	24	16									↓ 0.08%
5	Asuransi	10	4	3	8									↑ 0.05%
Jumlah		515	436	414	554									↑ 1.4%

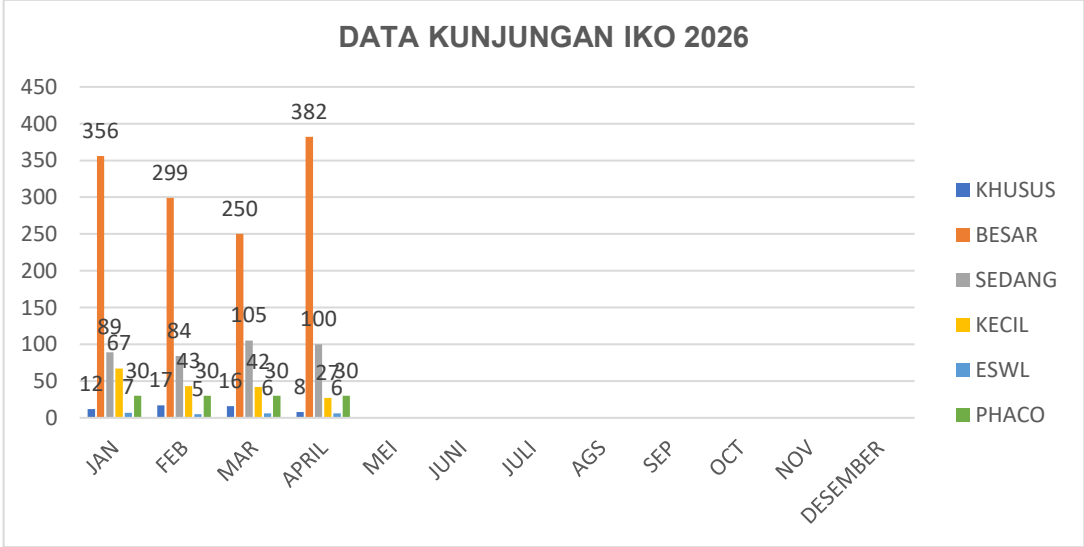
Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026



Tabel Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan Bulan April 2026

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	%
1	Khusus	12	17	16	8									↓ 0.08%
2	Besar	356	288	250	382									↑ 1.32%
3	Sedang	89	88	105	100									↓ 0.05%
4	Kecil	21	8	42	27									↓ 0.15%
5	ESWL	7	5	6	6									Tetap
6	Phaco	30	30	30	30									Tetap
Jumlah		515	436	414	554									↑ 1.4%

Grafik Kunjungan Pasien IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan Bulan April 2026



Analisa

Berdasarkan grafik dan tabel didapatkan kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Maret, sebanyak 1.4% dengan jumlah kunjungan pada bulan April sebanyak 554 dengan kenaikan pada operasi kategori besar.

Permasalahan Unit

Tabel Permasalahan IKO April 2026

IKO	
Problem	Terjadi ketidak cocokan penginputan mini plate dengan yang digunakan oleh pasien
Step	Meningkatkan ketelitian petugas IKO dalam menginput dan mencocokkan
Plan	1. Rencana a. Menganalisa masalah dengan 4M dan 1 E 2. Harapan a. Meningkatkan ketepatan dokumentasi penggunaan mini plate. b. Mencegah kesalahan pencatatan alat implant pasien. c. Meningkatkan keselamatan pasien dan ketertiban administrasi. 3. Tindakan a. Membuat checklist penggunaan mini plate b. Melakukan koordinasi tim IKO dengan pengadaan
Do	1. Membuat formulir/checklist verifikasi penggunaan mini plate di kamar operasi.

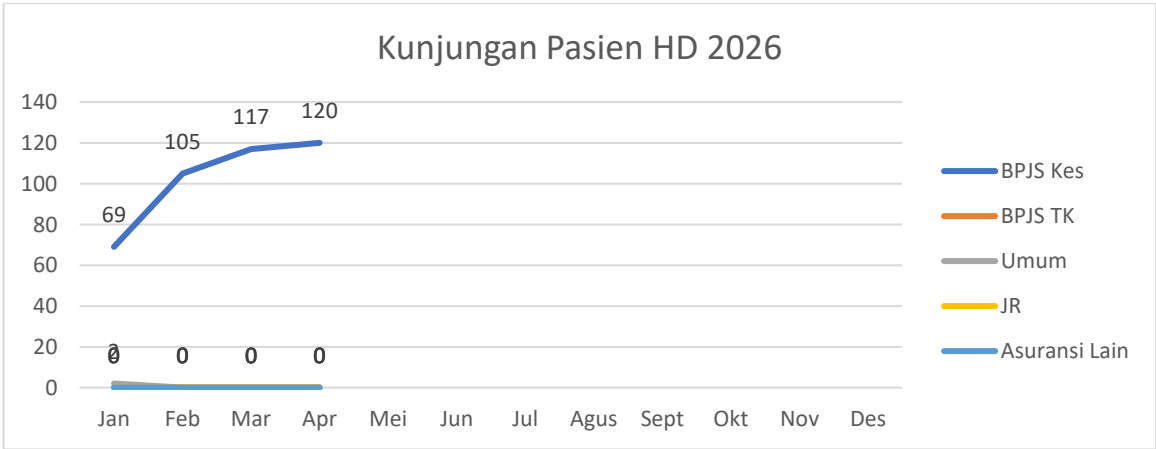
	2. Melakukan double check oleh perawat instrumen dan petugas administrasi sebelum input final. 3. Menempelkan barcode/label implant pada rekam medis dan formulir operasi. 4. Melakukan edukasi kepada petugas terkait pentingnya ketepatan dokumentasi implant. 5. Mengoptimalkan komunikasi antara operator, perawat OK, dan admin billing/logistik. 6. Melakukan pencatatan langsung setelah tindakan selesai untuk menghindari lupa atau tertukar
Study	1. Audit kesesuaian data mini plate dengan penggunaan aktual setiap minggu. 2. Monitoring jumlah insiden salah input implant. 3. Evaluasi kepatuhan penggunaan checklist verifikasi. 4. Mengidentifikasi kendala selama proses dokumentasi
Action	1. Menetapkan prosedur double verification sebagai standar tetap. 2. Mengembangkan sistem barcode atau scanning implant bila tersedia. 3. Melakukan briefing rutin terkait ketelitian dokumentasi implant. 4. Memberikan umpan balik kepada petugas bila ditemukan ketidaksesuaian. 5. Melakukan evaluasi berkala dan revisi alur pencatatan apabila masih ditemukan insiden

1.3.5. KINERJA HEMODIALISA

Tabel Kunjungan Pasien Hemodialisa Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	%
1	BPJS Kes	69	105	117	120									↑ 0.03%
2	BPJS TK	0	0	0	0									Tetap
3	Umum	2	0	0	0									Tetap
4	JR	0	0	0	0									Tetap
5	Asuransi lain	0	0	0	0									Tetap
Jumlah		71	105	117	120									↑ 0.03%

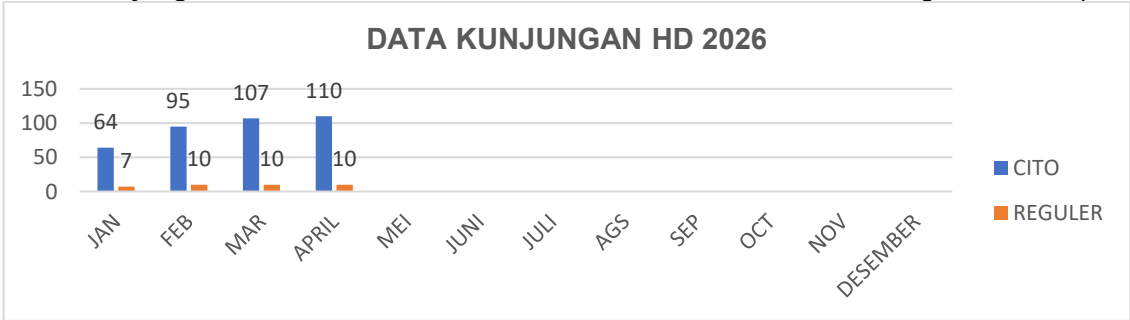
Grafik 3.10 Kunjungan Pasien Hemodialisa Berdasarkan Cara Bayar Bulan April 2026



Tabel Kunjungan Pasien Hemodialisa Berdasarkan Klasifikasi Kedatangan Bulan April 2026

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	%
1	Cito	64	95	107	110									↑ 0.03%
2	Reguler	7	10	10	10									Tetap
Jumlah		71	105	117	120									↑ 0.03%

Grafik Kunjungan Pasien Hemodialisa Berdasarkan Klasifikasi Kedatangan Bulan April 2026



Permasalahan Unit

Tabel Permasalahan Hemodialisa April 2026

HEMODIALISA	
Problem	Meningkatnya pelayanan HD Cito
Step	Mengurangi kejadian HD cito yang dapat dicegah.
Plan	1. Rencana a. Menganalisa penyebab 2. Harapan a. Mengurangi kejadian HD cito yang dapat dicegah. b. Mengoptimalkan pelayanan HD reguler dan HD cito. c. Meningkatkan keselamatan dan kontinuitas pelayanan pasien 3. Tindakan a. Melakukan edukasi secara berkala kepada pasien melalui sosial media maupun secara langsung b. Optimalisasi koordinasi dengan unit terkait HD, IGD, dan Rawat Inap
Do	1. Melakukan edukasi pasien terkait kepatuhan jadwal HD, diet, dan pembatasan cairan. 2. Melakukan monitoring kondisi pasien secara berkala sebelum jadwal HD berikutnya. 3. Membuat sistem skrining pasien berisiko tinggi mengalami kondisi emergency. 4. Mengoptimalkan koordinasi antara dokter, unit HD, IGD, dan rawat inap. 5. Menyediakan slot/jadwal cadangan khusus untuk HD cito bila memungkinkan. 6. Melakukan evaluasi pasien yang sering mengalami HD cito untuk perbaikan terapi.
Study	1. Monitoring jumlah kasus HD cito setiap bulan. 2. Evaluasi penyebab terbanyak terjadinya HD cito. 3. Audit kepatuhan pasien terhadap jadwal HD reguler. 4. Evaluasi dampak HD cito terhadap pelayanan HD reguler.
Action	1. Menetapkan monitoring pasien risiko tinggi sebagai kegiatan rutin unit HD. 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap kapasitas pelayanan HD. 3. Memperkuat edukasi pasien dan keluarga terkait pencegahan kondisi emergency. 4. Mengembangkan alur prioritas pelayanan HD cito agar tidak mengganggu layanan reguler secara signifikan. 5. Mengusulkan penambahan fasilitas atau SDM bila tren HD cito terus meningkat

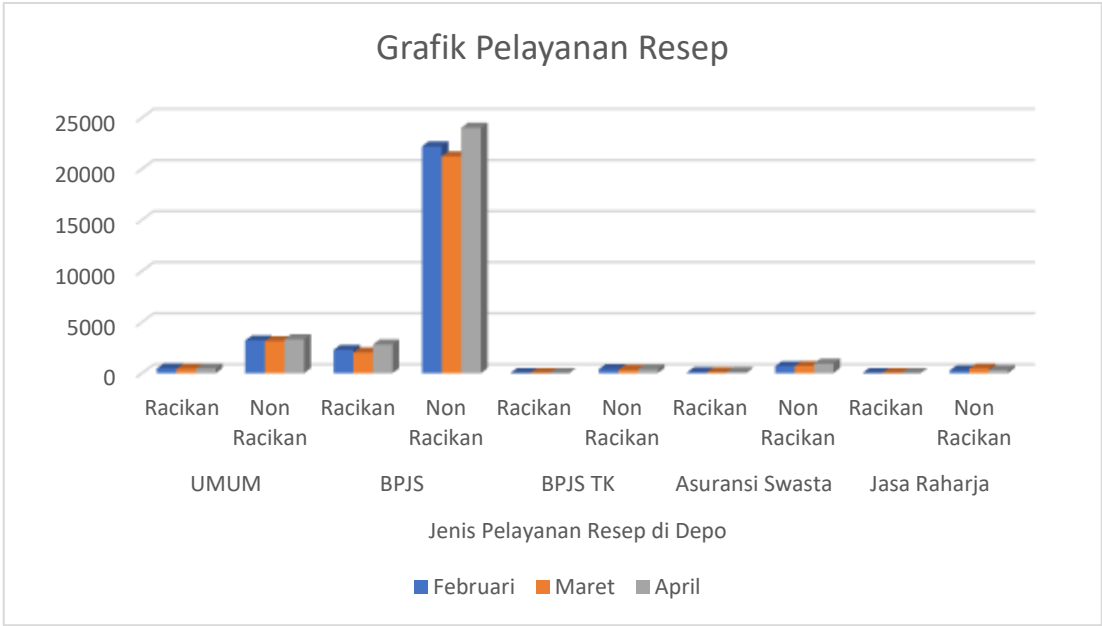
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

Tabel Kunjungan Pasien Berdasarkan Resep dan Cara Bayar

No	Bulan	Jenis Pelayanan Resep di Depo														
		UMUM			BPJS			BPJS TK			Asuransi Swasta			Jasa Raharja		
		Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah	Racikan	Non Racikan	Jumlah
1	Februari	458	3199	3657	2284	22186	24470	0	385	385	94	666	760	0	271	271
2	Maret	436	3131	3567	2021	21225	23246	0	342	342	101	687	788	3	451	454
3	April	456	3312	3768	2798	24012	26810	1	382	383	116	926	1042	1	301	302

Grafik Pelayanan Resep Berdasarkan Cara Bayar



Tabel Analisa Data Pelayanan Resep

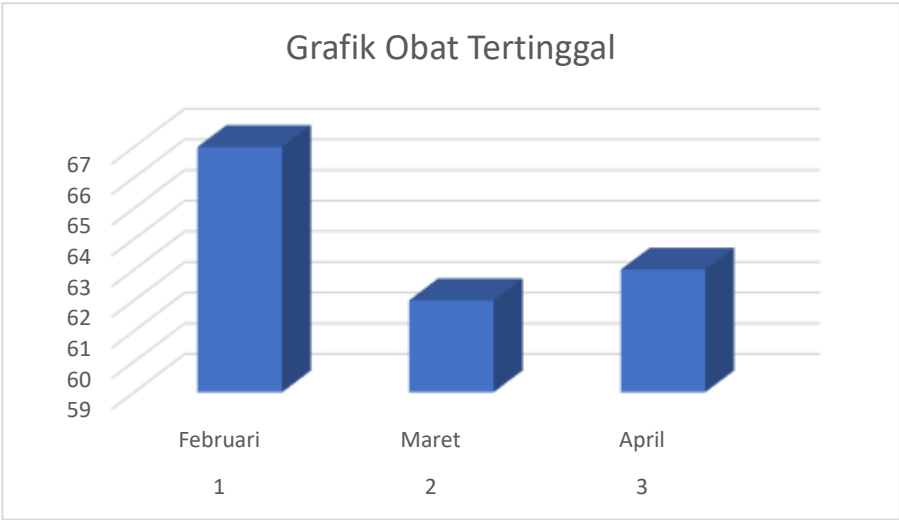
Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	Berdasarkan tabel 3.2.6.1 diatas menunjukkan - Jumlah resep meningkat pada bulan April 2026 dibandingkan bulan sebelumnya - Resep racikan meningkat pada bulan April dibandingkan bulan sebelumnya
Problem	- Peningkatan jumlah pelayanan resep menyebabkan beban kerja petugas farmasi meningkat, terutama pada jam praktek dokter yang bersamaan - Peningkatan resep racikan mempengaruhi waktu tunggu farmasi yang masih belum tercapai sesuai dengan standar mutu
Plan	- Menyusun pengaturan jaga petugas farmasi dengan menempatkan lebih banyak petugas di jam sibuk - Mengajukan penambahan jumlah staf sesuai dengan penghitungan tenaga berdasarkan beban kerja
Do	- Menyusun pengaturan jaga petugas farmasi dengan menempatkan lebih banyak petugas di jam sibuk - Menempatkan lebih banyak petugas di ruang peracikan obat
Study	- Audit pengaturan jaga petugas farmasi dalam 1 bulan masih belum memenuhi target mutu pelayanan terkait waktu tunggu farmasi - Kekurangan staf mempengaruhi kinerja pelayanan farmasi
Action	Mengajukan penambahan staf dengan membuka lowongan kerja untuk tenaga vokasi farmasi yang masih belum terpenuhi

a. Obat Tertinggal

Tabel Obat tertinggal

NO	PERIODE	JUMLAH OBAT
1	Februari	67
2	Maret	62
3	April	63

Grafik Obat Tertinggal



Tabel Analisa Data Obat Tertinggal

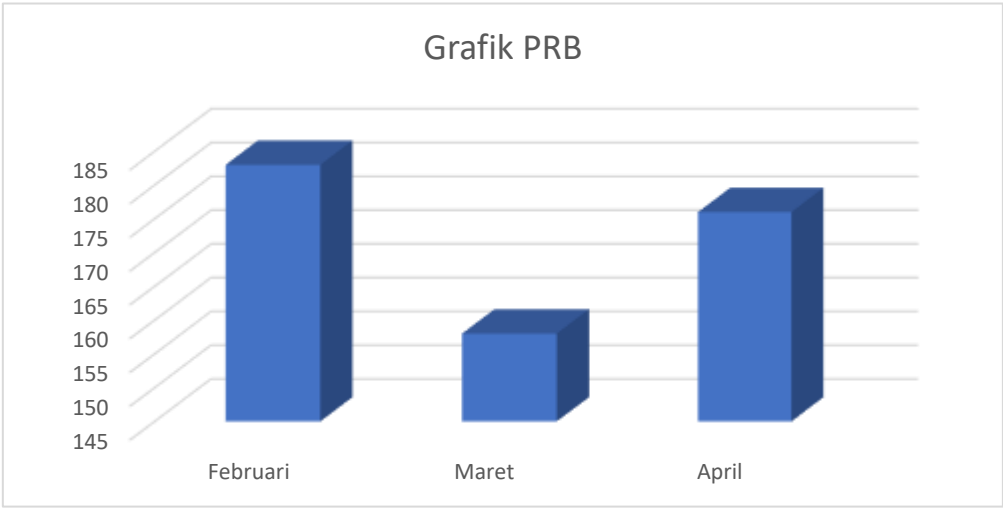
Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	- Kolaborasi dengan perawat poli untuk melakukan edukasi pengambilan obat - Melakukan edukasi jasa pengantaran obat
Do	- Melakukan edukasi ulang kepada pasien terkait waktu pengambilan obat - Memberikan informasi terkait jasa pengantaran obat
Study	- Mayoritas obat tidak diambil berasal dari resep BPJS obat kronis - Waktu tunggu mempengaruhi pengambilan obat
Action	- Edukasi kepada pasien waktu tunggu obat - Edukasi terkait jasa pengantaran obat

b. Obat PRB

Tabel Obat PRB

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	33
2	Februari	183
3	Maret	158

Grafik Jumlah PRB



Tabel Analisis Data Obat PRB

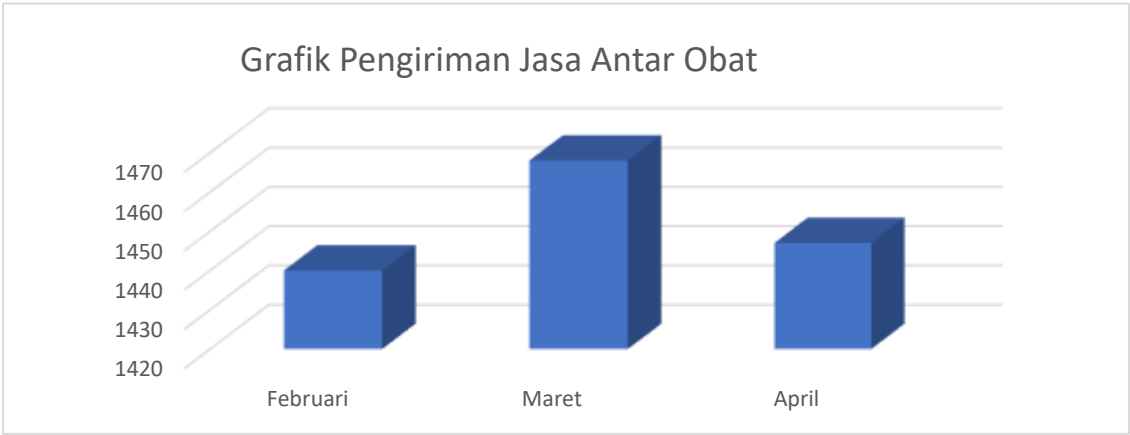
Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	Edukasi pasien terkait PRB kolaborasi dengan DPJP dan perawat poli
Do	- Koordinasi dengan DPJP terkait PRB - Edukasi pasien PRB mengenai alur pengambilan obat
Study	Masih terdapat hambatan terkait PRB, diantaranya: - Berkurangnya pasien yang memiliki kriteria PRB - Kendala dari faskes pertama yaitu tidak tersedianya obat PRB
Action	- Penguatan edukasi pasien PRB sejak di poli - Koordinasi aktif dengan FKTP terkait PRB

c. Pengiriman Jasa Antar Obat

Tabel Pengiriman Jasa Antar Obat

No	Periode	Jumlah Obat
1	Februari	1440
2	Maret	1468
3	April	1447

Grafik Pengiriman Jasa Antar Obat



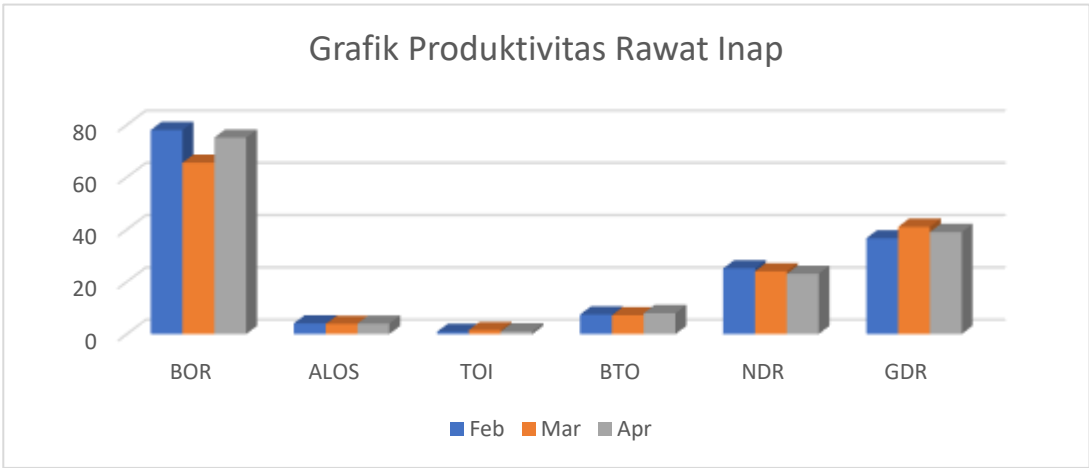
3.2.6 Instalasi Rekam Medik

a. Kinerja Unit Rawat Inap

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap

No	Indikator	Feb	Mar	Apr
1	BOR	78	65.5	75.1
2	ALOS	4.08	3.84	4
3	TOI	0.83	1.49	1
4	BTO	7.44	7.16	8
5	NDR	25.1	24	23
6	GDR	36.6	41	39

Grafik Produktivitas Rawat Inap



Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Plan	• Mengoptimalkan lama rawat inap sesuai indikasi medis • Mereview PPK CP
Do	• Monitoring BOR dan ketersediaan tempat tidur • Mereview PPK CP
Study	• Efisiensi pelayanan meningkat, diperlukan keseimbangan antara efisiensi dan keselamatan pasien • BOR menurun dipengaruhi oleh hari besar yang terjadi di bulan Maret
Action	• Optimalisasi manajemen tempat tidur • Review PPK CP • Meningkatkan koordinasi lintas unit perawatan

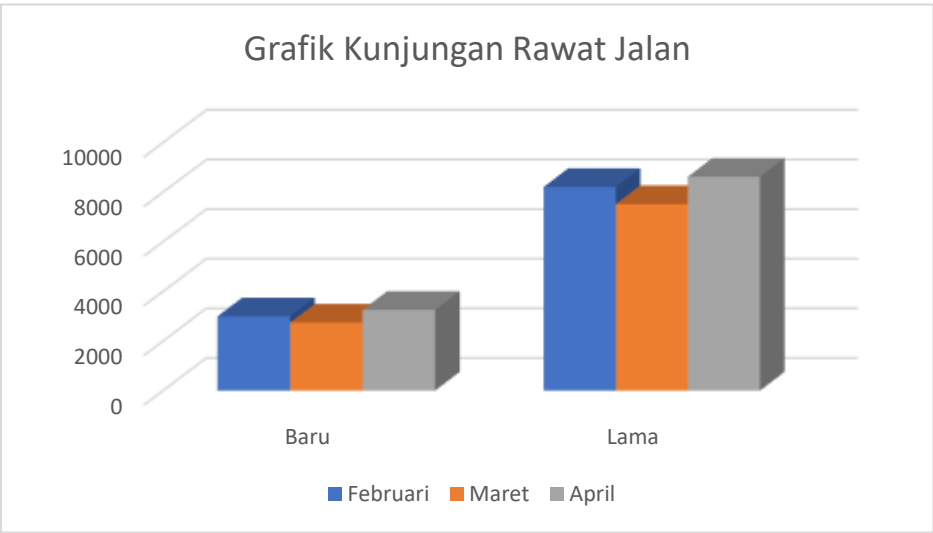
b. Kunjungan Rawat Jalan

Tabel Kunjungan Rawat Jalan

NO	KLINIK	Feb		Mar		Apr	
		Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama
1	Anak	209	579	160	506	180	576
2	Bedah	181	324	132	275	188	353
3	Bedah Plastik	7	10	15	15	16	14
4	Bedah Syaraf	3	1	15	5	27	12
5	Estetik	14	10	8	22	5	22
6	Gigi Anak	4	48	0	0	0	0
7	Gigi Umum	5	5	2	6	6	14
8	Jantung	78	658	56	531	92	596
9	Jiwa	31	267	14	222	30	250
10	Kandungan	238	587	203	602	238	675
11	Kulit dan Kelamin	67	167	65	140	82	149
12	Mata	99	455	82	410	103	478

13	Orthopedi	86	287	98	230	99	366
14	Paru	86	279	78	256	112	296
15	Penyakit Dalam	266	1568	205	1476	259	1539
16	Penyakit Dalam Sub KGH	47	80	44	83	49	115
17	Rehab Medik	25	439	24	275	26	316
18	Syaraf	142	1324	119	1295	137	1494
19	THT	62	121	57	87	98	113
20	Umum	107	12	70	8	156	27
21	Urologi	79	198	69	202	100	266
22	Hemodialisa	1	88	0	102	1	109
23	IGD	1153	703	1223	772	1246	845
TOTAL		2990	8210	2739	7520	3250	8625

Grafik Kunjungan Rawat Jalan



c. Rujuk dari Rawat Inap

Tabel 3.2.7.4 Rujuk dari Rawat Inap

No	Instansi	Feb	Mar	Apr
1	RSUD Bangil	10	7	3
2	RSUD dr.Saiful Anwar Malang	2	2	4
3	RSUD dr.Soetomo Surabaya	2	4	6
4	RS Lavalette	4	2	2
5	RSUD R.T Notopuro Sidoarjo	2	1	3
6	RS Tk. II dr.Soepraoen Malang	0	0	1
7	RSUP Kemenkes Surabaya	0	1	0
8	RS Pantu Nirmala Malang	0	2	0
9	RSPAL dr.Ramelan Surabaya	1	1	0
10	RS Aisyiyah Malang	1	1	0
11	RS Karsa Husada Batu	2	0	0
12	RS UMM	1	0	0
13	RSI Surabaya	1	0	0
14	RSUD dr.Mohammad Soewandhie	1	0	0
15	RS Unair Surabaya	0	0	1
Total		27	21	20

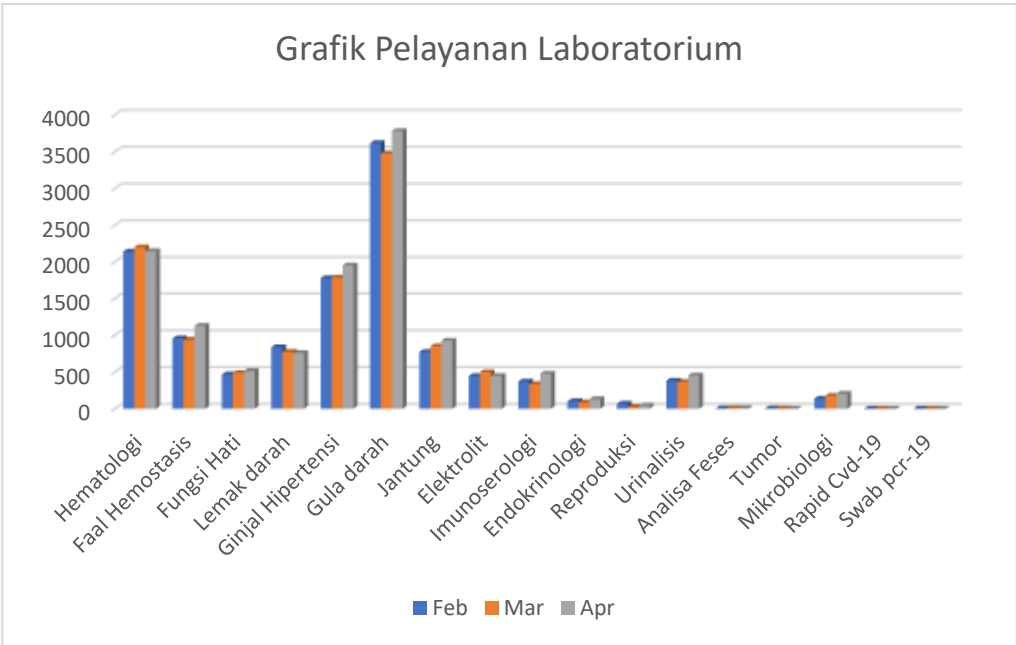
1.4.2. LABORATORIUM

a. Kunjungan Laboratorium

Tabel Kunjungan Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Feb	Mar	Apr	Prosentase Terhadap Bulan Sebelumnya
1	Hematologi	2138	2196	2145	↓2.32%
2	Faal Hemostasis	958	938	1128	↑20.26%
3	Fungsi Hati	467	486	514	↑5.76%
4	Lemak darah	837	772	758	↓1.81%
5	Ginjal Hipertensi	1776	1785	1951	↑9.30%
6	Gula darah	3616	3476	3781	↑8.77%
7	Jantung	773	852	925	↑8.57%
8	Elektrolit	446	496	445	↓10.28%
9	Imunoserologi	370	333	476	↑42.94%
10	Endokrinologi	102	85	131	↑54.12%
11	Reproduksi	68	25	42	↑68%
12	Urinalisis	382	364	451	↑23.9%
13	Analisa Feses	5	9	9	0.00
14	Tumor	5	4	2	↓50%
15	Mikrobiologi	138	173	204	↑17.92%
16	Rapid Cvd-19	0	0	0	0.00
17	Swab pcr-19	0	0	0	0.00
Jumlah		12081	11994	12962	↑8.07%

Grafik Kunjungan Pemeriksaan Laboratorium



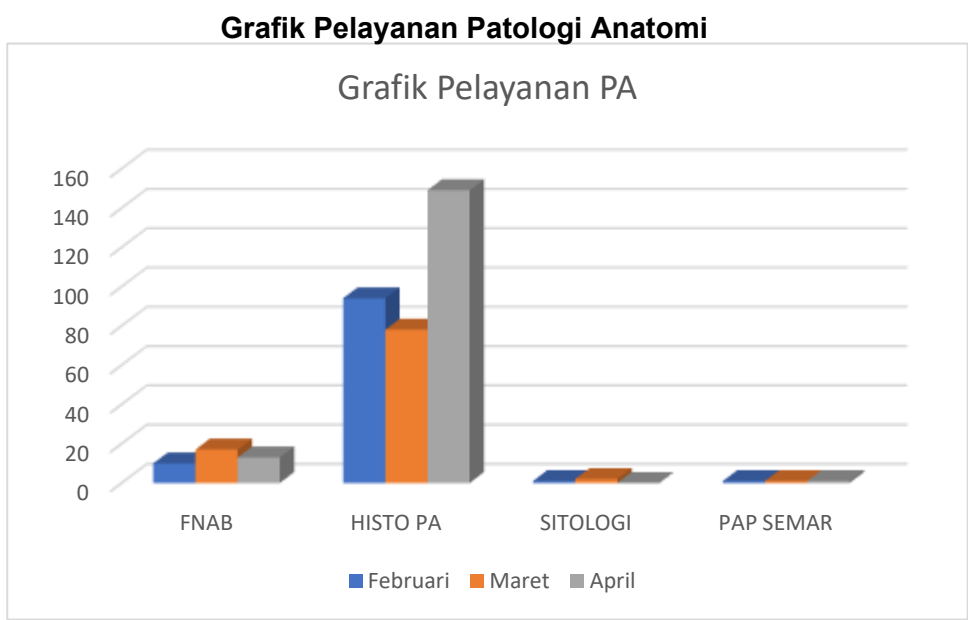
Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	- Berdasarkan tabel 3.2.1.1 diatas menunjukkan terdapat kenaikan kunjungan laboratorium pada bulan April 2026 sebanyak 8.07% dibandingkan bulan Maret 2026. - Kunjungan terbanyak pada pemeriksaan Hematologi sebanyak 2145 pemeriksaan
Problem	Ditemukan ketidaklengkapan formulir laboratorium yang mempengaruhi mutu pelayanan laboratorium

Plan	Melakukan sosialisasi kepada dokter, perawat dan petugas laboratorium terkait pentingnya kelengkapan permintaan pemeriksaan laboratorium
Do	- Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh unit pengirim pemeriksaan laboratorium - Menerapkan screening formulir oleh petugas laboratorium sebelum sampel diproses - Melakukan konfirmasi kepada unit yang bersangkutan
Study	- Setelah dilakukan pemantauan, terjadi peningkatan jumlah pelayanan laboratorium - Kelengkapan formulir laboratorium mulai mengalami perbaikan meskipun ditemukan beberapa formulir yang belum terisi lengkap. Dari ketidaklengkapan sebesar 2,83% menjadi 2,52%
Action	- Melanjutkan monitoring audit internal secara berkala - Memberikan umpan balik kepada unit yang masih sering mengirim formulir tidak lengkap

b. Rujukan Patologi Anatomi
Tabel Rujukan Patologi Anatomi

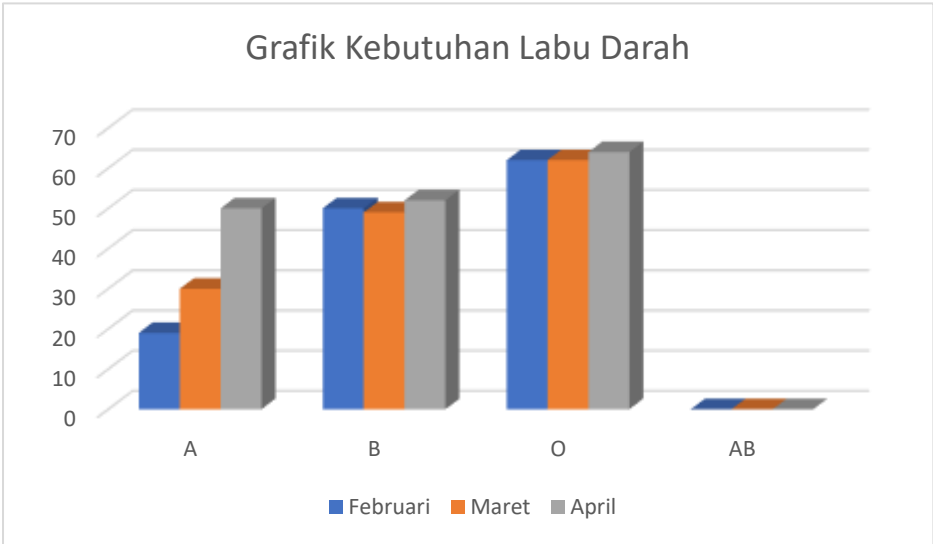
No	Jenis Pemeriksaan	Februari	Maret	April
1	FNAB	10	17	13
2	HISTO PA	94	78	149
3	SITOLOGI	1	2	0
4	PAP SEMAR	1	1	1
TOTAL		106	98	163



c. Kebutuhan Labu Darah
Tabel Kebutuhan Labu darah

NO	JENIS GOLDA	Februari	Maret	April
1	A	19	30	50
2	B	50	49	52
3	O	62	62	64
4	AB	0	0	0
Jumlah		131	141	166

Grafik Kebutuhan Labu Darah



Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	- Berdasarkan table 3.2.1.4 diatas menunjukkan terdapat peningkatan kebutuhan labu darah di bulan April 2026 sebanyak 17,73% dibandingkan bulan Maret 2026. - Kebutuhan labu darah terbanyak untuk golongan darah O mencapai 64 kantong
Problem	- Labu darah golongan AB tidak tersedia di BDRS, dikarenakan jenis golongan yg susah dan jarang digunakan. - Kantong darah AB permintaan dari unit perawatan tidak digunakan karena pasien meninggal sebelum kantong ditranfusikan, darah tidak bisa dikembalikan karena BDRS mengambil dari PMI Bangil dikarenakan BRSD tidak menyediakan stok golongan AB
Plan	- Melakukan evaluasi kebutuhan stok darah berdasarkan pola penggunaan setiap golongan darah - Menetapkan prosedur pemesanan darah berdasarkan indikasi medis yang jelas dan kondisi pasien terkini
Do	- Melaksanakan monitoring penggunaan darah setiap bulan berdasarkan jenis golongan darah - Melakukankonfirmasi ulang kondisi pasien sebelum pengambilan darah dari PMI
Study	- Evaluasi jumlah permintaan darah yang tidak digunakan setiap bulan - Menilai ketepatan prosedur permintaan darah terhadap kondisi klinis pasien
Action	Meningkatkan evaluasi berkala terhadap penggunaan darah dan pelaporan insiden tidak terpakai

1.4.3. RADIOLOGI

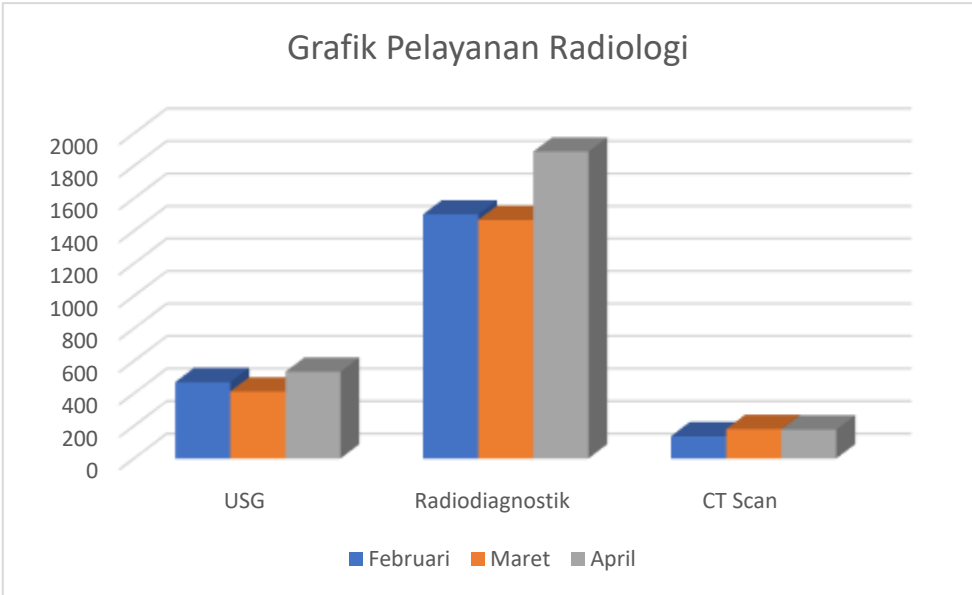
a. Produktivitas Radiologi Berdasarkan Jenis Pemeriksaan

Tabel Produktivitas Radiologi Berdasarkan Jenis Pemeriksaan

PEMERIKSAAN	JENIS PEMERIKSAAN	BULAN		
		Februari	Maret	April
USG	ABDOMEN/UROLOGI	427	368	468
	ABDOMEN CITO	0	3	0
	THORAX	2	10	0
	MAMMAE	4	2	10
	THYROID/COLLI	18	21	39
	TESTIS	13	6	13
	PAROTIS	0	0	0
	VASKULER	3	1	3
	ANKLE	0	0	0
	FEMUR	0	0	0
	KEPALA	0	1	0
	MUSKULOSKELETAL	3	0	1
	MANDIBULA	0	0	0
	TOTAL	470	412	534

RADIOLOGI	SKULL	4	11	5
	THORAX	964	925	1155
	EXTERMITAS ATAS	163	176	219
	EXTERMITAS BAWAH	129	160	213
	KUB/BNO	103	73	141
	PELVIS	29	33	18
	BABYGRAM	16	13	16
	CERVICAL	14	13	19
	THORACOLUMBAL	3	7	14
	LUMBOSACRAL	65	51	76
	LUMBAL	0	0	0
	IVP + KONTRAS	0	0	0
	URETROGRAFI	0	0	0
	COLON IN LOOP	0	0	0
	PANORAMIC	5	1	5
	WATERS	7	5	7
	TOTAL	1502	1468	1888
CT SCAN	KEPALA	90	111	106
	KEPALA DENGAN KONTRAS	4	5	4
	KEPALA TRAUMA	39	61	52
	BRAIN SINUS DAN MATOID NON KONTRAS	0	0	3
	THORAX	0	1	0
	THORAX DENGAN KONTRAS	1	0	0
	ABDOMEN	0	2	8
	ABDOMEN DENGAN KONTRAS	0	0	2
	PELVIS	1	0	1
	VERTEBRAE	0	0	0
	CERVICAL VERTEBRAE	0	0	0
	LUMBOSACRAL	0	0	0
	THORACAL VERTEBRAE NON KONTRAS	1	0	1
	THORACO LUMBAL	0	0	0
	3D	1	0	0
	CRURIS	0	0	0
	LUMBOSACRAL VERTEBRAE	0	0	0
	EKSTERMITAS LAIN	0	1	1
	TOTAL	137	181	178
	TOTAL PEMERIKSAAN	2109	2061	2600

Grafik Produktivitas Radiologi



Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	Berdasarkan tabel 3.2.2.1 diatas menunjukkan : • Terjadi peningkatan pemeriksaan UGS di bulan April sebanyak 29,61%dibandingkan bulan sebelumnya. • Terjadi peningkatan pemeriksaan Radiodiagnostik dibulan April sebanyak 28,61% dibandingkan bulan sebelumnya. • Terjadi penurunan pemeriksaan CT Scan dibulan April sebesar 1,65% dibandingkan bulan sebelumnya
Problem	Ditemukannya kerusakan CT Scan yang berulang mengakibatkan penurunan jumlah pemeriksaan CT Scan dan harus dirujuk parsial ke RS lain.
Plan	• Melakukan identifikasi penyebab kerusakan CT Scan melalui evaluasi teknis dan riwayat maintenance alat. • Menyusun prosedur penggunaan alat sesuai dengan arahan tekhnisi dari vendor
Do	• Melakukan penggunaan alat CT Scan sesuai arahan vendor • Menerbitkan SPO penggunaan CT scan yang baru sesuai update maintenance dari vendor
Study	• Terjadi kerusakan CT Scan berulang setelah dilakukan perubahan prosedur pengoperasian
Action	• Koordinasi dengan vendor terkait maintenance dan Analisa kerusakan yang terjadi

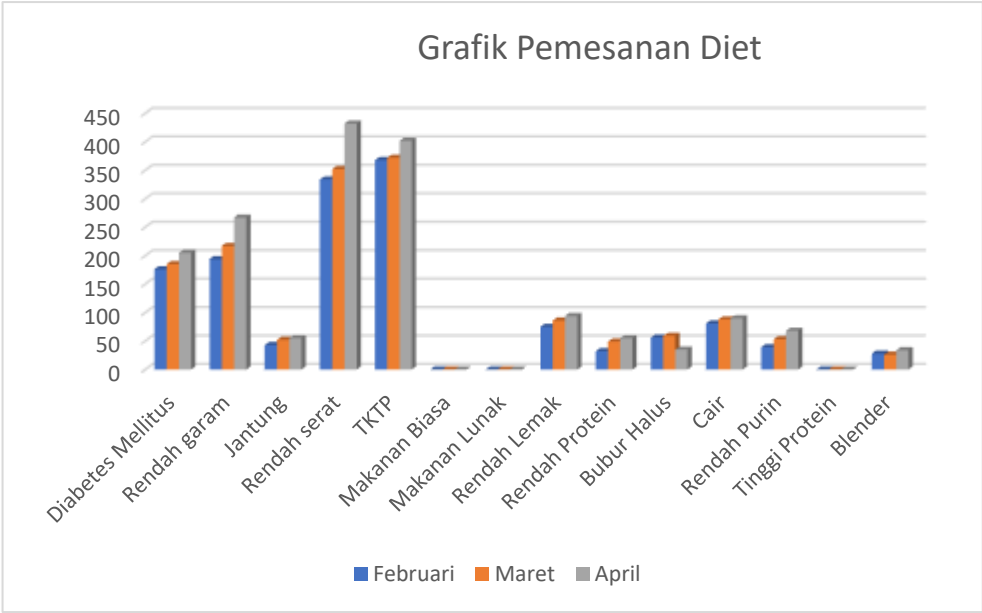
1.4.4. GIZI

a. Pemesanan Diet Pasien

Tabel Pemesanan Diet

No	Nama Diet	Februari	Maret	April
1	Diabetes Mellitus	176	185	205
2	Rendah garam	194	217	267
3	Jantung	43	52	55
4	Rendah serat	334	352	432
5	TKTP	368	372	402
6	Makanan Biasa	0	0	0
7	Makanan Lunak	0	0	0
8	Rendah Lemak	75	86	94
9	Rendah Protein	32	49	55
10	Bubur Halus	56	59	35
11	Cair	81	88	90
12	Rendah Purin	39	53	68
13	Tinggi Protein	0	0	0
14	Blender	28	26	34
TOTAL		1426	1539	1737

Grafik Pemesanan Diet Pasien



Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	Berdasarkan tabel 3.2.3.1 diatas menunjukkan pemesanan diet meningkat dibulan April sebanyak 12,86% dibandingkan bulan sebelumnya
Problem	Ditemukannya kejadian kesalahan pemberian diet yang tertukar identitasnya dengan pasien lain
Plan	Melakukan identifikasi penyebab kesalahan pemberian diet pasien melalui evaluasi proses pemesanan, distribusi, dan pemberian diet.
Do	- Melakukan pengecekan ulang (double check) terhadap identitas pasien dan jenis diet sebelum distribusi makanan - Memberikan edukasi kepada petugas distribusi makanan mengenai prosedur keselamatan pasien dalam pemberian diet
Study	Melakukan evaluasi jumlah insiden kesalahan pemberian diet setiap bulan
Action	Melakukan audit dan monitoring berkala terhadap proses distribusi makanan pasien

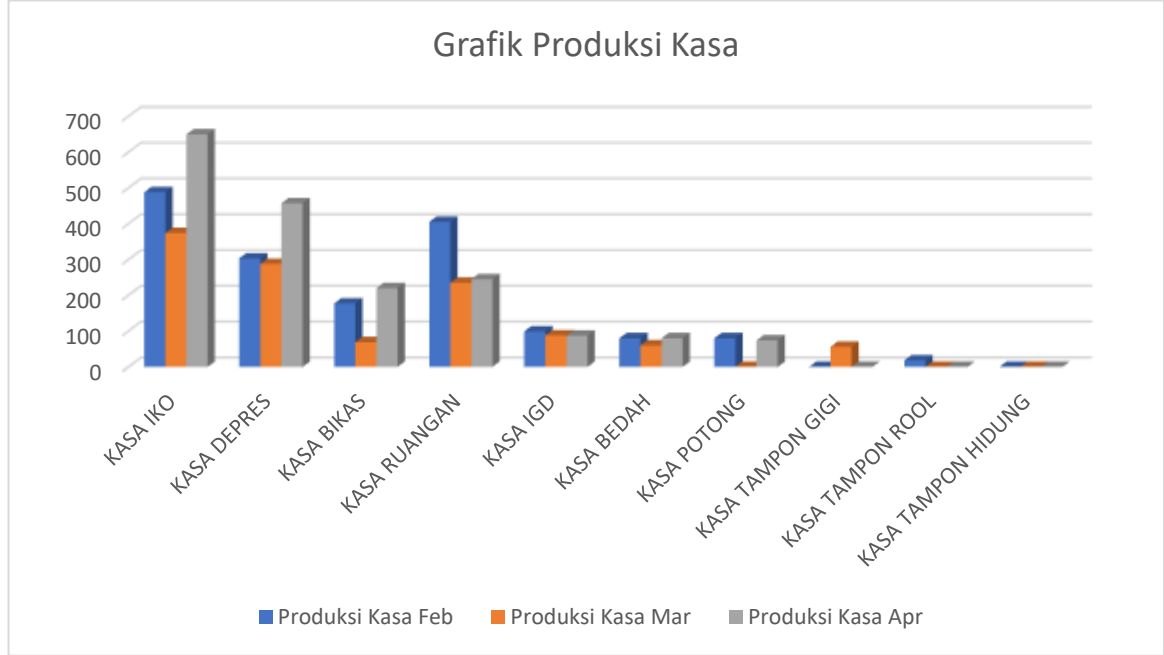
1.4.5. Instalasi CSSD

a. Kebutuhan Kassa

Tabel Kebutuhan Kassa

NO	JENIS KASA	Produksi Kasa		
		Feb	Mar	Apr
1	KASA IKO	488	374	650
2	KASA DEPRES	303	288	457
3	KASA BIKAS	177	69	220
4	KASA RUANGAN	405	235	245
5	KASA IGD	99	88	87
6	KASA BEDAH	80	60	80
7	KASA POTONG	80	0	74
8	KASA TAMPON GIGI	0	56	0
9	KASA TAMPON ROOL	18	0	0
10	KASA TAMPON HIDUNG	0	0	0

Grafik Kebutuhan Kasa



Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	Berdasarkan tabel 3.2.4.2.1 diatas menunjukkan kebutuhan kassa di bulan April meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Problem	Kebutuhan kassa di IKO meningkat tetapi pembuatan kassa membutuhkan extra tenaga.
Plan	Menentukan target pemenuhan kebutuhan kassa dengan rata – rata perbulan dilihat daribulan sebelumnya
Do	Mengoptimalkan jadwal produksi kassa pada waktu dengan beban kerja lebih rendah
Study	Mengevaluasi kesesuaian antara jumlah produksi kassa dengan kebutuhan pelayanan IKO
Action	Menetapkan monitoring kebutuhan dan stok kassa

b. Reagen

Tabel Penggunaan Reagen

NO	BAHAN	Kebutuhan		
		Feb	Mar	Apr
1	Metracide (ml)	2000	2100	2200
2	Metrazyme (ml)	2000	2100	2200

c. Produktivitas Lain
Tabel Produktivitas Lain CSSD pada bulan April 2025

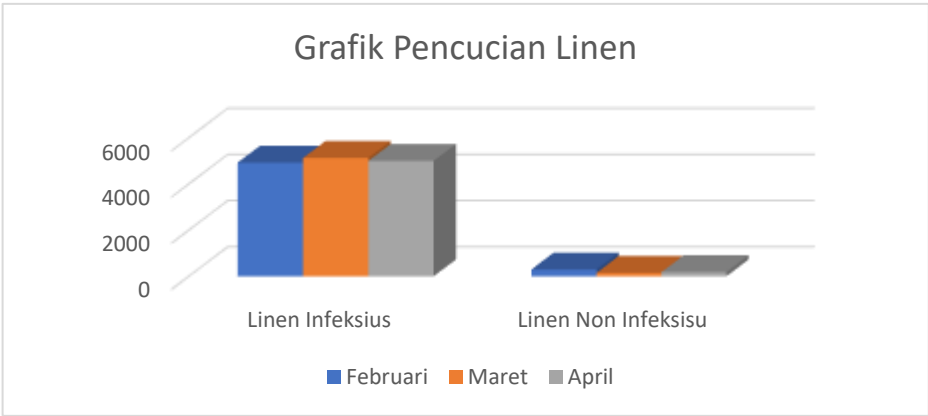
No	Produktivitas Lain	Satuan	Jumlah		
			Feb	Mar	Apr
1	Pencucian Alat	Kali	566	494	735
2	Pemakaian Alat Steril				
	a. Memmert kecil	Kali	175	174	172
	b. Memmert besar	Kali	120	116	100
	c. Autoclave	Kali	11	11	16
3	Penyeterilan Alat IKO	Pack	880	816	1164

1.4.6. LAUNDRY

a. Pencucian Linen
Tabel Pencucian Linen

No	Periode	Linen Infeksius	Linen Non Infeksius
1	Februari	4927.7	294
2	Maret	5126.64	148
3	April	4997.14	180.5

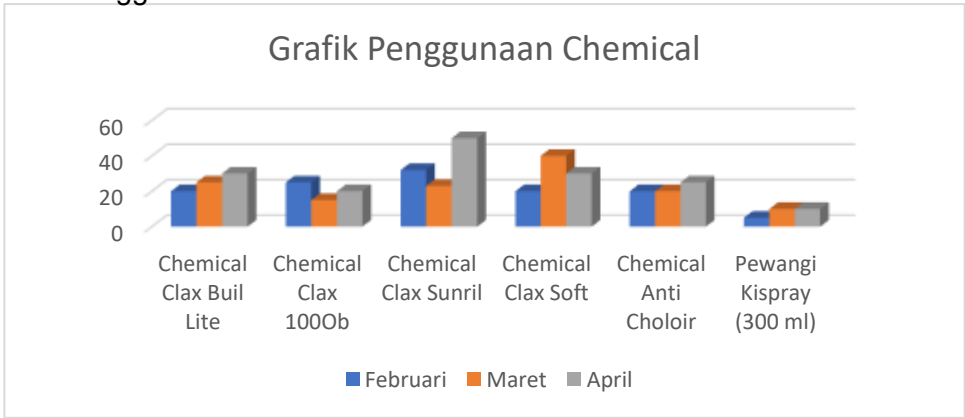
Grafik Pencucian Linen



b. Penggunaan Reagen
Tabel Penggunaan Reagen

No	Jenis	Februari	Maret	April
1	Chemical Clax Buil Lite	20	25	30
2	Chemical Clax 100Ob	25	15	20
3	Chemical Clax Sunril	32	23	50
4	Chemical Clax Soft	20	40	30
5	Chemical Anti Choloir	20	20	25
6	Pewangi Kispray (300 ml)	5	10	10
7	Tabung LPG (12 Kg)	336	372	384

Grafik Penggunaan Chemical



c. Stok Linen

Tabel Stok Berkurang Bulan April 2026

No	Jenis Linen	Hilang	Rusak
1	Sprei	-	12
2	Selimut Hijau	-	-
3	Sarung Bantal	-	3
4	Selimut Coklat	-	-
5	Selimut VIP	-	-
6	Baju Pasien	-	-
7	Gown	-	-
8	Baju Tim	-	3
9	Alas Meja Operasi	-	-
10	Duk Kaki	-	-
11	Duk Lubang (B)	-	-
12	Meja Mayo	-	-
13	Duk Kecil	-	-
14	Duk Doble	-	-
15	Duk Sedang	-	-
16	Duk Lubang (K)	-	-
17	Duk Buntu	-	-
18	Selimut Hijau	-	-
19	Handuk	-	-
20	Stik Laken	-	-

Tabel Rekapitulasi Stok Bulan April 2026

No	Ruangan	Jenis Linen	Jumlah Stok		Keterangan		
			Maret	April	Rusak	Hilang	Penambahan
1	IRNA 3A	Sprei	68	63	5	0	0
		Selimut Hijau	62	62	0	0	0
		Sarung Bantal	82	82	0	0	0
		Selimut Coklat	24	24	0	0	0
		Selimut VIP	24	24	0	0	0
		Bantal	42	42	0	0	0
2	Maternitas	Sprei	52	52	0	0	0
		Selimut Hijau	46	46	0	0	0
		Sarung Bantal	26	26	0	0	0
		Selimut Coklat	6	6	0	0	0
		Selimut VIP	3	3	0	0	0
		Bantal	19	19	0	0	0
3	IRNA 2A + 2D	Sprei	82	81	1	0	0
		Selimut Hijau	79	79	0	0	0
		Sarung Bantal	100	100	0	0	0
		Bantal	60	60	0	0	0
4	IRNA 2B	Sprei	73	68	5	0	0
		Selimut Hijau	62	62	0	0	0
		Sarung Bantal	80	77	3	0	0
		Selimut Coklat	7	7	0	0	0
		Bantal	33	33	0	0	0
5	IRNA 3B	Sprei	47	46	1	0	0
		Selimut Hijau	79	79	0	0	0
		Sarung Bantal	71	71	0	0	0
		Bantal	30	30	0	0	0
6	ICU	Sprei	8	8	0	0	0
		Selimut Hijau	13	13	0	0	0
		Baju px	10	10	0	0	0
7	PERIN	Sprei	20	20	0	0	0
		Selimut Hijau	20	20	0	0	0
		Sarung Bantal	20	20	0	0	0
8	REHAB	Sprei	24	24	0	0	0

		Selimut	23	23	0	0	0
		Sarung Bantal	19	19	0	0	0
		Bantal	7	7	0	0	0
9	IGD	Selimut Hijau	21	21	0	0	0
10	HD	Sprei	20	20	0	0	0
		Selimut Hijau	20	20	0	0	0
		Sarung Bantal	20	20	0	0	0
		Bantal	7	7	0	0	0
11	IKO	Gown	94	94	0	0	0
		Baju Pasien	29	29	0	0	0
		Baju Tim	66	83	3	0	20
		Alas Meja Operasi	56	56	0	0	0
		Duk Kaki	6	6	0	0	0
		Duk Lubang (B)	33	33	0	0	0
		Meja Mayo	32	32	0	0	0
		Duk Kecil	140	140	0	0	0
		Duk Double	18	18	0	0	0
		Duk Sedang	50	50	0	0	0
		Duk Lubang (K)	15	15	0	0	0
		Duk Buntu	22	22	0	0	0
		Selimut Hijau	10	10	0	0	0
		Handuk	27	27	0	0	0
		Stik Laken	12	12	0	0	0
12	Poli	Selimut Coklat	22	22	0	0	0
		Sarung Bantal	10	10	0	0	0
		Bantal	14	14	0	0	0

Tabel Analisa Data

Review Hasil Berdasarkan PDSA	
Analisa	Berdasarkan tabel 3.2.5.4 diatas menunjukkan - Masih ada linen yang rusak - Penambahan baju tim IKO yang sudah rusak dan tidak layak pakai
Problem	Didapatkan masih ada linen rusak terutama jenis sprei karena penggunaan lama dan bahan tipis sehingga mudah robek
Plan	- Memberikan identitas tahun pembelian untuk linen baru - Melakukan pencatatan jumlah linen rusak, hilang dan penggantian linen setiap bulan - Melakukan pemusnahan linen yang sudah rusak dan tidak layak pakai sesuai dengan standar
Do	- Melakukan pencatatan jumlah linen rusak, hilang dan penggantian linen setiap bulan - Melakukan pemusnahan linen yang sudah rusak dan tidak layak pakai sesuai dengan standar
Study	Audit kerusakan, kehilangan linen satu bulan didapatkan data kehilangan berkurang, namun kerusakan masih tetap terjadi
Action	Melakukan pengadaan linen baru sesuai dengan anggaran pada program kerja laundry

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.1 Asuransi Centre

Tabel Kunjungan Pasien

No	Jaminan	Maret			April		
		RJ	RI	Total	RJ	RI	Total
1	UMUM	1.993	45	2.038	2.306	47	2.353
2	BPJS KESEHATAN	6.308	1.163	7.471	7.312	1.392	8.704
3	ASURANSI SWASTA	229	6	235	264	14	278
4	BPJS TENAGA KERJA	177	19	196	184	22	206
5	PERUSAHAAN	48	13	61	125	15	140
6	JARA RAHARJA	26	27	53	38	17	55
7	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
Total		8.781	1.273	10.054	10.229	1.507	11.736

Permasalahan unit terkait BPJS Kesehatan

Masalah	Dampak	Tindak Lanjut
a. Masih ditemukan catatan perbaikan (note PR) dari tim KMKB unit yang belum diselesaikan hingga pasien pulang (KRS). b. Resume medis seringkali masih kosong saat pasien KRS karena ketergantungan pada jadwal visite DPJP. c. Unit tidak melakukan pengecekan ulang (<i>final check</i>) rekam medis saat pasien pulang, sehingga berkas yang disetorkan tidak lengkap seperti TTD pada resume, tgl KRS yang belum dipulangkan, lembar operasi, lembar konsultasi yang belum terisi, diagnosa pada resume d. Jadwal visite DPJP yang dilakukan pada sore dan malam hari (setelah jam poliklinik) sehingga tidak bertemu dengan tim KMKB non shift e. Belum ada rencana KRS pada sore hari sehingga saat tim KBKB sore ke unit masih belum dapat melakkan pengecekan resume medis karena belum terisi oleh dpjp sehingga tidak optimal	a. Pengecekan dokumen rekam medis menjadi 2x kerja sehingga menjadi tidak efektif b. Petugas asuransi yang berjaga di kantor beban kerja menjadi bertambah harus menerima setoran dan melakukan pengecekan berkas rekam medis pasien pulang sendiri dengan jumlah pasien KRS rata-rata setiap hari 47 pasien sehingga tidak memenuhi target final harian c. Adanya penumpukan klaim di akhir bulan	a. Koordinasi dengan kabisid pelayanan untuk dapat bersinergi b. Melakukan perhitungan beban kerja Kembali di unti asuransi center

Permasalahan unit terkait Non BPJS Kesehatan

Masalah	Dampak	Tindak Lanjut
Adanya update aplikasi terbaru pada aplikasi BPJS ketenagakerjaan (PLKK) yang tidak terinfokan ke rumah sakit	Jumlah klaim BPJS TK sebanyak 215 yang dapat diajukan pada aplikasi hanya 60 dan sisa 155 belum dapat diajukan	Berkoordinasi dengan BPJS TK dan bersurat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut

Indikator Mutu Klaim

NO	Indikator Mutu	Standar	Januari			Februari			Maret			April		
			Numerator	Denominator	Nilai	Numerator	Denominator	Nilai	Numerator	Denominator	Nilai	Numerator	Denominator	Nilai
1	Waktu Pengajuan Klaim	Tanggal 5 Awal bulan			5/2/2026			5/3/2026			5/4/2026			7/5/2026
2	% Klaim Pending RJTL	< 0,1% dari total klaim	3	8218	0,0%	2	7213	0,0%	1	6308	0,0%	-	7312	0,0%
3	% Klaim Pending RITL	< 1% dari total klaim	105	1514	6,9%	92	1211	7,6%	88	1163	7,6%	-	1392	0,0%
4	% Klaim Tidak Layak	0% dari total klaim	6	9732	0,1%	89	8424	1,1%	58	7471	0,8%	-	8704	0,0%
5	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	< Rp 1.000 .000	-	-	1.141.761.700	-	-	22.246.500	-	-	0	-	-	-
6	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	< Rp 5.000 .000	-	-	4.163.300	-	-	5.349.400	-	-	4.661.900	-	-	-
7	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL	< Rp 50.000.000	-	-	70.274.542	-	-	48.817.472	-	-	27.812.396	-	-	75.820.903
8	Nilai Selisih Negatif Klaim RITL	< Rp 100.000.000	-	-	-540.169.308	-	-	-489.851.024	-	-	-424.814.880	-	-	-873.275.481

3.2.1.3 Klaim BPJS Kesehatan

Tahun	Bulan Pelayanan	Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus	Tarif RS	Tarif NCC	selisih	Tgl Pengajuan	Tgl FPK	KLAIM LAYAK				KLAIM PENDING			
									Jumlah Kasus	Tarif RS	Tarif INA CBG	SELISIH	Jumlah Kasus	Tarif RS	Tarif INA CBG	SELISIH
2025	DESEMBER	RJ	7.803	1.858.982.652	1.903.884.100	44.901.448	05/01/2026	23/01/2026	7.774	1.853.423.616	1.896.854.100	14.457.822.000	19	4.123.464	5.069.000	1.516.611.157
		RI	1.529	8.518.134.357	7.442.783.600	-1.075.350.757	05/01/2026	23/01/2026	1.407	7.801.204.956	6.613.186.560		120	709.449.521	806.216.100	
			9.332	10.377.117.009	9.346.667.700	-1.030.449.309			9.181	9.654.628.572	8.510.040.660	14.457.822.000	139	713.572.985	811.285.100	1.516.611.157
	PENDING KE 1	RJ	21	11.592.344	6.450.300		26/03/2026									
Tahun	Bulan Pelayanan	Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus	Tarif RS	Tarif NCC	selisih	Tgl Pengajuan	Tgl FPK	KLAIM LAYAK				KLAIM PENDING			
									Jumlah Kasus	Tarif RS	Tarif INA CBG	SELISIH	Jumlah Kasus	Tarif RS	Tarif INA CBG	SELISIH
2026	Januari	RJ	8,218	1,989,605,586	2,045,267,800	55,662,214	05/02/2026	23/2/2026	8,204	1,984,463,746	2,040,718,700	56,254,954	9	4,342,701	3,568,600	-774,101
		RI	1,514	8,533,314,956	7,829,868,200	-703,446,756	05/02/2026	23/2/2026	1,400	7,837,725,139	7,042,233,864	-795,491,275	113	692,017,119	779,011,100	86,993,981
			9,732	10,522,920,542	9,875,136,000	-647,784,542			9,604	9,822,188,885	9,082,952,564	-739,236,321	122	696,359,820	782,579,700	86,219,880
	PENDING KE 1	RJ	9	4,342,701	3,568,600	-774,101						0	9	4,342,701	3,568,600	-774,101
		RI	113	692,017,119	779,011,100	86,993,981						0	113	692,017,119	779,011,100	86,993,981
			122	696,359,820	782,579,700	86,219,880			0	0	0	0	122	696,359,820	782,579,700	86,219,880
2026	Februari	RJ	7,213	1,813,383,928	1,862,201,400	48,817,472	5/3/2026	24/3/2026	7,116	1,796,782,679	1,842,594,200	45,811,521	8	2,388,312	1,821,900	-566,412
		RI	1,211	7,286,240,077	6,603,845,500	-682,394,577	5/3/2026	24/3/2025	1,111	6,697,812,670	5,863,942,158	-833,870,512	100	588,427,407	6,603,988,100	6,015,560,693
			8,424	9,099,624,005	8,466,046,900	-633,577,105			8,227	8,494,595,349	7,706,536,358	-788,058,991	108	590,815,719	6,605,810,000	6,014,994,281
	PENDING KE 1	RJ	8	2,388,312	1,821,900	-566,412						0	8	2,388,312	1,821,900	-566,412
		RI	100	588,427,407	6,603,988,100	6,015,560,693						0	100	588,427,407	6,603,988,100	6,015,560,693
			108	590,815,719	6,605,810,000	6,014,994,281			0	0	0	0	108	590,815,719	6,605,810,000	6,014,994,281
2026	MARET	RJ	6,308	1,660,806,104	1,667,103,000	6,296,896	5/4/2026	26/4/2026	6,248	1,650,835,536	1,655,233,600	4,398,064	2	9,970,568	493,000	-9,477,568
		RI	1,163	6,956,674,494	6,246,387,200	-710,287,294	5/4/2026	24/4/2026	1,065	6,360,760,879	5,526,967,576	-833,793,303	98	595,913,615	723,817,688	127,904,073
			7,471	8,617,480,598	7,913,490,200	-703,990,398			7,313	8,011,596,415	7,182,201,176	-829,395,239	100	605,884,183	724,310,688	118,426,505
	PENDING KE 1	RJ	2	9,970,568	493,000	-9,477,568						0	2	9,970,568	493,000	-9,477,568
		RI	98	6,956,674,494	723,817,688	-6,232,856,806						0	98	6,956,674,494	723,817,688	-6,232,856,806
			100	6,966,645,062	724,310,688	-6,242,334,374			0	0	0	0	100	6,966,645,062	724,310,688	-6,242,334,374
2026	APRIL	RJ	7,312	1,851,032,797	1,912,143,500	61,110,703	7/5/2026					0	7,312	1,851,032,797	1,912,143,500	61,110,703
		RI	1,392	8,625,367,255	7,525,240,400	-1,100,126,855	7/5/2026					0	1,392	8,625,367,255	7,525,240,400	-1,100,126,855
			8,704	10,476,400,052	9,437,383,900	-1,039,016,152			0	0	0	0	8,704	10,476,400,052	9,437,383,900	-1,039,016,152

Piutang Non BPJS

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c= d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
	PERIODE APRIL 2026 :															
1	Asuransi	659,677,834	150,604,645	2,426,239	506,646,950	281,361,480	66,934,453	1,328,192	213,098,835	719,745,785	340,859,894	109,203,646	38,719,215	55,354,596	175,608,434	719,745,785
2	Perusahaan	463,061,614	252,155,610	23,702,316	187,203,688	480,948,741	64,762,307	5,270,001	410,916,433	598,120,121	532,043,079	37,650,305	7,639,739	980,883	19,806,113	598,120,119
3	Mandiri Inhealth	33,974,709	19,572,979	2,128,866	12,272,864	43,029,942	-	-	43,029,942	55,302,807	52,015,608	3,287,198	-	-	-	55,302,807
4	Jasa Raharja	742,562,456	334,103,003	184,545	408,274,907	258,290,888	55,192,788	1	203,098,099	611,373,006	547,135,699	26,704,616	3,544,879	-	33,987,813	611,373,006
5	Kantin	15,815,750	1,637,650	-	14,178,100	300,000	-	-	300,000	14,478,100	1,290,700	2,706,100	-	-	10,481,300	14,478,100
6	BPJS Ketenagakerjaan	652,237,763	399,698,270	1,923,838	250,615,655	521,025,296			521,025,296	771,640,951	662,714,819	108,926,133				771,640,952
Total Saldo										2,770,660,770	2,136,059,800	288,477,998	49,903,833	56,335,479	239,883,660	2,770,660,770

3.2.2 Cleaning Service

Tabel Data Tumpahan B3 Tahun 2026

Bulan	Lantai 1	Lantai 2	Lantai 3	IGD	HD	IKO	ICU	Total	Keterangan
Januari	-	12	1	-	5	4		22	Pembersihan tumpahan sesuai dengan sop PPI rumah sakit
Februari		4	1		1	4	1	11	Pembersihan tumpahan sesuai dengan sop PPI rumah sakit
Maret	1	2	1	9	1	2	1		Pembersihan tumpahan sesuai dengan sop PPI rumah sakit
April	2	3	1	-	-	3	-	-	Pembersihan tumpahan sesuai dengan sop PPI rumah sakit
Mei									
Juni									
Juli									
Agustus									
September									
Oktober									
Desember									

3.5.2 Humas & Marketing

Tabel kunjungan MCU dan Vaksin

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN	
		MCU	VAKSIN
1	JANUARI	283	9
2	FEBRUARI	413	3
3	MARET	345	5
4	APRIL	102	-
5	MEI		
6	JUNI		
7	JULI		
8	AGUSTUS		
9	SEPTEMBER		
10	OKTOBER		
11	NOVEMBER		
12	DESEMBER		

Permasalahan unit

NO	PERMASALAHAN	ANALISA	RTL
1	Kunjungan MCU dan Vaksin turun drastis dari sebelumnya	1. Kunjungan ke Perusahaan atau relasi belum maksimal karena staf belum bisa focus dan membagi tugas administratif unit humas marketing 2. Vaksin internasional yang mengalami penurunan karena sudah mulai memasuki musim kloter haji yang berangkat	1. Mulai pertengahan Bulan April 2026 mulai kolaborasi dengan petugas pasien experience untuk berkunjung ke FKTP dan Perusahaan / relasi minimal 1x kunjungan dalam sehari 2. Pembagian tugas dengan tim MCU / Perawat MCU untuk administratif saat ada MCU di RS

			3. Kunjungan ke Biro jasa travel untuk Kerjasama vaksin internasional
2	Update PKS baru dan perpanjangan	1. PKS dengan ED dekat belum terproses untuk <i>followup</i> perpanjangan / evaluasi 2. PKS baru yang sudah lama review draft belum ada feedback dari relasi tidak ter <i>follow up</i>	1. Inventarisasi ulang seluruh PKS agar mudah identifikasi 2. Dijalankan logbook dan jadwal harian humas agar bersinergi dengan kunjungan ke Perusahaan / relasi

3.5.3 PARKIR

Tabel Kunjungan Kendaraan dan Pendapatan

BULAN	JUMLAH KENDARAAN						TOTAL PENDAPATAN
	MOTOR		MOBIL		TRUK		
	MEMBER	UMUM	MEMBER	UMUM	MEMBER	UMUM	
Januari	14.421	24.441	5.286	5.613	-	-	114.146.000
Februari	12.858	20.882	5.105	4.504	-	-	95.463.000
Maret	13.097	20.905	4.481	4.710	-	-	95.923.000
April	15.288	24.060	4.634	5.108	-	-	109.916.000

PERMASALAHAN	ANALISA	RTL
Sistem gate out motor sering mengalami trouble dan tidak bisa digunakan	Instalasi perkabelan antara gate out mobil dan gate out motor bermasalah	Perbaiki oleh IPSRS dan IT sementara, apabila masih tidak bisa teratasi akan dilakukan oleh vendor
Area parkir yang sebagian terkena proyek, sehingga banyak pengunjung yang kesusahan mencari parkir	1. Kurangnya papan petunjuk tambahan saat rekayasa jalur sementara 2. Petugas stanby yang kurang	1. Penambahan papan petunjuk tambahan sementara 2. Jadwal petugas <i>standby</i> di area parkir barat agar bisa mengarahkan pengunjung

3.5.4 Penjaminan

3.5.4.1 Tabel Data Klaim Pending

Bulan	Klaim Pending RJ	Jumlah Berkas Klaim RJ	Klaim Pending RI	Jumlah Berkas Klaim RI
Oktober' 24	0	11.634	13	1.623
November'24	0	10.933	4	1.628
Des'24	82	10.623	226	1.493
Januari	108	9.549	268	1.376
Februari				
Maret				

kasus pending

1. reseleksi diagnosa utama, dimana secara anamnesa dan klinis menurut BPJS diagnosa sekunder lebih banyak dari pada diagnosa utama, sedangkan bila berdasarkan resource terbanyak diagnosa utama penyumbang resource terbanyak

-
2. hasil PA yang tidak terlampir, dimana hal tersebut merupakan pasien yang KRS di akhir bulan dan hasil PA membutuhkan waktu kurang lebih 14hr
 3. kasus kehamilan dimana diagnos KPD bukan merupakan tanda-tanda inpartu sehingga diagnosa yang digunakan seharusnya bukan KPD
 4. pengkodean tindakan flap bila kondisi flap hanya di bagian skin maka gunakan Radical excision of skin lesion, namun pada laporan operasi telah dijelaskan kedalamannya, dan lokasi flap tersebut
 5. kasus penerbitan surat kontrol bersamaan dengan penerbitan SEP (surat kontrol dan SEP dihari yang sama) dimana kasus tersebut adalah kasus pasien maju/mundur kontrol namun surat kontrol vklaim dihapus dan di buat baru sesuai dengan tgl pasien maju/mundur kontrol, seharusnya surat kontrol tidak dihapus namun dilakukan edit tgl kontrol sehingga tgl entri dan tgl terbit SEP akan berbeda
 6. kasus KPD pada kehamilan bukan merupakan tanda-tanda persalinan

tindak lanjut

1. koordinasi dengan DPJP terkait reseleksi diagnosa berdasarkan resource terbanyak
2. koordinasi dengan kabid penunjang medik untuk hasil PA dapat dikirim melalui email asuransi center oleh dokter patologi sehingga tidak perlu menunggu dari laborat agar proses lebih cepat
3. koordinasi dengan DPJP terkait ketentuan penegakan diagnosa KPD berdasarkan kolegium
4. bila pasien maju dan mundur kontrol maka pasien di buat surat kontrol terlebih kemudian kontrol di lain hari sesuai dengan jadwal DPJP, bila terdapat case tertentu maka bagi pasien yang maju dan mundur kontrol maka dilakukan edit tgl kontrol pada vklaim bukan menghapus surat kontrol agar tidak terdeteksi penerbitan surat kontrol dihari yang sama dengan penerbitan SEP
5. koordinasi dengan DPJP terkait kasus KPD bahwa tanda-tanda persalinan dilihat dari pembukaan pasien

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Bulan Januari Tahun 2026.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

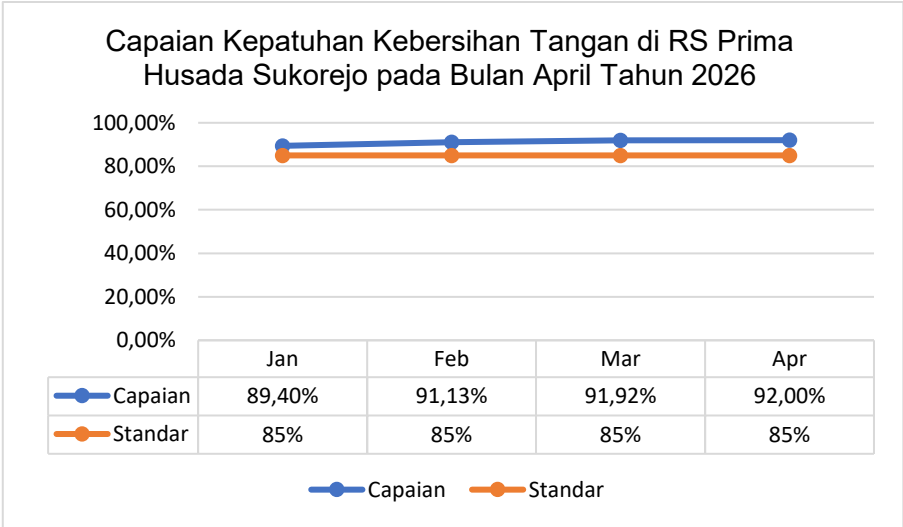
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Bulan April Tahun 2026

No	Indikator	Bulan												Standar	rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	99,40%	99,13%	99,92%	99,92%									≥85%	99,11%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	99,54%	99,82%	99,98%	99,94%									100%	99,07%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,04%	99,51%	99,51%	99,76%									100%	99,46%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	80%	80%	78,13%	60%									≥80%	74,53%	PDSA
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	98,12%	85,61%	85,83%	85,93%									≥80%		Dipertahankan
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	2,14%	1,28%	1,14%	1,57%									≤5%	1,53%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	66,21%	72,78%	72,05%	69,90%									≥80%	70,24%	PDSA
8	Waktu Laporan Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	98,24%	98,91%	98,05%	100%									≥80%	98,80%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur	99,39%	99,53%	99,60%	85,34%									≥80%	95,97%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)															
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	98,02%	98,09%	98,04%	96,82%									100%	97,74%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	96,15%	94,74%	81,82%									≥80%	93,18%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	91,80%	88,10%	89,74%	92,59%									≥76.61%	90,56%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

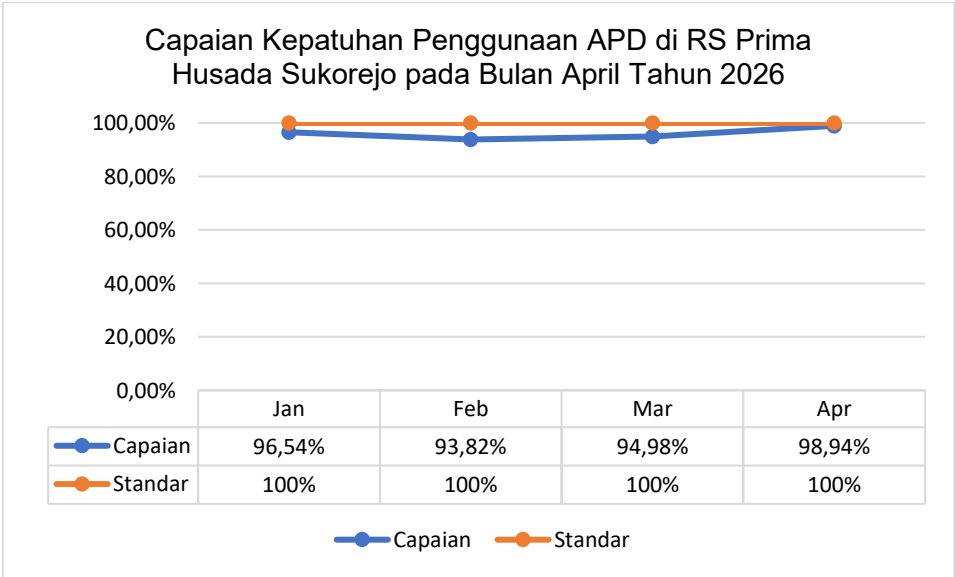


Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan April yakni mencapai 92%. Dari 1062 petugas yang diobservasi yang melakukan patuhan dengan benar yakni 977 petugas. Capaian sebesar **92%** ini menandakan bahwa mayoritas besar petugas (977 dari 1062 orang) telah menerapkan prosedur cuci tangan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun angka ini sudah berada di kategori tinggi, upaya monitoring tetap diperlukan untuk menjangkau sisa petugas yang belum konsisten dalam kepatuhan.

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Bulan April yakni mencapai 98,94%. Dari 758 petugas yang diobservasi terkait kepatuhan penggunaan APD, 750 petugas patuh dalam pemakaian APD.

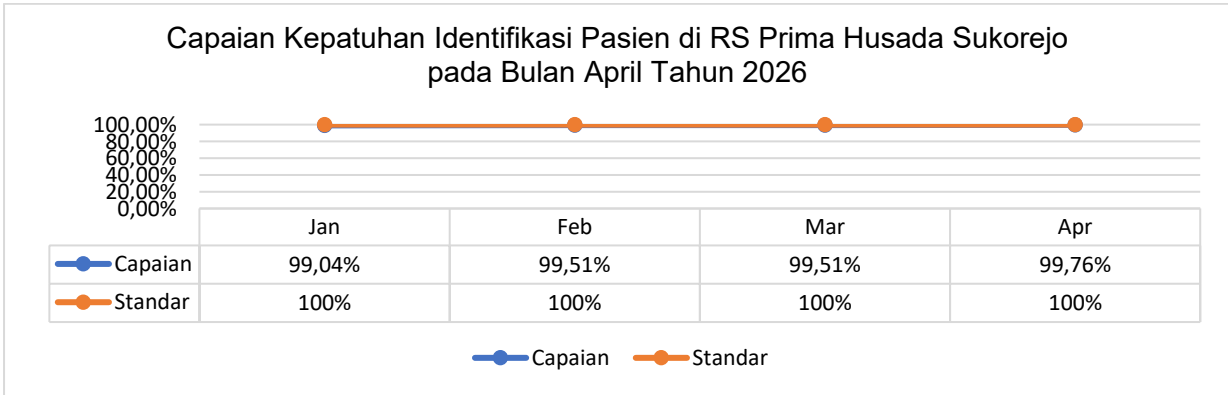
Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan April Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan APD bulan April sebesar 98,94% masih belum mencapai standar minimal (100%). Kepatuhan penggunaan APD menunjukkan tren fluktuatif selama 4 bulan terakhir, meskipun secara umum berada di atas 90%. Selain itu, kepatuhan pelaporan dan konsistensi monitoring belum berjalan optimal.
Step	1. Penguatan sistem monitoring kepatuhan APD secara konsisten di seluruh unit 2. Penguatan edukasi risiko infeksi bagi petugas
Plan	1. Objective: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD serta memastikan pelaporan kepatuhan berjalan konsisten di seluruh unit 2. Rencana intervensi: - Melakukan audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala (harian/mingguan) - Memberikan edukasi penyegaran terkait SPO APD 3. Harapan: Meningkatnya kepatuhan penggunaan APD hingga 100% serta teridentifikasinya unit dengan variasi capaian
Do	1. Melaksanakan audit mendadak oleh Tim PPI di unit pelayanan 2. Memberikan edukasi dan teguran on-the-spot kepada petugas yang ditemukan tidak patuh menggunakan APD
Study	1. Hasil Kuantitatif: Capaian April 98,94% (750/758). Meskipun tinggi, secara regulasi ini dianggap "Tidak Tercapai" karena standar adalah 100%. 2. Hasil audit akan dianalisis untuk melihat tren kepatuhan penggunaan APD selama periode observasi serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan, termasuk aspek kenyamanan, ketersediaan APD, dan perilaku petugas.
Action	1. Jika intervensi terbukti meningkatkan kepatuhan, maka audit kepatuhan APD akan dipertahankan sebagai metode monitoring rutin 2. Jika masih rendah, pendekatan edukasi dan teguran langsung akan diperkuat dengan umpan balik berbasis data kepada kepala unit untuk meningkatkan pengawasan internal

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melaksanakan audit kepatuhan APD secara rutin (harian/mingguan) sesuai jadwal monitoring	Menjaga keberlanjutan peningkatan kepatuhan APD	Seluruh unit pelayanan	Monitoring rutin berbasis checklist kepatuhan APD dan pelaporan hasil audit secara berkala	Tim PPI	1 bulan
2	Penyampaian umpan balik hasil audit kepatuhan APD kepada kepala unit secara rutin	Meningkatkan pengawasan internal dan tanggung jawab kepala unit terhadap kepatuhan APD	Kepala unit pelayanan	Feedback berbasis data hasil audit (grafik/tren kepatuhan) disampaikan secara periodik dan dibahas dalam forum evaluasi unit	Komite PMKP dan PPI	1 bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan April 2026 mencapai 99,76%. Dari 7047 petugas yang diobservasi ditemukan 7030 petugas yang patuh terhadap identifikasi pasien. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan April Tahun 2026

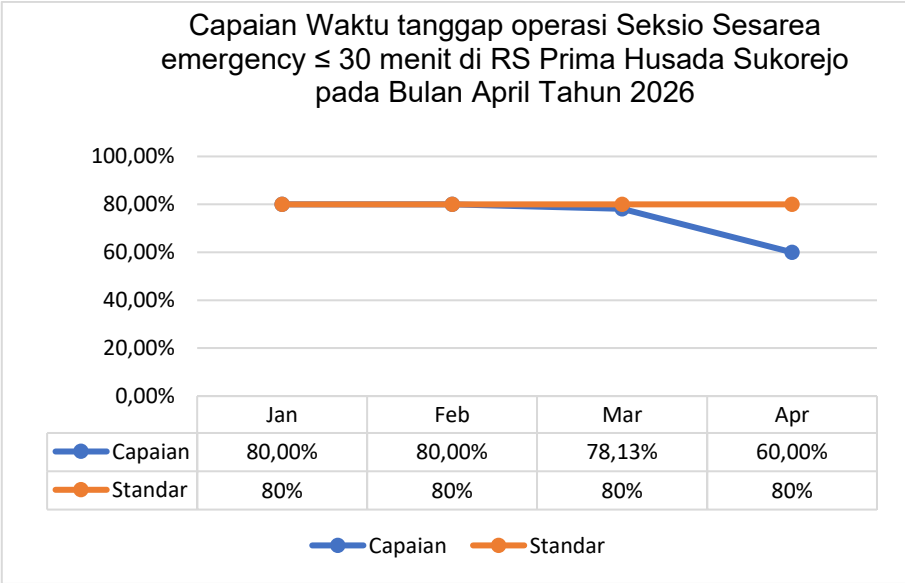
Problem	Meskipun capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan April sangat tinggi (99,76%) dan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, masih ditemukan 17 petugas (0,24%) dari 7047 observasi yang belum patuh. Ditemukan bahwa petugas tidak melakukan pengecekan gelang identitas sebelum melakukan tindakan krusial seperti: a. Pemberian Injeksi (Analgesik/Obat lain) b. Edukasi Relaksasi Napas Dalam c. Pengambilan Sampling Darah d. Pemeriksaan Gula Darah (GDA) e. Monitoring TTV f. Pemasangan Infus g. Transfusi Darah h. Pemberian Nebulisasi Hal ini menunjukkan adanya gap antara "bertanya nama" dengan "verifikasi identitas pada gelang", yang merupakan standar baku keselamatan pasien
Step	1. Mengidentifikasi data <i>by name</i> dan unit asal dari 17 petugas yang tidak melakukan verifikasi gelang untuk memetakan area dengan risiko tertinggi. 2. Melakukan wawancara kepada 17 petugas terkait dengan alasan ketidakpatuhan dalam melakukan identifikasi pasien.
Plan	1. Objective: Mencapai 100% verifikasi gelang pada setiap tindakan medis dan keperawatan. 2. Rencana intervensi: - Mewajibkan ritual "Lihat, Baca, dan Cocokkan" sebelum menyentuh pasien untuk tindakan apa pun. - Menjadwalkan kehadiran perwakilan Komite PMKP pada rapat rutin bulanan di setiap unit pelayanan untuk diseminasi data.
Do	1. Edukasi "On-the-Spot": Menegur langsung saat petugas terlihat hanya bertanya nama tanpa melihat gelang saat akan menyuntik atau mengambil darah 2. Menyerahkan data (<i>by name</i>) kepada Kepala Unit untuk dilakukan pembinaan mengenai identifikasi pasien 3. Perwakilan Komite PMKP menghadiri rapat dan mengevaluasi capaian mutu
Study	1. Hasil Analisis: Petugas cenderung melewati cek gelang pada tindakan rutin (seperti monitoring TTV atau GDA) karena merasa tindakan tersebut "ringan", padahal kesalahan identitas pada TTV atau GDA tetap dapat mengakibatkan salah diagnosa dan salah terapi oleh dokter. 2. Tindakan seperti "Injeksi Analgesik" dan "Sampling Darah" adalah titik kritis yang paling berbahaya jika gelang tidak dicek.
Action	1. Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu. 2. Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk	Memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan mengidentifikasi kendala spesifik di lapangan.	Kepala Unit dan seluruh staf klinis (Rawat Inap, IGD, IKO, dll)	Diseminasi Data Faktual: Menyajikan perbandingan data kepatuhan antar unit dan diskusi solusi	Komite PMKP	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	transparansi mutu.			atas kendala "tidak cek gelang".		
2	Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.	Meningkatkan kedisiplinan staf dan memastikan prosedur "Lihat, Baca, Cocokkan" dijalankan 100%.	Staf yang tidak patuh dalam observasi.	Kepala Ruangan memasukkan poin pelanggaran identifikasi ke dalam evaluasi kinerja staf.	Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit



Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026 belum mencapai standar yakni 60%. Dari 25 pasien yang diobservasi, masih terdapat 10 pasien yang mendapatkan pelayanan tanggap SC Emergency diatas dari 30 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga hampir seluruh operasi dilakukan secara tepat.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit pada Bulan April Tahun 2026

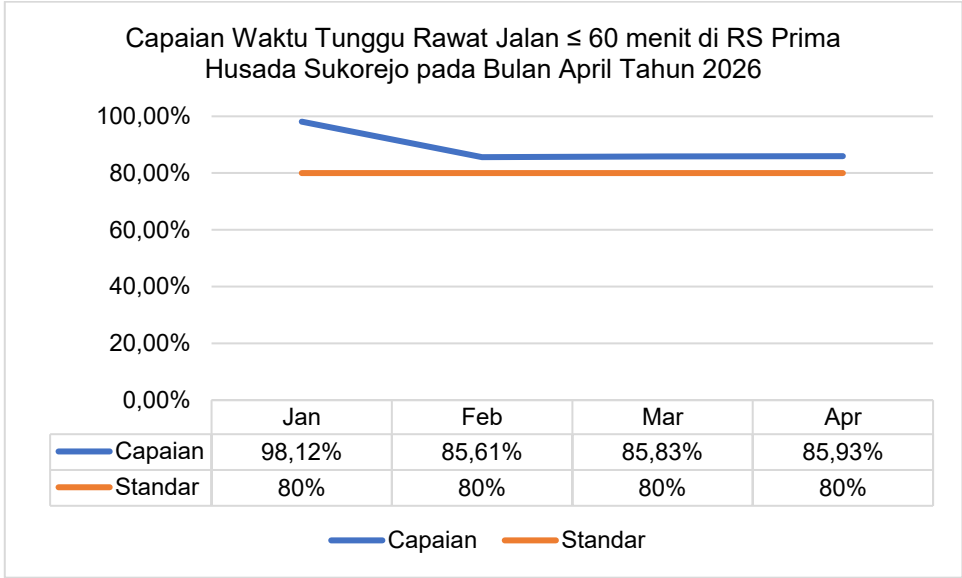
Problem	Capaian waktu tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit pada bulan April adalah 60%. Capaian ini mengalami penurunan dari bulan ke bulan.
Step	1. Mengidentifikasi alasan keterlambatan waktu tanggap SC Emergency melalui data laporan dan wawancara PIC dari unit Maternitas dan Ponek. 2. Hasilnya diketahui jarak tempuh dari kediaman dokter ke RS rata-rata memakan waktu > 30 menit sehingga target sulit tercapai
Plan	1. Objective: mencapai target waktu SC Emergency ≥ 80 menit 2. Melakukan sosialisasi dan supervisi terhadap kepatuhan waktu tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit
Do	1. Melakukan pertemuan koordinasi dengan tim Ponek dan Maternitas untuk menyosialisasikan pentingnya kepatuhan waktu tanggap ≤ 30 menit. 2. Melakukan supervisi langsung pada saat terjadi kasus SC Emergency untuk memastikan prosedur pemanggilan dokter dilakukan tepat waktu.
Study	Kasus keterlambatan disebabkan oleh jarak tempuh DPJP yang > 30 menit karena pada saat Emergency DPJP tidak di Rumah Sakit, kecuali DPJP sudah stan by di Rumah Sakit

Action	1. Sosialisasi kepada seluruh staf dan DPJP mengenai kepatuhan waktu tanggap seksio sesarea emergency <30 menit 2. Supervisi dan evaluasi secara berkala
---------------	---

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Sosialisasi kepada seluruh staf dan DPJP mengenai kepatuhan waktu tanggap seksio sesarea emergency <30 menit	Meningkatkan pemahaman staf dan DPJP terkait target mutu	Seluruh staf Ponek, OK, Anestesi, dan DPJP Obgyn	Melakukan Sosialisasi ulang mengenai SPO SC Emergency < 30 menit serta memaparkan data <i>gap</i> 1,87% bulan April sebagai dasar evaluasi	Komite PMKP & Kepala Ruangan	1 bulan
2	Supervisi dan evaluasi secara berkala	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Melaksanakan Supervisi langsung pada setiap kasus SC Cito untuk memantau waktu respon mulai dari keputusan dokter sampai insisi	Komite PMKP & Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



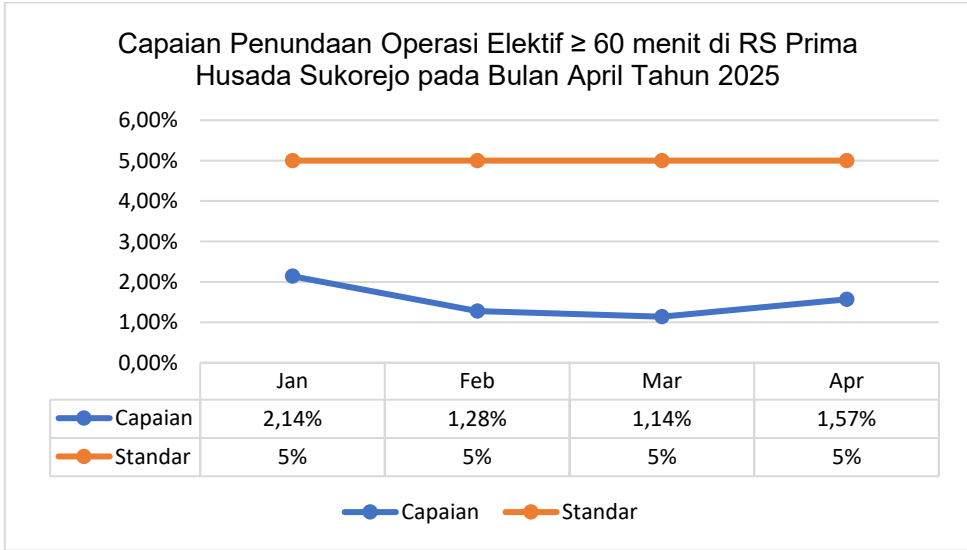
Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026 mencapai 85,93%. Hasil capaian ini berarti dari total pasien yang terdaftar dan menunggu poli, yakni 9.045 pasien. Total pasien yang berhasil menunggu dan dilayani dokter dalam waktu kurang dari 60 menit adalah sebanyak 7.772 pasien. Capaian 85,93% ini **telah melampaui** standar minimum yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan, yaitu ≥ 80%. Dengan rata – rata waktu tunggu poli yakni 56 menit. Data ini diambil dalam fitur **Antrian Online** dari **Mobile JKN**.
 Capaian diatas mengartikan rumah sakit memanfaatkan fitur **Antrian Online** dari **Mobile JKN** secara maksimal, sehingga pasien datang sudah terdaftar dan siap dilayani (mengurangi *waiting*

time di loket). Dan juga data yang diambil langsung dari *database* BPJS lebih akurat, mengurangi waktu yang terbuang untuk koreksi data administrasi.

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit



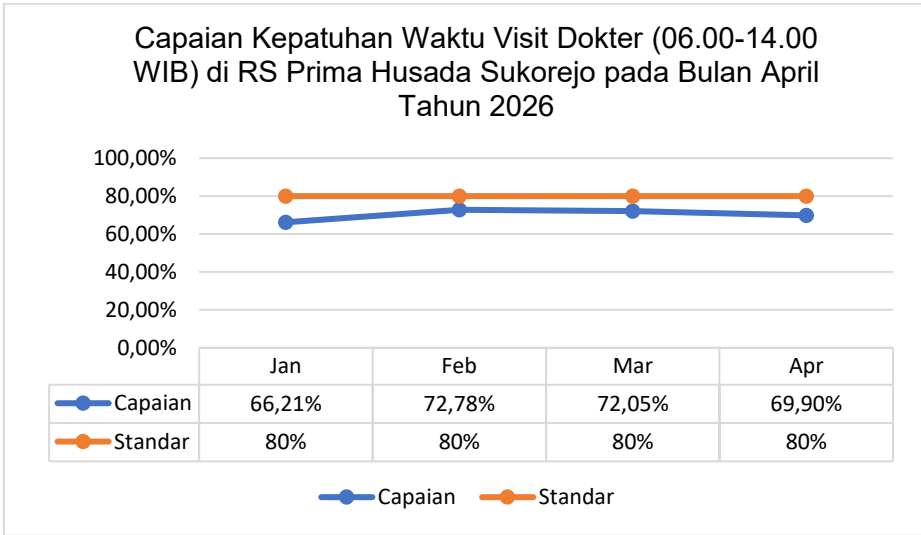
Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026.

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan April tahun 2026 yakni 1,57%. Capaian ini sudah mencapai standar <5%. Ini dikarenakan dari 381 pasien yang diobservasi 6 pasien dengan operasi elektif yang mengalami penundaan lebih dari 1 jam. Faktor pendukung keberhasilan ini dikarenakan:

- a. Kesiapan pasien: proses administrasi, pemeriksaan penunjang (laboratorium/rontgen) dan puasa pasien dilakukan dengan tepat
- b. Kehadiran dokter operator, dokter anestesi dan perawat tim IKO tepat sesuai jadwal
- c. Ketersediaan alat bedah yang steril siap digunakan tepat waktu sesuai antrean operasi
- d. Perpindahan pasien dari ruang rawat inap ke ruang IKO sesuai jadwal

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 69,90% belum memenuhi standar minimal ≥ 80%. Ini dikarenakan dari 804 yang dibservasi dalam visite ke pasien, hanya 562 pasien yang di visit dokter kurang dari jam 14.00 WIB.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Bulan April Tahun 2026

Problem	Capaian waktu visite dokter spesialis pada bulan April 2026 sebesar 69,90%, masih di bawah standar minimal ≥ 80%. Dari 804 observasi, terdapat 242 pasien yang
---------	--

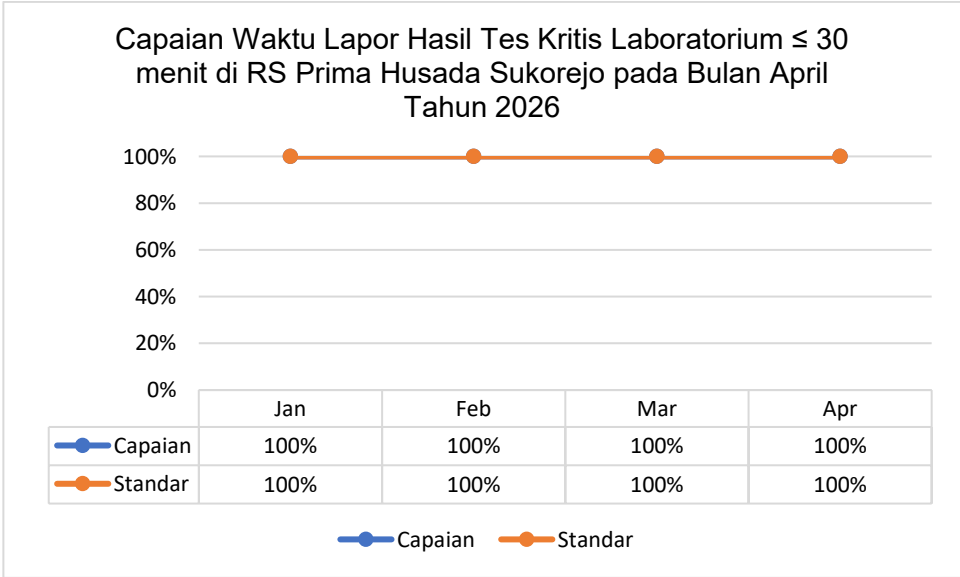
	mendapatkan visite di atas jam 14.00 WIB. Kondisi ini berisiko menunda rencana terapi dan proses pemulangan pasien.
Step	1. Mapping Jadwal: Mengidentifikasi jam praktik dokter spesialis di RS lain untuk menentukan prioritas kunjungan pagi. 2. Review Progress Rekrutmen: Melakukan koordinasi dengan bagian SDM mengenai status rekrutmen dokter ruangan (dokter tetap) untuk mengisi kekosongan tenaga medis pendamping.
Plan	1. Objective: Meningkatkan kepatuhan visite menjadi $\geq 80\%$ dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 2. Strategi: Mempercepat proses rekrutmen dokter ruangan dan meningkatkan peran perawat senior dalam memfasilitasi persiapan asuhan medis.
Do	1. Percepatan Rekrutmen: Bagian SDM memprioritaskan seleksi dokter ruangan agar segera ada tenaga medis yang <i>standby</i> di RS. 2. Bidan/Perawat melakukan konfirmasi (reminder) via WhatsApp kepada dokter spesialis pada jam 10.00 pagi 3. Perawat ruangan secara aktif menyiapkan kelengkapan pemeriksaan (berkas/hasil penunjang) agar saat dokter spesialis datang di sela jadwal praktiknya, proses visite bisa berlangsung lebih cepat.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? 1. Capaian bulan April sebesar 69,90% masih berada di bawah target standar minimal $\geq 80\%$. 2. Mayoritas dokter spesialis memiliki jadwal praktik di Rumah Sakit lain atau Klinik pada jam utama (06.00 – 14.00 WIB), sehingga waktu untuk melakukan visite di RS Prima Husada Sukorejo menjadi sangat terbatas dan sering tergeser ke atas jam 14.00 WIB. 3. Saat ini belum tersedia Dokter Ruangan karena proses rekrutmen masih berjalan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tenaga medis tetap yang dapat membantu melakukan pemeriksaan awal atau mendampingi dokter spesialis saat visite pagi. 4. Beban Kerja Tinggi: Terbatasnya jumlah dokter <i>home base</i> menyebabkan penumpukan beban visite pasien rawat inap pada dokter mitra yang memiliki mobilitas tinggi antar fasilitas kesehatan. 5. Dampak Operasional: Ketidakpatuhan waktu visite ini berdampak pada tertundanya rencana asuhan pasien (pemeriksaan penunjang/terapi) serta menghambat proses pemulangan pasien (<i>discharge</i>) tepat waktu
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan siklus PDSA yang telah dijalankan pada bulan April 2026, dapat disimpulkan bahwa: 1. Capaian kepatuhan waktu visite dokter spesialis (69,90%) belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). 2. Akar masalah utama bersifat sistemik, yaitu adanya bentrok jadwal praktik dokter di fasilitas kesehatan lain pada jam utama (06.00–14.00 WIB) serta kekosongan posisi Dokter Ruangan yang saat ini masih dalam proses rekrutmen. How-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melaksanakan proses rekrutmen terbuka dokter umum di bulan April 2026 untuk ditempatkan sebagai dokter ruangan (Senin-Jumat dan Sabtu). 2. Mempercepat proses kredensial dokter baru 3. Evaluasi Penempatan: Melakukan orientasi cepat bagi dokter ruangan baru mengenai standar akreditasi dan prosedur visite sebelum jam 14.00 WIB agar dampak kehadirannya langsung terasa pada capaian indikator bulan berikutnya

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelaksanaan <i>Open Recruitment</i> (Rekrutmen Terbuka) Dokter Umum sebagai	Memenuhi kebutuhan Dokter Ruangan agar proses pendelegasia	Tenaga Medis (Dokter Umum).	Mempublikasikan lowongan kerja secara luas dan melakukan seleksi cepat untuk mengisi	SDM dan Kabid Pelayanan Medis.	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
	dokter ruangan	n visite di hari kerja (Senin-Jumat) dan Sabtu berjalan optimal tanpa membebani Dokter IGD.		posisi dokter ruangan khusus <i>home-base</i> .		
2	Mempercepat proses kredensial dokter baru	Memastikan legalitas dan kewenangan klinis dokter baru	Tenaga Medis (Dokter Umum).	Melakukan percepatan proses kredensial (Fast Track) melalui verifikasi ijazah/STR	SDM dan Kabid Pelayanan Medis.	1 bulan
3	Orientasi Khusus & Sosialisasi Standar Akreditasi	Memastikan dokter baru memahami prosedur visite tepat waktu sebelum jam 14.00 WIB	Dokter Ruangan Baru	Memberikan <i>briefing</i> mendalam mengenai indikator mutu nasional (INM) dan dampak kepatuhan visite terhadap keselamatan pasien.	Komite PMKP, Bidang Pelayanan, SDM	Saat awal pene mpatan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

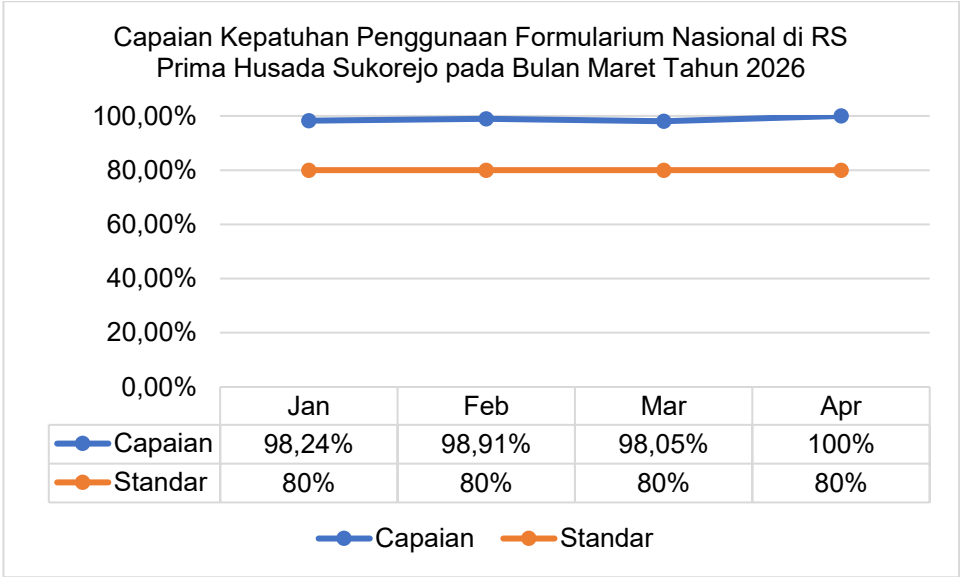


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan April Tahun 2026 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

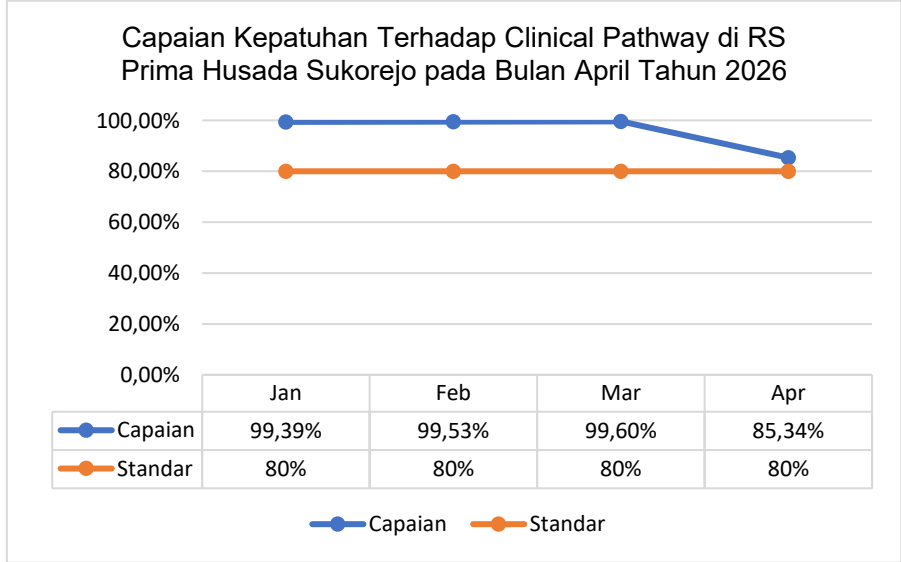


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepsan obat hanya dari Formularium Nasional. Dari 117 obat yang diobservasi, seluruhnya sudah sesuai dengan formularium nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

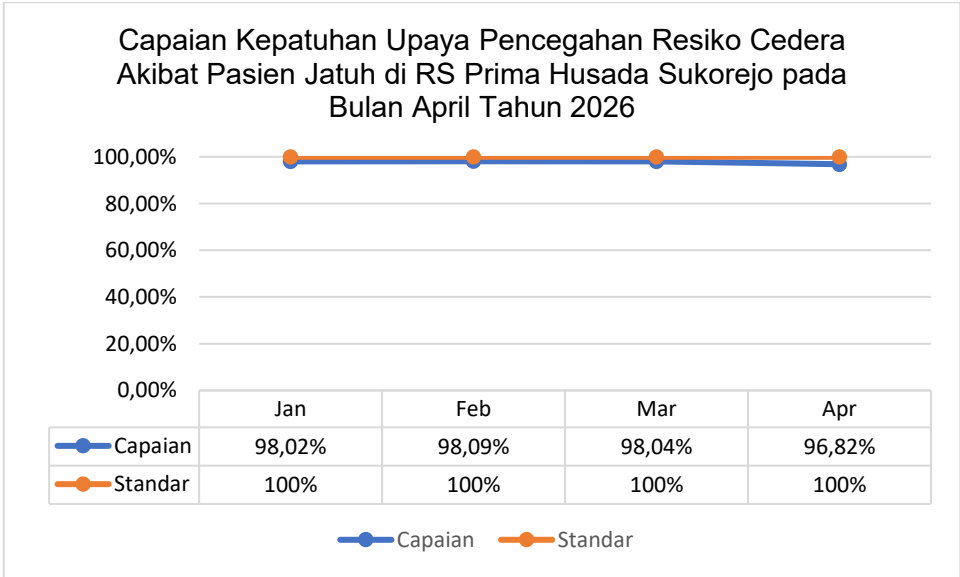


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan April Tahun 2026 telah mencapai standar yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan April didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Prematurus, Seksio Cesarea, TB Paru, Pneumonia, Bacterial Pneumonia, Tifoid, dan Bronchopneumonia.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Bulan April tahun 2026 adalah 96,82%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1476 pasien yang diobservasi, 1429 pasien dilakukan upaya pencegahan risiko jatuh secara benar.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2026

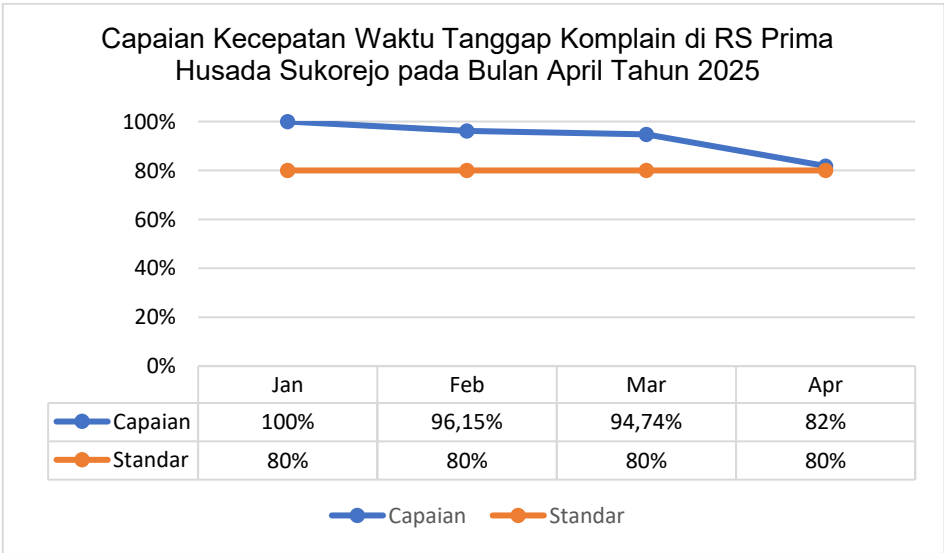
Problem	Capaian kepatuhan pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan April 2026 sebesar 96,82% , masih di bawah target mutlak 100% . Dari 1476 pasien, terdapat 47 pasien (3,18) yang tidak mendapatkan perlindungan risiko jatuh secara standar. Berdasarkan audit visual, ditemukan: 1. Pasien risiko tinggi tidak ada tanda risiko jatuh di bed pasien. 2. <i>Handrail</i> tempat tidur tidak terpasang/terkunci. 3. Kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh. 4. Tidak identifikasi gelang pasien dengan risiko jatuh
Step	1. Audit Logistik: Memastikan ketersediaan stok stiker risiko jatuh di setiap <i>nurse station</i>. 2. Pengecekan Fasilitas: Melakukan inspeksi terhadap kondisi <i>handrail</i> tempat tidur di seluruh ruang perawatan untuk memastikan fungsi kuncinya masih baik.
Plan	1. Objective: Mencapai tingkat kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 100% pada periode audit berikutnya melalui penguatan pengawasan fasilitas dan edukasi keluarga. 2. Strategi: Optimalisasi Penandaan: Mewajibkan pemasangan tanda risiko jatuh pada tempat tidur segera setelah skor asesmen menunjukkan risiko tinggi.
Do	1. Pemasangan Atribut: Petugas wajib memasang stiker kuning di bed pasien segera setelah asesmen awal menunjukkan skor risiko tinggi. 2. Perawat memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien mengenai cara menjaga <i>handrail</i> tetap terpasang dan cara memanggil bantuan.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Ketidakpatuhan (3,18%) sering terjadi karena petugas lupa memasang tanda risiko jatuh saat pasien baru datang atau saat beban kerja tinggi. 2. <i>Handrail</i> yang tidak terpasang sering kali disebabkan oleh keluarga pasien yang menurunkannya dan perawat tidak segera mengecek ulang saat ronde.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Bulan April Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 96,82% llow-up dan Rencana Lanjutan

	1. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan temuan 47 pasien tidak patuh tersebut dalam rapat unit sebagai pengingat risiko cedera kepala atau patah tulang jika pasien jatuh. 2. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bertanggung jawab pada 47 kasus ketidakpatuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan. 3. Redesign Monitoring: Mewajibkan pengecekan <i>handrail</i> menjadi bagian dari <i>checklist</i> operan perawat setiap pergantian <i>shift</i>.
--	--

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi pencegahan cedera (patah tulang/cedera kepala) akibat jatuh.	Seluruh staf klinis di unit rawat inap.	Memaparkan data 47 pasien tidak patuh secara transparan sebagai bahan evaluasi dan pengingat risiko klinis	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan standar prosedur keselamatan pasien.	47 Petugas yang teridentifikasi tidak patuh.	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	<i>Redesign Monitoring</i> melalui <i>Checklist</i> Operan.	Menjamin fasilitas keamanan (<i>handrail</i>) dan tanda risiko selalu terpasang di setiap pergantian <i>shift</i> .	Fasilitas tempat tidur pasien risiko tinggi.	Mewajibkan pengecekan fisik <i>handrail</i> dan stiker sebagai item wajib dalam <i>bedside handover</i> (operan di samping bed).	Perawat Pelaksana & Karu	1 bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

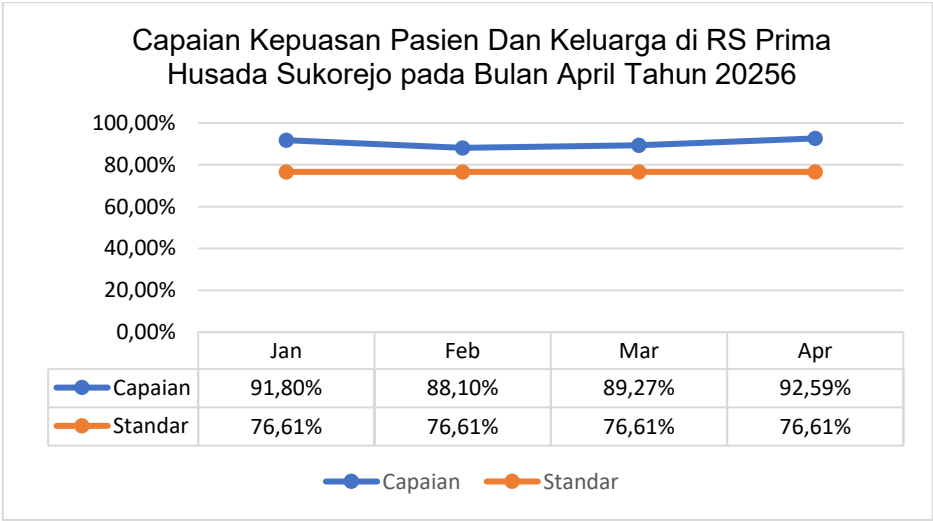


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Bulan April Tahun 2026 yakni 82% dan sesuai standar yakni $\geq 80\%$. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan April Tahun 2026 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 92,59%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Bulan April Tahun 2026

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,04%	99,51%	99,51%	99,76%									100%	99,35%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	98,28%	97,35%	99,43%									100%	98,28%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert	-	-	-	90,17%									100%	90,17%	PDSA
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur	-	-	-	-									100%		

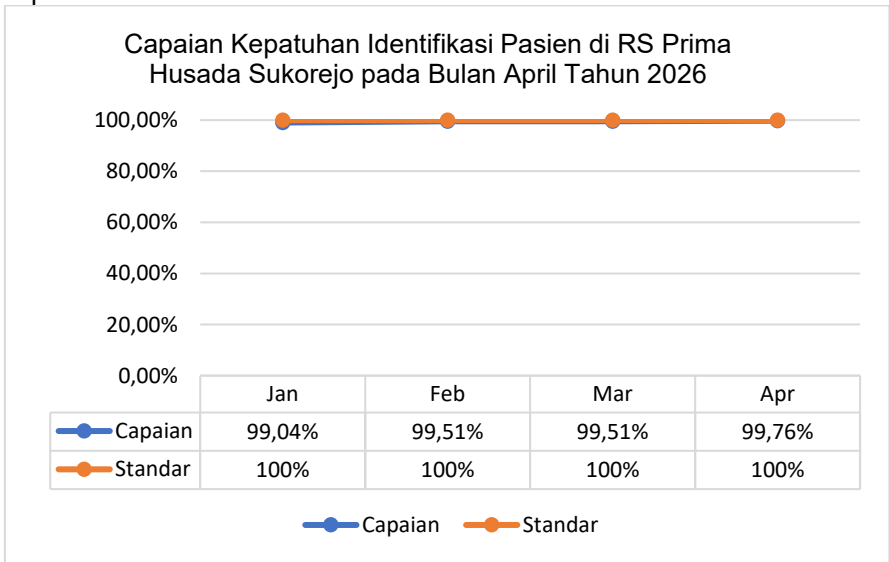
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien															
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40%	91,13%	91,92%	92%									85%	90,81%	Dipertahankan
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,02%	98,09%	98,04%	96,82%									100%	98,05%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi complain pasca rawat															Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		2. Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan Komplikasi															Dipertahankan
3	Renstra RS	1. Presentase Pasien Complain															Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit	85,93%	84,17%	83%	86%									≥80%	84,78%	Dipertahankan
		2. Waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit	75,56%	75%	70%	78%									≥80%	74,64%	PDSA
5	Manajemen Resiko	1. Presentase berkas pending klaim	3,49%	3,81%	3,79%										<5%		
		2. Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan April 2026 mencapai 99,76%. Dari 7047 petugas yang diobservasi ditemukan 7030 petugas yang patuh terhadap identifikasi pasien. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan April Tahun 2026

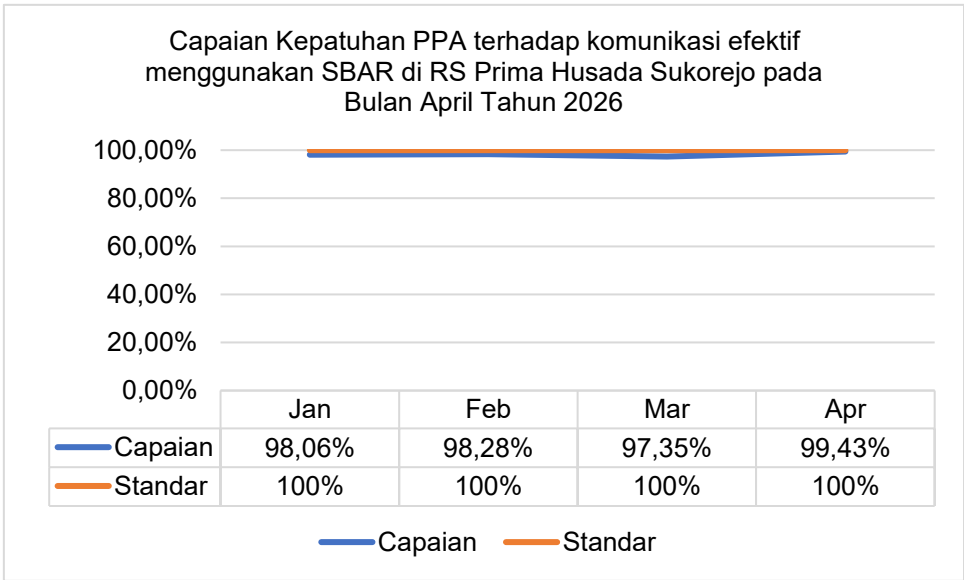
Problem	Meskipun capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan April sangat tinggi (99,76%) dan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, masih ditemukan 17 petugas (0,24%) dari 7047 observasi yang belum patuh. Ditemukan bahwa petugas tidak melakukan pengecekan gelang identitas sebelum melakukan tindakan krusial seperti: i. Pemberian Injeksi (Analgesik/Obat lain) j. Edukasi Relaksasi Napas Dalam k. Pengambilan Sampling Darah l. Pemeriksaan Gula Darah (GDA) m. Monitoring TTV n. Pemasangan Infus o. Transfusi Darah p. Pemberian Nebulisasi Hal ini menunjukkan adanya gap antara "bertanya nama" dengan "verifikasi identitas pada gelang", yang merupakan standar baku keselamatan pasien
Step	3. Mengidentifikasi data <i>by name</i> dan unit asal dari 17 petugas yang tidak melakukan verifikasi gelang untuk memetakan area dengan risiko tertinggi. 4. Melakukan wawancara kepada 17 petugas terkait dengan alasan ketidakpatuhan dalam melakukan identifikasi pasien.
Plan	3. Objective: Mencapai 100% verifikasi gelang pada setiap tindakan medis dan keperawatan. 4. Rencana intervensi: - Mewajibkan ritual "Lihat, Baca, dan Cocokkan" sebelum menyentuh pasien untuk tindakan apa pun. - Menjadwalkan kehadiran perwakilan Komite PMKP pada rapat rutin bulanan di setiap unit pelayanan untuk diseminasi data.
Do	4. Edukasi "On-the-Spot": Menegur langsung saat petugas terlihat hanya bertanya nama tanpa melihat gelang saat akan menyuntik atau mengambil darah 5. Menyerahkan data (<i>by name</i>) kepada Kepala Unit untuk dilakukan pembinaan mengenai identifikasi pasien

	6. Perwakilan Komite PMKP menghadiri rapat dan mengevaluasi capaian mutu
Study	3. Hasil Analisis: Petugas cenderung melewati cek gelang pada tindakan rutin (seperti monitoring TTV atau GDA) karena merasa tindakan tersebut "ringan", padahal kesalahan identitas pada TTV atau GDA tetap dapat mengakibatkan salah diagnosa dan salah terapi oleh dokter. 4. Tindakan seperti "Injeksi Analgesik" dan "Sampling Darah" adalah titik kritis yang paling berbahaya jika gelang tidak dicek.
Action	1. Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu. 2. Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu.	Memaparkan data data ketidakpatuhan secara transparan dan mengidentifikasi kendala spesifik di lapangan.	Kepala Unit dan seluruh staf klinis (Rawat Inap, IGD, IKO, dll)	Diseminasi Data Faktual: Menyajikan perbandingan data kepatuhan antar unit dan diskusi solusi atas kendala "tidak cek gelang".	Komite PMKP	1 bulan
2	Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.	Meningkatkan kedisiplinan staf dan memastikan prosedur "Lihat, Baca, Cocokkan" dijalankan 100%.	Staf yang tidak patuh dalam observasi.	Kepala Ruangan memasukkan poin pelanggaran identifikasi ke dalam evaluasi kinerja staf.	Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan April Tahun 2026 yakni 99,43%. meskipun angkanya tergolong tinggi capaiannya masih dibawah standar 100%. Dari 1588 sbar pasien yang diobservasi, 1579 sbar lengkap. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

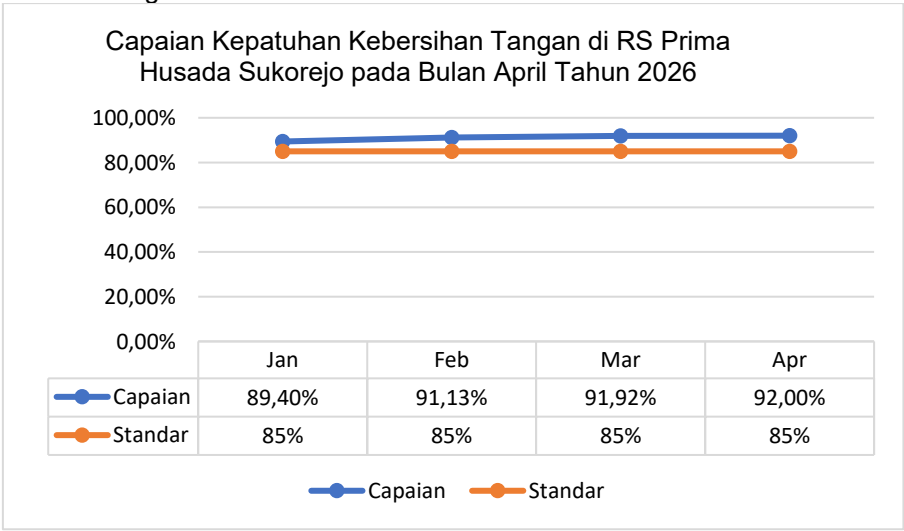
Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan April Tahun 2026

Problem	Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif SBAR pada bulan April 2026 sebesar 99,43%, masih di bawah standar 100%. Dari 9 data tidak patuh, ditemukan masalah serius yaitu instruksi dokter via WhatsApp tidak dituangkan ke dalam form SBAR dan adanya form yang tidak ditandatangani oleh penerima pesan. Hal ini berisiko pada legalitas instruksi medis dan keselamatan pasien
Step	1. Audit Kepatuhan TBAK: Meninjau kembali prosedur Konfirmasi (TBAK: Tulis, Baca, Konfirmasi) khusus untuk instruksi via media sosial/pesan singkat (WA). 2. Review Rekam Medis: Mengidentifikasi unit-unit yang sering menerima <i>advice</i> via WA namun lalai mencatatnya di lembar SBAR terintegrasi.
Plan	1. Objective: Mencapai kepatuhan 100% dengan fokus pada pendokumentasian instruksi verbal/pesan singkat 2. Strategi: Memperketat pengawasan terhadap instruksi "Advice WA" agar wajib disalin ke form SBAR dalam waktu maksimal 1x24 jam dan ditandatangani. 3. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala
Do	1. Edukasi Khusus: Mengingatkan PPA bahwa instruksi via WA tetap harus mengikuti prosedur SBAR/TBAK sebagai bukti legal di rekam medis. 2. Verifikasi Penerima: Mewajibkan kepala tim untuk mengecek kelengkapan TTD penerima pesan sebelum pergantian <i>shift</i> . 3. Kepala Ruangan mengecek kelengkapan TTD instruksi SBAR di setiap akhir <i>shift</i>
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada bulan Bulan April Tahun 2026 yakni 99,43%. 2. Hasil Analisis: Ketidakpatuhan (0,57%) disebabkan oleh anggapan bahwa instruksi di WA sudah cukup kuat sebagai bukti, sehingga petugas malas/lupa menyalinnya ke rekam medis. 3. Temuan: Adanya kelalaian administratif berupa TTD yang tertinggal karena petugas terburu-buru melakukan tindakan setelah menerima instruksi.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Bulan April Tahun 2026 yakni 98,35% . Capaian 99,43% belum memenuhi standar minimal 100% karena masih ditemukan instruksi via WhatsApp yang tidak dilakukan SBAR dan ketiadaan TTD penerima pesan. Ilow-up dan Rencana Lanjutan 1. Sosialisasi Prosedur "Advice WA": Menegaskan kembali bahwa instruksi melalui pesan singkat (WhatsApp) memiliki status yang sama dengan instruksi verbal, sehingga wajib dilakukan prosedur TBAK (Tulis, Baca, Konfirmasi) dan dicatat dalam rekam medis. 2. Audit Tanda Tangan Penerima: Mewajibkan Kepala Ruangan untuk melakukan <i>spot check</i> setiap akhir <i>shift</i> guna memastikan seluruh instruksi telepon/WA sudah ditandatangani oleh penerima pesan. 3. Pembinaan Personal "By Name": Memberikan edukasi lisan kepada 9 petugas yang teridentifikasi tidak patuh untuk memahami risiko hukum jika instruksi medis tidak terdokumentasi dengan lengkap. 4. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Diseminasi Data & Sosialisasi TBAK Digital.	Memastikan PPA memahami bahwa instruksi WA harus disalin ke rekam medis (SBAR).	Seluruh Perawat, Bidan, dan Dokter.	Menekankan aspek legalitas rekam medis sebagai perlindungan hukum bagi PPA.	Komite PMKP	1 bulan
2	Supervisi Kelengkapan Administrasi (TTD).	Menghilangkan <i>gap</i> administratif pada kolom tanda tangan penerima pesan.	Berkas Rekam Medis (Lembar SBAR/CPPT).	Melakukan kroscek antara grup koordinasi WA unit dengan catatan di rekam medis.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	Monitoring Pasca-Intervensi.	Mengevaluasi efektivitas edukasi terhadap pencapaian target 100%.	Unit Pelayanan Rawat Inap & IGD	Membandingkan data kepatuhan SBAR bulan April dengan April 2026.	Tim Mutu	Akhir April 2026

c. Kebersihan Tangan

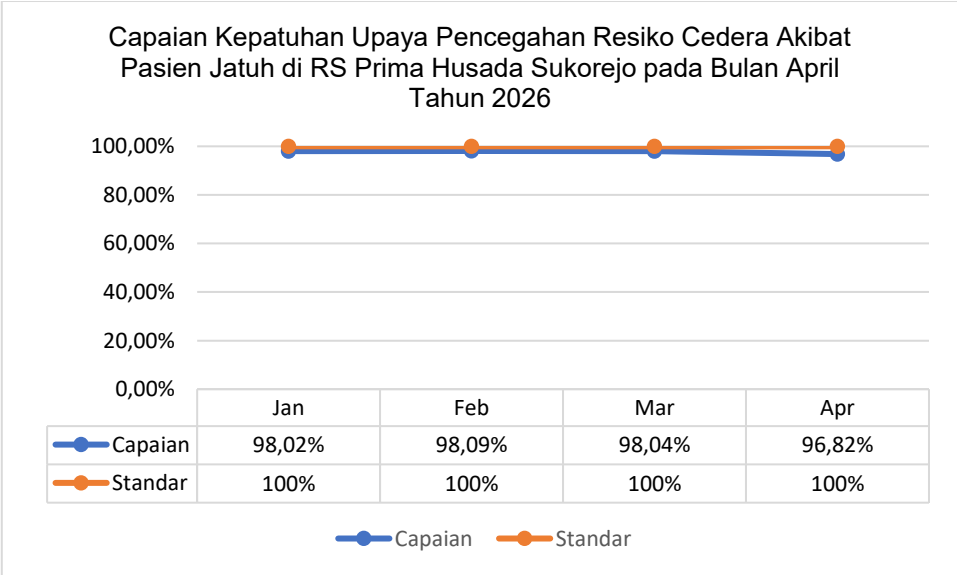


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan April yakni mencapai 92%. Dari 1062 petugas yang diobservasi yang melakukan patuhan dengan benar yakni 977 petugas. Capaian sebesar **92%** ini menandakan bahwa mayoritas besar petugas (977 dari 1062 orang) telah menerapkan prosedur cuci tangan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun angka ini sudah berada di kategori tinggi, upaya monitoring tetap diperlukan untuk menjangkau sisa petugas yang belum konsisten dalam kepatuhan.

d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Bulan April tahun 2026 adalah 96,82%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 1476 pasien yang diobservasi, 1429 pasien dilakukan upaya pencegahan risiko jatuh secara benar.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan April 2026 sebesar 96,82% , masih di bawah target mutlak 100% . Dari 1476 pasien, terdapat 47 pasien (3,18) yang tidak mendapatkan perlindungan risiko jatuh secara standar. Berdasarkan audit visual, ditemukan: 5. Pasien risiko tinggi tidak ada tanda risiko jatuh di bed pasien. 6. <i>Handrail</i> tempat tidur tidak terpasang/terkunci. 7. Kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh. 8. Tidak identifikasi gelang pasien dengan risiko jatuh
Step	3. Audit Logistik: Memastikan ketersediaan stok stiker risiko jatuh di setiap <i>nurse station</i> . 4. Pengecekan Fasilitas: Melakukan inspeksi terhadap kondisi <i>handrail</i> tempat tidur di seluruh ruang perawatan untuk memastikan fungsi kuncinya masih baik.
Plan	3. Objective: Mencapai tingkat kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 100% pada periode audit berikutnya melalui penguatan pengawasan fasilitas dan edukasi keluarga. 4. Strategi: Optimalisasi Penandaan: Mewajibkan pemasangan tanda resiko jatuh pada tempat tidur segera setelah skor asesmen menunjukkan risiko tinggi.
Do	3. Pemasangan Atribut: Petugas wajib memasang stiker kuning di bed pasien segera setelah asesmen awal menunjukkan skor risiko tinggi. 4. Perawat memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien mengenai cara menjaga <i>handrail</i> tetap terpasang dan cara memanggil bantuan.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 3. Ketidakpatuhan (3,18%) sering terjadi karena petugas lupa memasang tanda resiko jatuh saat pasien baru datang atau saat beban kerja tinggi. 4. <i>Handrail</i> yang tidak terpasang sering kali disebabkan oleh keluarga pasien yang menurunkannya dan perawat tidak segera mengecek ulang saat ronde.
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Bulan April Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 96,82% llow-up dan Rencana Lanjutan

	4. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan temuan 47 pasien tidak patuh tersebut dalam rapat unit sebagai pengingat risiko cedera kepala atau patah tulang jika pasien jatuh. 5. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bertanggung jawab pada 47 kasus ketidakpatuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan. 6. Redesign Monitoring: Mewajibkan pengecekan <i>handrail</i> menjadi bagian dari <i>checklist</i> operan perawat setiap pergantian <i>shift</i>.
--	---

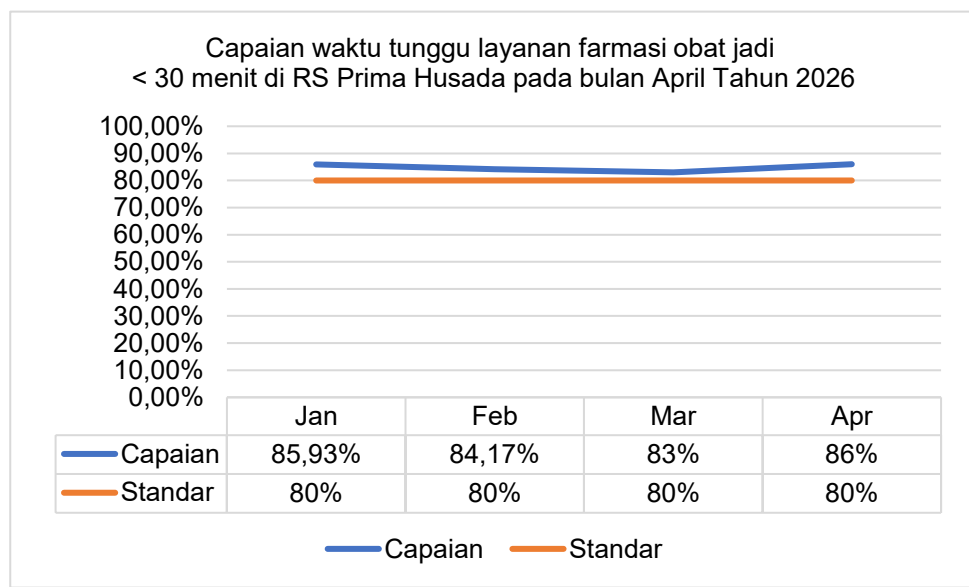
Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi pencegahan cedera (patah tulang/cedera kepala) akibat jatuh.	Seluruh staf klinis di unit rawat inap.	Memaparkan data 47 pasien tidak patuh secara transparan sebagai bahan evaluasi dan pengingat risiko klinis	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan standar prosedur keselamatan pasien.	47 Petugas yang teridentifikasi tidak patuh.	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	<i>Redesign Monitoring</i> melalui <i>Checklist</i> Operan.	Menjamin fasilitas keamanan (<i>handrail</i>) dan tanda risiko selalu terpasang di setiap pergantian <i>shift</i> .	Fasilitas tempat tidur pasien risiko tinggi.	Mewajibkan pengecekan fisik <i>handrail</i> dan stiker sebagai item wajib dalam <i>bedside handover</i> (operan di samping bed).	Perawat Pelaksana & Karu	1 bulan

2. **Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas**
 - a. Tingkat Kesesuaian Ukuran Tumor dengan Hasil PA
 - b. Kepatuhan PPK/CP Tumor Jaringan Lunak
 - c. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi komplain pasca rawat
 - d. Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan Komplikasi
3. **Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS**
 - a. Presentase Pasien Complain

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

a. Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit

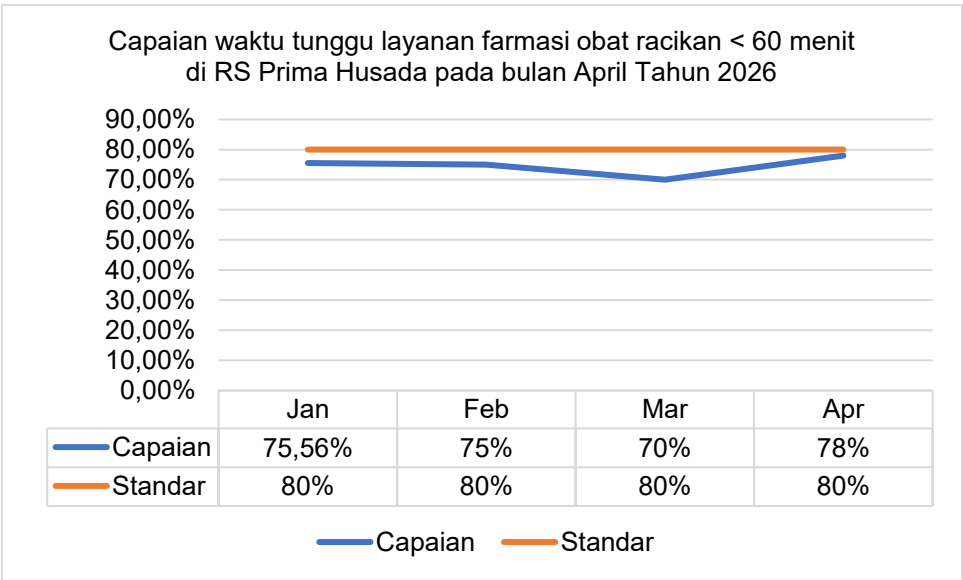


Gambar 3.19. Capaian Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Jadi < 30 Menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit pada Bulan April tahun 2026 adalah 86%. Angka tersebut telah mencapai target 80%. Dari 125 resep yang diobservasi, 107 resep yang selesai < 30 menit.

b. Waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit



Gambar 3.20. Capaian Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Racikan < 60 Menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada Bulan April tahun 2026 adalah 78%. Angka tersebut belum mencapai target 80%. Dari 125 resep yang diobservasi, 98 resep yang selesai < 60 menit.

Tabel 3.22 PDSA Capaian Waktu Tunggu Obat Racikan < 60 Menit pada Tahun 2026

Problem	Capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan April 2026 sebesar 78%, masih di bawah target 80%. Dari 125 resep, terdapat 27 resep (28%) yang selesai > 60 menit
Step	1. Analisis Beban Kerja: Menghitung jumlah resep per petugas di jam sibuk

	2. Observasi Alur (<i>Time Motion Study</i>): Mengamati di tahap mana (pengetikan, menumbuk, atau mengemas) yang paling lambat 3. Wawancara Staf: Mencari tahu kendala teknis yang dirasakan petugas
Plan	1. Memisahkan alur pelayanan resep racikan dan non racikan 2. Menyediakan petugas khusus peracikan pada jam sibuk 3. Menyiapkan bahan dan kemasan racikan yang sering digunakan 4. Menggunakan sistem antrian dan pencatatan waktu (mulai–selesai) 5. Menginformasikan estimasi waktu tunggu kepada pasien 6. Melakukan briefing harian terkait pembagian tugas
Do	1. Melaksanakan pemisahan alur pelayanan racikan 2. Menugaskan petugas khusus racikan pada jam puncak. 3. Mencatat waktu penerimaan resep dan waktu penyerahan obat 4. Menyediakan bahan racikan yang sering digunakan di area peracikan 5. Memberikan edukasi kepada pasien mengenai estimasi waktu tunggu
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan April 2026 sebesar 78%, masih di bawah target 80%. 2. Penyebab belum tercapainya target waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan April 2026 adalah penumpukan antrean di satu meja peracikan yang sama dengan obat non-racikan
Action	a yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Mengusulkan penambahan SDM pada jam sibuk 2. Mengembangkan sistem elektronik monitoring waktu tunggu 3. Melakukan pelatihan efisiensi teknik peracikan 4. Menyusun daftar (formularium) obat racikan standar yang bisa disiapkan lebih awal (pre-compounding) sesuai regulasi 5. Mengoptimalkan manajemen beban kerja dan jadwal petugas

Tabel 3.23 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Mengusulkan penambahan SDM pada jam sibuk	Memastikan ketersediaan petugas yang cukup untuk menangani lonjakan resep pada jam sibuk	Staf farmasi	Mengajukan penambahan tenaga farmasi khusus jam sibuk berdasarkan analisis beban kerja	Kepala ruang farmasi & SDM Rumah Sakit	1 bulan
2	Mengembangkan sistem elektronik monitoring waktu tunggu	Memantau performa waktu tunggu secara akurat	SIMRS	Mengembangkan sistem elektronik yang mencatat waktu mulai resep masuk hingga obat siap serah secara otomatis	Tim IT & PIC Mutu Farmasi	1 bulan
3	Melakukan pelatihan efisiensi teknik peracikan	Meningkatkan kecepatan teknis peracikan	Staf farmasi	Mengadakan <i>workshop</i> teknik peracikan cepat dan penggunaan alat otomatis	Apoteker koordinator	1 bulan
4	Menyusun daftar (formularium) obat racikan standar yang bisa disiapkan lebih awal (pre-compounding) sesuai regulasi	Memangkas waktu proses persiapan obat	Stok obat	Menetapkan daftar racikan standar yang sering digunakan untuk disiapkan lebih awal sesuai regulasi kefarmasian	Apoteker koordinator	1 bulan
5	Mengoptimalkan manajemen beban kerja dan jadwal petugas	Menyeimbangkan distribusi tugas harian	Staf farmasi	Melakukan penataan ulang jadwal shift agar jumlah petugas maksimal saat kunjungan	Kepala ruang farmasi	1 bulan

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
				pasien tinggi		

5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko

- a. Presentase berkas pending klaim
- b. Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO



Gambar 3.21. Capaian Angka Kerusakan Alat Medis Karena Ketidakpatuhan Staf Menjalankan SPO di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April Tahun

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO pada Bulan April tahun 2026 adalah 0. Angka tersebut telah mencapai target 0 kejadian.

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.24 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Bulan April Tahun 2026

Kategori Indikator	Detail Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Catatan/ Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
	Kepatuhan identifikasi pasien	0%	0%	0%	0%									100%	100%	Mertahankan
	Kepatuhan kebersihan tangan	0%	0%	0%	75%									≥ 85 %	98,44%	Mertahankan
	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	0%	0%	0%	0%									100%	100%	Mertahankan
	Kepuasan pasien	21%	79%	25%	67%									≥ 76,61 %	98,23%	Mertahankan
	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	0%	0%	0%	5%									100%	98,75%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	36%	0%	0%	0%									100%	99,84%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	0%	0%	0%	66%									100%	92,42%	PDSA
	Kematian pasien< 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	21	0											≤ dua per seribu		PDSA
	Angkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	0%	0%	0%	0%									100%	100%	Mertahankan
	Angkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	0%	0%	0%	0%									100%	100%	Mertahankan
	Angkapan pengisian LOP	0%	0%											100%		Mertahankan
	Angkapan	0%	0%											100%		Mertahankan

Kategori Indikator	Bulan	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des			
berkas triage E-RM pada pasien IGD																
Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftarkan sampai terpasang di pasien < 15 menit		55%	0%	0%	0%									100%	98,39%	PDSA
Waktu tunggu pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam		48%	0%											100%		PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.25 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuha n identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertaha nkan
2	Kepatuha n kebersiha n tangan	100 %	87,69 %	90,41 %	92,75 %									≥ 85 %	92,71 %	Dipertaha nkan
3	Kepatuha n Upaya pencegah an resiko pasien jatuh	77,60 %	70,48 %	76,42 %	77,60 %									100%	75,53 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	100 %	50%	100 %	100 %									≥ 76,61 %	87,50 %	Dipertaha nkan
5	Waktu tunggu rawat jalan	98,12 %	85,61 %	100 %	60%									≥ 80%	85,93 %	Dipertaha nkan
6	Kepatuha n Pengguna an Alat Pelindung Diri	100 %	100 %	100 %	100%									100%	100 %	Dipertaha nkan
Indikator Mutu Prioritas RS																
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka keterlamb atan dokter di poli rawat jalan yang tidak sesuai	32,70 %	4%	96,23 %	99,11 %									0%	58,01 %	PDSA

	dengan jadwal praktek dokter															
2.	Kelengka pan pengisian pengkajia n awal medis E- RM pasien rawat jalan	100 %	100 %											100%		Dipertaha nkan
3.	Kelengka pan pengisian pengkajia n awal keperawat an E-RM pasien rawat jalan	100 %	100 %											100%		PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.26 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,67 %	97,39 %	97,50 %	97,50 %									100%	97,27 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,58 %	85,61 %	82,58 %	86,50 %									≥ 85 %	85,57 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,17 %	96,52 %	96,67 %	97,50 %									100%	96,22 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	91,84 %	92,50 %	88,10 %									≥ 76,61 %	93,11 %	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	79,34 %	80,17 %	81,67 %	80,83 %									≥ 80%	80,50 %	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 80%		Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	82,14 %	100%	100%									100%	95,54 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan	95,83	95,95	95,83	94,25									100%	95,47	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	n perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	%	%	%	%										%	
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap															
3	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	2,27 %	0,63 %	1,21 %										≤ 0,24 %	1,37 %	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	3 kejadi an	2 kejadi an	2 kejadi an	1 kejadi an									0 kejadi an	2 kejadi an	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥24 Jam	94,21 %	95,69 %	96,64 %	97,50 %									100%	96,01 %	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	95,83 %	96,55 %	100%	96,67 %									100%	97,26 %	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.27 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71 %	95%	100%	98,67 %									100%	98,10 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,54 %	88,33 %	89,36 %	85,71 %									≥ 85 %	87,99 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,13 %	95%	98,71 %	96%									100%	96,46 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	88,89 %	83,54 %	87,27 %	90,32 %									≥ 76,61 %	87,51 %	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	53,55 %	60%	60,65 %	37,33 %									≥ 80%	52,88 %	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 80%		
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	82,35 %	100%									100%	95,59 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,75 %	2,13 %	1,52 %	0%									≤ 0,24 %	1,10 %	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	4 kejadian	6 kejadian	2 kejadian	2 kejadian									0 kejadian	4 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	2 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan	85,81 %	93,57 %	86,45 %	94,67 %									100%	90,13 %	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- rata	Keterang- an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	n Pengisiha n pengkajia n awal medis oleh DPJP ≤24 Jam															
5.	Kepatuha n Penempel an Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	97,42 %	97,14 %	97,42 %	91,33 %									100%	95,83 %	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.28 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71 %	98,57 %	99,35 %	99,33 %									100%	98,99 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	80%	86,96 %	95,71 %	90,22 %									≥ 85 %	88,22 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,06 %	97,86 %	98,06 %	98,67 %									100%	98,16 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	(Tidak ada pasien yang mengisi barcode kepuasan pasien)	94,12 %	100%	87,50 %									≥ 76,61 %	93,87 %	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	83,87 %	91,43 %	87,10 %	85,33 %									≥ 80%	86,93 %	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	93,75 %	Tidak diisi	Tidak diisi										≥ 80%		Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggun	86,96 %	100%	97,22 %	100%									100%	96,05 %	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	aan Alat Pelindung Diri															
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06 %	98,57 %	98,06 %	98,67 %									100%	98,34 %	PDSA
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap				96%									100%		
3	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien				100%									100%		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0%	0%									≤ 0.24 %	0%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	5 kejadian	3 kejadian	5 kejadian	2 kejadian									0 kejadian	4 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	4 kejadian									0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	98,06 %	97,14 %	97,42 %	97,33 %									100%	97,49 %	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	pada Box Obat															

6.
INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.29
Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	D es			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	90%	90%	90%	93,60 %									100%	90,90 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	85,96 %	74,07 %	87,10 %	85,19 %									≥ 85 %	83,08 %	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,07 %	92%	87,50 %	95,20 %									100%	92,19 %	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	100%	83,33 %									≥ 76,61 %	95,83 %	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	45,97 %	55%	54,55 %	40%									≥ 80%	48,88 %	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP										≥ 80%		
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,44 %	88,46 %	96,97 %	100%									100%	95,14 %	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	90,83 %	92%	90%	98,40 %									100%	92,81 %	PDSA
2	Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert															

3	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien																
Indikator Mutu Prioritas Unit																	
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,5%	0,75%	1,47%	1,29%									≤ 0.24 %	1%	PDSA	
2.	Kejadian pulang paksa	2 Kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	PDSA	
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan	
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	66,92 %	84%	84,17 %	94,40 %									100%	82,37 %	PDSA	
5.	Kepatuhan Penempatan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	89,17 %	88%	88,33 %	91,20 %									100%	89,18 %	PDSA	

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.30 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	83,87 %	91,23 %	100%	100%									≥ 85 %	93,78 %	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegaha n resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%									100%	100,0 0%	Dipertaha nkan
4	Penundaa n operasi	2,14 %	1,28 %	1,14 %	1,57 %									≤ 5%	1,53 %	Dipertaha nkan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	De s			
	elektif ≥ 60 menit															
5	Kepuasan pasien													≥ 76,61 %		Dipertaha nkan
6	Kepatuhan Pengguna an Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan pelaksana an <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%											100%		Dipertaha nkan
2	Kejadian tidak dilakukann ya penandaan pada pasien operasi	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian									0 kejad ian	0 kejadi an	Dipertaha nkan
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksana an Operasi Soft Tissue Tumor													≥ 90 %		Dipertaha nkan
5	Kejadian ketidaks es uaian diagnose pre dan post operasi	1 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian									0 kejad ian	1 kejadi an	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka kelengkap an laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	99,46 %	100%									100%	99,87 %	Dipertaha nkan
2	Angka kelengkap an asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
3.	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejad ian	0 kejad ian											0 kejad ian		Dipertaha nkan
4.	Waktu tunggu operasi	100%	100%											100%		Dipertaha nkan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	De s			
	elektif ≤ 2 hari															
5.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian											0 kejadian		Dipertaha nkan
6.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian											0 kejadian		Dipertaha nkan
7.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian											0 kejadian		Dipertaha nkan
8.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian											0 kejadian		Dipertaha nkan
9.	Kejadian tertinggaln ya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian											0 kejadian		Dipertaha nkan

B. Anestesi

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	D es			
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertaha nkan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertaha nkan
3	Kejadian salah penempata n	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertaha nkan
4	Kejadian ketidakleng kapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertaha nkan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	4 kejadian									0 kejadian	2 kejadian	PDSA
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertaha nkan
7	Kejadian	0	0	0	0									0	0	Dipertaha

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	D es			
	tidak dilakukanny a proses monitoring status fisiologis selama anestesi	kejad ian	kejad ian	kejad ian	kejad ian									kejad ian	kejad ian	nkan
8	Kejadian tidak dilakukanny a proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian									0 kejad ian	0 kejad ian	Dipertaha nkan

8. MATERNITAS

Tabel 3.32 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,56 %	93,55 %	100%									100%	97,28 %	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	94,83 %	97,37 %	93,10 %	93,75 %									≥ 85 %	94,76 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,85 %	100%	100%	98%									100%	98,96 %	PDSA
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	50%	60%	50%	44%									> 80%	51,00 %	PDSA
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	75,89 %	76,85 %	83,72 %	76,99 %									≥ 80%	78,36 %	PDSA
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	100%	100%	100%										≥ 80%	100%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	100%									≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap			100%	100%											
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan pemberian MgSO4 pada pasien PEB	100%	100%	100%	100%										100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3	Kejadian pasien dengan kasus PEB aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
6	Kejadian kematian ibu persalina n yang disebabkan oleh Eklampsi a	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan
7	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan
8	Kejadian kematian ibu persalina n karena sepsis	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan
9	Kepatuha n pemberia n kortikoste roid pada persalina n prematur e	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan

9. PONEK

Tabel 3.33 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	94,44 %	100%	94,44 %	100%									> 80%	97,22 %	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	100%	100%	Tidak ada yang mengisi survei	100%									≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha

	n bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR															nkan
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh Ponек				100%									100%		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan pemberian MgSO4 pada pasien PEB	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Tidak ada pasien HPP di Ponек
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponек yang terlatih	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
4	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatanan/severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

	an oleh PEB															
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian kematian bayi di rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.34 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Bulan April Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Sta
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Indikator Mutu Nasional														
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%									100%
2	Kepatuhan kebersihan tangan	95,70%	87,50%	93,94%	92%									≥ 90%
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%									100%
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	95%	100%									100%
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	70,97%	77,01%	63,83%	70,87%									≥ 60%
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-										≥ 80%
7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	100%									76,19%
Indikator Mutu Prioritas RS														
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%									100%
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap				100%									
Indikator Mutu Prioritas Unit														
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	8 Kejadian	9 kejadian	7 kejadian	12 kejadian									kejadian

2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%												1
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%	100%												1
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	100%	100%	100%												1
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%												1
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian												kej
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%												1

11. ICU

A. ICU

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100,00 %	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	89,29 %	96,43 %	96,77 %	96,67 %									≥ 85%	94,79 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100,00 %	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	30,77 %	52,50 %	34,38 %	45,45 %									≥ 80%	40,78 %	PDSA
5	Kepatuhan	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100,00 %	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	Pengguna an Alat Pelindung Diri															
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuha n perawat terhadap komunika si efektif menggun akan SBAR	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100%	Dipertaha nkan
2	Kepatuha n crosschec k ulang penempel an stiker LASA dan High Alert oleh petugas ICU			100 %	100 %											
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka pasien yang kembali ke perawata n intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	50%	0%	0%									≤ 3 %	16,66 %	PDSA
2.	Kepatuha n pengisian pengkajia n form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100%	Dipertaha nkan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Bulan April Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	A gs	Sep
Indikator Mutu Nasional										
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	100%					
2	Kepatuhan kebersihan tangan	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	96,67%					
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	100%					

No.	Indikator	Bulan								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien						
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	100%					
Indikator Mutu Prioritas Unit										
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	0%					
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien						

12. RADIOLOGI

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Ap r	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tida k diisi	Tida k diisi											100%		PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100 %	100 %	78,57 %	-									≥ 85%		PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tida k diisi	Tida k diisi											100%		PDSA
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100 %	100 %	100%	-									100%		Dipertahan kan
5	Kepuasan pasien	Tida k diisi	Tida k diisi											≥ 76,61 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	Tida k diisi	Tida k diisi											100%		PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	Tida k diisi	Tida k diisi											0%		PDSA
3.	Angka ketidakleng k apan form permintaan radiologi	Tida k diisi	Tida k diisi											0%		PDSA
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	Tida k diisi	Tida k diisi											0 kejadian		PDSA

13. LABORATORIUM

Tabel 3.37 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	D es			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,62 %	98,04 %	90,74 %	100%									≥ 85%	93,35 %	Dipertaha nkan
3	Kepatuhan Penggunaa n Alat Pelindung Diri	69,23 %	77,42 %	89,53 %	97,92 %									100%	83,53 %	PDSA
4	Kepuasan pasien													≥76,6 1%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 60 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
2	Tidak adanya kesalaha n pemberia n hasil pemeriks a laborator ium	100%	100%	100%	100%									100%	100%	PDSA
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0,02 %	0%	0%	0%									0%	0,01 %	PDSA
4	Angka ketidakleng kapan form permintaan laboratorium	3,95 %	4,37 %	2,83 %	2,52 %									0%	3,42 %	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindaha n Hasil Laboratoriu m ke SIMRS	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadi an	1 kejadi an	PDSA
6	Kejadian Ketidaktepa tan Waktu Pemelihara an Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan
7	Kejadian	0	0	0	0									0	0	Dipertaha

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	Se p	O kt	N ov	D es			
	Keterlamba tan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	kejad ian	kejad ian	kejad ian	kejad ian									kejadi an	kejad ian	nkan
8	Kejadian Keterlamba tan Hasil Laboratoriu m CITO ≥30menit	0 kejad ian	7 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian									0 kejadi an	3 kejad ian	PDSA
9	Kejadian Keterlamba tan Penyeraha n labu darah > 1 jam	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian									0 kejadi an	0 kejad ian	Dipertaha nkan
10	Kebutuha n darah bagi setiap pelayana n transfuse	100%	97,87 %	100%	98,82 %									100%	99,17 %	PDSA
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	1,01 %	0%	0%									< 0,01 %	0,25 %	PDSA
12	Kejadian ED labu darah	0 kejad ian	1 kejad ian	0 kejad ian	0 kejad ian									0 kejadi an	1 kejad ian	PDSA

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.38 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%												≥ 85%	95,90 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien													≥ 76,61 %		Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggun	100%												100%	100%	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	aan Alat Pelindung Diri															
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi													100%		Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.39 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	91,94%	89,80%	90,32%	87,80%									≥ 85%	89,97%	Dipertahankan
3	Kepatuhan	100%	100%	100%	100%									100%	100,0	Dipertaha

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	an Penggun aan Alat Pelindun g Diri														0%	nkan
4	Kepuasa n pasien													≥ 76,61 %		Belum diisi
5	Penulisa n resep sesuai formulari um	100%	95%	87,83 %	100%									100%	95,71 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	waktu tunggu pelayana n obat jadi ≤ 30 menit	85,93 %	84,17 %	83%	86%									≥80%	84,78 %	Dipertaha nkan
2	waktu tunggu pelayana n obat racikan ≤ 60 menit	75,56 %	75%	70%	78%									≥80%	74,64 %	PDSA
3	Kepatuh an staf farmasi dalam penemp elan stiker LASA dan High Alert			70%	73%											
Indikator Mutu Prioritas Unit																
4	Kejadian kesalah an pemberi an obat	0 kejadi an	6 kejadi an	0 kejadi an	3 kejadi an									0 kejadi an	3 kejadi an	PDSA
5	Kejadian kekoson gan obat di Instalasi Farmasi	2 kejadi an	1 kejadi an	5 kejadi an	6 kejadi an									0 Kejadi an	4 kejadi an	PDSA
6	Kejadian pemberi an antibiotik profilaksi s < 60 menit sebelum insisi	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 Kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan
7	Kejadian perubah an pemberi an obat profilaksi s menjadi			0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an		PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	terapi petik															
8	Ketepatan waktu pengiriman obat oleh vendor				96,62 %									≥95%		

16. GIZI

Tabel 3.40 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	95,56%	100%	93,33%	87,30%									≥ 85%	94,05%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,78%	88,89%	92,06%	90,20%									100%	92,23%	PDSA
4	Kepuasan Pasien	91,80%	88,10%	89,74%	92,59%									≥ 76,61%	90,56%	
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	100%									≥ 90%	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	16%	16%	15%	16%									≤ 20%	15,75%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ditemukan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	nya benda asing dalam makanan pasien	an	an	an	an									an	an	
6	Tersedia nya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	0%									100%	0%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien				92%									100%		Dipertahankan
2	Kepatuhan Kebersihan Tangan	100%	100%	100%	100%									≥ 85%	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	91,80 %												≥ 76,61 %		
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	96,03 %	95,80 %	98,45 %	94,62 %									100 %	96,23 %	PDSA
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	33,33 %	65%	65,91 %	58,14 %									100 %	55,60 %	PDSA
3	Kejadian Nomor	3 terjadi	2 terjadi	1 terjadi	1 terjadi									0 terjadi	2 terjadi	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	Rekam Medis Ganda	an	an	an	an									an	an	
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	PDSA
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	96,77 %	96%	96%	94%									100%	95,69 %	PDSA
6	Angka keterlambatan pengambilan DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	33,90 %	37,66 %	44,29 %	27,16 %									0%	35,75 %	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,19 %	97,19 %	96,83 %	96,76 %									100%	96,99 %	PDSA
8	Kelengkapan General Concent	99,35 %	100%	99%										100%	99,45 %	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	19,35 %	21,43 %	23,70 %	16,67 %									100%	20,29 %	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertahankan

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	A pr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Baku mutu limbah cair	a.BO D =10,06 mg/l b. COD = 30,56 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l	a.BO D =7,2 mg/l b. COD = 24,38 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l	a.BO D =10,07 mg/l b. COD = 44,59 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l										a.BO D < 12 mg/l b. COD = < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH	BOD =9,11 mg/l b. COD = 33,17 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata- rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	A pr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
		d. PH =8,64 e. Faeca l coli = 270	d. PH =8,17 e. Faeca l coli = 220	d. PH =6,72 e. Faeca l coli = 120										6-9 e. Faeca l coli < 200	=7,84 e. Faeca l coli = 203,3 3	
2.	Pengelol aan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%										100 %	100%	Dipertahan kan
3.	Angka kepatuha n staf dalam mengikut i kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	0%										100%	0%	1 Tahun
4.	Kejadian pelapora n kecelaka an kerja ≤ 48 jam	1 kejadi an	0 kejadi an	1 kejadi an										0 kejadi an	1 kejadi an	PDSA

19. SDM

Tabel 3.43 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata -rata	Keteran gan
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	S ep	O kt	N ov	D es			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0%	0%	5,97 %	3,73 %									100 %	2,43 %	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	0%									≥ 60 %	0,00 %	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	2,38 %	1,50 %	0,64 %	1,30 %									≤10 % / bulan	1,46 %	Dipertah ankan
4.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	25,1 1%	20,1 3%	31,1 2%	29,2 8%									0%	26,4 1%	PDSA
5.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/G ELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PIC U	69,4 1%	69,4 1%	69,4 1%	69,4 1%									100 %	69,4 1%	PDSA
6.	Kepuasan karyawan													≥ 80 %		semester an

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.44 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata -rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Ketepatan Pengumpul an UMANDOK 1 X 24 jam setelah selesai kegiatan	100 %	100 %	100%	100 %									100%	100,0 0%	Dipertahan kan
2.	Ketepatan waktu pengumpul an laporan bulanan unit ke sekretariat an	100 %	100 %	100%	100 %									100%	100,0 0%	Dipertahan kan
3.	Ketepatan pendistribusi sura t masuk	100 %	100 %	98,39 %	100 %									100%	99,60 %	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusi sura t keluar	100 %	100 %	100%	100 %									100%	100,0 0%	Dipertahan kan

21. DRIVER

Tabel 3.45 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kepatuhan waktu pengantar an pengguna an ambulance < 30 menit	100%	100 %	100 %	100 %									100%	100,0 0%	Dipertahan kan
2.	Kepatuhan pelaksana an dekontami nasi ambulace	100%	100 %	100 %	100 %									≥80%	100,0 0%	Dipertahan kan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	99,05 %	100 %	100 %	100 %									100%	99,76 %	PDSA

22. PEMULASARAN JENAZAH

Tabel 3.46 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokument asian pemulasaraan jenazah	100 %	100 %	100 %	Tidak ada jenaz ah									100%	100 %	Dipertahan kan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.47 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
ATEM																
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100 %	100 %	100 %									≥80%	100%	Dipertahan kan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	100%	100 %	100 %	100 %									100%	100%	Dipertahan kan
3.	Ketepatan waktu pemelihar aan alat medis	100%	100 %	100 %	100 %									100%	100%	Dipertahan kan
4.	Ketepatan kalibrasi	-	-	100 %	-									100%	100%	Alat di Kalibrasi di

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	alat sesuai dengan jadwal															Bulan September
IPSRS																
1.	Waktu pelayanan perbaikan alat non medis ≤ 24 jam	95,71 %	100 %	100 %	100 %									≥80%	98,93 %	Dipertahan kan
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	100 %	100 %	100 %									100%	100%	Dipertahan kan
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)	100%	100 %	100 %	100 %									100%	100%	Dipertahan kan

24. LAUNDRY

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se pt	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan penggunaan APD	83,33 %	85,71 %	50%	100%									100%	79,76 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian linen yang hilang	3 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	3 Kejadian	3 kejadian	4 kejadian	3 kejadian									0 kejadian	4 kejadian	PDSA

25. CSSD

Tabel 3.49 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keteran gan
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	A gs	S ep	O kt	N ov	D es			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	91,3 4%	93,4 8%	100 %	100 %									100 %	96,2 1%	Dipertah ankan
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar	1 keja dian	1 keja dian	1 keja dian	0 keja dian									0 keja dian	1 keja dian	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata -rata	Keteran gan
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	J un	J ul	A gs	S ep	O kt	N ov	D es			
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	97,47%	90,27%	94,90%	100%									100%	95,66%	PDSA (IGD, Poli, IRNA 2A)
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. reathing circuit 2. egging 3. MA 4. R	-	-	-	-									100%	-	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertah ankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertah ankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	97,47%	92,44%	97,96%	100%									100%	96,97%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	96,23%	91,56%	96,43%	100%									100%	96,06%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertah ankan

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata -rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Pengguna an APD	93,06%	84,52%	91,40%	99,32%									100%	92,08%	PDSA
2.	Kepatuha	80%	86,9	92,4	93,3									≥85%	88,1	Dipertaha

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata -rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	n Kebersiha n Tangan		0%	7%	3%										8%	nkan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuha n clening service dalam membersi hkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100 %	100 %	99,4 7%	100 %									100%	99,8 7%	PDSA
2.	Respon time petugas kebersiha n ≤ 15 menit	100 %	99,8 9%	99,7 9%	100 %									100%	99,9 2%	PDSA
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambil an sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100 %	97,2 8%	98,4 0%	100 %									100%	98,9 2%	PDSA
4.	Kepatuha n petugas dalam membersi hkan area umum 3x dalam sehari	100 %	99,8 9%	100 %	100 %									100%	99,9 7%	PDSA

27. KEAMANAN

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kejadian kehilanga n barang milik pasien, penggung jung dan karyawan	2 Kejad ian	3 kejadi an	2 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	2 kejadi an	PDSA
2.	Kepatuha n petugas keamana n melaksan	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	akan pengawas an keliling RS 2x dalam setiap shift															
3.	Kepatuha n jam berkunjun g sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%									100%	100%	Dipertaha nkan
4.	Kejadian kekerasa n staf, pasien, & pengunju ng di Rumah sakit	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	615 kejadi an	547 kejadi an	615 kejadi an	626 kejadi an									0 kejadi an	601 kejadi an	PDSA
6.	Kepatuha n pengguna an id card pengunju ng di area rumah sakit	87,85 %	86,07 %	87,85 %	83,44 %									100%	86,30 %	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.52 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kepatuh an unit dalam pengam bilan barang	93,13 %	90,91 %	87,50 %	100%									100%	92,89 %	PDSA
2.	Selish barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	1,52 %	2,89 %	1,84 %	0%									0%	1,56 %	PDSA
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an	0 kejadi an									0 kejadi an	0 kejadi an	Dipertaha nkan

29. PPI

Tabel 3.53 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40 %	91,13 %	91,92 %	92%									≥ 85%	91,11 %	Dipertahankan
2.	Kepatuhan APD	96,54 %	93,82 %	94,98 %	98,94 %									100%	96,07 %	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI																
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	100%	100%	100%	100%									100 %	100,00%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	80%	83,21 %	89,03 %	89,67 %									75 %	85,48 %	Dipertahankan
3.	Angka infeksi daerah operasi	0,27 %	0,28 %	0,29 %	92%									≤ 1,5%	23,21 %	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	96,88 %	93,07 %	100%	98,94 %									100%	97,22 %	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	97,02 %	95%	96,13 %	97%									100%	96,29 %	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	99,82 %	93,28 %	97,51 %	97,47 %									100%	97,02 %	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	95,14 %	99,08 %	98,98 %	89,82 %									100%	95,76 %	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	52,63 %	52,63 %	44,74 %	60,53 %									100%	52,63 %	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.54 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi Kelompok	64,06 %	64,06 %	46,43 %	54,69 %									100 %	57,31 %	PDSA
2.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertahankan
3.	Angka pelaksanaan survei ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi oleh PPA	100 %	100 %	97,96 %	100 %									100 %	99,49 %	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam	64,06 %	64,06 %	53,13 %	58,59 %									100 %	59,96 %	PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	menggun akan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)															
5.	Kepatuha n Komunika si efektif terkait SBAR- TBAK (Konsul DPJP, HO, rujuk internal, rujuk eksternal, konsultasi antar spesialis, pelaporan nilai kritis lab)	100 %	100 %	100 %	97,62 %									100 %	99,41 %	PDSA
6.	Kepatuha n pembinaa n komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	100 %	100 %	33,33 %	41,67 %									100 %	68,75 %	Dipertaha nkan

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.55 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikato r	Bulan												Stand ar	Rata- rata	Ketera ngan
		Jan	Feb	Mar	A p r	M ei	J u n	J u l	A g s	S e p	O kt	N o v	D e s			
1.	Waktu Pengaj uan Klaim	Tanggal 5	Tanggal 5	Tanggal 5										Tangg al 5	Tanggal 5	Diperta hankan
2.	% Klaim Pendin g RJTL	0,04%	0,03%	0,02%										<0,1% dari total klaim	0,03%	Belum diisi
3.	% Klaim Pendin g RITL	6,97%	7,60%	7,57%										<1% dari total klaim	7,38%	Belum diisi
4.	% Klaim Tidak Layak	0,06%	1,06%	0,78%										0% dari total klaim	0,63%	Belum diisi
5.	Nilai Penge mbalian	Rp1.141. 761.700	Rp22.24 6.500	0										< Rp 1.000. 000	Rp388.0 02.733	Belum diisi

	Audit Klaim RJTL															
6.	Nilai Penge mbalian Audit Klaim RITL	Rp4.163.300	Rp5.349.400	Rp4.661.900										< Rp 5.000.000	Rp4.724.867	Belum diisi
7.	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL	Rp56.592.940	Rp27.812.396	Rp27.812.396										< Rp 50.000.000	Rp37.405.911	Belum diisi
8.	Nilai Selisih Negatif Klaim RITL	Rp691.112.400	Rp424.814.880	Rp424.814.880										< Rp 100.000.000	Rp513.580.720	Belum diisi

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	A pr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kepuasan Pasien MCU	26,47 %	100%	100%										≥ 76,61 %	75,49 %	Dipertahan kan
2.	Ketidakpat uhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	24,59 %	24,59 %	21,68 %										0%	23,62 %	PDSA
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0%	0%	0%										10% / tahun	0%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.57 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keteran gan
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Respon ti me CSO <30 mnt (WA)	9,93 %	11,59 %	10,89 %	32,17 %									100%	16,15 %	PDSA

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepuasa n Pasien	91,80 %	88,10 %	89,74 %	92,59 %									≥ 76,61	90,56 %	Dipertaha nkan

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
														%		
2	Respon time penangan complain <5 menit	100 %	96,15 %	94,74 %	81,82 %									100%	93,18 %	PDSA
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP																
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	86,79 %	50,33 %	40,38 %	50,92 %									100%	57,11 %	PDSA
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	86,79 %	50,33 %	40,38 %	50,92 %									100%	57,11 %	PDSA

35. TB di IRJA

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	Belu m diisi	Belu m diisi	Belu m diisi	Belu m diisi									100%		PDSA
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penualaran ke pasien TB	Belu m diisi	Belu m diisi	Belu m diisi	Belu m diisi									≥ 90%		PDSA

36. TIM HIV

Tabel 3.60 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan	Belu m diisi	Belu m diisi	Belu m diisi	Belu m diis									≥ 90%		PDSA

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
	penualara n ke pasien HIV															

37. KB

Tabel 3.61 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kepatuha n pengisian kartu K4 KB	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertaha nkan
2.	Angka terlaksan nya program KB pasca persalina n & pasca kegugura n	26,89 %	23,01 %	21,01 %	26,96 %									50%	24,47 %	PDSA
3.	Semua ibu melahirka n dan curretage mendapat kan KIE KB	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertaha nkan
4.	Angka pelaksan aan pelayana n konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	100 %	100 %	100 %	100 %									30%	100 %	Dipertaha nkan

38. STUNTING

Tabel 3.62 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1.	Prevalens i Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%									0%	0%	Dipertahan kan
2.	Kepatuha n petugas melakuka	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertahan kan

	n KIE kelompok pada ibu balita 1x dalam sebulan															
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali	-	-	-	-									100%		Triwulanan PDSA
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	-	-	-	-									100%		

39. IT - SIM RS

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stand ar	Rat a-rata	Keteranga n
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertahan kan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertahan kan
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertahan kan
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	100 %	100 %	100 %	100 %									100%	100 %	Dipertahan kan

40. HEMODIALISA

Tabel 3.64 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Hemodialisa pada Bulan April Tahun 2026

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata-rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	98,10 %	100%	100%									100%	99,53 %	PDSA
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	94,83 %	100%	97,37 %	98,65 %									≥ 85 %	97,71 %	Dipertahankan
3.	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	99,05 %	100%	100%									100%	99,76 %	PDSA
4.	Kepuasan Pasien	100%												≥ 76,61 %		Dipertahankan
5.	Kepatuhan Penggunaan APD	100%	100%	98,46 %	100%									100%	99,62 %	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1.	Kejadian Tidak Adanya Label High Alert pada Obat	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian Ketidaktepatan Pemasangan Akses Vaskuler	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian									0 kejadian	3 kejadian	PDSA
2.	Kejadian Hipotensi Intra Dialisis	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan Teknik Steril Perawat HD dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial	100%	100%	100%	100%									≥80%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan Jadwal Hemodialisa	98,36 %	93,88 %	99,15 %	99,17 %									≥95%	97,64 %	Dipertahankan
5.	Kejadian Clotting Durante HD	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian									0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Waktu Pelayanan perawat dari pasien datang	95,52 %	100%	100%	96,67 %									≥80%	98,05 %	Dipertahankan

N o.	Indikator	Bulan												Stan dar	Rata- rata	Keterang an
		Jan	Feb	Mar	Apr	M ei	Ju n	J ul	Ag s	Se p	O kt	No v	De s			
	sampai proses HD berjalan < 15 menit															

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Kewaspadaan Standart

1. Kebersihan Tangan
 - a. Kebersihan Tangan Umum

Gambar 3.3.1.1 Grafik Capaian Kebersihan Tangan Umum



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan April tahun 2026 sebesar 92% dengan rerata 91,11%.

Tabel 3.3.1.1 Tabel PDSA

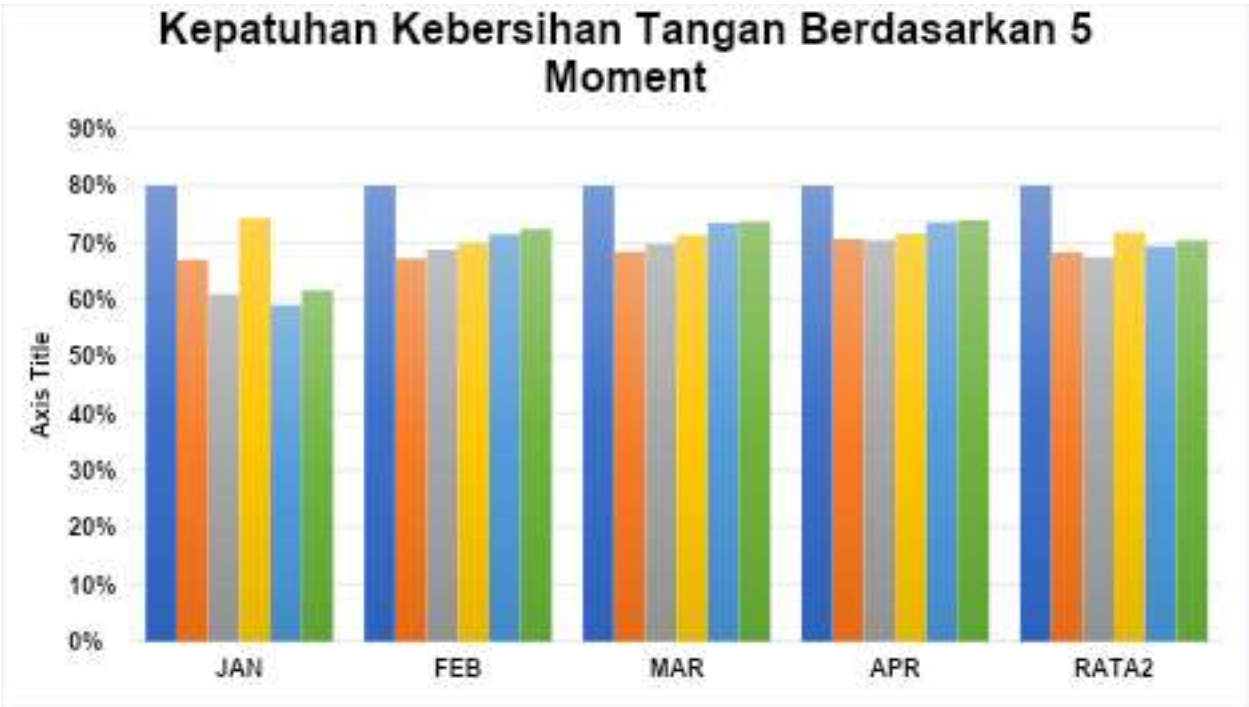
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan petugas sudah mencapai standar 85%
Step	Monitoring dan sosialisasi kembali dan melakukan perbaikan sistem monitoring kepatuhan cuci tangan pada setiap bidang (penunjang, umum dan pelayanan medis)
Plan	- Rencana Mengadakan audit internal mingguan dan edukasi penyegaran (refreshment) 5 Moment Cuci Tangan. - Harapan Kepatuhan kembali mencapai target $\geq 85\%$ dan pelaporan data konsisten setiap bulan - Analisa Kurangnya kesadaran berkelanjutan, keterbatasan fasilitas (handrub habis), atau beban kerja yang tinggi sehingga pelaporan terabaikan. - Tindakan Menunjuk <i>"Hand Hygiene Champion"</i> di setiap unit dan memastikan ketersediaan logistik (sabun/handrub).
Do	- Melaksanakan edukasi singkat tentang pentingnya kebersihan tangan pada setiap pergantian dinas - Memasang poster pengingat di titik-titik strategis. - Melakukan observasi kepatuhan secara langsung oleh tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
Study	- Membandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah tindakan. - Menganalisis apakah kendala utama terletak pada perilaku petugas atau ketersediaan sarana prasarana.

Action	1. Jika hasil membaik, standarisasi prosedur audit mingguan. 2. Jika belum mencapai target, lakukan modifikasi pada metode edukasi atau tambahkan sistem reward & punishment bagi unit kerja.
--------	--

b. Kebersihan Tangan Berdasarkan 5 Momen

Tabel 3.3.1.2 Kebersihan Tangan Berdasarkan 5 Momen

Standar	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	RATA2
	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Sebelum kontak dengan pasien	67,04%	67,28%	68,42%	70,62%									68,34%
Sebelum tindakan aseptik	60,88%	68,81%	69,78%	70,43%									67,48%
Setelah terpapar cairan tubuh pasien	74,35%	69,93%	71,32%	71,66%									71,82%
Setelah kontak dengan pasien	59,04%	71,46%	73,50%	73,63%									69,41%
Setelah dari lingkungan pasien	61,65%	72,48%	73,68%	74,01%									70,46%



Interpretasi : Pada tabel 3.3.1.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen di bulan April tahun 2026 tertinggi pada momen kontak dengan lingkungan pasien sebesar 74,01%.

Tabel 3.3.1.3 PDSA Kebersihan Tangan Berdasarkan 5 Momen

Plan	1. Rencana Meningkatkan persentase kepatuhan pada momen-momen yang sering terabaikan (khususnya Momen 4 dan 5) agar total capaian profesi Perawat dan Dokter naik di atas 90%. 2. Harapan Kepatuhan 5 Momen mencapai >90% secara merata di semua profesi dan diantara 5 momen cuci tangan
------	---

	3. Analisa Berdasarkan observasi awal, kepatuhan tinggi pada momen sebelum tindakan (Momen 2), namun rendah pada momen setelah menyentuh lingkungan pasien (Momen 5) karena persepsi bahwa lingkungan "tidak seketor" pasien. 4. Tindakan a. Edukasi terfokus pada Momen 4 (setelah terkena cairan tubuh) dan Momen 5 (setelah menyentuh lingkungan). b. Pengadaan <i>handrub</i> yang dipasang langsung pada <i>bed</i> pasien untuk meminimalkan jarak.
Do	1. Melakukan sosialisasi "Ingat Momen 5" (menyentuh bed, meja, atau nakas tetap wajib cuci tangan). 2. IPCLN melakukan <i>briefing</i> kilat (5 menit) di ruang rawat inap saat pergantian <i>shift</i> berlangsung 3. Mewajibkan setiap dokter yang melakukan <i>visite</i> untuk membawa <i>handrub</i> saku atau menggunakan yang tersedia di <i>point of care</i>.
Study	1. Analisis menunjukkan bahwa nakes lain (seperti petugas lab/fisioterapi) lebih patuh karena prosedur kerja mereka yang lebih <i>linear</i> (datang, ambil sampel/tindakan, selesai, cuci tangan). Sementara perawat dan dokter sering berpindah antar pasien dengan cepat sehingga sering melewatkan momen "Setelah". 2. Penambahan <i>handrub</i> di titik perawatan terbukti mengurangi alasan "lupa" karena fasilitas sudah di depan mata
Action	1. Adopsi: Jika pada evaluasi minggu kedua Maret angka kepatuhan naik, metode <i>briefing</i> kilat saat operan <i>shift</i> akan dipatenkan sebagai prosedur tetap. 2. Modifikasi: Jika kepatuhan dokter masih stagnan, maka akan dilakukan pendekatan melalui Ketua Komite Medik untuk audit internal antar teman sejawat (<i>peer review</i>). 3. Rencana Lanjutan: Melanjutkan siklus PDSA untuk bulan Maret dengan fokus pada teknik cuci tangan 6 langkah yang benar.

c. Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi

Gambar 3.3.1.2 Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



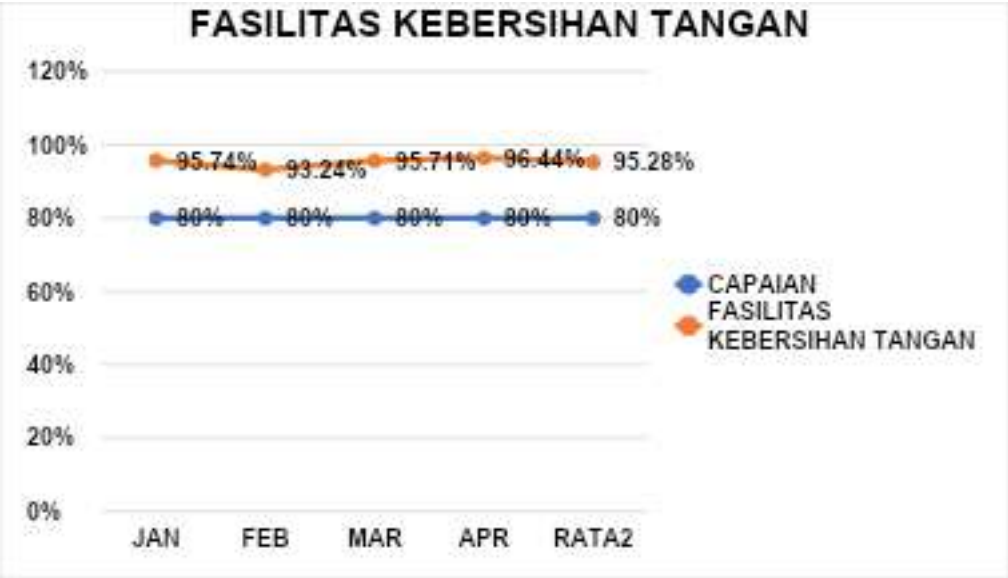
Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan April tahun 2026 sebesar 97,78% pada dokter dan sudah mencapai standart 85%.

Tabel 3.3.1.4 PDSA Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi

Plan	- Rencana Meningkatkan dan menyetarakan kepatuhan cuci tangan di angka >90% untuk seluruh profesi (Perawat, Dokter, dan Nakes Lain) pada siklus berikutnya. - Harapan - Analisa Beban kerja tinggi atau kurangnya akses fasilitas <i>handrub</i> di dekat pasien (<i>point of care</i>) - Tindakan - Melakukan audit fasilitas (ketersediaan <i>handrub</i> di troli tindakan). - Sosialisasi ulang "5 Moments Hand Hygiene" saat <i>handover</i> atau rapat komite medik.
Do	- Mendistribusikan <i>pocket bottle</i> (handrub saku) kepada dokter, perawat, bidan dan nakes lain untuk memudahkan akses menuju kepada pasien - Memasang pengingat visual (stiker/poster) di area strategis seperti pintu masuk kamar pasien dan meja perawat (<i>nurse station</i>). - Melakukan observasi secara diam-diam (<i>blind observation</i>) oleh IPCN atau IPCLN.
Study	Terdapat kesenjangan sekitar 2,5% antara Perawat/Dokter dengan Nakes Lain. Perawat memiliki angka terendah (meskipun sudah di atas standar minimal nasional 85%), hal ini perlu perhatian karena perawat memiliki durasi kontak dengan pasien paling lama.
Action	- Standardisasi: Melanjutkan program <i>handrub</i> saku untuk profesi dengan mobilitas tinggi (Dokter & Perawat). - Reward: Memberikan apresiasi atau pengakuan kepada unit dengan capaian tertinggi (Nakes Lain) sebagai motivasi bagi profesi lain. - Revisi Rencana: Jika angka perawat tidak naik di bulan depan, pertimbangkan untuk meninjau rasio perawat dibanding jumlah pasien agar beban kerja tidak menjadi alasan kelalaian cuci tangan.

d. Fasilitas Kebersihan Tangan

Gambar 3.3.1.3 Fasilitas Kebersihan Tangan

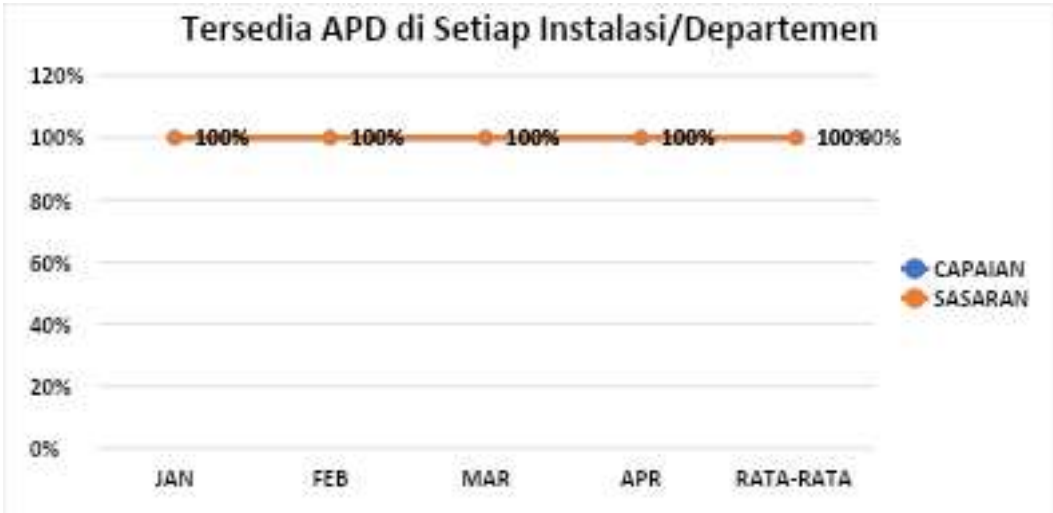


Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.3 diketahui bahwa rerata fasilitas kebersihan tangan di bulan April tahun 2026 sebesar 96,44% dengan rerata sebesar 95,28%.

Tabel 3.3.1.5 PDSA Fasilitas Kebersihan Tangan

Problem	Masih ditemukan fasilitas kebersihan tangan yang tidak tersedia di masing-masing unit seperti di area wastafel perawatan, diarea rawat inap pasien (bed pasien) dan area koridor umum
Step	Standarisasi sistem monitoring ketersediaan fasilitas (sabun, handrub, tisu) dan kepatuhan pengisian data bulanan.
Plan	1. Rencana Menyusun jadwal pengecekan stok harian oleh petugas ruangan dan sistem pelaporan digital bulanan 2. Harapan Mempertahankan ketersediaan fasilitas >95% dan memastikan data laporan terisi lengkap setiap bulan (100% data entry). 3. Analisa Berdasarkan Analisa lapangan di temukan ada beberapa kendala seperti; a. Botol handrub hilang b. Botol handrub kosong belum terisi c. Rusaknya botol handrub 4. Tindakan Mengintegrasikan form pengecekan fasilitas ke dalam checklist harian ruangan dan menunjuk koordinator logistik PPI.
Do	1. Melakukan inventarisasi seluruh titik fasilitas kebersihan tangan (wastafel, dispenser handrub). 2. Mendistribusikan checklist ketersediaan logistik ke setiap unit. 3. Melakukan pengadaan stok cadangan (buffer stock) untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi.
Study	1. Melakukan verifikasi data bulanan untuk memastikan tidak ada lagi bulan yang kosong (0%) dalam grafik capaian. 2. Mengevaluasi apakah ada kendala dalam distribusi barang dari gudang ke unit.
Action	1. Jika ketersediaan tetap stabil dan laporan terisi penuh, lanjutkan sistem monitoring yang ada. 2. Jika ditemukan kendala distribusi, lakukan revisi pada alur permintaan barang ke bagian logistik/farmasi

2. Alat Pelindung Diri
- a. Ketersediaan APD yang sesuai di unit
- Gambar 3.3.1.4 Ketersediaan APD yang sesuai di unit

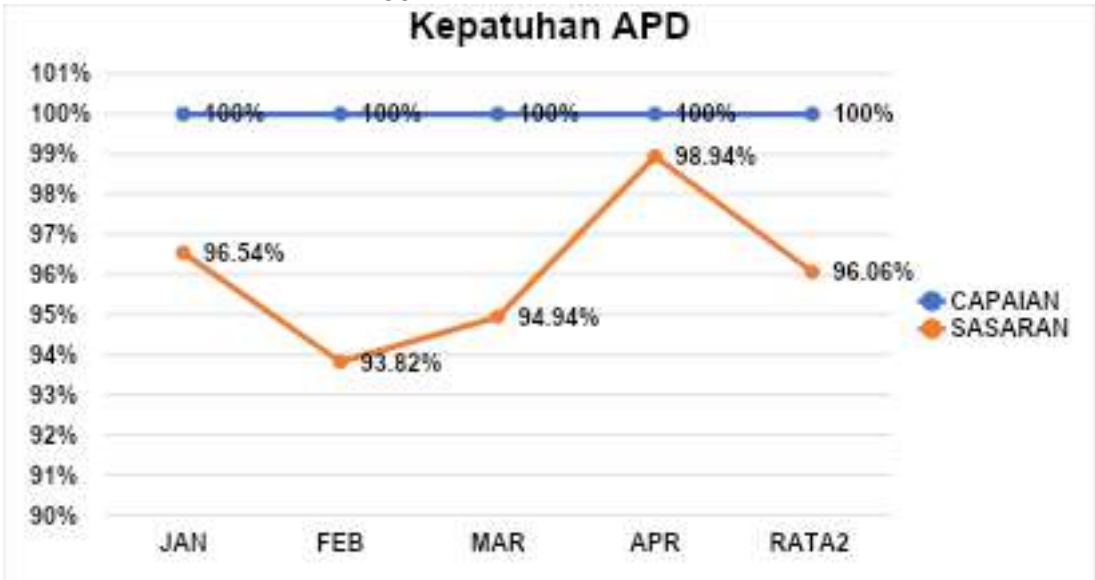


Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.4 diketahui bahwa rerata ketersediaan APD di unit bulan April tahun 2026 sebesar 100% dan sudah mencapai standart 100%.

Tabel 3.3.1.6 PDSA Ketersediaan APD yang sesuai di unit

Problem	Ketersediaan APD di unit sudah memenuhi standart
Step	Perbaikan sistem pelaporan stok APD dan sinkronisasi logistik antar unit.
Plan	1. Rencana Mengimplementasikan kartu stok digital atau checklist ketersediaan APD harian di setiap unit pelayanan. 2. Harapan Mempertahankan ketersediaan APD di angka > 95% dan memastikan pelaporan bulanan masuk 100% tepat waktu 3. Analisa Kemungkinan terjadi hambatan dalam birokrasi permintaan stok ke gudang atau kelalaian dalam pengisian form laporan bulanan oleh petugas unit. 4. Tindakan Menyederhanakan formulir pemantauan APD dan menetapkan "Stock Keeper" di setiap shift kerja.
Do	1. Melakukan audit mendadak (spot check) untuk memverifikasi kesesuaian APD di unit dengan standar PPI. 2. Mensosialisasikan alur permintaan APD darurat jika terjadi lonjakan kebutuhan. 3. Mengumpulkan data ketersediaan APD secara rutin setiap akhir minggu.
Study	1. Mengevaluasi grafik capaian pada bulan berjalan untuk memastikan data tidak lagi kosong. 2. Menganalisis apakah ada jenis APD tertentu (misal: masker atau sarung tangan) yang lebih sering habis dibanding yang lain.
Action	1. Jika data pelaporan sudah konsisten, jadikan sistem pelaporan baru sebagai standar prosedur operasional (SPO). 2. Jika masih ada kendala stok, lakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk menambah kuota <i>buffer stock</i>.

- b. Kepatuhan Penggunaan APD
- Gambar 3.3.1.5 Kepatuhan Penggunaan APD



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan alat pelindung diri di bulan April tahun 2026 sebesar 98,94% dengan rerata 96,06%.

Tabel 3.3.1.7 PDSA Kepatuhan Alat Pelindung Diri

Problem	Prosentase kepatuhan alat pelindung diri sudah mencapai standart 80%
Step	Reaktivasi monitoring kepatuhan APD dan edukasi risiko infeksi bagi petugas.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala (harian/mingguan) dan mengadakan sesi penyegaran terkait SPO APD. 2. Harapan Tingkat kepatuhan kembali stabil di atas target sasaran (80%) dan data terisi secara konsisten setiap bulan. 3. Analisa Rendahnya angka kemungkinan disebabkan oleh kejenuhan petugas, ketidaknyamanan dalam penggunaan APD, kurangnya pengawasan, atau sistem pelaporan yang terhenti dan ketidak sesuaian penggunaan APD berdasarkan tindakan yang dilakukan 4. Tindakan Menetapkan supervisor di setiap shift untuk melakukan verifikasi pemakaian APD sebelum petugas memasuki area pelayanan.
Do	1. Melaksanakan audit mendadak oleh Tim PPI di berbagai unit pelayanan. 2. Memberikan edukasi "on-the-spot" jika ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD sesuai standar serta melakukan penulisan pelanggaran pada link supervisi 3. Mengaktifkan kembali form laporan kepatuhan bulanan <i>by name</i> dan unit asal
Study	1. Menganalisis hasil audit untuk melihat tren kepatuhan. 2. Memeriksa apakah alasan ketidakpatuhan disebabkan oleh faktor kenyamanan APD, ketersediaan, atau murni perilaku petugas.
Action	1. Jika kepatuhan meningkat, teruskan audit berkala sebagai standar pemantauan. 2. Jika masih rendah, pertimbangkan untuk menerapkan sistem <i>feedback</i> langsung kepada kepala unit terkait.

3. Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (CSSD)

Gambar 3.3.1.6 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (CSSD)



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.6 diketahui bahwa rerata dekontaminasi peralatan perawatan pasien di bulan April tahun 2026 sebesar 100% dengan rerata 96,49%.

Tabel 3.3.1.8 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (CSSD)

Problem	Prosentase dekontaminasi peralatan perawatan pasien (CSSD) sudah mencapai standart 80%
Step	Audit Titik Kritis Pengendalian Kualitas (3 T): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan penurunan mutu: 1) Pengecekan tanggal kadaluarsa BMHP 2) Pencatatan/Verifikasi ulang tanda indikator sterilisasi pada setiap paket instrumen. 3) Pencatatan monitoring lingkungan dan fasilitas yang tersedia selama proses BMHP
Plan	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP agar mencapai minimal 80% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan sistem double check ketika melakukan serah terima instrumen kotor di CSSD dengan melakukan pendokumentasian dibuku serah terima b. Menerapkan sistem <i>double check</i> (dua orang) untuk pengecekan tanggal kadaluarsa BMHP sebelum didistribusikan ke unit pengguna. c. Menetapkan Checklist Serah Terima Instumen Steril yang mewajibkan pengguna (perawat/dokter) dan petugas CSSD memverifikasi <i>External Indicator</i> dan mencatatnya. d. Memberikan pelatihan ulang singkat kepada petugas CSSD dan perawat ruangan tentang manajemen stok BMHP dan <i>first-in, first-out</i> (FIFO) untuk BMHP. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Checklist Serah Terima Instumen Steril</i>. b. Indikator Proses: Persentase BMHP yang didistribusikan/digunakan dengan tanggal kadaluarsa yang valid. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP bulanan (Sasaran).
Do	1. Mengadakan audit kepatuhan prosedur dekontaminasi di unit secara acak. 2. Mengumpulkan semua laporan fisik yang tertunda untuk diinput ke sistem. 3. Petugas CSSD dan perawat ruangan wajib menggunakan Checklist serah terima instumen steril pada setiap penyerahan/penerimaan. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>double check</i> BMHP dan kepatuhan <i>checklist</i>.
Study	1. Mengevaluasi apakah angka capaian di bulan berjalan kembali muncul dalam grafik dan tetap berada di atas target 80%. 2. Menganalisis kendala jika masih ada data yang tidak dilaporkan.
Action	1. Standarisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 95%, standardisasikan <i>Checklist</i> serah terima instumen steril dan prosedur <i>double check</i> BMHP ke seluruh unit pengguna. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi

	intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan penyimpanan (misalnya, desain ulang rak penyimpanan agar stok lama mudah diakses untuk implementasi FIFO) atau pada validasi siklus sterilisasi (jika indikator sterilisasi masih menjadi masalah). Fokuskan pada stok BMHP di unit cek masa kadaluarsa pemakaian
--	---

4. Penanganan Linen

Gambar 3.3.1.7 Penanganan Linen



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.7 diketahui bahwa rerata penanganan linen di bulan April tahun 2026 sebesar 98,57% dengan rerata 98,34%.

Tabel 3.3.1.9 Penanganan Linen

Problem	Prosentase penanganan linen sudah mencapai standart 80%
Step	Audit Titik Kontaminasi Kritis (3 Zona): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan kontaminasi atau ketidakpatuhan: - Pemisahan Linen Kotor & Infeksius dari unit, - Prosedur Serah Terima antara unit dan laundry, dan - Kondisi Area Penyimpanan Linen Bersih (bersih, kering, tertutup) baik di unit dan di laundry.
Plan	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Linen/Laundry agar mencapai minimal 80% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Melakukan <i>coaching</i> ulang kepada staf perawat dan <i>cleaning service</i> di unit terkait tata cara pemilahan linen (kotor vs infeksius) dan pengisian kantong linen. - Menerapkan Checklist Harian Kondisi Linen Bersih di setiap unit (memastikan area penyimpanan bersih, tertutup, dan tidak lembap). - Standardisasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap oleh petugas <i>laundry</i> saat menangani linen kotor/infeksius. - Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan pemisahan linen di unit. - Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Checklist Harian Kondisi Linen Bersih</i>. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Linen/Laundry bulanan (Sasaran).
Do	Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur pemilahan dan pengisian



	<i>checklist</i> baru. - Unit-unit wajib mengisi Checklist Harian Kondisi Linen Bersih. - Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit-unit tentang cara pemilahan linen dan di area penyimpanan linen bersih. - Tim <i>Laundry</i> mencatat kepatuhan penggunaan APD.
Study	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung prosentase kepatuhan terhadap pemisahan linen dan kelengkapan <i>checklist</i> linen bersih. - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 98,34 %). - Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah tempat penyimpanan linen kotor/infeksius tidak memadai (misalnya, jumlah troli kurang)? * Apakah petugas kesulitan mengosongkan linen kotor segera?
Action	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 80%, standardisasikan <i>Checklist Harian Kondisi Linen Bersih</i> dan prosedur pemilahan ke seluruh unit pengguna. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. - Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan infrastruktur/logistik (misalnya, menambah troli/kantong linen) atau pada desain ulang alur distribusi dari <i>laundry</i> ke unit untuk mencegah linen bersih terkontaminasi.

5. Pengendalian Lingkungan

a. Kebersihan Umum

Gambar 3.3.1.8 Kebersihan Umum



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.8 diketahui bahwa rerata kebersihan lingkungan di bulan April tahun 2026 rerata sebesar 99,49% dengan rerata 98,70%.

Tabel 3.3.1.10 PDSA Kebersihan Umum

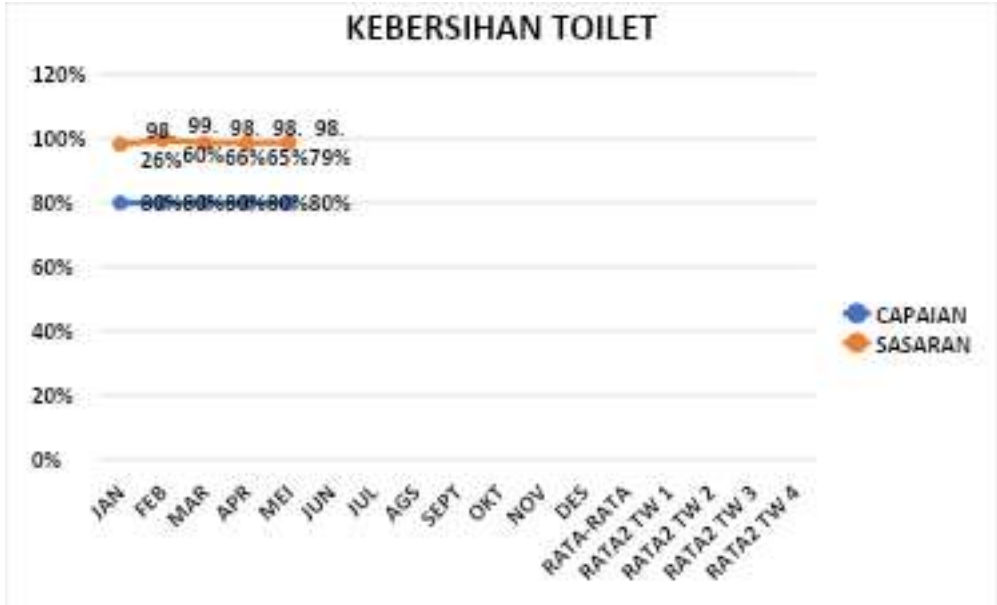
Problem	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 99,49% dan sudah mencapai target 80%.
Step	Monitoring berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan di area rumah sakit.
Plan	1. Rencana:



	Meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit hingga minimal 80% sesuai target pada semua bulan berjalan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya kepatuhan staff dalam menjaga kebersihan area kerja dan area perawatan pasien b. Kurangnya pengawasan dari supervisor lingkungan c. Kurangnya motivasi atau reward bagi petugas kebersihan yang berdinis d. Kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan SPO yang tersedia 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan (baik secara mingguan, bulanan dan memberikan umpan balik) b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Menyediakan checklist kebersihan harian
Do	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
Study	1. Nilai kepatuhan kebersihan umum pada bulan April tahun 2026 dengan rerata sebesar 99,49% dan sudah mencapai sasaran 80%. 2. Monitoring capaian kepatuhan setiap minggu 3. Lakukan perbandingan hasil kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan dengan bulan sebelumnya 4. Evaluasi area dengan peningkatan dan penurunan 5. Survei kepuasan staff dan petugas terhadap sistem baru
Action	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart 2. Beri feedback pada hasil temuan 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit dengan SOP dan audit sebagai standar rutin 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan SOP dan audit sebagai standar rutin

b. Kebersihan Toilet

Gambar 3.3.1.9 Kebersihan Toilet



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.9 diketahui bahwa rerata kebersihan toilet di bulan April tahun 2026 rerata sebesar 98,65% dengan rerata sebesar 98,79%.

Tabel 3.3.1.11 PDSA Kebersihan Toilet

Problem	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan kebersihan toilet bulan April 2026 dengan rerata 98,65% dan sudah mencapai target 80%.
Step	Standarisasi jadwal monitoring harian dan perbaikan sistem pelaporan dokumentasi kebersihan toilet.
Plan	1. Rencana Melakukan audit rutin menggunakan checklist kebersihan harian (lantai, dinding, ketersediaan sabun/air) dan memastikan tim kebersihan (<i>cleaning service</i>) melakukan input data setiap bulan. 2. Harapan Mempertahankan capaian kebersihan di atas 95% dan memastikan data laporan bulanan terisi 100% tanpa kekosongan. 3. Analisa Ada beberapa toilet yang berada di perawatan yang mengalami kerusakan fasilitas seperti ujung pintu, kran bocor. 4. Tindakan Menunjuk pengawas (supervisor) khusus untuk memvalidasi checklist harian sebelum direkap menjadi laporan bulanan.
Do	1. Melaksanakan pembersihan toilet minimal 3 kali sehari atau sesuai kebutuhan. 2. Melakukan penulisan cek list pada pembersihan toilet. 3. Mengumpulkan data kepatuhan kebersihan dari seluruh unit untuk dilaporkan ke komite mutu.
Study	Mengevaluasi apakah angka capaian di bulan berjalan tetap konsisten di atas target 80%
Action	1. Jika data kembali stabil dan kualitas terjaga, jadikan alur monitoring ini sebagai prosedur tetap.

	2. Jika ditemukan penurunan kualitas di unit tertentu, lakukan penambahan frekuensi pembersihan atau penggantian bahan pembersih.
--	---

- c. Penyimpanan Alat dan Obat
- Gambar 3.3.1.10 Penyimpanan Alat dan Obat



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.10 diketahui bahwa rerata kebersihan ruang obat dan alat di bulan April 2026 rerata sebesar 80% dengan rerata sebesar 75,42%.

Tabel 3.3.1.12 PDSA Kebersihan Penyimpanan Alat dan Obat

Problem	Capaian kebersihan ruang obat pada bulan April sebesar 80% dengan rerata sebesar 75,42% dan belum mencapai standart
Step	Optimalisasi jadwal pembersihan harian dan pengawasan ketersediaan sarana kebersihan di ruang penyimpanan obat dan alat
Plan	1. Rencana Menyusun jadwal pembersihan berkala untuk rak obat, lantai, dan area penyimpanan alat medis serta melakukan audit kepatuhan petugas farmasi. 2. Harapan Meningkatkan capaian kebersihan di atas 90% pada periode berikutnya dan memastikan seluruh area penyimpanan bebas dari debu serta kontaminan. 3. Analisa Capaian 80% menunjukkan bahwa standar minimal sudah terpenuhi, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal konsistensi pembersihan detail (seperti sudut rak atau wadah alat). 4. Tindakan Menyediakan checklist kebersihan yang terintegrasi di ruang obat dan memastikan petugas kebersihan memahami standar PPI untuk area farmasi.
Do	1. Melakukan pembersihan rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Mengisi checklist monitoring harian untuk setiap area di ruang obat dan alat. 3. Melakukan pemilahan alat yang sudah tidak terpakai agar tidak menumpuk dan menjadi sarang debu.



Study	1. Mengevaluasi apakah lingkungan ruang obat menjadi lebih rapi dan bersih setelah penerapan checklist. 2. Membandingkan hasil observasi mingguan untuk melihat titik mana yang sering terlewatkan dalam pembersihan.
Action	1. Jika hasil audit menunjukkan peningkatan kepatuhan, teruskan sistem monitoring yang ada. 2. Jika capaian tetap di angka 80%, lakukan peninjauan ulang terhadap beban kerja petugas atau kecukupan alat pembersih yang tersedia.

d. Pemeriksaan Lingkungan Rumah Sakit

(a) Uji Lingkungan

Tabel 3.3.1.13 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Pemeriksaan Lantai, Dinding dan Udara pada bulan Januari 2026

UNIT	JENIS PEMERIKSAAN BULAN JANUARI		
	LANTAI	DINDING	UDARA
IKO 1	<1	<1	<1
IKO 2	<1	<1	20
IKO 3	<1	<1	35
IKO 4	<1	<1	10
DAPUR	3	<1	155
RANAP (C.3A.2)	4	<1	235
R. ISOLASI	<1	<1	55
R. IGD	1	<1	25
ICU	<1	<1	40
NICU	<1	<1	75

Standart :

1. Lantai : 0-5 CFU/m³
2. Dinding : 0-5 CFU/m³
3. Udara Ranap/R. Khusus : maks 700
4. Udara R. Operasi : 35 CFU/m³ dalam kondiri ruangan kosong

Tabel 3.3.1.14 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Alat Medis

UNIT	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN ALAT MEDIS						
		LMA	CIRCUIT BREATHING	BAGGING	SET SC	SET LAPAROTOMI	SET ALAT KADALUARSA	KASSA
CSSD/IKO	JANUARI	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Standart :

Tidak mengandung 20 CFU/100 cm²



Tabel 3.3.1.15 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Swab Linen

UNIT	JENIS PEMERIKSAAN SWAB LINEN BULAN JANUARI	
	SKORT OK	LINEN/DUK
CSSD	<1	<1

Standart :

Tidak mengandung 20 CFU/100 cm²

Tabel 3.3.1.16 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Pemeriksaan Alat Masak dan Alat Makan

UNIT	JENIS PEMERIKSAAN BULAN JANUARI				
	ALAT MASAK	ALAT MAKAN			
		MANGKOK	SENDOK	PIRIN G	GELA S
DAPUR	<1	<1	<1	<1	<1

Standart :

Set alat masak dan alat makan <1,1 CFU/cm²

Tabel 3.3.1.17 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Pemeriksaan Uji Mikrobiologi

UNIT	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN							
		UJI MIKROBIOLOGI							
		NASI		OSEN TUMIS		AYAM GORENG		AIR TEH	
		E. COLI	SALMONELLA	E. COLI	SALMONELLA	E. COLI	SALMONELLA	E. COLI	SALMONELLA
DAPUR	Januari	<3 MPN/g	-	<3 MPN/g	-	<3 MPN/g	-	<3 MPN/g	-

Standart :

1. E.Coli pada makanan dan minuman harun <3,6 MPN/gr atau <3,6 MPN/ml
2. Salmonella Neg/25 g



Tabel 3.3.1.18 Uji Air Bersih (Tandon)

LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL (AIR TANDON)	NAB	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
TOTAL COLIFORM	0	29	<1	34	17								
ESCHERICHIA COLI	0	<1	<1	<1	<1								
TEMPERATUR	<3												
TDS	<300												
KEKERUHAN	<3												
WARNA	10												
** BAU	TIDAK BERBAU												
PH	6,5 - 8,5												
NO3	20												
NO2	3												
KROM VAL 6	0,01												
BESI (FE) TERLARUT	0,2												
MANGAN (MN) TERLARUT)	0,1												
**) KLOLIN BEBAS	0,2 - 0,5												
ARSEN (AS) TERLARUT	0,01												
KADMIUM (CD)TERLARUT	0,003												
TIMBAL (PB) TERLARUT	0,01												
FLUORIDA (F-)	1,5												
ALUMINIUM (AL) TERLARUT	0,2												



Tabel 3.3.1.19 Uji Air Pantry

LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL (AIR PANTRY)	NAB	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
TOTAL COLIFORM	0	<1	<1	21	-								
ESCHERICHIA COLI	0	<1	<1	<1	-								
TEMPERATUR	<3												
TDS	<300												
KEKERUHAN	<3												
WARNA	10												
** BAU	TIDAK BERBAU												
PH	6,5 - 8,5												
NO3	20												
NO2	3												
KROM VAL 6	0,01												
BESI (FE) TERLARUT	0,2												
MANGAN (MN) TERLARUT)	0,1												
**) KLOLIN BEBAS	0,2 - 0,5												
ARSEN (AS) TERLARUT	0,01												
KADMIUM (CD)TERLARUT	0,003												
TIMBAL (PB) TERLARUT	0,01												
FLUORIDA (F-)	1,5												
ALUMINIUM (AL) TERLARUT	0,2												



Tabel 3.3.1.20 Uji Air Minum

LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL (AIR MINUM)	NAB	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
TOTAL COLIFORM	0	<1	<1	<1	<1								
ESCHERICHIA COLI	0	<1	<1	<1	<1								
TEMPERATUR	<3												
TDS	<300												
KEKERUHAN	<3												
WARNA	10												
** BAU	TIDAK BERBAU												
PH	6,5 - 8,5												
NO3	20												
NO2	3												
KROM VAL 6	0,01												
BESI (FE) TERLARUT	0,2												
MANGAN (MN) TERLARUT)	0,1												
**) KLOLIN BEBAS	0,2 - 0,5												
ARSEN (AS) TERLARUT	0,01												
KADMIUM (CD)TERLARUT	0,003												
TIMBAL (PB) TERLARUT	0,01												
FLUORIDA (F-)	1,5												
ALUMINIUM (AL) TERLARUT	0,2												



Tabel 3.3.1.21 Uji Air Bersih

LOKASI PENGAMBILAN SAMPel (AIR IKO)	NAB	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
TOTAL COLIFORM	0	-	-	-	4								
ESCHERICHIA COLI	0	-	-	-	<1								
TEMPERATUR	<3												
TDS	<300												
KEKERUHAN	<3												
WARNA	10												
** BAU	TIDAK BERBAU												
PH	6,5 - 8,5												
NO3	20												
NO2	3												
KROM VAL 6	0,01												
BESI (FE) TERLARUT	0,2												
MANGAN (MN) TERLARUT	0,1												
**) KLOrin BEBAS	0,2 - 0,5												
ARSEN (AS) TERLARUT	0,01												
KADMIUM (CD)TERLARUT	0,003												
TIMBAL (PB) TERLARUT	0,01												
FLUORIDA (F-)	1,5												
ALUMINIUM (AL) TERLARUT	0,2												

Tabel 3.3.1.22 Uji Air Limbah In let

LOKASI PENGAMBILAN SAMPOL (IN LET)	NAB	STANDART	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
PH	06 s/d 9	06 s/d 9												
BOD	12	12												
COD	80	80												
ZAT PADAT TERSUSPENSI (TSS)	30	30												
**) RESIDUAL KLOLIN	1	1												
FAECAL COLI	200	200												
**) SALMONELA	NEGATIF	NEGATIF												
SHIGELLA SP	/ 25 ML	NEGATIF												
VIBRIO CHOLERA	/ 25 ML	NEGATIF												
STREPTOCOCCUS SP.	COLONY / 100 ML	NEGATIF												

Tabel 3.3.1.23 Uji Air Limbah Out Let

LOKASI PENGAMBILAN SAMPOL (IN LET)	NAB	STANDART	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
PH	06 s/d 9	06 s/d 9	8,64	8,17	6,72									
BOD	12	12	10,06	7,2	10,07									
COD	80	80	30,56	24,38	44,59									
ZAT PADAT TERSUSPENSI (TSS)	30	30	5,4	5,4	5,4									
**) RESIDUAL KLOLIN	1	1	<0,45	<0,45	<0,45									
FAECAL COLI	200	200	270	220	120									
**) SALMONELA	NEGATIF	NEGATIF	negatif	negatif	negatif									



SHIGELLA SP	/ 25 ML	NEGATIF	1,4x100	negatif	2,8x100									
VIBRIO CHOLERAЕ	/ 25 ML	NEGATIF	negatif	negatif	negatif									
STREPTOCOCCUS SP.	COLONY / 100 ML	NEGATIF	negatif	negatif	negatif									



Tabel 3.3.1.24 PDSA Hasil Uji Lingkungan

Plan	1. Rencana a. Memastikan seluruh area rumah sakit, terutama area kritikal seperti Ruang IKO, ICU, dan NICU, tetap memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan rumah sakit (0-5 CFU/cm²) sesuai Permenkes No. 7 Tahun 2019 b. Memastikan nilai baku mutu air bersih sesuai dengan Permenkes No. 7 Tahun 2019 dengan total caliform 0, dan eschericia coli 0 2. Harapan a. Mempertahankan hasil <1 CFU/cm² di semua area kritikal dan menurunkan angka kuman di area Dapur serta Rawat Inap agar tetap jauh di bawah ambang batas maksimal 5 CFU/cm² b. Mempertahankan hasil air bersih dan air minum sesuai dengan Permenkes No. 7 tahun 2019 3. Analisa a. Hasil uji menunjukkan sebagian besar area berada pada angka <1 CFU/cm² (negatif). Namun, terdapat pertumbuhan kuman di beberapa titik seperti,
	a) Lantai R. Dapur: 3 CFU/cm² b) Lantai R. Ranap 3: 4 CFU/cm² c) Dinding R. IGD: 1 CFU/cm² Dan yang terlampir di dalamnya b. Hasil uji air bersih menunjukkan ada beberapa titik pengujian yang belum standart yakni, a) Air minum : Total caliform : <1 Eschericia Choli : <1 b) Air Bersih Tandon utama : Total caliform : 17 Eschericia choli : <1 c) Air Bersih IKO Total caliform : 7 Eschericia choli : <1 4. Tindakan a. Review prosedur pembersihan dan disinfeksi harian di R. Dapur dan R. Ranap 3. b. Pengecekan konsentrasi cairan disinfektan yang digunakan. c. Rive SPO pembersihan tandon utama d. Buat jadwal pembersihan sesuai setiap 2 minggu sekali di minggu ke 1 dan 3 di hari Rabu
Do	1. Melaksanakan pembersihan rutin (<i>mopping</i> dan <i>wiping</i>) dengan pengawasan lebih ketat pada area yang memiliki hasil uji di atas 1 CFU/cm². 2. Memastikan petugas kebersihan (<i>cleaning service</i>) menggunakan teknik pembersihan yang benar (dari area bersih ke kotor). 3. Melakukan disinfeksi berkala pada permukaan dinding dan lantai menggunakan cairan disinfektan sesuai standar rumah sakit. 4. Melakukan pembersihan tandon utama sesuai dengan jadwa yang telah di tentukan



Study	1. Analisis Hasil: Meskipun semua ruangan saat ini Lolos/Memenuhi Syarat (di bawah 5 CFU/cm²), terdapat variasi kepadatan kuman. 2. Prosedur disinfeksi saat ini sudah efektif, namun perlu perhatian khusus pada area non-bedah agar angka kuman tidak meningkat mendekati batas maksimal.
Action	1. Standardisasi: Menetapkan jadwal pembersihan ekstra untuk area Dapur dan Rawat Inap. 2. Edukasi: Memberikan pelatihan ulang kepada petugas kebersihan mengenai pentingnya waktu kontak (contact time) disinfektan pada permukaan lantai dan dinding. 3. Keberlanjutan: Menjadwalkan uji petik swab ruang secara berkala (per semester atau sesuai regulasi) untuk memantau konsistensi kebersihan lingkungan rumah sakit

Link Suhu : https://drive.google.com/drive/folders/1KdTC9-9Y7MYDre3sFGduT-x6EAy4Q0xl?usp=drive_link

6. Penanganan Limbah

a. Limbah Domestik

Tabel 3.3.1.25 Limbah Domestik

No	Bulan	Hasil Limbah Domestik (kg)
1	Januari	7857
2	Februari	7066
3	Maret	7800
4	April	7528
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	
Rata-rata		7563

Tabel 3.3.1.26 PDSA Limbah Domestik

Problem	Jumlah limbah domestik yang dihasilkan sebanyak 7.528 kg dan memerlukan sistem monitoring pembuangan yang terjadwal agar tidak terjadi penumpukan di TPS.
Step	Pengaturan jadwal pengangkutan limbah dan pemilahan awal di unit penghasil.
Plan	- Rencana Melakukan penimbangan rutin harian dan memastikan pengangkutan oleh pihak ketiga dilakukan tepat waktu. - Harapan Tidak ada penumpukan limbah domestik di area pelayanan dan data timbangan tercatat akurat setiap hari. - Analisa - Total limbah 7.528 kg menunjukkan rata-rata harian yang besar, sehingga koordinasi jadwal angkut sangat krusial untuk mencegah bau dan lalat. - Masih ditemukan ketidakpatuhan petugas dalam melakukan pengambilan sampah domestik di bulan April sebanyak 1x dikarenakan armada pengangkutan sedang dalam perbaikan - Tindakan Menyediakan kantong plastik hitam yang cukup di setiap unit dan memastikan petugas kebersihan mengikat kantong saat sudah 3/4 penuh.
Do	Melaksanakan penimbangan limbah setiap pagi sebelum diangkut ke TPS.



	2. Mencatat hasil timbangan harian ke dalam logbook penanganan limbah. 3. Memastikan petugas menggunakan APD lengkap (sarung tangan rumah tangga dan masker) saat mengelola limbah.
Study	1. Mengevaluasi ketepatan waktu pengangkutan limbah. 2. Memeriksa apakah ada keluhan terkait penumpukan atau aroma tidak sedap di titik-titik pengumpulan selama bulan Januari.
Action	1. Berdasarkan data 7.857 kg tersebut, jika ditemukan penumpukan, frekuensi pengangkutan harian perlu ditambah di bulan berikutnya. 2. Jika sistem sudah berjalan baik, jadikan alur ini sebagai SOP tetap.

b. Limbah B3

1) Padat

Tabel 3.3.1.27 Limbah B3 “Padat”

BULAN/2026	LIMBAH INFEKSIUS (KG)	LIMBAH BOTOL INFUS (KG)	LIMBAH BENDA TAJAM (KG)	LIMBAH SLUDGE IPAL (KG)	LIMBAH FARMASI KADALUARSA (KG)	LIMBAH DOMESTIK (KG)	JUMLAH LIMBAH YANG DIAMBIL VENDOR
JANUARI	1793	1595	622	72	0	7857	4042
FEBRUARI	1682	1141	542	70	0	7066	3324
MARET	1733	1475	614	67	0	7528	3841
APRIL							
MEI							
JUNI							
JULI							
AGUSTUS							
SEPTEMBER							
OKTOBER							
NOVEMBER							
DESEMBER	1793	1595	622	72	0	7563	3610,25
TOTAL DALAM 1 TAHUN	1793	1595	622	72	0	7574	3533,333333
RATA-RATA BULANAN	3586	3190	1244	144	0	15714	8084
RATA-RATA HARIAN	1733	1475	614	67	0	7528	3841

Tabel 3.3.1.28 PDSA Limbah B3 “Padat”

Problem	Tingginya volume limbah B3 pada bulan April (total infeksius, botol infus, dan benda tajam mencapai lebih dari 3.841 kg dalam satu bulan) yang memerlukan pemantauan ketat pada sistem pemilahan dan pengangkutan agar tidak terjadi penumpukan di TPS B3.
Step	Standarisasi penimbangan harian dan verifikasi kepatuhan pemilahan limbah B3 di setiap unit penghasil.
Plan	1. Rencana

	Melakukan audit kepatuhan pemilahan limbah (penggunaan kantong kuning untuk infeksius dan <i>safety box</i> untuk benda tajam) serta validasi data timbangan harian. 2. Harapan Akurasi data limbah mencapai 100% antara catatan unit dan logbook TPS B3, serta memastikan seluruh limbah diambil oleh vendor tepat waktu. 3. Analisa c. Volume limbah infeksius (1.733 kg), limbah botol infus (1.475 kg) dan benda tajam (614 kg) yang signifikan memerlukan wadah penampung yang memadai untuk mencegah risiko kecelakaan kerja. 4. Tindakan Memastikan ketersediaan kantong plastik kuning, <i>safety box</i>, dan label limbah B3 di seluruh titik pelayanan.
Do	1. Mencatat volume harian setiap kategori limbah B3 (Infeksius, Benda Tajam, Botol Infus, Sludge) ke dalam formulir neraca limbah 2. Melakukan pengawasan langsung saat proses pengangkutan dari unit ke TPS B3. 3. Memeriksa manifest pengambilan limbah oleh vendor pihak ketiga (Total diambil vendor: 3.324 kg).
Study	1. Membandingkan total timbangan harian dengan rata-rata bulanan 2. Mengevaluasi apakah ada limbah farmasi kadaluarsa di bulan berjalan
Action	1. Berdasarkan capaian bulan April, jika sistem pencatatan sudah akurat, lanjutkan prosedur ke bulan Mei 2. Jika ditemukan ketidaksesuaian timbangan antara unit dan vendor, lakukan kalibrasi alat timbang secara berkala.

2) Cair (IPAL)

Tabel 3.3.1.29 Limbah B3 "Cair"

BULAN	DEBIT IN LET	DEBIT OUT LET	pH (6-9)	Suhu (°C) MAX 30	KETERANGAN
JANUARI	3130	3429	7,4	26,5	
FEBRUARI	4586	3114	7,4	26,5	
MARET	4183	2139	7,4	26,5	
APRIL	4687	2714	7,4	26,5	
MEI					
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOVEMBER					
DESEMBER					
TOTAL / TAHUN	16586	11396	29,6	106	

RATA-RATA / BULAN	3966	2894	7	27	
RATA-RATA / HARI	45	31	0	0	

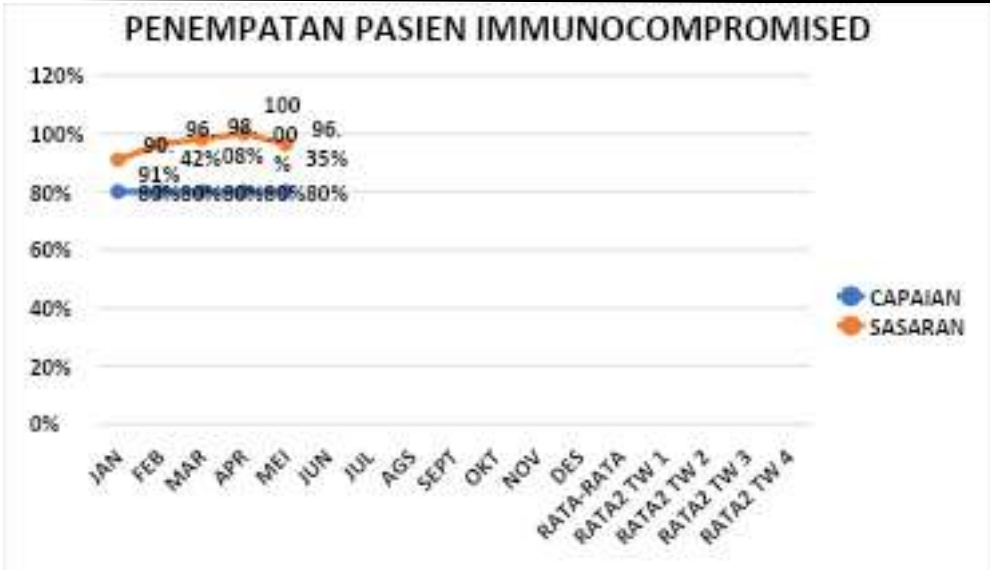
Tabel 3.3.1.30 PDSA Limbah B3 “Cair”

Problem	Adanya selisih volume antara debit masuk (inlet) dan debit keluar (outlet) pada bulan Maret, serta perlunya menjaga konsistensi parameter mutu air limbah agar tetap di bawah ambang batas.
Step	Kalibrasi alat ukur debit (flow meter) dan optimalisasi proses pengolahan biologi/kimia pada IPAL.
Plan	- Rencana Melakukan pengecekan akurasi <i>flow meter</i> inlet dan outlet serta pemantauan harian parameter pH dan suhu - Harapan Selisih debit inlet dan outlet terminimalisir (< 5%) dan seluruh parameter uji limbah cair tetap memenuhi standar baku mutu lingkungan. - Analisa Perbedaan debit (inlet 7687 vs outlet 2714) kemungkinan disebabkan oleh adanya limpasan air hujan yang masuk ke sistem IPAL atau kurang akurasinya alat ukur dan adanya ier yang tidak masuk dalam sistem IPAL diakibatkan adanya sumbatan pada bak kontrol IPAL di samping Rawat Jalan - Tindakan Melakukan pemeriksaan kebocoran pada pipa sistem IPAL dan memastikan sensor suhu serta pH bekerja dengan baik.
Do	- Mencatat debit inlet dan outlet setiap hari pada jam yang sama. - Melakukan pengambilan sampel air limbah untuk uji laboratorium di minggu pertama setiap bulan berjalan - Membersihkan bak kontrol dan <i>screen</i> dari sumbatan sampah padat
Study	- Mengevaluasi apakah data pH (7,4) dan suhu (26,5°C) tetap stabil sepanjang bulan. - Menganalisis penyebab utama kenaikan volume pada debit outlet dibandingkan debit inlet.
Action	- Jika parameter tetap aman dan alat ukur sudah terkalibrasi, lanjutkan prosedur monitoring rutin. - Jika selisih debit tetap tinggi, rencanakan audit infrastruktur jaringan perpipaan limbah di bulan berikutnya.

7. Penempatan Pasien

a. Penempatan Pasien *Immunocompromised*

Gambar 3.3.1.11 Penempatan Pasien *Immunocompromised*



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.11 diketahui bahwa rerata penempatan pasien *immunocompromised* di bulan April tahun 2026 rerata sebesar 100% dengan rerata sebesar 96,35%.

Tabel 3.3.1.31 PDSA Penempatan Pasien *Immunocompromised*

Problem	Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> sudah mencapai 80%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan pasien <i>immunocompromised</i> sesuai standart dengan target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial; a. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya penempatan khusus bagi pasien immunocompromised b. fasilitas ruang isoalsi terbatas c. kelemahan dalam system triase awal dan komunikasi lintas unit 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> terhadap proses triase d. Optimalisasi ruang perawatan dengan system kohorting pasien sejenis
Do	Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> sudah mencapai 80%



Study	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> pada bulan April di tahun 2026 yaitu sebesar dengan rerata 100% dan sudah mencapai standart 80%. 2. Lakukan audit internal mingguan terhadap dokumentasi dan praktik penempatan 3. Data dievaluasi untuk melihat perbaikan dan hambatan dalam proses 4. Lakukan pembahasan secara rutin dalam rapat koordinasi
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>. 2. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 3. Evaluasi keberlanjutan program setiap 3 bulan dan perbaikan berkelanjutan 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>

b. Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone*

Gambar 3.3.1.12 Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone*



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.12 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer pasien infeksi *airbone* di bulan April tahun 2026 rerata sebesar 97,22% dengan rerata 90,65%.

Tabel 3.3.1.32 PDSA Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone*

Problem	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sudah mencapai 80%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkasi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
Plan	1. Rencana:



	Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan dan transfer pasien dengan infeksi airborne agar mencapai target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial ; - Kurangnya pemahaman staff mengenai prosedur <i>airbone precaution</i> - Tidak semua ruang perawatan dilengkapi system isolasi airborne - Koordinasi antar unit dalam proses transfer masih lemah - Masih ditemukan pengunjung di ruang Isolasi dengan sistem berkerumun 4. Tindakan - Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sesuai dengan SOP dan standart yang berlaku - Koordinasi dengan IPCLN melalui grub komunikasi aktif di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
Do	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
Study	- Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> pada bulan April tahun 2026 dengan rerata sudah mencapai target 80%, - Monitoring kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dilakukan secara mingguan - Evaluasi dilakukan terhadap proses transfer yang terjadi setiap bulan - Lakukan audit terhadap dokumentasi penempatan pasien
Action	- Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. - Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) - Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi, - Perkuat system pemantauan dan laporan internal - Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, - Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat

c. Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

Gambar 3.3.1.13 Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.13 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan April tahun 2026 rerata sebesar 80% dengan rerata sebesar 80,72%.

Tabel 3.3.1.33 PDSA Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

Problem	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
Do	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
Study	Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat pada bulan April tahun 2026 yaitu sebesar 80%
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-



	sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.
--	---

8. Penyuntikan Aman dan Pencegahan Cidera Benda Tajam
Gambar 3.3.1.14 Penyuntikan Aman dan Pencegahan Cidera Benda Tajam



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.14 diketahui bahwa rerata praktik menyuntik yang aman di bulan April tahun 2026 sebesar 95,96% dengan rerata 94,53%.

Tabel 3.3.1.34 PDSA Penyuntikan Aman dan Pencegahan Cidera Benda Tajam

Problem	Prosentasi praktik menyuntik yang aman di bulan April 2026 sebesar 95,96% dengan rerata 94,53%.
Step	Sosialisasi berkelanjutan mengenai <i>Single Use Device</i> dan perbaikan konsistensi pelaporan observasi lapangan.
Plan	1. Rencana Melakukan supervisi mendadak terkait penggunaan <i>sprit</i> sekali pakai dan pembuangan jarum langsung ke <i>safety box</i>. 2. Harapan Mempertahankan kepatuhan di atas 95% dan memastikan data laporan bulanan terisi penuh 100%. 3. Analisa Tidak ada staff yang terkena pajanan 4. Tindakan Menunjuk mentor klinis di setiap unit untuk memvalidasi kepatuhan praktik menyuntik secara harian.
Do	1. Mengobservasi teknik menyuntik petugas (tidak melakukan <i>recapping</i> jarum dengan dua tangan). 2. Memastikan ketersediaan <i>safety box</i> di dekat area tindakan. 3. Mencatat hasil observasi ke dalam formulir pemantauan bulanan PPI.
Study	Mengevaluasi hasil observasi untuk memastikan angka tetap konsisten di atas target 80% dan menganalisis jika ditemukan



	insiden tertusuk jarum (meskipun data Januari menunjukkan 0 kejadian benda tajam).
Action	Jika kepatuhan tetap tinggi, lanjutkan edukasi berkala. Jika ditemukan kendala dokumentasi, integrasikan checklist praktik menyuntik ke dalam aplikasi pelaporan mutu rumah sakit.

9. Etika Batuk
Gambar 3.3.1.15 Etika Batuk



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.15 diketahui capaian etika batuk pada bulan April tahun 2026 sebesar 86,11% dengan rerata sebesar 83,33%.

Tabel 3.3.1.35 PDSA Etika Batuk

Problem	Kepatuhan belum stabil di atas 90%, yang penting untuk pencegahan transmisi infeksi pernapasan.
Step	Edukasi <i>High-Impact</i> dan Pemasangan Media Visual Kritis (3M): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis: 1) Pemasangan Media Visual (Poster) di area berisiko tinggi (misalnya, Poliklinik, IGD), 2) <i>Coaching</i> Langsung (<i>role-model</i>) oleh staf senior, dan 3) Ketersediaan Tisu dan Tempat Sampah Tertutup yang memadai.
Plan	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Etika Batuk hingga mencapai minimal 90% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Desain dan cetak poster/stiker sederhana bergambar tentang Etika Batuk. b. Pemasangan poster/stiker tersebut di area tunggu pasien, pintu masuk, dan area <i>triase</i> . c. Menerapkan Prosedur <i>Buddy Coaching</i> : Staf senior (<i>role-model</i>) wajib memberikan <i>coaching</i> singkat kepada staf dan pasien/pengunjung yang terlihat tidak patuh. d. Audit ketersediaan tisu dan tempat sampah tertutup di area publik. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase ketersediaan media visual (poster/stiker).

	b. Indikator Proses: Persentase ketersediaan tisu dan tempat sampah tertutup. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Etika Batuk bulanan (Sasaran).
Do	1. Melakukan sosialisasi pemasangan media visual. 2. Memasang poster/stiker di lokasi yang telah ditentukan. 3. Menerapkan prosedur <i>Buddy Coaching</i> di unit-unit berisiko. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi langsung <i>spot check</i> di area publik untuk memverifikasi kepatuhan staf/pasien dan ketersediaan fasilitas.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase ketersediaan media visual dan fasilitas. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah pasien/pengunjung tidak mengerti bahasa pada poster? * Apakah <i>Buddy Coaching</i> tidak dilakukan secara konsisten? *Apakah edukasi kelompok sudah berjalan di masing-masing unit? *Apakah role play petugas ke antar staff/pengunjung berjalan atau tidak?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 90%, standardisasikan penggunaan media visual dan prosedur <i>Buddy Coaching</i> sebagai bagian dari budaya keselamatan. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada pendekatan edukasi yang berbeda (misalnya, menggunakan video singkat di area tunggu) atau pada peningkatan intensitas <i>coaching</i> di area <i>triase</i> pasien.

10. Perlindungan Kesehatan Petugas (Pajanan)

Gambar 3.3.1.16 Perlindungan Kesehatan Petugas (Pajanan)

REKAP LAPORAN PAJANAN PDI TAHUN 2026																
 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  PT. DISA PRIMA MEDIKA																
No	Tgl/Lam Laporan	Tgl/Lam Paparan	Unit	Nama Terpapar	Posisi	Route Paparan	Sumber Paparan	Area Tubuh Terpapar	Kronologi	Jenis APD yang Digunakan	Perlindungan Pertama	Nama Pasien	RMR	Diagnosa & Rawat Iv	Tindakan Terpapar	Tindakan Lanjutan
JANUARI																
	5/1/2026	5/1/2026	IKO	SHAFENDRA	KUK	Mata	Darah	Wajah	Saat operasi syfeleka terciprat darah di wajah	Handsome, gown, mukaas, sepatu	Mendauru sayat dengan air mengalir	HAHYU LLAHROB	10/10/19	LULUS REGO BL/MSB SD DO PISTULA RMI + RBR	PDS-GA KE IKO	CDI HIV KONGUNSI ARV 10 HARI PADA PUKUL 18.00 KONTROL IPO TOL 25/1/2026 DGN DR CAMELIA
FEBRUARI																
1	13/02/2026	13/02/2026	ICU	REVI	DEBI	Luka pada KUK	Darah	JARI TANGGAH SEBELAH KANAN	saat melakukan pemasangan infus	handsome	Dias air mengalir & sabun antiseptik selama 1-3 menit	Dasa	13/02/19	Cat infark Grand mal selena + Emaara EIMRONA	periksa ke IKO	Repeat luka
2	20/02/2026	20/02/2026	OS	DOKI	DOKI	Luka pada KUK	Darah	PERDELAANG AN TANGGAH KANAN	saat melakukan pengumpulan sampel dari ke dalam air	sarung tangan karet	Dias air mengalir & sabun antiseptik selama 1-3 menit	Isak Shesana	-	periksa ke IKO	Cek HIV Cek HDSAg Cek anti HCV	
MARET																
APRIL																
					</											



Link Laporan Pajanan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbsak_IGRgV0ytSYfvc4ukvnKIVFSAD/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true

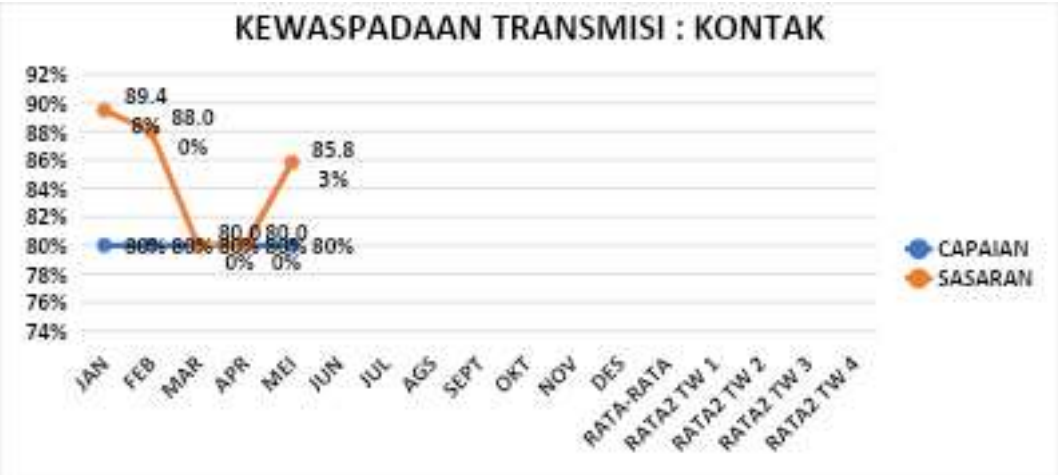
11. Praktik Lumbal Pungsi

(tidak ada tindakan praktik lumbal pungsi)

3.3.1 Kewaspadaan Transmisi

a. Kewaspadaan Transmisi “Kontak”

Gambar 3.3.2.1 Kewaspadaan Transmisi “Kontak”



Interpretasi : Pada gambar 3.3.2.1 diketahui kewaspadaan transmisi “kontak” pada bulan April tahun 2026 sebesar 80% dengan rerata 85,83%.

Tabel 3.3.2.1 PDSA Kewaspadaan Transmisi “Kontak”

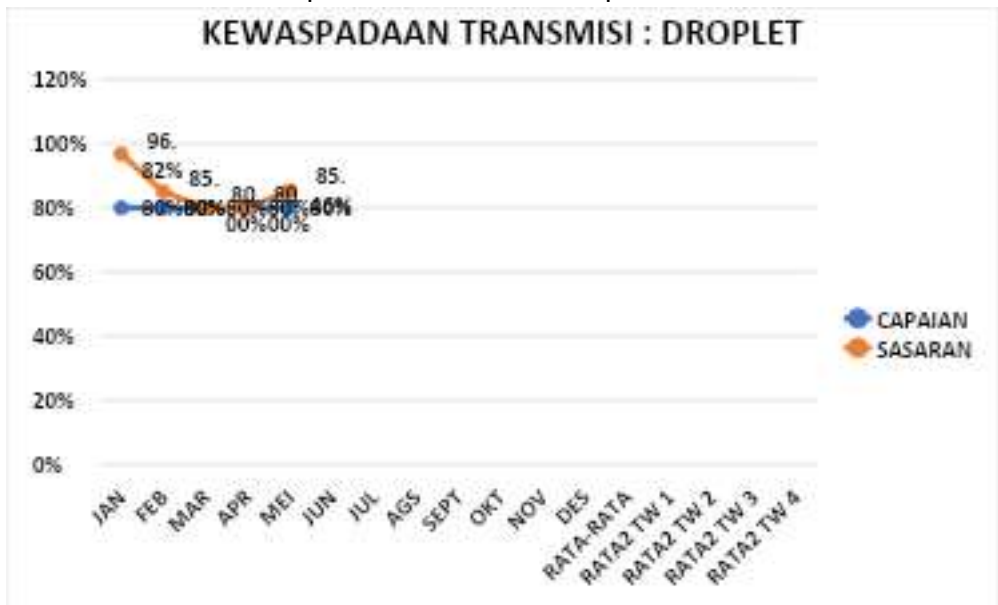
Problem	Prosentase kewaspadaan transmisi kontak sudah mencapai standart 80%
Step	Penguatan monitoring kepatuhan transmisi kontak dan stabilisasi sistem pelaporan bulanan.
Plan	- Rencana Melakukan audit kepatuhan rutin terhadap prosedur kontak (penggunaan APD sesuai indikasi, penempatan pasien) dan memastikan tim PPI melakukan input data setiap akhir bulan. - Harapan Mempertahankan angka kepatuhan di atas 80% secara konsisten. - Analisa Capaian 80% menunjukkan pemahaman petugas sudah baik, namun sistem dokumentasi berkelanjutan belum berjalan optimal. - Tindakan Menunjuk koordinator PPI di setiap ruangan untuk memverifikasi data kepatuhan sebelum dilaporkan ke tingkat komite.
Do	- Melakukan observasi langsung pada ruangan dengan pasien isolasi kontak. - Memastikan ketersediaan gaun dan sarung tangan di area anteroom atau depan kamar pasien. - Mencatat setiap interaksi petugas dengan pasien yang memerlukan kewaspadaan kontak.
Study	- Menganalisis hasil kepatuhan bulan berjalan dibandingkan dengan capaian Februari (88%). - Mengevaluasi apakah hambatan pelaporan dalam bulan berjalan
Action	Jika kepatuhan tetap tinggi dan laporan terisi, lanjutkan sebagai prosedur pemantauan standar.



2. Jika ditemukan kendala pada kesinambungan data, lakukan digitalisasi form observasi agar laporan masuk secara *real-time*.

b. Kewaspadaan Transmisi “Droplet”

Gambar 3.3.2.2 Kewaspadaan Transmisi “Droplet”



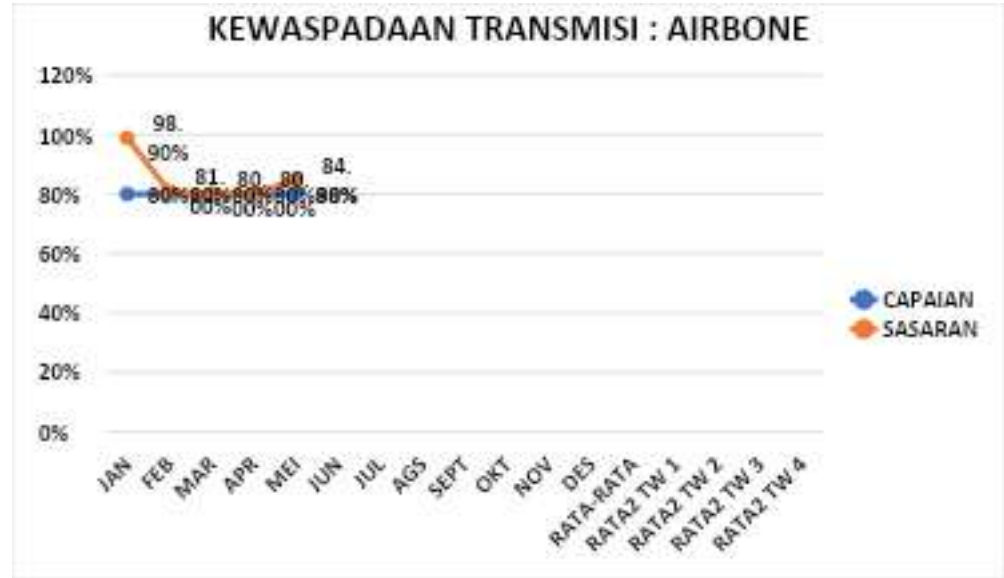
Interpretasi : Pada gambar 3.3.2.2 diketahui kewaspadaan transmisi “droplet” pada bulan April tahun 2026 sebesar 80% dengan rerata sebesar 85,46%.

Tabel 3.3.2.2 PDSA Kewaspadaan Transmisi “Droplet”

Problem	Prosentase kewaspadaan transmisi droplet sudah mencapai standart 80%
Step	Pemeliharaan kepatuhan protokol transmisi droplet dan perbaikan sistem pelaporan data berkala.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan penggunaan masker bedah oleh petugas dan penempatan pasien dengan jarak minimal 1 meter. 2. Harapan Mempertahankan kepatuhan di atas 95% dan memastikan pelaporan data masuk secara konsisten setiap bulan (100% <i>data entry</i>). 3. Analisa Capaian April menunjukkan edukasi awal berhasil, namun masih terdapat ketidak patuhan keluarga dalam memakai APD pada saat menunggu pasien . 4. Tindakan Menunjuk PIC PPI di setiap unit untuk memvalidasi kepatuhan harian dan menginput data tepat waktu.
Do	Melakukan observasi kepatuhan petugas dalam menggunakan masker saat berhadapan dengan pasien gejala saluran napas. Memastikan ketersediaan masker bedah yang cukup di area pelayanan. Mengumpulkan formulir monitoring mingguan untuk direkap menjadi laporan bulanan.
Study	Mengevaluasi apakah angka capaian pada bulan berjalan tetap stabil di atas 80% dan memastikan tidak ada lagi bulan dengan data kosong pada grafik pelaporan.

Action	Jika data kembali muncul dan stabil, standarisasi alur pelaporan ini ke dalam sistem manajemen mutu rumah sakit. Jika masih ada data kosong, lakukan evaluasi terhadap hambatan teknis penginputan data di unit terkait.
--------	--

c. Kewaspadaan Transmisi “Airbone”
 Gambar 3.3.2.3 Kewaspadaan Transmisi “Airbone”



Interpretasi : Pada gambar 3.3.2.3 diketahui kewaspadaan transmisi “airbone” pada bulan April tahun 2026 sebesar 80% dengan rerata sebesar 84,98%.

Tabel 3.3.2.2 PDSA Kewaspadaan Transmisi “Airbone”

Problem	Prosentase kewaspadaan transmisi <i>airbone</i> sudah mencapai standart 80%
Step	Pemeliharaan standar kepatuhan transmisi <i>airbone</i> dan sinkronisasi sistem dokumentasi bulanan.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan penggunaan masker N95 oleh petugas dan memastikan fungsi ruang isolasi tekanan negatif berjalan optimal. 2. Harapan Mempertahankan kepatuhan di atas 95% dan memastikan pelaporan data masuk secara konsisten 12 bulan penuh. 3. Analisa Capaian 80% menunjukkan kesadaran petugas sangat tinggi terhadap risiko airborne, namun sistem administrasi laporan mengalami hambatan pasca-Januari. 4. Tindakan Menunjuk PIC di unit rawat inap isolasi untuk melakukan verifikasi data kepatuhan secara rutin setiap minggu.
Do	1. Melakukan observasi kepatuhan petugas saat memasuki ruang isolasi airborne. 2. Memastikan ketersediaan stok masker N95 dan melakukan <i>fit test</i> mandiri bagi petugas. 3. Mendokumentasikan hasil observasi ke dalam sistem laporan mutu PPI.
Study	Mengevaluasi apakah angka kepatuhan pada bulan berjalan tetap stabil dan membandingkannya dengan data April (80%)



	untuk memastikan tidak ada penurunan kualitas pelayanan.
Action	Jika hasil audit tetap tinggi dan laporan terisi, jadikan sistem pemantauan ini sebagai standar di unit isolasi. Jika data pelaporan masih terkendala, lakukan evaluasi alur input data di tingkat manajemen.

3.3.2 Surveilans

a. Plebitis

Tabel 3.3.3.1 Plebitis



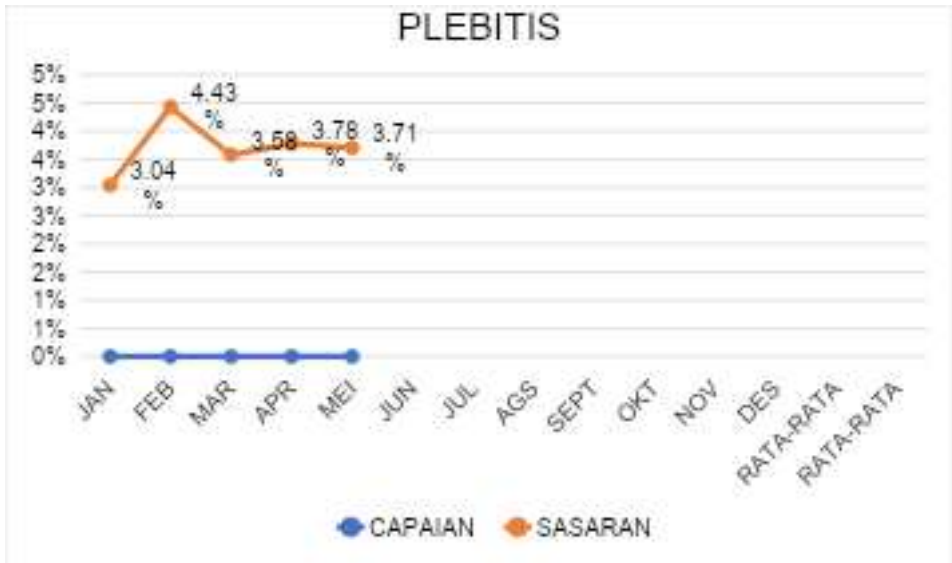
No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU HEMODIALISA	11 8 3 23 0 2 0 0
2	Februari	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU HEMODIALISA	18 11 4 18 0 0 0 0
3	Maret	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU HEMODIALISA	10 13 10 10 0 6 2 0
4	April	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU HEMODIALISA	22 10 3 7 1 0 3 0
5	Mei		
6.	Juni		
7.	Juli		
8.	Agustus		
9.	September		
10.	Oktober		
11.	November		
12.	Desember		



TOTAL	222 kejadian plebitis
-------	-----------------------

Interpretasi : Pada tabel 3.3.3.1 diketahui kejadian plebitis dalam pada bulan April 2026 sebanyak 46 kejadian

Gambar 3.3.3.1 Plebitis



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan April tahun 2026 sebesar 3,78% dengan rerata sebesar 3,71%.

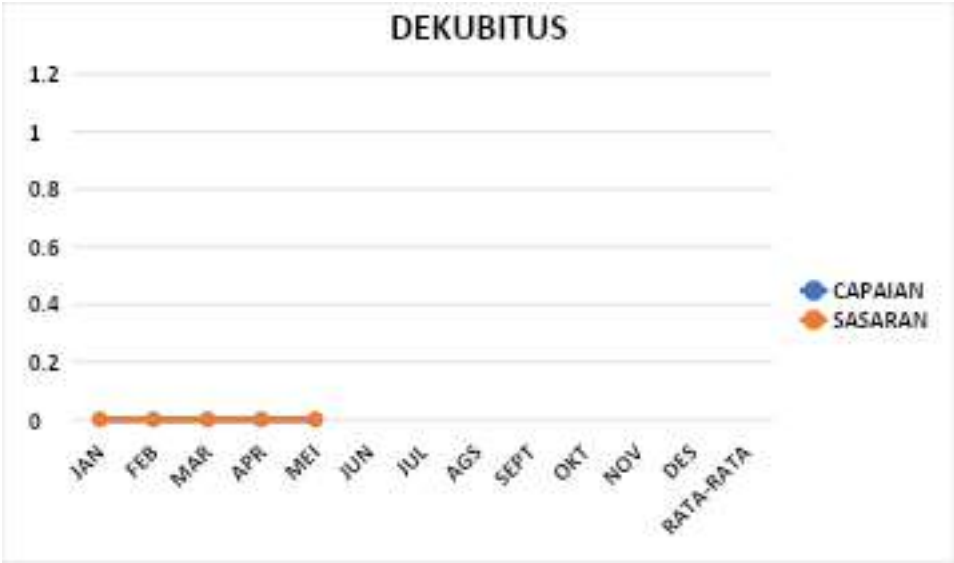
Tabel 3.3.3.2 PDSA Plebitis

Problem	Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
Plan	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi $\leq 1\%$ dalam 3 bulan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit. 3. Analisa a. Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus dari unit IGD b. Lama pemasangan infus >72 jam c. Kurangnya pencatatan dan monitoring harian d. Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis e. Banyak data phlebitis yang tidak dilaporkan dari unit 4. Tindakan a. Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus b. Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus c. Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam d. Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis
Do	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.
Study	1. Data kejadian phlebitis pada bulan April tahun 2026 sebesar 3,78% dan belum mencapai target 0% 2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi

	4. Audit kepatuhan pelaporan bundle plebitis 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
Action	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika angka tetap tinggi; a. Evaluasi Kembali penyebab utama b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan c. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan

b. Dekubitus

Gambar 3.3.3.2 Dekubitus



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.2 diketahui bahwa rerata kejadian Dekubitus di bulan April 2026 sebesar 0 kejadian

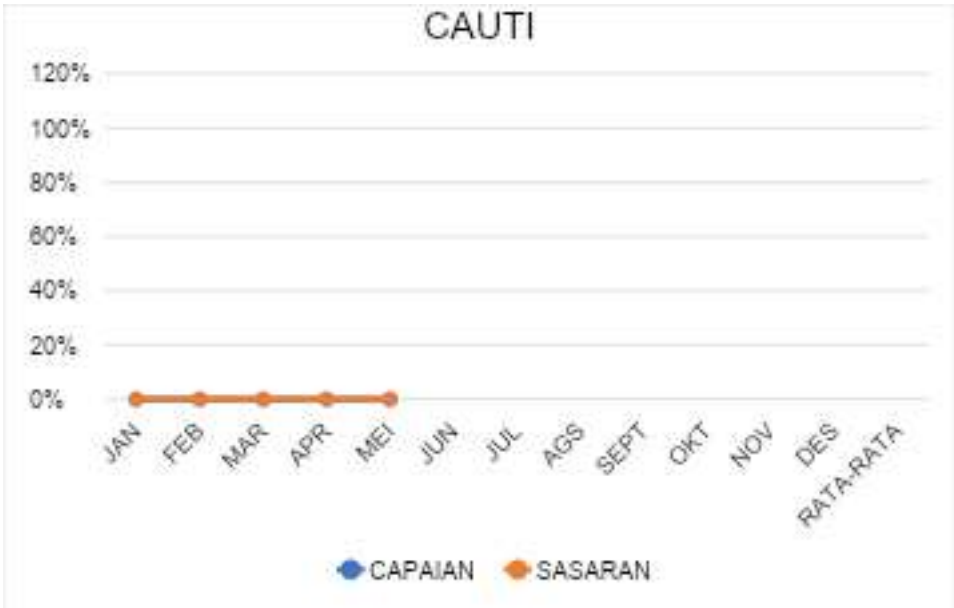
Tabel 3.3.3.3 PDSA Dekubitus

Problem	Kejadian dekubitus di bulan April tahun 2026 sebanyak 0 kejadian
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit rawat inap dan unit khusus (ICU) mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus untuk mengurangi resiko decubitus pada pada pasien tirah baring lama melalui peningkatan kepatuhan terhadap pencegahan luka tekan sesuai dengan standart PPI
Plan	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian dekubitus menjadi 0 kejadian dalam 3 bulan . 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian dekubitus dan dapat menurunkan kejadian dekubitus di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Ketidakpatuhan staff dalam melakukan tindakan keperawatan mika-miki pada pasien tirah baring b. Ketidakpatuhan staff melakukan edukasi terkait penggunaan kasur dekubitus 4. Tindakan a. Melakukan skrining risiko dekubitus menggunakan skala Braden

	pada saat pasien masuk - Memberikan pelatihan kepada perawat tentang pencegahan luka tekan - Menyediakan alat bantu seperti Kasur dekubitus dan posisi miring berkala (2 jam) di semua rawat inap - Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini dan perawatan kulit
Do	Angka kejadian dekubitus dapat mencapai 0 kejadian.
Study	- Data kejadian dekubitus bulan Maret 2026 sebanyak 0 kejadian - Peningkatan kepatuhan dokumentasi perubahan posisi pasien dari 50% menjadi 100% - Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi - Audit kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus di ruangan - Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
Action	- Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru - Jika masih ditemukan kejadian decubitus maka, - Evaluasi Kembali penyebab utama - Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan - Melakukan audit bulanan kepatuhan dokumentasi posisi dan perawatan kulit - Memberikan pelatihan rutin PPI dengan fokus pencegahan infeksi dari luka tekan

c. CAUTI

Gambar 3.3.3.3 CAUTI



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.3 diketahui bahwa rerata kejadian CAUTI di bulan April tahun 2026 sebesar 0%.

Tabel 3.3.3.4 PDSA CAUTI

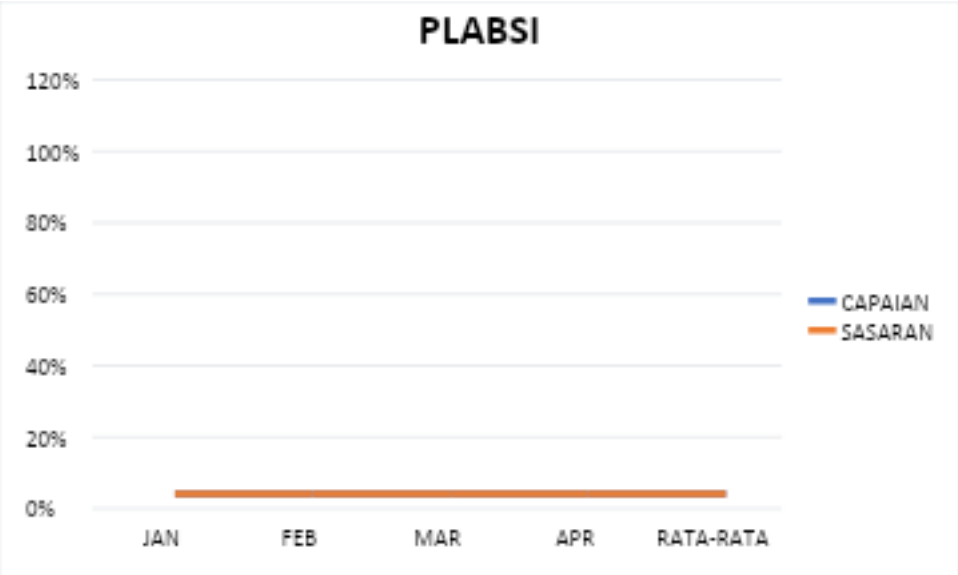
Problem	Prosentasi CAUTI di bulan April 2026 sebesar 0% yang menunjukkan tidak adanya kejadian CAUTI di ruang intensif dan rawat inap
Step	Menerapkan audit kepatuhan harian yang ketat pada: - Ketepatan Indikasi Pemasangan Kateter dan - Kebersihan Tangan (<i>Hand Hygiene</i>) saat perawatan kateter.



Plan	1. Tujuan (Goal): Menurunkan Angka Sasaran CAUTI menjadi 0% dalam periode uji coba 1 bulan. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai 5 indikasi yang diperbolehkan untuk pemasangan kateter urin. b. Menerapkan "Stiker/Label Harian" pada tas urin pasien yang mencantumkan tanggal pemasangan dan indikasi. c. Tim pengawas/PPI melakukan observasi mendadak (<i>spot check</i>) terhadap kepatuhan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan kateter urin. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap indikasi pemasangan kateter. b. Indikator Proses: Persentase kepatuhan kebersihan tangan perawat sebelum/sesudah perawatan. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran CAUTI bulanan (diukur dalam 1 bulan berikutnya).
Do	1. Melakukan pelatihan kepada perawat dan dokter. 2. Menerapkan Stiker/Label Harian pada semua pasien yang terpasang kateter di unit uji coba. 3. Memulai audit harian kepatuhan kebersihan tangan dan audit kebutuhan pelepasan kateter (penilaian setiap hari apakah kateter masih diperlukan). 4. Tim PPI/Pengawas mengumpulkan data kepatuhan proses setiap akhir minggu.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: b. Ketepatan Indikasi Pemasangan dan Pelepasan Harian Kateter. c. Kepatuhan Kebersihan Tangan saat perawatan. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran CAUTI pada periode uji coba dengan data lonjakan (Desember 0% dengan rerata 0,04%). * Pertanyaan: Apakah kepatuhan yang meningkat berhasil menurunkan CAUTI menjadi 0%? 3. Identifikasi Akar Masalah: Jika CAUTI tetap terjadi atau kepatuhan rendah: * Apakah masalahnya adalah lamanya hari pemasangan (indikasi tidak dievaluasi harian)? * Apakah masalahnya adalah teknik pemasangan yang kurang steril? (Jika elemen kebersihan tangan sudah baik).
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika CAUTI turun menjadi 0% dan kepatuhan tinggi, standarkan <i>checklist</i> pelepasan harian kateter dan masuk ke dalam SPO. 2. Perluas penerapan Stiker/Label Harian ke seluruh rumah sakit. 3. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. 4. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika insiden tetap terjadi, gunakan data dari tahap <i>Study</i> untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya. Fokuskan pada elemen bundel yang belum optimal (misalnya, teknik pemasangan kateter yang steril, atau perawatan meatus urinarius).

d. PLABSI

Gambar 3.3.3.4 PLABSI



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.4 diketahui bahwa rerata kejadian PLABSI di bulan April tahun 2026 sebesar 0%.

Tabel 3.3.3.5 PDSA PLABSI

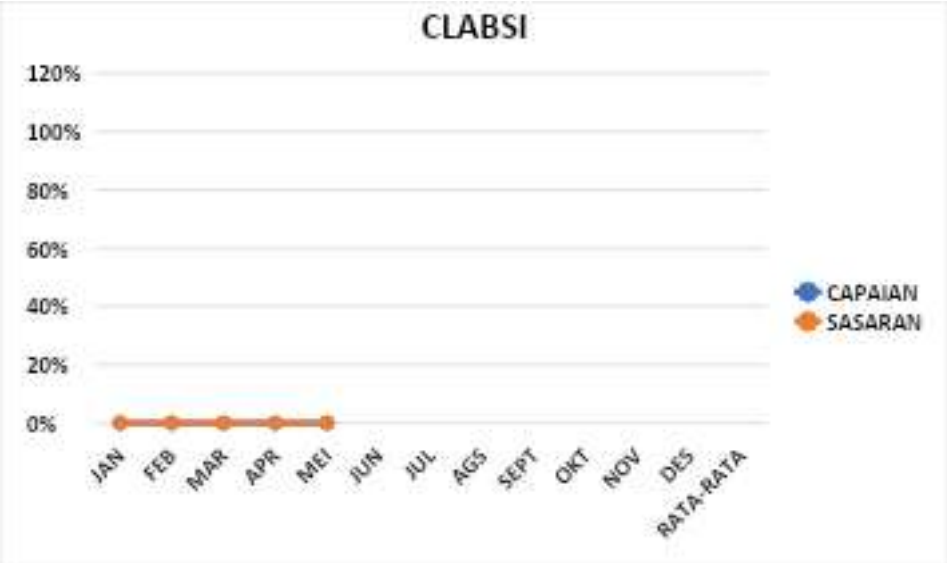
Problem	Angka Sasaran PLABSI saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle PLABSI) perlu diverifikasi dan distandardisasi untuk mencegah lonjakan insiden di masa mendatang.
Step	Penguatan monitoring kepatuhan <i>bundle</i> pencegahan PLABSI pada tahap insersi dan pemeliharaan.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan <i>bundle</i> PLABSI (kebersihan tangan, penggunaan APD, desinfeksi area insersi, dan evaluasi harian lokasi tusukan). 2. Harapan Mempertahankan insidensi PLABSI pada angka 0% secara berkelanjutan. 3. Analisa Capaian 0% di Januari menunjukkan prosedur awal sudah berjalan sesuai standar, namun memerlukan pengawasan agar tidak terjadi <i>fatigue</i> atau kelalaian di bulan berikutnya. 4. Tindakan Menginstruksikan perawat ruangan untuk melakukan penilaian harian pada lokasi pemasangan infus menggunakan skala <i>phlebitis</i>.
Do	1. Melaksanakan edukasi penyegaran mengenai teknik aseptik saat pemasangan kateter perifer. 2. Memastikan ketersediaan <i>dressing</i> transparan untuk memudahkan observasi lokasi insersi.



	3. Melakukan dokumentasi tanggal pemasangan pada fiksasi infus secara disiplin.
Study	1. Mengevaluasi apakah ada tanda-tanda awal infeksi lokal meskipun angka kejadian sistemik (PLABSI) tetap 0%. 2. Memeriksa apakah pelaporan data bulanan tetap konsisten dan tidak mengalami kekosongan seperti pada indikator lainnya.
Action	1. Jika hasil tetap 0%, teruskan standar prosedur yang ada sebagai kebijakan tetap unit. 2. Jika ditemukan tren peningkatan infeksi lokal, lakukan revisi pada jenis cairan desinfektan yang digunakan atau frekuensi penggantian <i>set</i> infus.

e. CLABSI

Gambar 3.3.3.5 CLABSI



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.5 diketahui bahwa rerata kejadian CLABSI di bulan April tahun 2026 sebesar 0 %

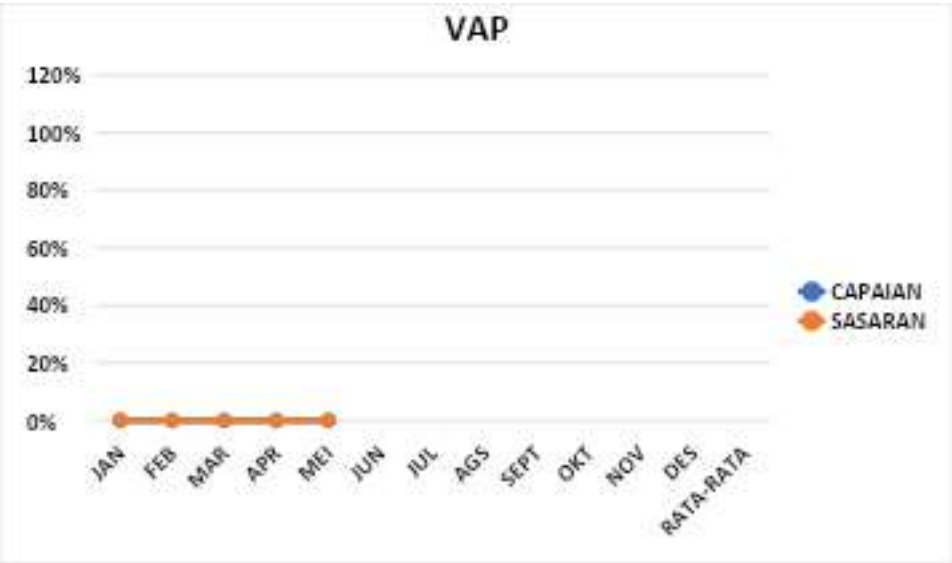
Tabel 3.3.3.6 PDSA CLABSI

Problem	Angka Sasaran CLABSI saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle CLABSI) perlu diverifikasi dan distandardisasi untuk mencegah lonjakan insiden di masa mendatang.
Step	Audit Kepatuhan pada Perawatan dan Pemeliharaan <i>Central Line</i> : Memfokuskan audit pada Perawatan Balutan (<i>Dressing</i>) dan Penggunaan <i>Checklist</i> Harian Pelepasan Kateter sentral.
Plan	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden CLABSI 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Bundel Perawatan Kateter Sentral. 2. Tindakan (Implementasi): f. Sosialisasi ulang prosedur dan teknik steril penggantian balutan kateter sentral. g. Menerapkan <i>checklist</i> evaluasi harian untuk menilai perlunya pelepasan kateter sentral (<i>daily necessity review</i>). h. Perawat ruang rawat intensif (ICU) diwajibkan melakukan <i>time-out</i> singkat sebelum penggantian balutan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan penggantian balutan sesuai jadwal dan teknik.



	b. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran CLABSI bulanan (Target: 0%).
Do	1. Melakukan pelatihan kepada perawat unit terkait (ICU/NICU/unit berisiko tinggi). 2. Menerapkan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter pada semua pasien yang terpasang <i>central line</i>. 3. Tim PPI/Pengawas melakukan audit observasi langsung (minimal 5 kali per minggu) terhadap kepatuhan penggantian balutan.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Penggantian balutan steril dan tepat waktu. b. Pengisian <i>checklist</i> pelepasan harian. 2. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran CLABSI tetap 0% selama periode uji coba. * Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): a. Apakah beban kerja perawat terlalu tinggi? b. Apakah pasokan <i>dressing kit</i> steril tidak tersedia dengan baik?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standardisasikan <i>checklist</i> pelepasan harian dan <i>time-out</i> balutan ke seluruh unit dan masukkan ke dalam sistem manajemen mutu. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif dan <i>reward</i> kepada unit untuk mempertahankan kinerja 0% CLABSI. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem pendukung (misalnya, membuat sistem pengadaan <i>dressing kit</i> menjadi lebih efisien) atau pada elemen bundel CLABSI lain (misalnya, kepatuhan <i>hand hygiene</i> sebelum manipulasi <i>line</i>).

f. VAP
Gambar 3.3.3.6 VAP



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.6 diketahui bahwa rerata kejadian VAP di bulan April tahun 2026 sebesar 0%

Tabel 3.3.3.6 PDSA VAP

Problem	Angka Sasaran VAP saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap
---------	--



	proses (Bundle VAP) perlu diverifikasi dan ditingkatkan untuk menjamin hasil yang berkelanjutan dan mencegah <i>zero-report</i> yang palsu
Step	Audit Kepatuhan pada 2 Elemen Inti Bundle VAP: Memfokuskan audit pada 1) Elevasi Kepala Tempat Tidur (30° hingga 45°) dan 2) Penghentian Sedasi Harian (<i>Daily Sedation Interruption</i>).
Plan	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden VAP 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Elemen Kunci Bundel VAP. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai pentingnya elevasi kepala 30° hingga 45° untuk semua pasien yang terintubasi. b. Menerapkan stiker atau <i>reminder</i> visual di samping tempat tidur pasien untuk mencatat waktu penghentian sedasi harian (<i>sedation vacation</i>). c. Dokter dan Perawat ICU diwajibkan mencatat <i>reason</i> (alasan) jika elevasi kepala kurang dari 30° hingga 45° atau jika <i>sedation vacation</i> tidak dilakukan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan elevasi kepala 30° hingga 45°. b. Indikator Proses: Persentase <i>Daily Sedation Interruption</i> yang berhasil dilakukan. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran VAP bulanan (Target: 0%).
Do	1. Menerapkan <i>reminder</i> visual dan pencatatan alasan pengecualian di setiap <i>bedside</i> . 2. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi mendadak (minimal 2 kali per minggu) untuk mengecek posisi kepala tempat tidur dan pencatatan <i>sedation vacation</i> .
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Elevasi kepala 30° hingga 45° b. Pelaksanaan <i>Daily Sedation Interruption</i> . 2. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran VAP tetap 0% selama periode uji coba. Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): a. Apakah ranjang tidak berfungsi dengan baik (<i>technical issue</i>) sehingga sulit mencapai 30° hingga 45° b. Apakah dokter atau perawat khawatir akan efek samping <i>sedation vacation</i> (misalnya, ekstubasi diri)?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standarisasikan penggunaan <i>reminder</i> visual dan wajibkan pencatatan alasan pengecualian dalam rekam medis. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif dan penghargaan kepada unit ICU untuk mempertahankan kinerja 0% VAP. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan peralatan (jika ranjang rusak) atau pada elemen bundel VAP lain



	(misalnya, perawatan kebersihan mulut <i>oral hygiene</i>) jika audit proses menunjukkan ini sebagai area terlemah.
--	--

e. Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Tabel 3.3.3.7 Infeksi Daerah Operasi (IDO)

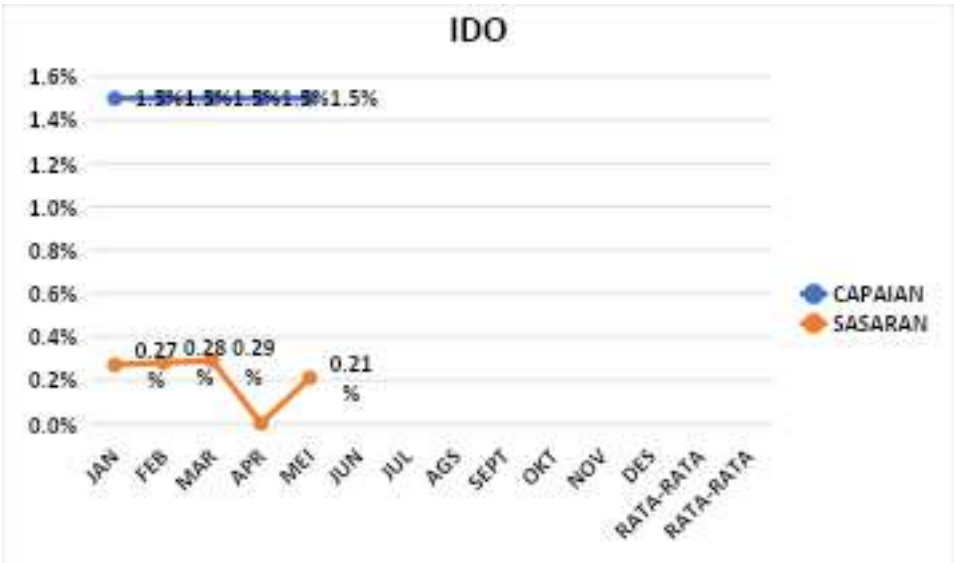
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2026																				PT. DISA PRIMA MEDIKA											
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Initial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl/Ura MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi 1	Tgl Operasi 2	Dr. Operasi & Tindakan Operasi 1	Dr. Operasi & Tindakan Operasi 2	Tim Operasi 1					Tim Operasi 2					Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Assesmen lain	Prognosis Penyebab ILO	RTL	Total Kejadian IDO		
													Ast Bd	dr An	Ast An	Instrumen	Onloop	Ast Bd	dr An	Ast An	Instrumen	Onloop			Saat Op	Saat IDO							
Januari																																	
1	13/01/2026	TY. ACHANDI SUTAWATI	138510	PRIMA 3D	26 TH	11/01/2026	DR. ROSY	DPJS KLS 1	31/12/2025	13/01/2026	perforasi akut + perforasi caecum	wound dehiscence +bacterial infection post op + sekulitis femoralis	wali	robot	agung	fenda	cerang	wali	robot	rohman	antuk	siti	17/01/2026	tidak ada selaput sari	tb. 14,3 l. 23.700 T. 292.000 GLA 100	tb. 12,8 l. 24.600 T. 307.000 GLA 100	iv. Ceftriaxone 2x1 iv. Rantidol 2x1 mg iv. Metronidazole 3x1 iv. Santalol 3x1 iv. Piriton 3x1	iv. KRS iv. Rantidol 2x1 iv. Cefixim 2x1 iv. Paraset 2x10 mg iv. Omeprazole 2x1	Leukosit naik trombosit kurang PHEG kurang Gly kurang	Pasien operasi ke 1		1	
Februari																																	
1	18/02/2026	NY. MUSTINA	66616	IOD	66 TH	18/02/2026	DR. AHMAD (C)	DPJS KLS 3	28/01/2026		CT NIFH (H40/C40) R. FEMUR	LO POST OP PHK (H40/C40) C FEMUR D	edo	robot	rohman	fenda	nko						15/02/2026	tidak ada infeksi sari	tb. 11,5 l. 14.700 T. 210.000 GLA 200	tb. 9,6 l. 24.800 T. 301.300 GLA 100	iv. Ketorolac 3x1 iv. Ceftriaxone 2x1 iv. Rantidol 2x1 iv. Paraset 3x1 (1000)	iv. Ketorolac 2x1 iv. Paraset 3x1 iv. Omeprazole 2x1	DM tidak terkontrol infeksi modifikasi sarema pasien CVA	Rawat Luka Zak kultur pus		2	
Maret																																	
1	18/03/2026	NY. MARGARETA ACHARYA	131225	POU (KIRAN)	20 TH	07/03/2026	DR. RUDI	DPJS KLS 3	08/03/2026		CIFRADO JK 31 36 mengg. dgn PHK (H40)		wali	robot	rohman	fenda	cerang						10/03/2026	tidak ada bekas operasi, luka operasi bersih, tidak ada selaput, luka operasi banyak, tidak ada SARI	tb. 6,6 l. 12.100 T. 215.000 GLA 67		Rawat Luka Ceftriaxone 2x1 mg Metronidazole 3x500 mg asam metformin 3x1	Rawat Luka Ceftriaxone 2x1 mg Metronidazole 3x500 mg asam metformin 3x1	Mobilisasi mandiri lama mobilisasi jarang mandiri	Rawat Luka selaput dari di puli		3	dr. ahli : Post SC 1 ILO
April																																	
Mei																																	
Juni																																	
Juli																																	
Agustus																																	
September																																	
Oktober																																	
November																																	
Desember																																	

Interpretasi : Berdasarkan tabel 3.3.3.7 dapat diketahui jumlah kejadian IDO di bulan April tahun 2026 sebanyak 0 kejadian.

Link Rekap analisa IDO 2026 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-oovztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true

Gambar 3.3.3.7 IDO



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.7 diketahui bahwa rerata angka infeksi daerah operasi di setiap unit pada bulan April tahun 2026 sebesar 0% dengan rerata 0,21%.

Tabel 3.3.3.8 PDSA Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Problem	Prosentasi kejadian IDO sudah mencapai target < 1,5% dan masih ditemukan satu kejadian
Step	Standardisasi Prosedur Pre- dan Intra-Operasi: Mengimplementasikan audit kepatuhan (checklist) yang ketat pada dua elemen utama Bundel Pencegahan IDO: 1. Waktu Pemberian Antibiotik Profilaksis 2. Pengendalian Suhu Tubuh (Normotermia) pasien 3. Pengendalian gula darah pasien
Plan	1. Rencana: Menurunkan Angka Sasaran IDO hingga di bawah rata-rata (0,25%) dan mencapai 0% selama periode uji coba 1 bulan 2. Tindakan Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai prosedur pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi. Menetapkan <i>checklist</i> wajib untuk memonitor suhu tubuh pasien di kamar operasi dan penggunaan alat penghangat jika diperlukan. 3. Analisa Tidak ada 4. Tindakan a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap pemberian antibiotik tepat waktu. b. Indikator Hasil: Angka Sasaran IDO bulanan pada periode uji coba.
Do	1. Menerapkan <i>checklist</i> kepatuhan pada semua pasien operasi di unit/kasus yang diuji coba selama 4 minggu. 2. Mencatat waktu pemberian antibiotik dan suhu tubuh pasien secara akurat pada rekam medis. 3. Tim PPI melakukan <i>audit harian</i> pada 100% kasus uji coba untuk kepatuhan <i>checklist</i>.
Study	1. Analisis Kepatuhan: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Pemberian antibiotik tepat waktu. b. Pencapaian normotermia (suhu tubuh >36°C)

	- Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran IDO pada bulan uji coba dengan data dasar - Identifikasi Akar Masalah: Jika IDO tidak turun atau kepatuhan rendah, identifikasi: - Antibiotik: Apakah ketidakpatuhan disebabkan ketersediaan obat, <i>delay</i> di ruang tunggu, atau kurangnya komunikasi? - Normotermia: Apakah alat penghangat tidak berfungsi, atau kurangnya <i>monitoring</i>?
Action	- Beri feedback hasil temuan. - Jika IDO turun signifikan dan kepatuhan >95%, jadikan <i>checklist</i> sebagai Standar Prosedur Operasional (SPO) wajib di seluruh kamar operasi. - Beri <i>feedback</i> hasil temuan IDO dan kepatuhan kepada tim bedah. - Jika IDO tidak turun, gunakan data dari tahap <i>Study</i> (misalnya, jika normotermia yang paling rendah) untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya yang berfokus pada elemen bundel IDO yang lain (misalnya, <i>skin preparation</i> / persiapan kulit pra-operasi) atau pada perbaikan sistem pendukung yang gagal.

3.3.3 ICRA Bangunan

Tabel 3.3.4.1 ICRA Bangunan 2026

NO	WAKTU	NO IZIN ICRA	JENIS KONTRUKSI	LOKASI KONSTRUKSI	KOORD. PROYEK	PEKERJA KONTRUKSI	TANGGAL MULAI PROYEK	PERKIRAAN DURASI	ICRA		
									TIPE	KELOMPOK RESIKO	LEVEL ICRA
JANUARI 2026											
1	26 Januari 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/I/2026	Pembangunan Gedung 5 lantai	RS Prima Husada Sukorejo	Bpk. Hasto	Bpk. Mail	28/01/2026	1 TAHUN	D	Resiko Tertinggi	Level IV
FEBRUARI 2026											
1	4 Februari 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Perbaikan D.2B.5	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	04/02/2026	1 BULAN	C	Resiko Tinggi	Level III
2	07 Februari 2026	02/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Renovasi kramik IKO koridor	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	08/02/2026	1 HARI	C	Resiko Tinggi	Level III
3	20 Februai 2026	03/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Perbaikan B.2C2	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	20/02/2026	1 BULAN	C	Resiko Tinggi	Level III
4	21 Februari 2026	04/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Renovasi kramik IKO koridor	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	21/02/2026	1 HARI	C	Resiko Tinggi	Level III
MARET 2026											
1	27 Maret 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/III/2026	Perbaikan D.2B.3	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	27/03/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
APRIL 2026											
1	10 April 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/IV/2026	Perbaikan plafon lt.2 dan kamar mandi	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	10/04/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
2	15 April 2026	02/KOMITE PPI-ICRA/IV/2026	Perbaikan plafon D.3A.4 dan cat ulang	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	15/04/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
3	20/04/2026	03/KOMITE PPI-ICRA/IV/2026	Perbaikan plafon IGD lama (toilet staff)	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	20/04/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III

Interpretasi : Pada tabel 3.3.4.1 diketahui ICRA 2026 terdapat satu agenda utama yakni pembangunan gedung 5 lantai di sisi barat

Tabel 3.3.4.1 PDSA ICRA 2026

Problem	Adanya proyek konstruksi di area pelayanan dengan tingkat risiko tinggi menyebarkan debu dan kontaminan udara ke area pelayanan pasien jika tidak dikelola dengan standar PPI yang ketat.
Step	Implementasi dan monitoring kepatuhan barrier fisik serta pengendalian lingkungan pada proyek pembangunan Gedung 5 lantai.
Plan	1. Rencana Melakukan inspeksi harian terhadap integritas barrier debu dan memastikan sistem pembuangan limbah konstruksi tidak melewati area publik. 2. Harapan Tidak ada peningkatan kasus infeksi terkait konstruksi dan debu terminimalisir 100% di area perawatan pasien. 3. Analisa a. Risiko Level III menunjukkan potensi bahaya besar bagi pasien rentan, sehingga membutuhkan penghalang kedap udara dan sistem ventilasi tekanan negatif sementara pada area kerja. b. Penggunaan APD belum berjalan dengan baik 4. Tindakan Mengevaluasi penggunaan APD bagi pekerja konstruksi dan memastikan adanya kesesuaian izin kerja dengan praktik di lapangan.
Do	1. Memasang barrier plastik kedap udara dari lantai hingga langit-langit di area konstruksi. 2. Menempatkan keset kaki basah/lengket di setiap pintu keluar-masuk area proyek. 3. Melakukan pembersihan debu secara rutin menggunakan metode vakum HEPA filter.
Study	1. Mengevaluasi hasil inspeksi mingguan oleh Tim PPI. 2. Memeriksa apakah ada keluhan dari unit perawatan terdekat terkait debu atau kebisingan yang mengganggu pelayanan.
Action	1. Jika hasil inspeksi menunjukkan barrier efektif, lanjutkan monitoring rutin hingga proyek selesai. 2. Jika ditemukan kebocoran debu, segera lakukan perbaikan barrier dan hentikan pekerjaan sementara hingga standar terpenuhi.



3.3.4 Sosialisasi dan Edukasi PPI

Tabel 3.3.5.1 Sosialisasi dan Edukasi PPI

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
JANUARI 2026					
1	IRNA 3A	4	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		3		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
2	IRNA 3B	4	5-6 orang	Pencegahan Infeksi	Kelompok
3	IRNA 2A	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
4	IRNA 2B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
		2		Pencegahan Infeksi	
5	Hemodialisa	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	Maternitas	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		1		Pemilahan Sampah	
7	Neonatologi	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
8	IRJA	1	5-6 orang	Etika Batuk	Kelompok
9	RM/PDF	2	4 orang	Cuci Tangan	Individu
10	Radiologi	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1	5-6 orang	Etika Batuk	
FEBRUARI 2026					
1	IRNA 3A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Etika Batuk	
2	IRNA 3B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		2		Pencegahan Infeksi	
3	IRNA 2A	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
4	IRNA 2B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Etika Batuk	
		1		Plebitis	
		1		Pemilahan Sampah	
5	Hemodialisa	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	Maternitas	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Pencegahan Infeksi	
		1		Pemilahan Sampah	
7	Neonatologi	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		1		Pemilahan Sampah	
8	IRJA	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
9	RM	1	4 orang	Cuci Tangan	Individu
		1		Etika Batuk	
10	Radiologi	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Pemilahan Sampah	
MARET 2026					
1	IRNA 3A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok



		1		Plebitis	
		1		Pemilahan Sampah	
2	IRNA 3B	1	5-6 orang	Pencegahan Infeksi	Kelompok
3	IRNA 2A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
4	IRNA 2B	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		1		Plebitis	
5	HEMODIALISA	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	MATERNITAS	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Pencegahan Infeksi	
7	NEONATOLOGI	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
8	IRJA	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
9	ICU	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Etika Batuk	
10	RM/PDF	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Individu
		1		Etika Batuk	
APRIL 2026					
1	IRNA 3A	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
2	IRNA 3B	1	5-6 orang	CT	Kelompok
		1		P	
3	IRNA 2A	1	5-6 orang	CT	Kelompok
4	IRNA 2B	3	5-6 orang	CT	Kelompok
		2		BE	
		1		P	
5	HEMODILISA	2	5-6 orang	CT	Kelompok
6	MATERNITAS	1	5-6 orang	CT	Kelompok
7	NEONATOLOGI	2	5-6 orang	CT	Kelompok
8	IRJA	2	5-6 orang	CT	Kelompok
		1		BE	
		1		Pencegahan infeksi	
9	ICU	1	5-6 orang	CT	Kelompok
		1		BE	
10	RM	3	5-6 orang	CT	Individu
		1		BE	
11	FARMASI	2	5-6 orang	CT	Individu
MEI 2026					

Interpretasi : pada tabel 3.3.5.1 diketahui ada 11 unit yang telah melakukan edukasi PPI sesuai dengan target 2x per bulan

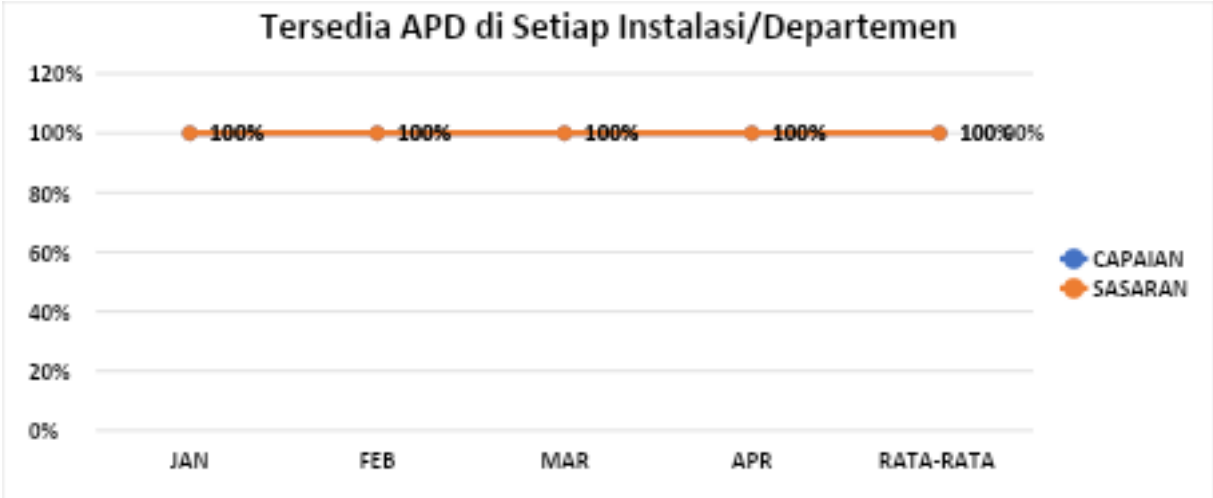
Tabel 3.3.5.2 PDSA Sosialisasi dan Edukasi PPI

Problem	Belum semua unit kerja melakukan edukasi PPI secara konsisten kepada pasien/pengunjung, serta adanya ketidakpatuhan dokumentasi pelaporan edukasi pada beberapa unit di bulan Februari.
Step	Standarisasi jadwal edukasi unit dan penguatan sistem monitoring laporan edukasi PPI.
Plan	1. Rencana Menyusun jadwal edukasi rutin untuk setiap unit dan melakukan audit mendadak terhadap pelaksanaan edukasi di area pelayanan. 2. Harapan Seluruh unit (100%) patuh melakukan minimal 1 kali edukasi PPI per minggu dan mendokumentasikannya dengan benar. 3. Analisa Unit yang tidak patuh kemungkinan terkendala beban kerja tinggi atau kurangnya media edukasi (lembar balik/leaflet) di ruangan. 4. Tindakan Memberikan teguran lisan dan pembinaan kepada Kepala Unit yang belum melaporkan kegiatan edukasi di bulan Januari.
Do	1. Membagikan jadwal edukasi bulanan ke seluruh unit rawat inap dan rawat jalan. 2. Menyediakan materi edukasi terstandar (topik: Cuci Tangan, Etika Batuk, Pemilahan Sampah). 3. Tim PPI berkeliling untuk memverifikasi pelaksanaan edukasi secara langsung.
Study	1. Mengevaluasi jumlah unit yang patuh melakukan edukasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 2. Menganalisis apakah edukasi tersebut efektif meningkatkan pemahaman pasien (melalui <i>post-test</i> singkat atau observasi perilaku).
Action	1. Jika kepatuhan meningkat, lanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi unit paling aktif. 2. Jika masih ada unit tidak patuh, integrasikan laporan edukasi PPI ke dalam penilaian kinerja bulanan unit (KPI).



3.4 Mutu PPI
3.4.1 Tersedia APD di Instalasi/Departemen

Gambar 3.4.1.1 Tersedia APD di Instalasi/Departemen



Interpretasi : Pada gambar 3.4.1.1 diketahui bahwa rerata ketersediaan APD di setiap unit di bulan April tahun 2026 sebesar 100% dan telah mencapai standart 100%.

Tabel 3.4.1.1 PDSA Tersedia APD di Instalasi/Departemen

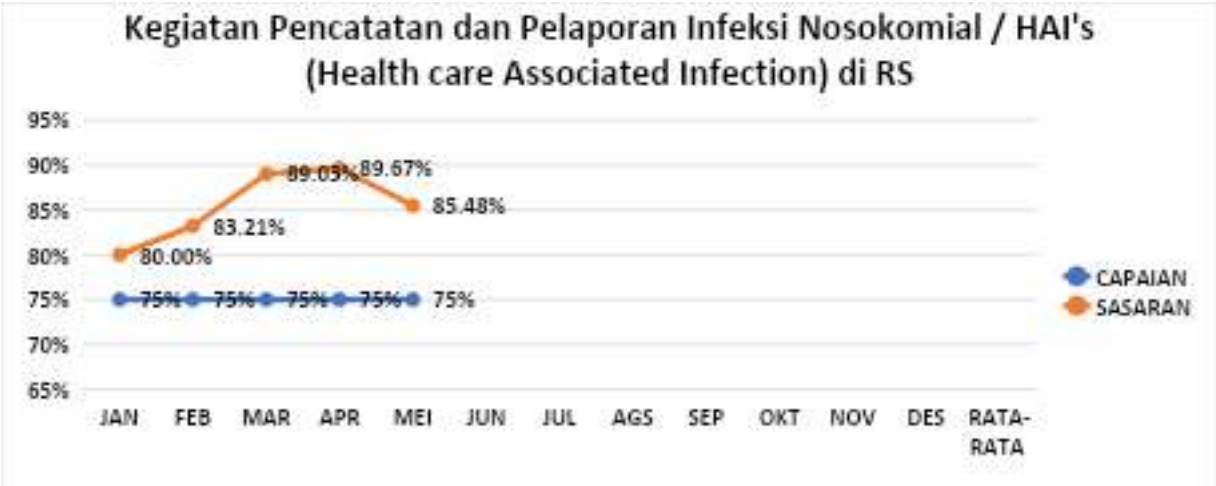
Problem	Ketersediaan APD di unit telah memenuhi target 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya melakukan pengecekan ketersediaan APD di masing-masing unit
Plan	1. Rencana Menjaga kepatuhan penyediaan APD di masing-masing unit pelayanan 2. Harapan Semua kebutuhan APD unit terpenuhi dan tersedia sesuai dengan ruangan 3. Analisa Tidak ditemukan APD yang tidak tersedia di unit pelayanan pasien dan diarea lingkungan rumah sakit 4. Tindakan a. Memastikan ketersediaan APD sesuai dengan kebutuhan unit b. Memastikan semua kebutuhan APD di unit sesuai dengan penginputan dan pemakaian yang sesuai dengan kondisi pasien
Do	Ketersediaan APD di unit sesuai
Study	1. Data ketersediaan APD di unit bulan April tahun 2026 sebesar 100% sehingga sudah mencapai standart 100%. 2. Evaluasi ketersediaan APD di unit. 3. Lakukan survei singkat terkait kepatuhan dan ketersediaa 4. APD apakah sesuai dengan penggunaan atau tidak 5. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat adanya ketidakterersediaan APD di unit
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Monitoring unit terkait ketersediaan APD 3. Supervisi terkait ketersediaan APD



4. Analisis kebutuhan APD di masing-masing unit

3.4.2 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial / HAI's

Gambar 3.4.2.1 Kegiatan dan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial (HAI's)



Interpretasi : Pada gambar 3.4.2.1 diketahui bahwa rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan April tahun 2026 sebesar 89,67% dengan rerata 85,48%.

Tabel 3.4.2.1

Problem	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial / HAIs sudah mencapai standart 75%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan HAIS mencapai 90% kelengkapan data dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Ketidaktahuan petugas tentang format pelaporan HAIs b. Kurangnya pemantauan dari tim IPCLN diunit c. Sistem pencatatan sudah digital namun staf masih tidak patuh dikarenakan lupa link pelaporan d. Beban kerja tinggi, menyebabkan pencatatatn tidak menjadi prioritas 4. Tindakan a. Sosialisasi Kembali terkait definisi, kategori HAIs dan pentingnya pelaporan b. Distribusi ulang format pelaporan yang mudah dipahami c. Monitoring mingguan dari IPCN ke setiap unit



Do	Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's sudah mencapai 75% dan akan dilakukan, 1. Lakukan sosialisasi dan pelatihan awal dalam 1 minggu pertama 2. Terapkan system pelaporan mingguan berbasis google form (by link : https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo/home) 3. IPCN melakukan validasi data mingguan selama 3 bulan 4. Berikan umpan balik kepada unit dengan Tingkat pelaporan rendah
Study	1. Rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan April tahun 2026 sebesar 89,67 % dan sudah mencapai target 75% 2. Bandingkan Tingkat kelengkapan dan ketepatan laporan HAIs antar unit 3. Liat tren pelaporan : apakah meningkat dari minggu ke minggu? Adakah perubahan dari bulan sebelumnya? 4. Identifikasi kesalahan umum dan kesenjangan pemahaman
Action	1. Re-sosialisasi ulang kepada staf terkait langkah pelaporan HAI's. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu all pelayanan untuk menghimbau IPCLN/PIC PPI unit untuk patuh dalam melaporkan kejadian HAI's dengan waktu perekapan selama 1 minggu sekali 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's

3.4.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 3.4.3.1 Kepatuhan Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 3.4.3.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan April 2026 sebesar 92% dengan rerata 91,11%.

Tabel 3.4.3.1 PDSA Kepatuhan Kebersihan Tangan

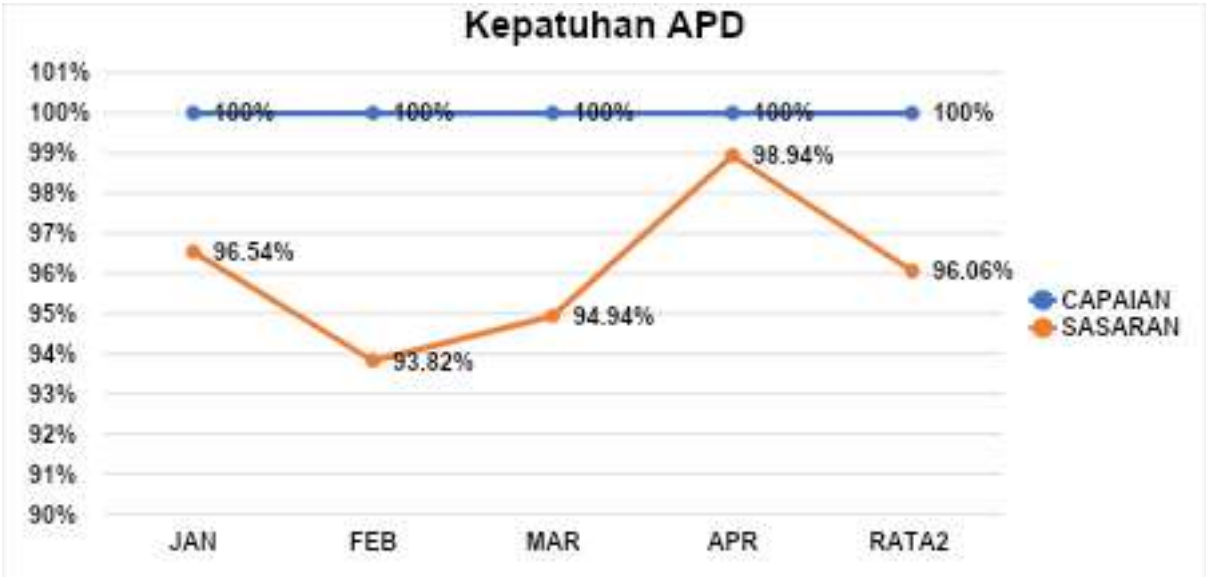
Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan April tahun 2026 sebesar 92% dengan rerata sudah mencapai target target $\geq 85\%$.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak



	dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mencapai kepatuhan minimal 85% dalam 3 bulan dan mempertahankan minimal 85% secara berkelanjutan 2. Harapan Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya 5 momen cuci tangan b. Adanya ketidakpatuhan pengisian handrub yang dilakukan oleh CS c. Supervise dan feedback belum dilakukan rutin d. Ketergantungan pada pengingat eksternal tidak menjadi kebiasaan 4. Tindakan a. Audit harian oleh IPCN dengan feedback mingguan b. Manfaatkan poster, QR-code edukasi video, dan pengingat audio di area kritis c. Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan d. Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk seluruh staf pada saat melakukan hand over e. Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi. f. Memberikan feedback langsung secara sopan jika ditemukan staff atau keluarga pasien yang melewatkan momen cuci tangan
Do	1. Monitoring fasilitas kebersihan tangan yang tersedia 2. Role model 3. Visual reminder 4. Edukasi on-the-spot
Study	1. Data kuantatif : cek kepatuhan kebersihan tangan bulan April tetap bertahan di atas 85% 2. Data kualitatif : lakukan wawancara singkat pada staff mengenai hambatan kebersihan cuci tangan 3. Analisis : kurangnya pengawasan
Action	1. Tetapkan SPO sebagai acuan 2. Lakukan rotasi “Champion Kebersihan Tangan” di setiap shift untuk saling mengingatkan 3. Memberikan apresiasi bagi unit dengan kepatuhan tertinggi untuk menjaga motivasi staff



3.4.4 Kepatuhan APD
Gambar 3.4.4.1 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 3.4.4.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan April tahun 2026 sebesar 98,94% dengan rerata 96,06%.

Tabel 3.4.4.1 Kepatuhan APD

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD belum mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mempertahankan kepatuhan APD di level 100% secara konsisten dalam 6 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa b. Ketidaknyamanan dalam penggunaan APD (panas, pengap, terlalu besar) c. Persepsi bahwa risiko infeksi menurun sehingga kepatuhan bisa longgar d. Ketidakteraturan dalam pengawasan langsung di unit 4. Tindakan a. Memberikan pengingat visual di area kerja (poster, stiker, digital signal) b. Supervise rutin oleh IPCN/IPCLN c. System reward bulanan unit dengan kepatuhan 100% d. Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di setiap bulan berjalan pada tahun 2026 dengan, 1. Lakukan pemasangan materi edukasi dan pengingat di setiap unit 2. Lakukan audit dan observasi harian



	3. Berikan umpan balik mingguan dan apresiasi bagi tenaga yang patuh 4. Lakukan survei kecil mengenai kenyamanan dan persepsi staff tentang APD
Study	1. Rerata kepatuhan penggunaan APD bulan April tahun 2026 yaitu sebesar 98,94% dan belum mencapai target 100% 2. Pantau tren kepatuhan : apakah tetap stabil di angka 100% 3. Analisa hasil audit : apabila ditemukan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan 4. Evaluasi hasil survei kenyamanan dan motivasi tenaga Kesehatan
Action	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Tinjau factor penyebab (misal APD tidak tersedia, tidak nyaman dalam penggunaan APD) 3. Beri feedback pada hasil temuan. 4. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Beri reward pada unit dengan tingakt kepatuhan penggunaan APD 100%

3.4.5 Angka Infeksi Daerah Operasi

Gambar 3.4.5.1 Angka Daerah Operasi



Interpretasi : Pada gambar 3.4.5.1 diketahui bahwa rerata angka infeksi daerah operasi di setiap unit pada bulan April tahun 2026 sebesar 0% dengan rerata 0,28%.

Tabel 3.4.5.1 PDSA Angka Daerah Operasi

Problem	Prosentasi kejadian IDO sudah mencapai target 1,5% dan masih ditemukan satu kejadian
Step	Standardisasi Prosedur Pre- dan Intra- Operasi: Mengimplementasikan audit kepatuhan (checklist) yang ketat pada dua elemen utama Bundel Pencegahan IDO: 1. Waktu Pemberian Antibiotik Profilaksis dan 2. Pengendalian Suhu Tubuh (Normotermia) pasien.
Plan	1. Rencana:

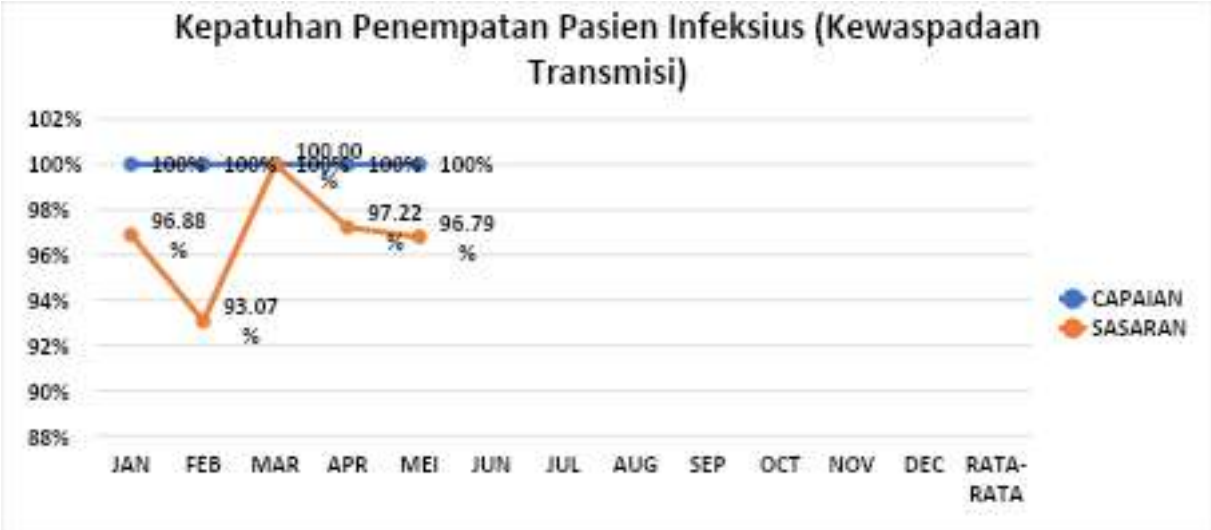


	Menurunkan Angka Sasaran IDO hingga di bawah rata-rata (0,25%) dan mencapai 0% selama periode uji coba 1 bulan 2. Tindakan Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai prosedur pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi. Menetapkan <i>checklist</i> wajib untuk memonitor suhu tubuh pasien di kamar operasi dan penggunaan alat penghangat jika diperlukan. 3. Analisa - 4. Tindakan a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap pemberian antibiotik tepat waktu. b. Indikator Hasil: Angka Sasaran IDO bulanan pada periode uji coba.
Do	1. Menerapkan <i>checklist</i> kepatuhan pada semua pasien operasi di unit/kasus yang diuji coba selama 4 minggu. 2. Mencatat waktu pemberian antibiotik dan suhu tubuh pasien secara akurat pada rekam medis. 3. Tim PPI melakukan <i>audit harian</i> pada 100% kasus uji coba untuk kepatuhan <i>checklist</i>.
Study	4. Analisis Kepatuhan: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Pemberian antibiotik tepat waktu. b. Pencapaian normotermia (suhu tubuh >36°C) c. Gula darah terkontrol d. Pasien tidak sedang dalam masa infeksi 5. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran IDO pada bulan uji coba dengan data dasar 6. Identifikasi Akar Masalah: Jika IDO tidak turun atau kepatuhan rendah, identifikasi: a. Antibiotik: Apakah ketidakpatuhan disebabkan ketersediaan obat, <i>delay</i> di ruang tunggu, atau kurangnya komunikasi? b. Normotermia: Apakah alat penghangat tidak berfungsi, atau kurangnya <i>monitoring</i>? c. Hipo/hiperglikemia : Apakah kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat gula terkontrol? Apakah gula darah pasien terkontrol?
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Jika IDO turun signifikan dan kepatuhan >95%, jadikan <i>checklist</i> sebagai Standar Prosedur Operasional (SPO) wajib di seluruh kamar operasi. 3. Beri <i>feedback</i> hasil temuan IDO dan kepatuhan kepada tim bedah. 4. Jika IDO tidak turun, gunakan data dari tahap <i>Study</i> (misalnya, jika normotermia yang paling rendah) untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya yang berfokus pada elemen bundel IDO yang lain (misalnya, <i>skin preparation</i> / persiapan kulit pra-operasi) atau pada perbaikan sistem pendukung yang gagal.



3.4.6 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Gamabr 3.4.6.1 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



Interpretasi : Pada gamabr 3.4.6.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius pada bulan April di tahun 2026 sebesar 97,22% dengan rerata 96,79%.

Tabel 3.4.6.1 PDSA Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Problem	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
Plan	1. Rencana: Menjaga kepatuhan 100% dalam penempatan pasien infeksius sesuai prinsip kewaspadaan transmisi selama 12 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah potensial ; a. Ketidakesesuaian pemahaman tenaga jesehatan tentang klasifikasi pasien infeksius b. Sistem triase atau skrining awal tidak optimal c. Ruangan isolasi terbatas atau tidak tersedia disaat dibutuhkan 4. Tindakan a. Refresh training tentang identifikasi pasien dengan infeksi menular dan protocol penempatannya b. Standarisasi formuli triase dan SOP pemindahan pasien infeksius c. Evaluasi dan optimasi ketersediaan ruang isolasi d. Audit dan umpan balik harian untuk kasus penempatan pasien baru
Do	Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100% dengan melakukan, 1. Lakukan sosialisasi ulang kepada perawat IGD, rawat inap dan IPLCN 2. Terapkan system checklist pada form masuk pasien terkait status infeksi



	dan tindak lanjutan 3. Buat system “red flag” di rekam medis pasien dengan infeksi menular 4. Monitoring harian oleh IPCN/IPCLN terhadap semua kasus rawat inap baru
Study	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan April tahun 2026 yaitu 97,22% dan belum mencapai target 100% 2. Review data audit harian atau mingguan : adakah kasus pasien infeksius tida sesuai dengan tempat 3. Tinjau waktu tunggu antara identifikasi infeksius dan pemindahan pasien
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu Rawat Inap untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan koordinasi dengan all Karu Rawat inap untuk penempatan pasien menular melalui kontrak dan airborne untuk di pisah dari pasien non infeksius 4. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 5. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 6. Beri feedback pada hasil temuan. 7. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.

3.4.7 Kejadian Pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam

Gambar 3.4.7.1 Kejadian pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam



Interpretasi : Pada gambar 3.4.7.1 diketahui bahwa rerata kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam setiap unit pada bulan April di tahun 2026 sebanyak 0 kejadian.



Tabel 3.4.7.1 PDSA Kejadian pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam

Problem	Tidak terdapat kejadian tertusuk jarum pada bulan April 2026
Step	Implementasi "3-Langkah Keamanan Benda Tajam" dan Sosialisasi Pelaporan: 1. Edukasi teknik <i>recaping</i> yang aman (menggunakan teknik satu tangan) atau penghilangan <i>recaping</i> sama sekali. 2. Penempatan <i>safety box</i> yang mudah dijangkau dan segera di dekat titik penggunaan. 3. <i>Refreshment training</i> tentang pentingnya dan alur pelaporan <48 jam.
Plan	1. Tujuan (Goal) : a. Menurunkan insiden Kejadian Tertusuk Jarum menjadi 0 dan mencapai 100% b. Kepatuhan pelaporan tepat waktu (<48 jam) untuk semua kejadian dalam 3 bulan. 2. Tindakan (Implementasi) : a. Audit lokasi penempatan <i>safety box</i> di unit berisiko tinggi (misalnya, IGD, rawat inap, laboratorium) untuk memastikan jaraknya tidak lebih dari 1 meter dari titik penggunaan. b. Membuat poster/leaflet singkat tentang teknik pembuangan yang benar dan alur pelaporan. 3. Analisa : - 4. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase ketersediaan <i>safety box</i> yang memenuhi standar penempatan (mudah dijangkau). b. Indikator Hasil: Jumlah Kejadian Tertusuk Jarum (Sasaran) per bulan.
Do	1. Melakukan audit penempatan <i>safety box</i> dan melakukan koreksi segera di unit-unit yang telah ditentukan. 2. Tim PPI memberikan <i>briefing</i> singkat (5-10 menit) tentang teknik pembuangan limbah tajam yang benar dan alur pelaporan <48 jam di setiap <i>shift meeting</i>. 3. Membagikan poster/leaflet sebagai pengingat.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase <i>safety box</i> yang telah dipindahkan/ditempatkan sesuai standar kedekatan (misalnya, mencapai 90% target). 2. Analisis Hasil: Memantau Angka Sasaran insiden tertusuk jarum pada periode uji coba (misalnya, 1 bulan). 3. Identifikasi Akar Masalah: Jika masih terjadi insiden, lakukan <i>root cause analysis</i> (RCA) singkat pada insiden tersebut. Apakah insiden terjadi karena faktor kelalaian (<i>human error</i>), desain alat (<i>safety device</i> tidak tersedia), atau lokasi <i>safety box</i> yang masih jauh?
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Jika insiden 0 dan kepatuhan penempatan <i>safety box</i> tinggi, jadikan penempatan <i>safety box</i> (jarak <1m) sebagai standar operasional dan masukkan ke dalam <i>checklist Patient Safety Rounds</i> 3. Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. 4. Jika insiden tetap terjadi, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada penyediaan dan pelatihan penggunaan jarum berfitur pengaman (<i>safety engineered devices</i>) atau pada audit praktik <i>recaping</i> (teknik satu tangan).



3.4.8 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

Gambar 3.4.8.1 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap



Interpretasi : Pada gamabr 3.4.8.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap di bulan April tahun 2026 sebesar 97% dengan rerata sebesar 96,29%.

Tabel 3.4.8.1 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

Problem	Prosentasi kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap belum mencapai target 100%
Step	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan kebersihan permukaan menjadi ≥90% selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Petugas CS kurang memahami area kritis b. Ketidakteraturan jadwal atau dokumentasi kebersihan c. Tidak adanya verifikasi atau audit lapangan secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Pelatihan ulang petugas CS tentang standart kebersihan permukaan khususnya area sentuh tinggi e. Pembuatan cheklist harian pembersihan permukaan di setiap ruangan



	(link https://drive.google.com/drive/folders/1LKqfjCbtCkdowmy9nsxlQmBcfVS0-WjU?usp=drive_link) 5. Sumber daya - Petugas kebershan CS yang terlatih - Peralatan pembersih yang memadai - SOP dan panduan visual untuk kebersihan - Peningkatan supervisi lebih sering
Do	Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, - Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Menggunakan cheklist untuk memastikan setiap sudut kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi - Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding - Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif - Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan - Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat
Study	- Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan April tahun 2026 yaitu sebesar 97% dengan rerata sebesar 96,29%. - Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut, - Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta kamar mandi bau tidak enak - CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor - Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah - Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed - Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai - Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau - Masih ditemukan gorden kotor tidak tercuci - Metrik evaluasi yang digunakan, - Audit kebersihan kamar kosong - Audit kebersihan area oleh CS - Audit kebersihan troli tindakan diruang rawat inap - Audit kebersihan di ruang IKO - Audit kepatuhan penggunaan APD pada saat pembersihan - Evaluasi kebersihan tirai/gorden - Penanganan linen infeksius - Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi
Action	- Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit.



4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

3.4.9 Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart (2/3 wadah)
Gambar 3.4.9.1 Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart (2/3 wadah)



Interpretasi : Pada gambar 3.4.9.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di bulan April tahun 2026 sebesar 97,47% dengan rerata 97,02%.

Tabel 3.4.9.1 Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart (2/3 wadah)

Problem	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan pengambilan linen menjadi 100% sesuai standart selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Petugas belum paham resiko infeksi silang akibat overfilling b. Kurangnya pengawasan atau evaluasi harian c. Tidak tersedia alternatif wadah bila kapasitas sudah 2/3 penuh 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan petugas



	dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai 2/3 wadah e. Sediakan Cadangan wadah linen untuk kondisi penuh agar petugas tidak terpaksa overfill f. Lakukan penambahan kantong linen sesuai jenis linen (a) Kantong linen spre (b) Kantong linen sarung bantal (c) Kantong linen selimut (d) Kantong linen gown dan baju pasien
Do	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya dengan upaya, 1. Melakukan pelatihan secara singkat kepada petugas kebersihan dan perawat tentang penanganan linen 2. Tempel stiker batas maksimal 2/3 pada semua wadah linen kotor du setiap ruangan 3. Terapkan observasi harian oleh petugas IPCN atau kepala ruangan selama satu minggu pertama 4. Catat Tingkat kepatuhan harian dan lakukan pengingat verbal jika ditemukan pelanggaran
Study	1. Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. 2. Evaluasi data observasi dan bandingkan dengan bulan sebelumnya 3. Lakukan diskusi mingguan dengan petugas terkait tantangan dilapangan 4. Catat perubahan tren kepatuhan dan identifikasi apakah penandaan visual
Action	1. Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah 2. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. 3. Berikan system reward / sanksi sederhana berbasis performa petugas 4. Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor

3.4.10 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN
Gambar 3.4.10.1 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN



Interpretasi : Pada gambar 3.4.10.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN di bulan April tahun 2026 sebesar 89,82% dengan rerata sebesar 95,76%.

Tabel 3.4.10.1 PDSA Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN

Problem	Pelaporan dari IPCLN (Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Unit) ke IPCN (Petugas PPI Rumah Sakit) tidak dilakukan tepat waktu.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN menjadi $\geq 90\%$ dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Analisa a. Minimnya kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan tepat waktu b. Beban kerja IPCLN yang tinggi diunit sehingga pelaporan di anggap beban c. Kurangnya sistem pemantauan atau pengingat pelaporan 4. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatutah IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi. c. Lakukan evaluasi bulanan terhadap kepatuhan pelaporan tiap unit



Study	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di bulan April tahun 2026 rerata 89,82% dan belum memenuhi standart 100% 2. Bandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi 3. Evaluasi kendala yang muncul selama implementasi 4. Lakukan kuesioner singkat atau FGD dengan IPCLN untuk mendapatkan umpan balik
Action	1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMSbAEduydwwaSi-AOWHlxYA8QYuDgE/edit?usp=sharing>

3.4.11 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

Gambar 3.4.11.1 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 3.4.11.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh di bulan April tahun 2026 sebesar 100% dengan rerata sudah mencapai target 100%.

Tabel 3.4.11.1 PDSA Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

Problem	Prosentasi kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh sudah mencapai 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penggunaan spillkit dalam menangani tumpahan B3 dan DUH tubuh
Plan	2. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan spill kit dalam penanganan tumpahan B3 dan DUH tubuh menjadi $\geq 80\%$ dalam 3 bulan. 3. Harapan



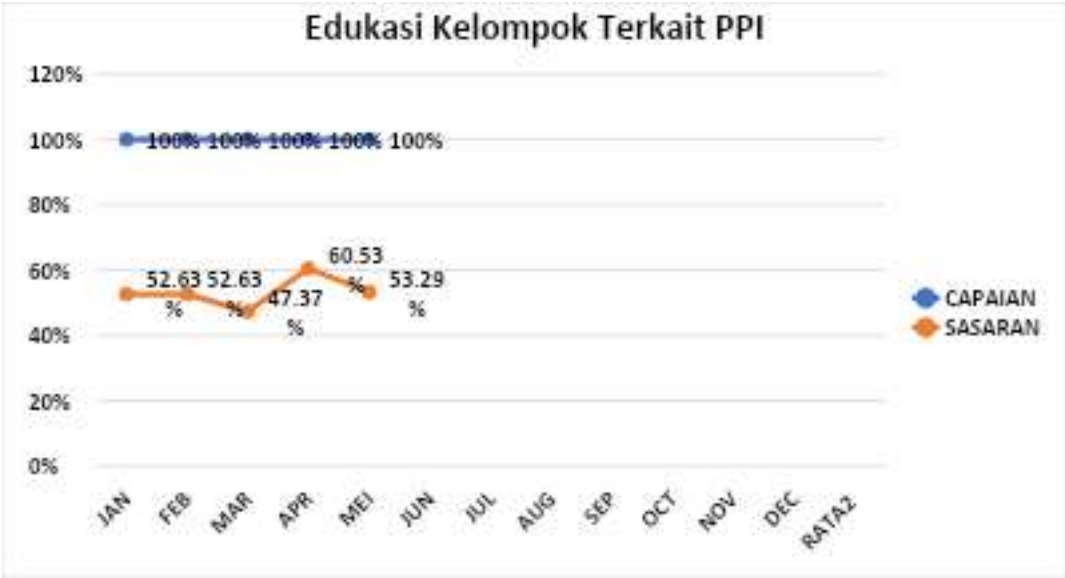
	Seluruh jenis tumpahan DUH pasien dan cairan B3 di unit wajib dilakukan pembersihan menggunakan Spillkit. 4. Analisa a. Belum ada riview pelatihan/praktik secara langsung b. Tidak ada pengawasan atau audit insiden tumpahan 5. Tindakan a. Pastikan keberadaan spill kit diseluruh unit pelayanan beresiko b. Sosialisasi dan pelatihan praktis penggunaan spill kit kepada seluruh petugas c. Tempelkan alur atau poster langkah penggunaan spill kit di area strategis. d. Bentuk tim audit untuk memantau kepatuhan dan tindak lanjut insiden.
Do	1. Distribusikan spill kit ke semua unit yang membutuhkan dan pastikan kelengkapannya 2. Laksanakan pelatihan langsung oleh IPCN/IPCLN (misalnya dengan simulasi tumpahan) 3. Sebarkan media edukasi visual (poster, video singkat). 4. Terapkan form pelaporan jika spill kit digunakan, untuk mendokumentasikan insiden.
Study	1. Data kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan April tahun 2026 sebesar 100% dengan rerata 100% sehingga sudah mencapai standart 100%. 2. Evaluasi jumlah penggunaan spill kit (dari log pelaporan) dibandingkan jumlah insiden. 3. Lakukan survei singkat pemahaman petugas pasca pelatihan. 4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat insiden terjadi.
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. 4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 5. Analisis kebutuhan spill kit di unit

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0LI6EkPMAypTMA/edit?usp=sharing

3.4.12 Edukasi Kelompok Terkait PPI

Gambar 3.4.12.1 Edukasi Kelompok Terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 3.4.12.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI di bulan April tahun 2026 sebesar 60,53% dengan rata-rata 53,29%.

Tabel 3.4.12.1 PDSA Edukasi Kelompok terkait PPI

Problem	Prosentasi kepatuhan edukasi PPI pada pengunjung ataupun pada staff belum mencapai target 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya melakukan edukasi PPI dengan sasaran kelompok ataupun sasaran individu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan dan pengendalian infeksi yang berada di rumah sakit
Plan	1. Masalah Edukasi kelompok terkait PPI belum dilaksanakan secara rutin atau terdokumentasi dengan baik. 2. Tujuan Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kelompok PPI ≥ 80% dalam 3 bulan 3. Analisa a. Jadwal edukasi tidak tersusun dengan sistematis. b. Petugas tidak patuh dalam melakukan edukasi c. Dokumentasi edukasi sering terlewatkan. d. Kurangnya koordinasi antar unit dengan IPCN/IPCLN. 4. Strategi a. Susun jadwal edukasi mingguan/bulanan di setiap unit. b. Sediakan materi edukasi PPI yang mudah dipahami pasien/keluarga. c. Buat form standar dokumentasi edukasi (manual/digital). d. Tetapkan PIC edukasi di tiap unit pelayanan.
Do	1. Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi. 2. Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif. 3. Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan. 4. IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal.
Study	1. Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan terdokumentasi. 2. Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan. 3. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya



Action	1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu 2. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu 3. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi
---------------	--

3.6.2.1

3.6.3 Tim PKRS

Tabel Kinerja Produktifitas PKRS Tahun 2025

No	Hal	Target	Januari	% bulan sebelumnya	Ket
	Produksi Leaflet baru	2x/bln	1 buah	$(1/2) \times 100\% = 50\%$ ↓ 50%	Ditingkatkan
	Produksi Poster/Flyer	4x/bln	6 buah	$(4/4) \times 100\% = 100\%$ ↑ 100%	Pertahankan
	Pembuatan Video	1x/bln	1 buah	$(4/1) \times 100\% = 400\%$ ↑ 400%	Pertahankan
	Pembuatan Podcast/ Audio edukasi	2x/bln	-	$(1/2) \times 100\% = 100\%$ ↑ 100%	Meningkat
	KIE Massa Radio Central	25x/bln tiap hari	2x putar	$(1/25) \times 100\% = 4\%$ ↓ 4%	Kurang 96% Rekaman Diinventaris jika punya 10 macam audio. Di putar setiap hari dan diulang berkali-kali. Buat audio materi Prognas : 5
	KIE WAG Komunitas	25x/bln tiap hari	4	$(2/25) \times 100\% = 8\%$ ↓ 8 %	Ditingkatkan
	Edukasi di sosmed (IG, FB)	25x/bln tiap hari	6	$(4/25) \times 100\% = 16\%$ ↓ 16 %	Ditingkatkan Buat metode baru : jadwalkan untuk edukasi live di IG
	Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	4x/bln	5	$(4/4) \times 100\% = 100\%$ ↑ 100%	Pertahankan
	Pemberdayaan Komunitas (DOLINA)	2x/bln	2	$(1/2) \times 100\% = 50\%$ ↓ 50%	Pertahankan

Analisis :

1. Pembuatan podcast pada bulan januari belum terlaksana.



2. Edukasi di sosmed hanya dilakukan dengan memposting poster belum terlaksana live Instagram.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Buat jadwal bulanan terkait program podcast dan pembuatan video, audio edukasi (Jadwalkan tiap DPJP wajib mengisi 1 menit edukasi sesuai PHBK poli)
2. Lakukan koordinasi dengan kepala ruang dan pic PKRS unit untuk menjadwalkan edukasi melalui sosmed dan edukasi langsung menggunakan audio central. (tiap unit diminta untuk membuat rekaman edukasi)
3. Evaluasi tim dolina dan menjadwalkan lagi petugas, agar aktif ikut serta dalam pelaksanaan dolina

Tabel Hasil Kinerja KIE Kelompok tiap Unit di RSPHS pada Bulan April Tahun 2025

No	Unit	Target	Jan	Mandok	Ket
1.	IRNA 2A	8x/bln	2x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari Target
2.	IRNA 2B	8x/bln	4x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari Target
3.	IRNA 3A	8x/bln	10x	<u>Lampiran B</u>	Melampaui Target
4.	IRNA 3B	8x/bln	4x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target
5.	ICU	8x/bln	9x	<u>Lampiran B</u>	Melampaui Target
6.	MATERNITAS	8x/bln	9x	<u>Lampiran B</u>	Melampaui Target
7.	PERINATOLOGI	8x/bln	3x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target
8.	IRJA	8x/bln	-	-	-
9.	IGD	8x/bln	6x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari Target
10.	GIZI	8x/bln	1x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target
11.	LABORATORIUM	8x/bln	-	-	-
12.	RADIOLOGI	8x/bln	-	-	-
13.	FARMASI	8x/bln	-	-	-
14.	IKO	8x/bln	1x	<u>Lampiran B</u>	Kurang dari target

Analisis :

Petugas cenderung tidak melaksanakan edukasi sesuai target, hanya beberapa unit yang melaksanakan sesuai target.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Beri feedback dan followup petugas
2. Menindaklanjuti karu dan pic pkrs yang bertugas
3. Menjadwalkan tiap minggu edukasi
4. Membuatkan jenjang peringkat agar petugas lebih semangat lagi untuk edukasi
5. Catat nama petugas/ unit yang tidak patuh dalam melakukan edukasi.
6. Laporkan kepada atasan agar di followup ke karu, apabila belum ada perubahan

3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

A. Kegiatan Pelayanan Maternal

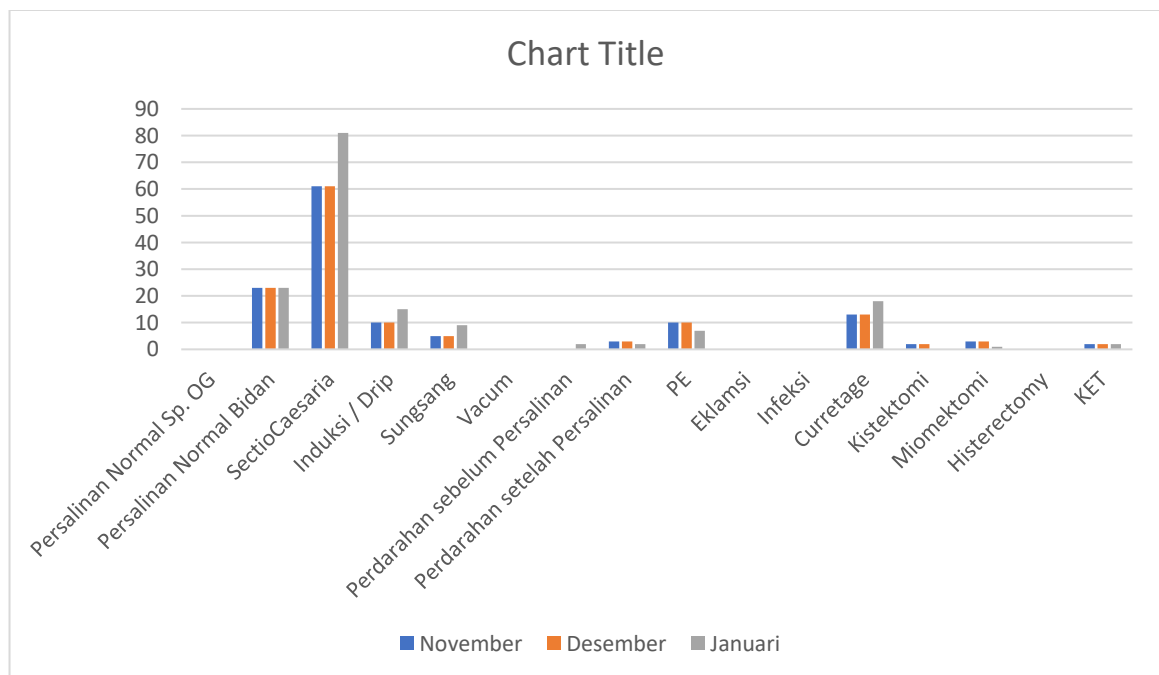
Tabel Kegiatan Pelayanan Maternal

		JUMLAH PASIEN
--	--	---------------



NO	JENIS PELAYANAN	November 2024	Desember 2024	Januari 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	0	0	0
	b. Persalinan Normal Bidan	23	26	23
	c. <i>SectioCaesaria</i>	61	65	81
2	Persalinan dengan tindakan			
	a. Induksi / Drip	10	10	15
	b. Sungsang	5	5	9
	c. Vacuum	0	0	0
3	Persalinan dengan Komplikasi			
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	0	2
	c. PE	10	9	7
	e. Eklamsi	0	0	0
	f. Infeksi	0	0	0
4	Kebidanan :			
	a. Curretage	13	13	18
	b. Kistektomi	2	1	0
	c. Miomektomi	3	2	1
	d. Histerectomy	0	0	0
	e. KET	2	2	2

GRAFIK 1
JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN MATERNAL DI RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA BULAN JANUARI 2025



Evaluasi :

1. Persalinan normal dengan Sp.Og untuk bulan januari tidak ada sama sekali
2. Untuk jumlah persalinan dengan bidan bulan ini turun dari bulan sebelumnya dikarenakan jumlah persalinan bulan ini naik di Tindakan SC
3. Untuk kasus persalinan sc dalam bulan ini naik dari bulan kemarin, karena rujukan emergency dari IGD dan lodingan dari poli juga naik
4. Persalinan dengan induksi untuk bulan ini jumlahnya naik dengan bulan kemarin . Untuk induksi sendiri di berikan kalau benar-benar ada indikasi yang sesuai dengan kriteri dilakukan induksi supaya pasiennya aman
5. Kasus persalinan sungsang bulan ini naik dengan bulan kemarin, dan rata-rata adalah pasien dari rujukan.
6. Tidak ada kasus persalinan dengan tindakan vacum
7. Kasus perdarahan sebelum persalinan untuk bulan naik dari bulan sebelumnya dan itu pasien dari IGD
8. Kasus perdarahan setelah melahirkan pada bulan ini naik dari bulan sebelumnya di karenakan pasien dengan PEB dan plasenta letak renda
9. Pasien dengan Preeklampsia bulan ini turun dengan bulan sebelumnya dan kebanyakan pasien rujukan dari bidan atau klinik.
10. Infeksi pada bulan ini tidak ada.
11. Tindakan curretage bulan ini lebih banyak dari bulan sebelumnya dengan diagnose terbanyak AUB
12. Tindakan miomektomi pada bulan ini turun dari bulan sebelumnya
13. Tindakan kistektomi pada bulan ini tidak ada sama sekali.
14. Kasus histerektomi untuk bulan ini tidak ada
15. Kasus KET pada bulan ini sama dengan bulan sebelumnya

Rencana dan Tindak Lanjut:

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit untuk melakukan promosi dan mengenalkan dokter-dokter obgyn yang ada di prima husada sukorejo
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya kehamilan di trimester 1, 2 dan 3 kehamilan.
3. Mengadakan kelas ibu hamil dan memberi materi dan edukasi terkait kehamilan dan persalinan



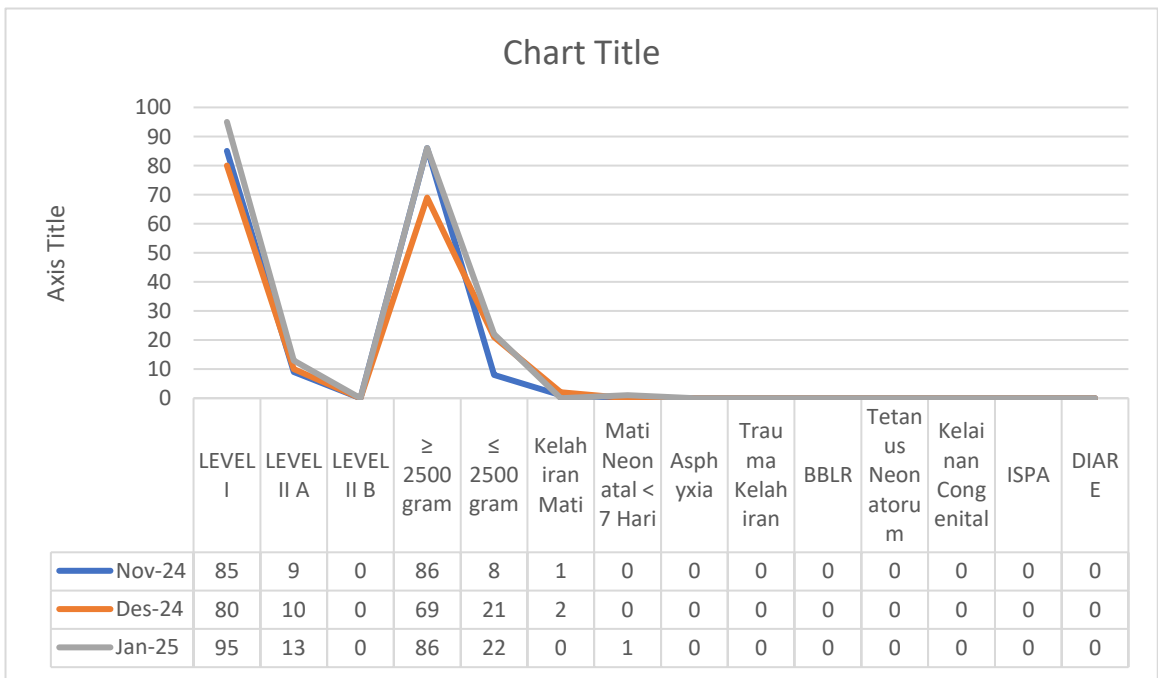
2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2024
1	Jumlah pasien neonatal			
	d. Level 1	85	80	95
	e. Level II A	9	10	13
	f. Level II B	0	0	0
2	Bayi Lahir Hidup			
	c. ≥ 2500 gram	86	69	86
	d. ≤ 2500 gram	8	21	22
3	Kematian neonatal			
	c. Kelahiran Mati	0	2	0
	d. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	1
4	Sebab Kematian Neonatal			
	a. Asphyxia	0	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	0	0	0
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0



GRAFIK 2

JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN NEONATAL DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

1. Untuk perawatan bayi level 1 bulan ini naik dari bulan sebelumnya karena jumlah persalinan bulan ini juga mengalami kenaikan juga
2. Perawatan bayi level II A naik dari bulan sebelumnya dan bayi hanya membutuhkan incubator saja. Hal ini dikarenakan rata-rata bayi sehat dan Sebagian besar rawat gabung.
3. Perawatan bayi level II B tidak ada
4. Terdapat kenaikan jumlah bayi dengan BB lebih dari 2500 karena banyak bayi yang lahir dengan keadaan yang sehat
5. Untuk bulan ini jumlah bayi lahir hidup dengan berat badan ≤ 2500 gram jumlahnya naik dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus partus prematurus imminens (PPI) pada ibu hamil dan ada dengan gemeli 2 pasien.
6. Untuk kelahiran mati bulan ini tidak ada kasus
7. Untuk kematian neonatal < 7 hari pada bulan ini ada 1 kasus dengan pasien tiba-tiba datang ke IGD dengan kehamilan gemelli dan keadaan janin sudah fetal distress, jadi yang 1 meninggal dan yg satunya hidup.
8. Bayi yang meninggal dengan sebab lain untuk bulan ini tidak ada.

Rencana dan Tindak Lanjut

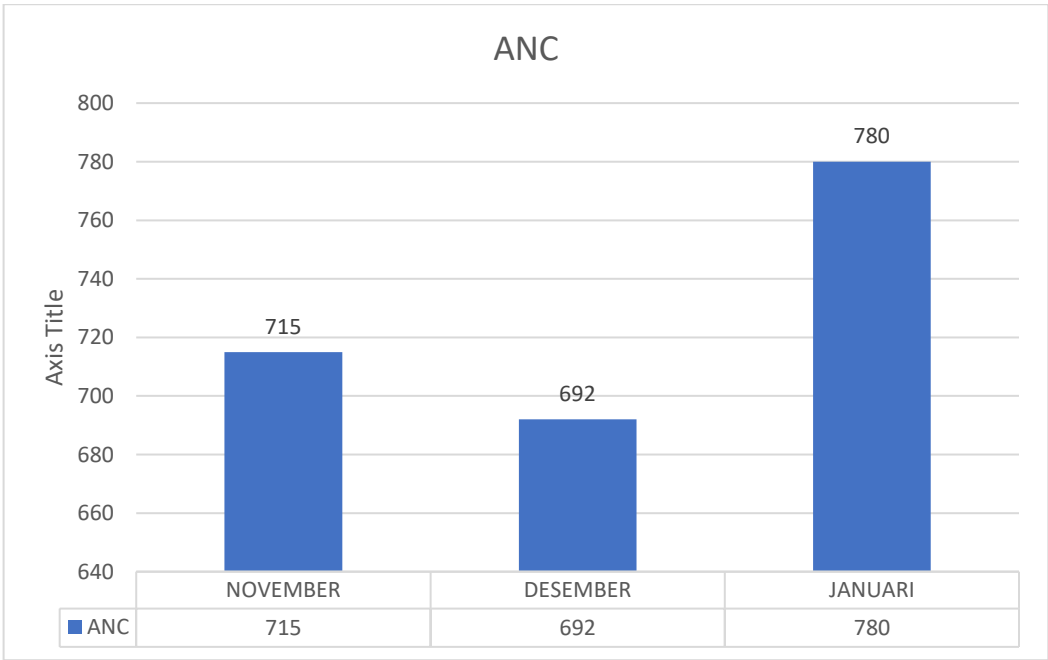
1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi dan persiapan persalinan agar tidak terjadi infeksi neonatus karena ketuban mekonial.



3. Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	ANC	715	692	780

GRAFIK 3
JUMLAH PELAYANAN ANTE NATAL CARE (ANC) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

Terdapat kenaikan jumlah pelayanan Ante Natal Care, pada bulan Januari 2025 sebanyak 780 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut

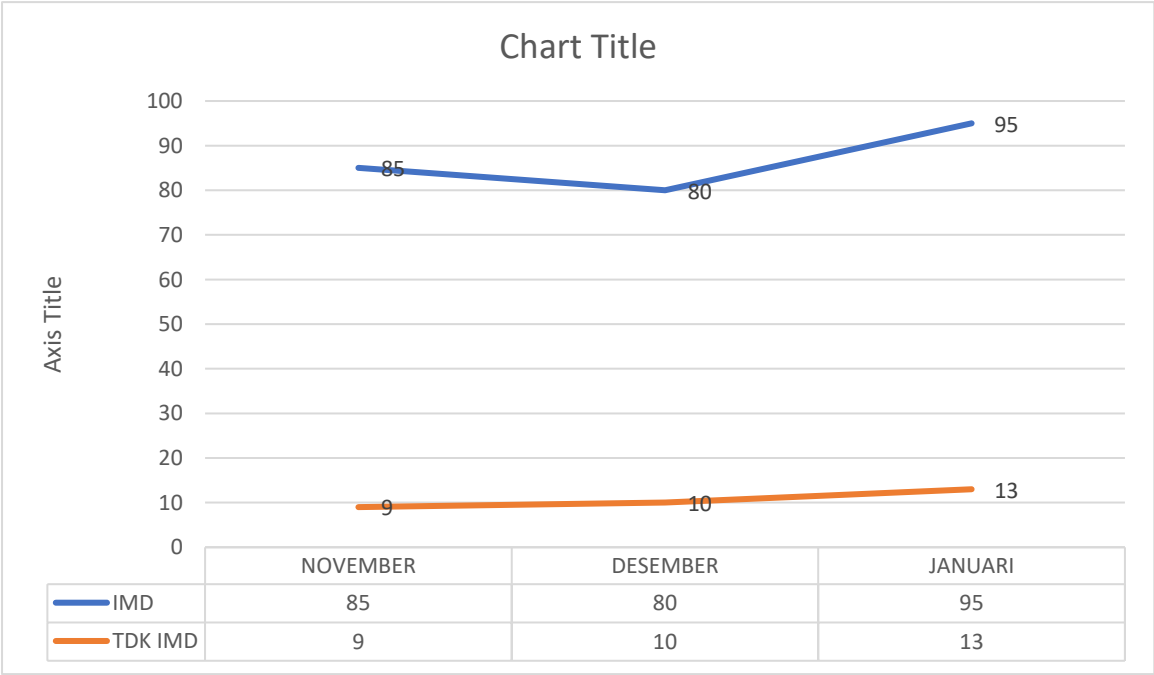
Melakukan promosi terkait senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya.

4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	IMD	85	80	95
2	Tidak IMD	9	10	13



GRAFIK 4
JUMLAH PELAYANAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

- 1. Dalam pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) untuk bulan ini naik dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan naiknya jumlah kelahiran bayi sehat di rumah sakit prima husada Sukorejo yang memungkinkan untuk dilakukan IMD.
- 2. Untuk tidakan IMD bulan ini naik sedikit dengan bulan kemarin. Hal ini dikarenakan bayi tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD atau bayi sakit.

Rencana dan Tindak Lanjut

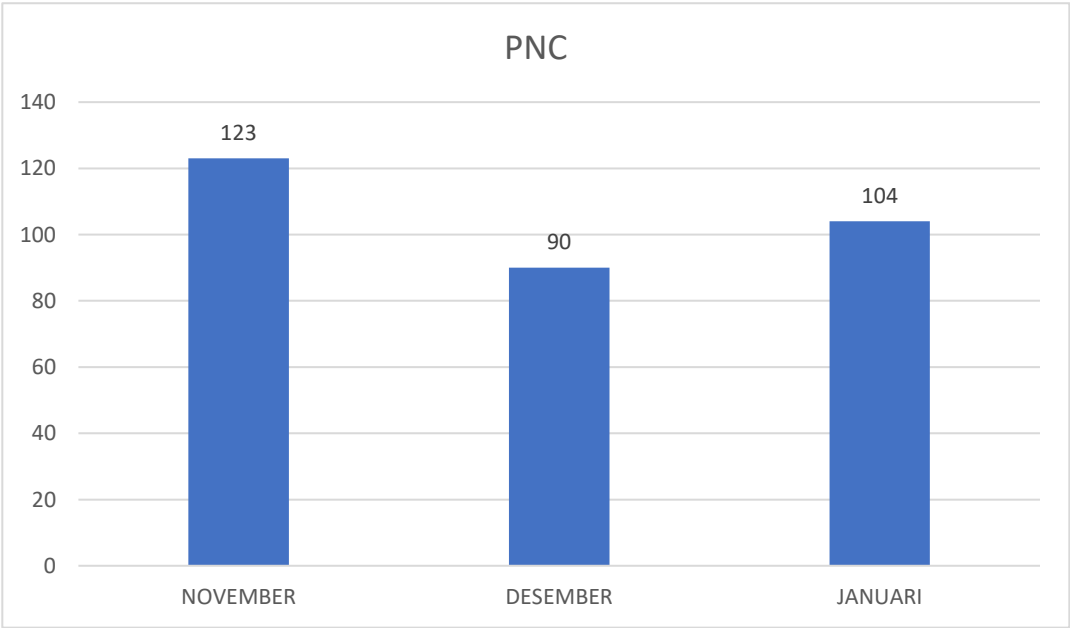
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

5. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	PNC	90	90	104



GRAFIK 5
JUMLAH PELAYANAN POST NATAL CARE (PNC) DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

Terdapat kenaikan jumlah kunjungan pasien PNC pada bulan ini sebanyak 104 pasien. Hal ini dikarenakan meningkatnya angka ibu bersalin di rumah sakit prima husada sukorejo.

Rencana dan Tindak Lanjut

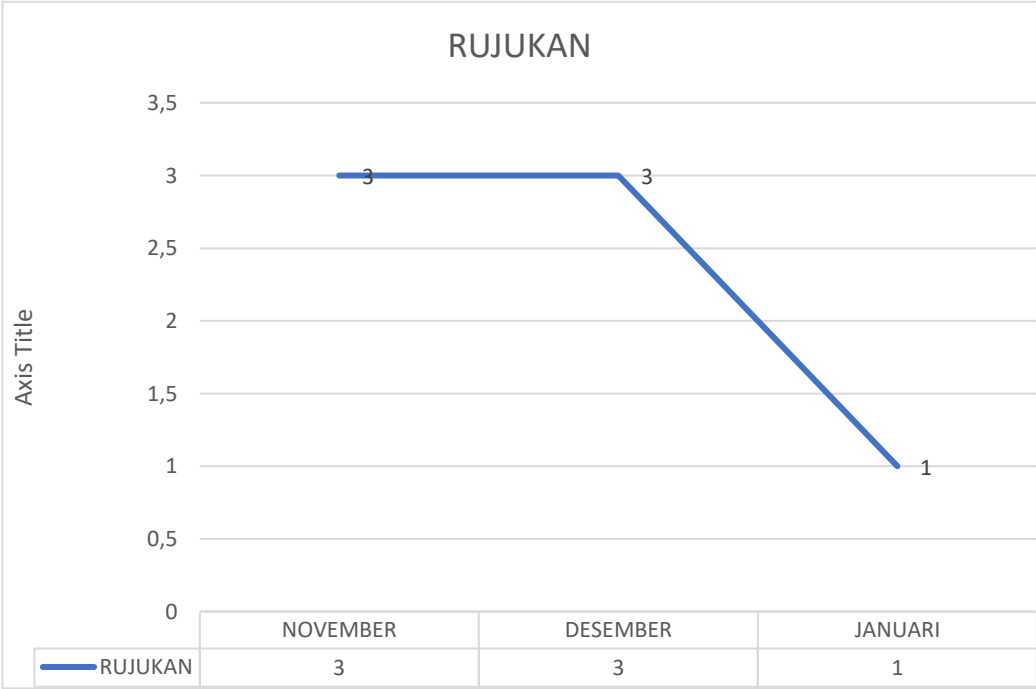
Melakukan promosi kegiatan tentang pelayanan post natal Care, dengan bekerjasama dengan bidan sekitar rumah sakit.

6. Pelayanan Jejaring Rujukan (Rujukan eksternal)

No	Pelayanan	JUMLAH			TUJUAN RUJUK
		NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	
1	Rujukan eksternal	3	0	1	RSUD Sidoarjo
TOTAL		4	3	0	



GRAFIK 7
PELAYANAN JEJARING RUJUKAN (RUJUKAN EKSTERNAL) RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA BULAN JANUARI 2025



Evaluasi :

Untuk bulan ini jumlah rujukan eksternal 1 yaitu bayi yang lahir prematur

Tindak Lanjut :

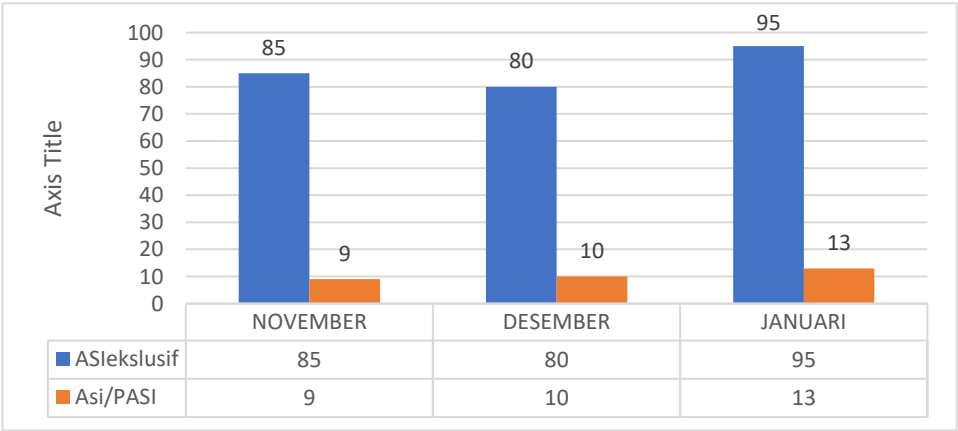
Meningkatkan jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

7. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

No	Pemberian ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	Asieksklusif	85	80	95
2	Asi /PASI	9	10	13



GRAFIK 7
PELAYANAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI 2025



Evaluasi

- 1. Terdapat peningkatan pada pelayanan pemberian ASI Eksklusif pada bulan Januari 2025, Hal ini dikarenakan jumlah persalinan pada bulan ini naik
- 2. Asi/pasi pada bulan ini naik dari bulan sebelumnya. Karena jumlah bayi sakit meningkat dan harus perawatan di ruang perinatologi terlebih dahulu dan sebagian juga disebabkan karena asi ibu masih belum keluar

Rencana dan Tindak Lanjut

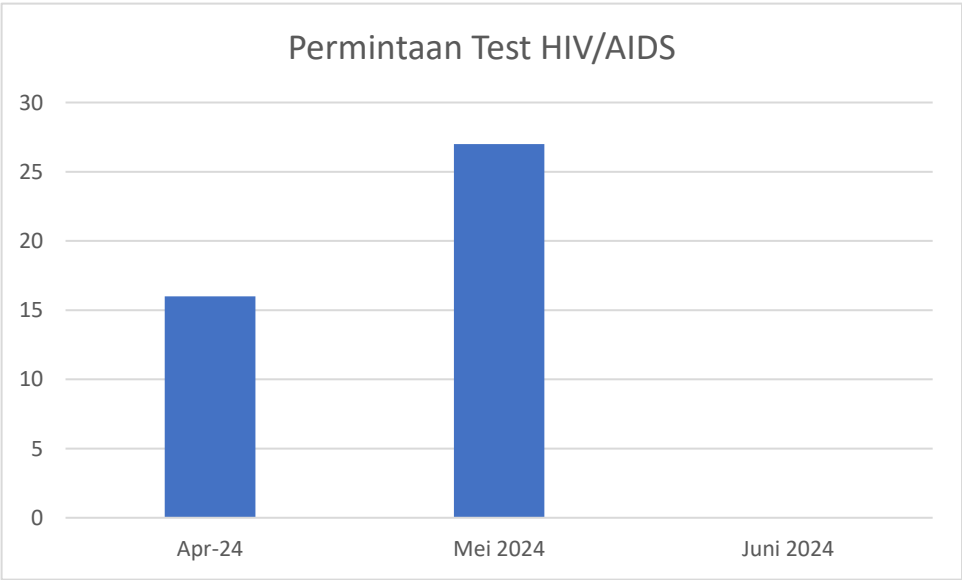
Dilakukan Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumahsakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI ekslusi

3.6.4.2 HIV

1. Jumlah permintaan Tes HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Juli	Agustus	September
1	Permintaan Test HIV/AIDS	16	27	0

GRAFIK 1
 JUMLAH PERMINTAAN TEST HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
 BULAN MEI 2024



Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Pada bulan April 2024 terdapat 16 permintaan testing HIV/AIDS. Pada bulan Mei 2024 terdapat 27 permintaan testing HIV/AIDS.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
- Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien TB yang status HIV nya tidak diketahui
- Melakukan edukasi dan sosialisasi terduga TB yang status HIV nya tidak diketahui.

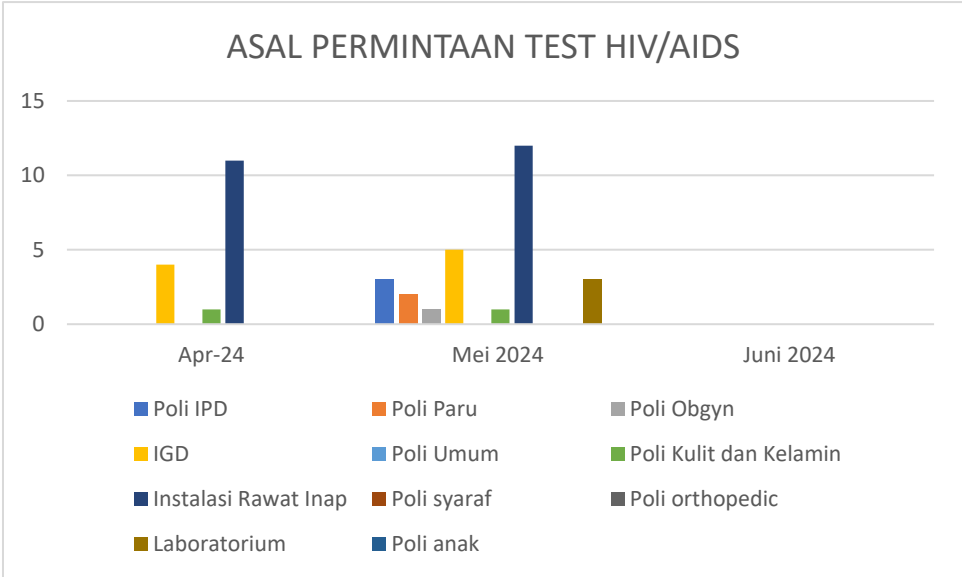
2. ASAL PERMINTAAN TES HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		Juli	Agustus	September
1	Poli IPD	0	3	0
2	Poli Paru	0	2	0

3	Poli Obgyn	0	1	0
4	IGD	4	5	0
5	Poli Umum	0	0	0
6	Poli Kulit dan Kelamin	1	1	0
7	Instalasi Rawat Inap	11	12	0
8	Poli syaraf	0	0	0
9	Poli orthopedic	0	0	0
10	Laboratorium	0	3	0
11	Poli anak	0	0	0

GRAFIK 2

JUMLAH ASAL PERMINTAAN TEST HIV/AIDS



Analisis Asal Permintaan Tes HIV/AIDS

Kenaikan permintaan test HIV/AIDS terdapat di IGD pada bulan Mei 2024.

Rencana dan Tindak Lanjut:

- Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
 - Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
 - Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
 - Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit Rumah Sakit

1. Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

No	Permasalahan	Analisa	
1	Maish ditemukan operasi HARUM Pen Kurang safty	P	- Memberikan informasi kepadl unit pelayanan iko Memberikan sosialisasi kepada semua staf IKO untuk mengingatkan jika ada terjadi percikan listrik di Harum pen - Melakukan koordinasi dengan kabit penunjang dan gudang farmasi
		D	- Memberikan informasi kepadl unit pelayanan iko Memberikan sosialisasi kepada semua staf IKO untuk mengingatkan jika ada terjadi percikan listrik di Harum pen - Melakukan koordinasi dengan kabit gugang farmasi
		S	monitoring dan evaluasi
		A	- Informasi kepada semua unit pelayanan unit iko jika terjadi percikan listrik segera hentikan dan ganti counter baru - sosialiasi kepada staf IKO untuk mentaati SOP yang berlaku - Melakukan koordinasi dengan kabit dan gudang

2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketidakpatuhan staf IGD dalam handover dimana masih ditemukan pasien dan RM di tranfer namun tidak segera melakukan handover dengan kurun waktu lebih dari 30 menit	P	- Mengingatkan staf agar melakukan handover tepat waktu pada - Melakukan koordinasi dengan karu untuk sosialisasi ulang ketepatan waktu handover kepada semua staf - Melakukan koordinasi dengan kabit kep dan pelayanan
		D	- Informasi kepada staf terkait untuk handover tepat waktu - Koordinasi dengan karu untuk sosialisasi ulang ketepatan waktu handover kepada semua staf - Koordinasi dengan kabit kep dan pelayanan
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	- Informasi kepada staf terkait untuk handover tepat waktu - Koordinasi dengan karu untuk sosialisasi ulang ketepatan waktu handover kepada semua staf - Koordinasi dengan kabit kep dan pelayanan
2	Pengisian ERM yang tidak lengkap sehingga menjal PR yang berhubungan dengan klaim mengakibatkan buka billing pada saat mendekati klaim dan mengakibatkan pembuatan kronoligo oleh staff tersebut.	P	- Mengingatkan kepada staff untuk disiplin pengisian ERM - Koordinasi ke karu apabila belum paham terkait ERM (staff baru)
		D	- Informasi kepada staff terkait pengisian erm yang lengkap - Sosialisai terkait pengisian ERM kepada anak baru
		S	Monitoring dan evaluasi

		A	Informasi kepada staff terkait pengisian ERM
3	Ketidaktepatan dokter IGD dalam proses konsul ke DPJP yang tidak membalas sehingga menunggu balasan DPJP yang mengakibatkan delay jawaban konsulan	P	Mengingatkan kepada staff untuk konsul ke DPJP sesuai dengan SPO
		D	Rivew ulang kepada staff dan dokter IGD dengan adanya SPO Baru
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	Informasi terkait SPO lebih di pahami

3. Permasalahan Maternitas

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketersediaan BE sesuai dengan kegawatan maternal belum sesuai	P	1. Melakukan pendataan obat-obat emergency maternal apa saja yang sering di butuhkan 2. Melakukan koordinasi dengan farmasi untuk menambahkan obat kegawatan maternal pada BE 3. Melakukan Koordinasi dengan kbid pelayanan dan penunjang
		D	1. Pendataan obat-obat emergency pada kasus maternal yang sering di butuhkan 2. Koordinasi dengan farmasi untuk menambahkan obat kegawatan maternal pada BE 3. Koordinasi dengan kbid pelayanan dan penunjang
		S	Monitoring dan evaluasi
		A	1. Pendataan obat-obat emergency pada kasus maternal yang sering di butuhkan 2. Koordinasi dengan farmasi untuk menambahkan obat kegawatan maternal pada BE 3. Koordinasi dengan kbid pelayanan dan penunjang
2	Bidan baru masih tidak boleh jaga malam karena SIP tidak kunjung jadi, sedang pengurusan SIP sekarang sulit	P	1. Melakukan koordinasi dengan SDM 2. Melakukan Koordinasi dengan SDM terkait satu sehat SDM 3. Melakukan koordinasi dengan kbid yanmed
		D	1. Kordinasi dengan SDM 2. Koordinasi dengan SDM terkait satu sehat SDM 3. Koordinasi dengan kbid

4. Permasalahan Neonatologi

No	Masalah	Tindak Lanjut	
1.	Belum terpenuhi alat suction di ruang ponek IGD	P	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kbid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		D	1. Koordinasi dengan Karu IGD dan Kbid Pelayanan untuk kesediaan alat suction 2. FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kbid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction

5. Permasalahan NICU

No	Permasalahan	Analisa	
1	Belum terpenuhi alat suction di ruang ponok IGD sehingga jika ada persalinan di IGD masih memakai punya NICU	P	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kabid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		D	1. Koordinasi dengan Karu IGD dan Kabid Pelayanan untuk kesediaan alat suction 2. FU berkala terkait ketersediaan alat suction
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Melakukan koordinasi dengan Karu IGD dan Kabid Pelayanan terkait ketersediaan alat suction 2. Melakukan FU berkala terkait ketersediaan alat suction

5. Permasalahan ICU

No	Permasalahan	Analisa	
1	Ketidakpatuhan DPJP untuk membacakan hasil ECG sehingga mempengaruhi proses klaim	P	1. Melakukan pendataan berapa DPJP yang tidak patuh akan aturan pembacaan ECG 2. Mengingatkan DPJP untuk membacakan hasil ECG pada saat visite pertamakali 3. Melakukan koordinasi dengan dr ruangan apabila sampai pasien KRS belum ada bacaan ECG, agar dr ruangan yang membacakan hasil ECG 4. Melakukan koordinasi dengan kabid yanmed untuk mengevaluasi DPJP terkait
		D	1. Pendataan oleh Karu berapa DPJP yang tidak patuh akan aturan pembacaan ECG 2. Komunikasi dengan DPJP untuk membacakan hasil ECG pada saat visite pertamakali 3. Koordinasi dengan dr ruangan apabila sampai pasien KRS belum ada bacaan ECG, agar dr ruangan yang membacakan hasil ECG 4. Koordinasi dengan kabid yanmed untuk mengevaluasi DPJP terkait
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Pendataan oleh Karu berapa DPJP yang tidak patuh akan aturan pembacaan ECG 2. Komunikasi dengan DPJP untuk membacakan hasil ECG pada saat visite pertamakali 3. Koordinasi dengan dr ruangan apabila sampai pasien KRS belum

			ada bacaan ECG, agar dr ruangan yang membacakan hasil ECG 4. Koordinasi dengan kabid yanmed untuk mengevaluasi DPJP terkait
2	Ketersediaan tempat skoret untuk petugas perawat yang tindakan di ruang icu iso TB sehingga skoret tergantung dan bekas masker tidak ada tempatnya	P	Melakukan Pendataan terkait penggunaan skoret yang digunakan oleh perawat setiap ke pasien dan penggunaan masker
		D	Koordinasi dengan karu dan tim PPI untuk terkait penyimpanan skoret dan masker sehingga tertata rapi
		S	Monitoring Evaluasi
		A	Koordinasi dengan PPI terkait penambahan nakas atau almari kecil untuk penyimpanan skoret
3.	Ruang tunggu keluarga pasien ICU masih didepan ruang IRNA 3A	P	1. Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan mengenai ruang tunggu keluarga pasien ICU 2. Menyediakan ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien ICU
		D	1. Koordinasi dengan kabid pelayanan mengenai ruang tunggu keluarga pasien ICU 2. Adanya ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien ICU
		S	Monitoring evaluasi
		A	1. Koordinasi dengan kabid pelayanan mengenai ruang tunggu keluarga pasien ICU 2. Adanya ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien ICU

6. Permasalahan Rawat Inap

No	Unit	Permasalahan	Analisa
1	2A	Ketidaktersediaan kulkas penyimpanan obat di unit mengakibatkan adanya penitipan obat di kulkas farmasi, dimana kebanyakan obat lupa untuk diambil dan di retur sehingga hal ini dapat mengakibatkan selisih.	P 1. Melakukan pendataan berapa obat yang tidak terambil pada kulkas farmasi. 2. Melakukan pendataan berapa banyak obat yang memerlukan penyimpanan di kulkas. 3. Melakukan koordinasi dengan direksi untuk pemenuhan kulkas di unit. 4. Melakukan edukasi kepada semua staf unit Irna 2 agar menggunakan kulkas sesuai peruntukannya (penyimpanan obat)



			D	1. Pendataan berapa obat yang tidak terambil pada kulkas farmasi. 2. Pendataan berapa banyak obat yang memerlukan penyimpanan di kulkas. 3. Koordinasi dengan direksi untuk pemenuhan kulkas di unit. 4. Edukasi kepada semua staf unit Irna 2 agar menggunakan kulkas sesuai peruntukannya (penyimpanan obat)
			S	Monitoring evaluasi
			A	1. Pendataan berapa obat yang tidak terambil pada kulkas farmasi. 2. Pendataan berapa banyak obat yang memerlukan penyimpanan di kulkas. 3. Koordinasi dengan direksi untuk pemenuhan kulkas di unit. 4. Edukasi kepada semua staf unit Irna 2 agar menggunakan kulkas sesuai peruntukannya (penyimpanan obat)
2	2B	Ketidakpatuhan staf dalam penginputan Tindakan mengakibatkan tingginya kasus open billing.	P	1. Melakukan sosialisasi ulang pada semua staf terkait kepatuhan penginputan di SIMRS. 2. Melakukan double cek mulai dari pendamping visite, PPJA dan di final cek oleh PJ krs setiap sif nya. 3. Melakukan evaluasi kinerja pada staf terkait. 4. Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan terkait open billing.
			D	1. Sosialisasi ulang pada semua staf terkait kepatuhan penginputan di SIMRS. 2. Lakukan double cek mulai dari pendamping visite, PPJA dan di final cek oleh PJ Krs setiap sif nya. 3. Evaluasi kinerja pada staf yang terlibat kasus open billing. 4. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan terkait open billing.
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Sosialisasi ulang pada semua staf terkait kepatuhan penginputan di SIMRS.



				- Lakukan double cek mulai dari pendamping visite, PPJA dan di final cek oleh PJ Krs setiap sif nya. - Evaluasi kinerja pada staf yang terlibat kasus open billing. - Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan terkait open billing.
3	3A	Kurangnya kepedulian dari unit terhadap perawatan playground.	P	- Melakukan pendataan kelengkapan playground - Melakukan koordinasi dengan staf unit 3a terkait penemuan kerusakan atau kehilangan dari kelengkapan playground - Melakukan komunikasi dengan unit dengan unit CS terkait pembersihan - Melakukan koordinasi dengan direksi terkait kesusakan, kehilangan, dan perawatan playground
			D	- Pendataan kelengkapan playground - Koordinasi dengan staf unit 3a terkait penemuan kerusakan atau kehilangan - Komunikasi dengan unit CS terkait pembersihan - Koordinasi dengan direksi terkait kerusakan, kehilangan, dan perawatan playground
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	- Pendataan kelengkapan playground - Koordinasi dengan staf unit 3a terkait penemuan kerusakan atau kehilangan - Komunikasi dengan CS terkait pembersihan - Koordinasi dengan direksi terkait kerusakan, kehilangan dan perawatan playground.
3	3B	Pembagian job desk oleh katim belum berjalan maximal.	P	- Melakukan koordinasi dengan Katim dalam pembagian tugas setiap shift. - Melakukan koordinasi dengan Katim untuk pembagian PPJA sesuai dengan ruangan pasien. - Melakukan evaluasi pelaksanaan MAKP metode Tim. - Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan.
			D	- Koordinasi dengan Katim dalam pembagian tugas setiap shift. - Koordinasi dengan Katim untuk pembagian PPJA

				sesuai dengan ruang an pasien.
				3. Evaluasi pelaksanaan MAKP metode Tim di unit.
				4. Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan.
			S	Monitoring dan evaluasi
			A	1. Koordinasi dengan Katim dalam pembagian tugas setiap shift.
				2. Koordinasi dengan Katim untuk pembagian PPJA sesuai dengan ruang an pasien.
				3. Evaluasi pelaksanaan MAKP metode Tim di unit.
				Koordinasi dengan kabid pelayanan dan keperawatan.

1. Permasalahan Rawat Jalan

No	Permasalahan	Analisa
1	Belum tersedianya alat pembuka gips mengakibatkan kesulitan Tindakan di poli orthopedi.	P 1. Melakukan pendataan intensitas Tindakan pembukaan gips setiap bulan nya di poli orthopedi. 2. Melakukan pembuatan SP alat pembuka gips. 3. Melakukan koordinasi dengan kabid pelayanan terkait pengajuan alat tersebut. D 1. Pendataan intensitas Tindakan pembukaan gips setiap bulan. 2. Pembuatan SP alat pembuka gips. 3. Koordinasi dengan kabid pelayanan terkait pengajuan alat. S Monitoring evaluasi A Konfirmasi ke pada pihak pengadaan ulang
2	Pasien dr camelia sp Pd komplain di karenakan belum di panggil (sudah di TL ternyata pasien terlambat datang, dr camelia memanggil melewati beberapa pasien)	P 1. Melakukan KIE ke pasien/keluarga jika waktunya Kontrol datang tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi dengan asisten untuk memanggil ulang pasien2 yag belum datang tapi sudah ada di billing sesuai nomer antrian. D 1. KIE ke pasien/keluarga jika waktunya Kontrol datang tepat waktu. 2. Koordinasi dengan asisten untuk memanggil ulang pasien2 yang belum datang tapi sudah ada di billing sesuai nomer antrian. S Monitoring evaluasi A 1. Melakukan KIE ke pasien/keluarga jika waktunya Kontrol datang tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi dengan asisten untuk memanggil ulang pasien2 yag belum datang tapi sudah ada di billing sesuai nomer antrian.

2. Permasalahan Farmasi

No	Kegiatan Pokok	Analisa	Tindak Lanjut
1	STOK OPNAME	DEPO FARMASI 1) Terdapat selisih karena salah input pada so bulan desember 2024 : - Hydroxychloroquin tab – yarindo (F00373) salah input ke Hydroxychloroquin tab (F04500) - Zidovudine/Lamivudine terinput dobel di master barang Lamivudine tab 150 mg (F00427) dan zidovudine / Lamivudine (F00848) 2) F01529 KASA STERIL 16X 16 CM – NASACO, belum ada rak depo 3) Selisih stok opname a. F00035 AMPLODIPIN TAB 10 MG HJ terdapat selisih lebih 1003 dikarenakan kurang telitnya perhitungan buffer. b. F00087 BISOPROLOL TAB 5MG Terdapat selisih lebih 508 c. F00163 CEFTRIAXONE INJ 1 G – BERNOFARM Terdapat selisih lebih 105 tab d. F01426 Handscoon Non Steril M Terdapat selisih kurang 163 pcs e. F02350 MASKER TALI – ONEMED Terdapat selisih kurang 269 pcs f. F01986 Sput 10 CC – GIDCARE Terdapat selisih 264 pcs g. F01991 Sput 3 CC terdapat selisih lebih 169 pcs h. F01990 Sput 3 CC terdapat selisih lebih 394 pcs i. F00013 ADALAT OROS TAB 30 MG terdapat selisih lebih 209 tab F00529 NITROKAF RETARD FORTE CAPS 5 MG – Terdapat selisih lebih 126 tab	1. Pada saat proses verifikasi akhir stock opname harus dilakukan double crosscheck oleh petugas farmasi agar tidak terjadi dobel input master barang 2. Koordinasi dengan Pengadaan PT untuk penambahan rak Depo Farmasi pada master barang 3. Penataan barang dan buffer saat perhitungan stok opname harus lebih teliti dan rapi dalam pelabelan obat 4. Penulisan kartu stock sudah berjalan akan tetapi belum maksimal masih belum bisa dijadikan sebagai data pembandingan Analisa stock opname
		GUDANG FARMASI 1. Terdapat sediaan ED dekat F00333 Gabaxa Inf 200 MG/ML ED 30/03/2025 sebanyak 7 Vial 2. Kartu Stock berjalan 3. Tidak ada selisih stok, sudah dilakukan random cek pada beberapa sediaan dan alkes > cocok dan sesuai dengan kartu stok	1. Sudah proses retur ke distributor (nota retur terlampir)

		DEPO IGD/IKO A. Master Barang Asam mefenamat HJ sudah dinon aktifkan tetapi fisik barang terdapat 10 tablet. B. Terdapat banyak selisih lebih pada Alkes Handscoon & Nurse Cap (dikarenakan template pada paket SC tidak sesuai dengan list fisik paket). C. Terdapat selisih kurang masker tali sejumlah 1024 pcs & Masker karet 165 pcs (dikarenakan fisik diberikan kepada perawat tetapi ditemplate pakatnya berbeda / belum terupdate).	1. Indikasi retur barang unit, sebelum pergantian obat gudang farmasi wajib mengecek sisa stok obat agar dihabiskan terlebih dahulu 2. Sudah dilakukan perbaikan template paket SC di SIMRS
2	Klaim Obat kronis	Pengajuan klaim obat apotek online bulan Januari 2025 sudah siap diproses menunggu konfirmasi dari Verifikator.	Berkordinasi dengan unit Verifikator dalam proses pengajuan klaim obat kronis (tanggal pengajuan).
4	Program BPJS	Total ITERISASI pada akhir bulan Januari 2025 didapatkan hasil sejumlah 263 pasien dari jumlah target per bulan dan telah memenuhi target iterisasi 100 pasien/bulan.	Lebih ditingkatkan ketelitian dari petugas input farmasi untuk melakukan centang iterisasi pada apotek online.
5	Obat Pasien Rawat Jalan Tertinggal	1. Obat pulang tidak di ambil pasien dilakukan retur sesuai fitur SIMRS maksimal tanggal 20 di bulan berjalan. 2. Jumlah obat tertinggal masih terdapat penurunan dari bulan sebelumnya	1. Dilakukan retur obat yang tidak diambil pasien ke gudang farmasi 2. Menghubungi pasien untuk mengambil obat ke farmasi 2x dan menawarkan jasa kirim Beetu
6	Pengembangan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi (Seminar/Workshop) salah satu staff pada bulan Januari mengikuti pelatihan jurnalistik oleh Radar Malang	Mencari referensi (Seminar/Workshop) terkait kefarmasian untuk pengembangan kompetensi.
7	Promosi Kegiatan Rumah Sakit	Kegiatan PKRS sosialisasi kelompok masih belum sesuai target pada bulan ini edukasi kelompok hanya dilakukan 3x dari target 8x/bulan.	Melakukan penjadwalan ulang dengan disesuaikan jumlah staff yang berjaga.
8	Rapat Bulanan Unit	Rapat Bulanan Dilakukan di depo Farmasi telah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2025	Umandok sudah dilaporkan kepada Seketariat, Kabid dan Direktur.
9	Waktu tggu farmasi	antrian waktu tunggu farmasi yang memanjang pada bulan sebelumnya yaitu hal ini dikarenakan pada SIM RS tidak dilakukan klik selesai saat selesai melayani resep, namun sebelumnya petugas melakukan klik ambil obat Dimana membuat waktu tunggu pelayanan farmasi menjadi memanjang	Dilakukan pengklikan obat selesai pada sim RS dan akan dilakukan evaluasi pada bulan serikutnya



1.9 Kinerja Produktifitas Profil SDM

1.9.1 Ketenagaan

Distribusi SDM

No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
1	Direktur	S2 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
2	PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis	Profesi Ners	1	1	0	0	1	0	0	1
3	Kepala Bidang Keperawatan	Profesi Ners	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepala Bidang Penunjang Medis	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
5	Kepala Bidang Umum & Keuangan	S1 Kesehatan	1	1	0	0	1	0	0	1
6	Staf Medis	Dokter Umum IGD	9	9	0	9	0	0	0	67
		Dokter Umum MCU	6	5	1	4	0	0	0	
		Dokter Umum Casemix	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Gigi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Emergency	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anak	4	4	0	4	0	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5	5	0	5	0	0	0	
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal & Hipertensi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0	1	0	0	0	



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Neurologi	4	4	0	4	0	0	0	
		Dokter Spesialis Paru	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Mata	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	3	3	0	3	0	0	0	
		Dokter Spesialis THT	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Urologi	2	1	1	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Gigi Anak	1	0	1	0	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	1	0	0	0	
		Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0	2	0	0	0	
		Dokter Spesialis Anestesiologi	4	4	0	3	1	0	0	



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
7	IRNA II A	D3 Keperawatan	26	12	0	6	6	0	0	24
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		13	2	12	1	0	1	
8	IRNA II B	D3 Keperawatan	25	8	0	3	5	0	1	23
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		16	2	12	4	0	0	
9	IRNA III A	D3 Keperawatan	20	11	0	3	8	0	0	20
		D4 Keperawatan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		8	0	5	3	0	0	
10	IRNA III B	D3 Keperawatan	18	10	0	4	6	0	0	18
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		8	0	7	1	0	0	
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	1	1	0	1	0	0	0	1
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		0	0	0	0	0	0	
12	Maternitas	D3 Kebidanan	14	3	0	0	3	0	0	14
		D4 Kebidanan		10	0	3	7	0	0	
		S1 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
13	ICU	D3 Keperawatan	10	4	0	1	3	0	0	10
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		6	0	0	6	0	0	
14	NICU	D3 Keperawatan	9	5	0	1	4	0	0	9
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		Profesi Ners		4	0	0	4	0	0	
15	IGD	D3 Keperawatan	27	7	0	3	4	0	0	26
		D3 Kebidanan		3	0	1	2	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		2	0	1	1	0	0	
		Profesi Ners		15	0	12	3	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
16	IKO	D3 Keperawatan	13	10	0	6	4	0	0	13
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
		Profesi Ners		3	0	1	2	0	0	
17	IRJA	D3 Keperawatan	25	15	0	4	11	0	0	25
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		1	1	0	1	0	0	
		Profesi Ners		7	0	3	4	0	0	
18	Rehab Medik	D3 Fisioterapi	5	1	0	1	0	0	0	5
		D4/S1 Fisioterapi		4	0	4	0	0	0	
19	HD	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		S1 Profesi Ners		3	0	1	2	0	0	
20	Perawat MCU & Klinik Perusahaan	D3 Keperawatan	8	6	0	5	1	0	0	8
		S1 Profesi Ners		1	2	1	0	0	0	
		S2 Psikolog	1	1	0	1	0	0	0	1
21	Farmasi	SMA/ SMK Farmasi	3	3	0	2	1	0	0	47
		S1 Admin Farmasi	1	1	0	0	1	0	0	
		D3 Farmasi	26	26	0	22	5	0	0	
		D3 Analis Farmasi	1	1	0	1	0	0	0	
		S1 Farmasi	4	4	0	3	1	0	0	
		Apoteker	12	12	0	5	7	0	0	
22	Rekam Medis	D3 RMIK	9	8	0	5	3	0	0	9
		D4 RMIK		1	0	0	1	0	0	
23	Pendaftaran	SMA/SMK	18	2	0	0	2	0	0	18
		D1		1	0	1	0	0	0	
		D3		5	0	1	4	0	0	
		D4		2	0	1	1	0	0	
		S1		8	0	5	3	0	0	
24	Laboratorium	D3 Analis Kesehatan	12	9	0	2	7	0	0	12
		D4 Analis Kesehatan		3	0	2	1	0	0	
25	Radiologi	SMA/SMK	7	0	0	0	0	0	0	7
		D3 Radiologi		7	0	6	1	0	0	
26	CSSD	SMA/SMK	4	3	0	1	2	0	0	4
		D3 Keperawatan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	1	0	0	



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
27	Laundry	SMA/SMK	6	5	0	2	3	0	0	6
		D1		1	0	1	0	0	0	
28	Ahli Gizi	D3 Gizi	6	3	0	3	0	0	0	6
		D4 Gizi		2	0	0	2	0	0	
		S1 Gizi		1	0	0	1	0	0	
29	Dapur & Pantry	SMA/SMK	15	15	0	6	9	0	0	15
30	Keuangan & Akuntansi	SMA/SMK	9	0	0	0	0	0	0	9
		D1		1	0	0	1	0	0	
		D3		0	0	0	0	0	0	
		S1		8	0	1	7	0	0	
31	SDM & Diklat	S1 Psikologi	2	1	0	1	0	0	0	2
		S1 Manajemen		0	0	0	0	0	0	
		S1 Kesehatan		1	0	0	1	0	0	
		S1 Lainnya		0	0	0	0	0	0	
32	Asuransi Center	SMA/SMK	12	0	0	0	0	0	0	12
		D3 RMIK		7	0	5	2	0	0	
		D3 Asuransi Kesehatan		0	0	0	0	0	0	
		D4 RMIK		1	0	0	1	0	0	
		D4 Asuransi Kesehatn		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kesehatan / Lainnya		4	0	1	3	0	0	
33	Humas Marketing	S2 Manajemen Kesehatan	1	0	0	0	0	0	0	1
		S1 Marketing		0	0	0	0	0	0	
		D3 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		S1 Keperawatan		0	0	0	0	0	0	
		SMA/SMK		0	0	0	1	0	0	
34	Sekretariat	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
35	Security	SMA/SMK	11	11	0	4	7	0	0	11
36	Parkir	SMA/SMK	11	10	0	10	0	0	0	11
		S1 Lainnya		1	0	1	0	0	0	
37	Driver	SMA/SMK	7	7	0	0	7	0	0	7
38	Cleaning Service	SMA/SMK	41	40	0	12	28	0	0	41
		D3		1	0	0	1	0	0	
39	Tukang Kebun PHL	SMA/SMK	3	2	0	2	0	0	0	3
		SMP		1	0	1	0	0	0	
		SD		0	0	0	0	0	0	
	IPSRs	SMA/SMK	4	4	0	3	1	0	0	5



No.	Unit	Pendidikan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan	Tidak Tetap	Tetap	Baru	Resign/ Mutasi	JUMLAH AKHIR
40		D3 ATEM	1	1	0	1	0	0	0	
		Admin IPSRS	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gudang Umum	S1	1	1	0	0	1	0	0	1
42	IT & SIMRS	D4 Teknologi Informasi	2	0	0	0	0	0	0	2
		S1 Teknologi Informatika		1	0	1	0	0	0	
		S1 Lainnya		1	0	0	1	0	0	
43	PKRS	DIV Promosi Kesehatan	1	1	0	1	0	0	0	1
44	Mutu	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	1	0	0	0	1
45	PPI	S1 Profesi Keperawatan	1	1	0	0	1	0	0	1
46	K3RS	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0	0	1	0	0	1
47	MOD/MPP	D3 Keperawatan	5	2	0	0	2	0	0	5
		D3 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		D4 Kebidanan		1	0	0	1	0	0	
		Profesi Ners		1	0	0	1	0	0	
		S1 Kebidanan		0	0	0	0	0	0	
TOTAL			521	517	5	279	241	0	0	515

Keterangan : Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bulan Desember 2025 terdapat jumlah staf sebanyak 515 orang dari total kebutuhan sejumlah 521 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah kekurangan staf sejumlah 5 orang

1.9.2 Pendidikan dan Pelatihan

ada Bulan Januari Tahun 2026 1 diklat, dengan rincian 0 diklat internal dan 1 diklat eksternal.

1.9.3 Staf SIP N-ED

Tabel Hasil Rekapitulasi Jumlah Staf yang SIP Near Expired Date (N-ED)

No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
Terproses					
1	Ns Wilda Faiqotun Nikmah, S.Kep	Perawat	NR35142603009040	17 April 2026	12 April 2031
2	Riza Rachmadhani, S.Kep., Ns	Perawat	NR35142603009039	17 April 2026	12 April 2031
3	Durriyyatin Nabila, A.Md.Kep	Perawat	NR35142603002329	06 April 2026	27 April 2031
4	Choirul Achmad, S.Kep., Ns	Perawat	NR35142603000665	06 April 2026	02 Mei 2028
OFF karena Legalitas					
1	Titik Nur Fadilah., Amd Kep	Perawat	446/SIK-P/328/424.072/2021	15 Juli 2021	30 April 2026
Masa Berlaku Kurang dari 6 Bulan					
1	Bagas Surya Purwono, A.Md. Kep	Perawat	446/SIK-P/333/424.072/2021	15 Juli 2021	21 Agustus 2026



No.	Nama	Profesi	Nomor SIP	Tanggal Berlaku SIP	Masa Berlaku
2	Vira Agustin Sintia Putri, A.Md.Kep	Perawat	446/SIK-P/331/424.072/2021	15 Juli 2021	18 Agustus 2026
3	Yuyun Dianita, Amd. Kep	Perawat	500.16.7.2/237/SIP-P/V/424.086/2024	17 Mei 2024	06 Mei 2026
4	Iin Widowati, S.Tr.Keb	Perawat	446/SIK-B/078/424.072/2021	21 Mei 2021	20 Mei 2026
5	Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep	Perawat	446/SIK-P/323/424.072/2021	14 Juli 2021	24 Agustus 2026
6	Linda Saputri., Amd Kep	Perawat	446/SIK-P/234/424.072/2021	21 Mei 2021	20 Mei 2026
7	Devi Apriliyanti., Amd Kep	Perawat	503/334/SIP-P/VI/424.086/2022	7 Juni 2022	10 April 2026
8	Aulia Rahmatul Amani, A.Md.Kep	Perawat	NR35142508004544	11 Agustus 2025	20 April 2026
9	Moh. Ivanus Sholihin., S Kep Ns	Perawat	503/345/SIP-P/VI/424.086/2022	7 Juni 2022	13 Juli 2026
11	Zaifatus Saila., A.Md.Kep	Perawat	503/320/SIP-P/VI/424.086/2022	7 Juni 2022	26 Juni 2026
12	Mery Ayu Maharani, A.Md.Kep	Perawat	503/427/SIP-P/VI/424.086/2022	21 Juni 2022	19 Mei 2026
13	Zairina Rahmawati, A.Md.Kep	Perawat	503/196/SIP-P/V/424.086/2022	17 Mei 2022	09 Juni 2026
14	Titania Aurily Meilany, A.Md.Kep	Perawat	503/381/SIP-P/VI/424.086/2022	9 Juni 2022	18 Mei 2026
15	Latifatus Sofia Melati., Amd Kep	Perawat	503/910/SIP-P/X/424.086/2022	23 Oktober 2022	02 Juli 2026
16	Bd. Devi Puspita Sari S.Tr.Keb	Bidan	NR35142502001016	5 Februari 2025	11 April 2026
17	Tersa Donara Wulan, Amd.Kes	Analisis Kesehatan	503/027/SIP-ATLM/B-VII/424.086/2021	29 Juli 2021	22 Agustus 2026
18	Yolanda Riskawasianda Yuniavirsa, S.Farm., Apt	Apoteker	19980617/SIPA_35.14/254/2021	14 Juli 2021	17 Juni 2026
19	Sintia Anggriani, A.Md.Kes	TTK	503/069/SIP-TTK/VII/424.086/2023	11 Juli 2023	15 Juni 2026
20	Amirul Rosyidin, A.Md.RMIK	Perekam Medis	503/027/SIK-PM/VI/424.086/2022	30 Juni 2022	14 Mei 2026
21	Yuli Ferian Nanda, A.Md.RMIK	Perekam Medis	NR35142502009222	3 April 2025	11 Juli 2026
22	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns	Perawat	503/079/SIP-P/III/424.086/2022	22 April 2022	26 Mei 2026

1.9.5. Mutasi / Rotasi SDM Unit

No	Nama	Jabatan/Unit Asal	Jabatan/Unit Tujuan	Tanggal Mutasi/rotasi
Januari				
1	Siti Rahmawati, S.Kep., Ns	IRNA III B	IGD	01/03/2026
2	Syarif Hidayatullah, A.Md.Kep	IRNA II B	IGD	01/03/2026

Keterangan : Pada Bulan April 2026 terdapat 2 staf yang dirotasi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan unit yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.9.6. Pendidikan dan Pelatihan

Pada Bulan April 2026 tidak ada pelatihan

1.10 Kemajuan Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a-b-c= d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
	PERIODE APRIL 2026 :															
1	Asuransi	659.677.834	150.604.645	2.426.239	506.646.950	281.361.480	66.934.453	1.328.192	213.098.835	719.745.785	340.859.894	109.203.646	38.719.215	55.354.596	175.608.434	719.745.785
2	Perusahaan	463.061.614	252.155.610	23.702.316	187.203.688	480.948.741	64.762.307	5.270.001	410.916.433	598.120.121	532.043.079	37.650.305	7.639.739	980.883	19.806.113	598.120.119
3	Mandiri Inhealth	33.974.709	19.572.979	2.128.866	12.272.864	43.029.942	-	-	43.029.942	55.302.807	52.015.608	3.287.198	-	-	-	55.302.807
4	Jasa Raharja	742.562.456	334.103.003	184.545	408.274.907	258.290.888	55.192.788	1	203.098.099	611.373.006	547.135.699	26.704.616	3.544.879	-	33.987.813	611.373.006
5	Kantin	15.815.750	1.637.650	-	14.178.100	300.000	-	-	300.000	14.478.100	1.290.700	2.706.100	-	-	10.481.300	14.478.100
6	BPJS Ketenagakerjaa	652.237.763	399.698.270	1.923.838	250.615.655	521.025.296			521.025.296	771.640.951	662.714.819	108.926.133				771.640.952
Total Saldo										2.770.660.770	2.136.059.800	288.477.998	49.903.833	56.335.479	239.883.660	2.770.660.770

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

RS Prima Husada Sukorejo yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Letak Geografis yang strategis dekat dengan banyak Perusahaan mengharuskan RS Prima Husada Sukorejo berinovasi memberikan pelayanan yang prima dan diminati kalangan sekitar.

Pemanfaatan Gedung semaksimal mungkin ditujukan untuk dapat memberikan pelayanan yang nyaman untuk Masyarakat daerah Pasuruan. Pemenuhan layanan-layanan Kesehatan juga dijadikan daya Tarik dalam mencapai pasar. Pengembangan layanan penunjang dimaksimalkan untuk menambah daya Tarik rumah sakit.

Penambahan pelayanan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang ada. Melakukan update kebijakan sesuai standart dan peraturan yang terbaru serta pengupayaan berupa refresh pelatihan berkala menjadi agenda rumah sakit. Ketersediaan pemenuhan jabatan diharap akan berdampak positif dalam peningkatan kegiatan supervise berjenjang.

4.2 SARAN

- 4.2.1.1 Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Sukorejo
- 4.2.1.2 Meningkatkan pelayanan yang prima kepada stakeholder rumah sakit
- 4.2.1.3 Meningkatkan kepatuhan DPJP terkait peraturan terbaru rumah sakit
- 4.2.1.4 Meningkatkan dan menambah layanan rumah sakit

BAB V PENUTUP

Demikian laporan Bulan April ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Sukorejo, 10 Mei 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep